



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULAN SEPTEMBER
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Bab I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan 1

Bab II Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Malang 2

2.1 Visi 2

2.2 Misi 2

2.3 Motto 2

2.4 7 Nilai Budi Utama 2

2.5 Struktur Organisasi 3

Bab III Laporan Kinerja Pelayanan 4

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI) 4

3.1.1 Tabel Capaian BOR,LOS,TOI,BTO 4

3.1.2 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO 4

3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut 5

3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan 6

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada 7

3.3 Kinerja Bidang Pelayanan 20

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik 20

3.3.2 Rawat Inap 22

3.3.3 Intensive Care Unit (ICU) 30

3.3.4 High Care Unit (HCU) 31

3.3.5 Instalasi Gawat Darurat (IGD) 32

3.3.6 Instalasi Kamar Operasi (IKO) 34

3.4 Kinerja Bidang Penunjang 35

3.4.1 Instalasi Farmasi 35

3.4.2 Laboratorium 55

3.4.3 Rekam Medis - Pendaftaran 58

3.4.4 Radiologi 64

3.4.5 Gizi 69

3.4.6 CSSD - Laundry 82

3.5 Kinerja Bidang Umum dan Keuangan 87

3.5.1 SDM 87

3.5.2 IPSRS 96

3.5.3 Security 104

3.5.4 Parkir 107

3.5.5 Humas Marketing 107

3.5.6 Penjaminan 114

3.5.7 PIPP – MOD - MPP 115

3.5.8 Cleaning Service 123

3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum 124

3.5.10 IT - SIMRS 125

3.6 Komite dan Tim 127

3.6.1 Komite Mutu 127

3.6.2 Komite PPI 180

3.6.3 Tim PKRS 195

3.6.4 Tim Prognas 197

3.6.5 Tim PPRA 239

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT 240

3.7 Permasalahan Rumah Sakit 247

3.8 Profil SDM 257

Bab IV Kesimpulan dan Saran 261

Bab V Penutup 262

Lampiran 263

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Bulan September Tahun 2025 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

2.1 VISI

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

2.2 MISI

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

2.3 MOTTO

Sahabat Menuju Sehat

2.4 7 NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur Dipercaya
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan struktur Organisasi Rumah Sakit Prima Husada Malang sebagai berikut :



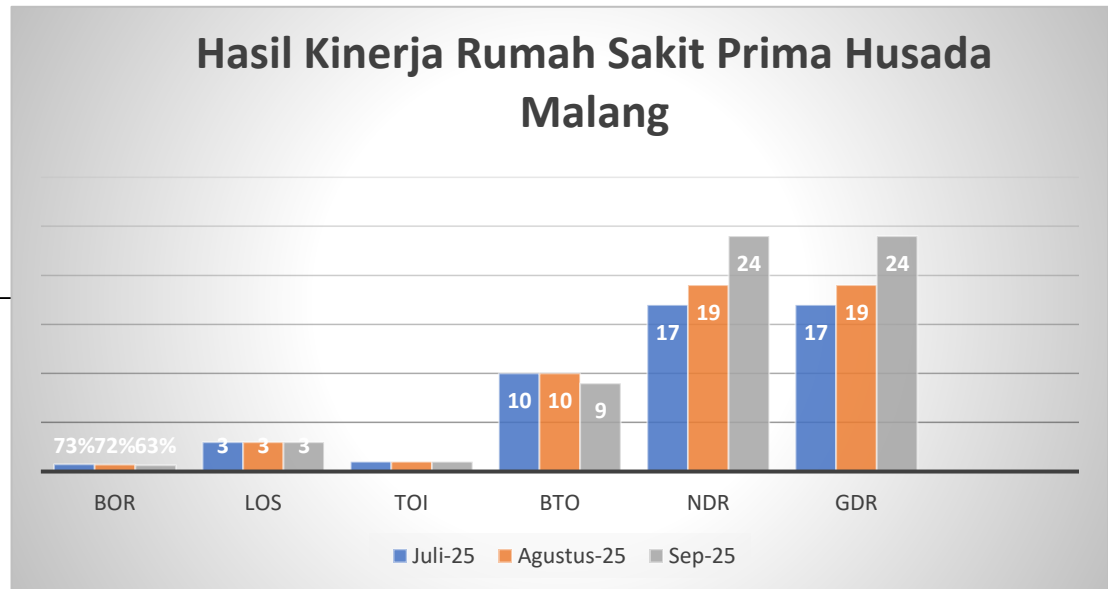
BAB III
LAPORAN KINERJA PELAYANAN

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI)

3.1.1 Tabel Capaian BOR, LOS, TOI, BTO

INDIKATOR	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
BOR	73%	72%	63%
LOS	3 hari	3 hari	3 hari
TOI	1 hari	1 hari	1 hari
BTO	10 kali	10 kali	9 kali

3.1.2 Grafik Capaian BOR, LOS, TOI, BTO



3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut

Masalah :

- LOS terlalu rendah (3 hari)** → indikasi pasien dirawat relatif singkat, bisa karena:
 - Kasus yang ditangani sebagian besar ringan.
 - Tekanan efisiensi rawat inap (lebih banyak diarahkan rawat jalan).
 - Atau kemungkinan pasien pulang cepat namun berpotensi readmisi.
- BTO tinggi** → mengindikasikan perputaran pasien cepat, tetapi bila tidak diimbangi dengan mutu pelayanan bisa meningkatkan beban kerja tenaga medis.
- BOR fluktuatif** walaupun masih dalam batas ideal → perlu perhatian agar tetap stabil dan tidak menurun di bawah standar.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Untuk BOR:

Lakukan monitoring tren kunjungan pasien dan optimalkan pemasaran layanan unggulan agar BOR tetap stabil.

2. Untuk LOS:

- Evaluasi clinical pathway: apakah perawatan sudah sesuai standar atau pasien pulang terlalu cepat.
- Lakukan monitoring readmisi untuk mendeteksi apakah pasien yang pulang cepat sering kembali ke RS.

3. Untuk TOI:

Sudah sesuai standar, tetap dipertahankan dengan manajemen bed yang baik.

4. Untuk BTO:

- Pastikan mutu pelayanan tetap terjaga meski perputaran pasien tinggi.
- Perkuat manajemen SDM (tenaga medis dan paramedis) agar tidak terjadi kelelahan kerja (burnout).
- Evaluasi ketersediaan fasilitas dan sarana agar tetap seimbang dengan volume pasien.

Analisa

1. BOR (Bed Occupancy Rate)

- 73 % → 72 % → 63 %
- Utilisasi (BOR) menurun secara signifikan pada September dibandingkan bulan sebelumnya (~10 poin persentase)

2. LOS (Length of Stay)

Karena LOS dan TOI tetap konstan, penurunan BOR & BTO sangat mungkin disebabkan oleh **penurunan jumlah pasien yang masuk / rawat inap**, bukan karena inefisiensi internal

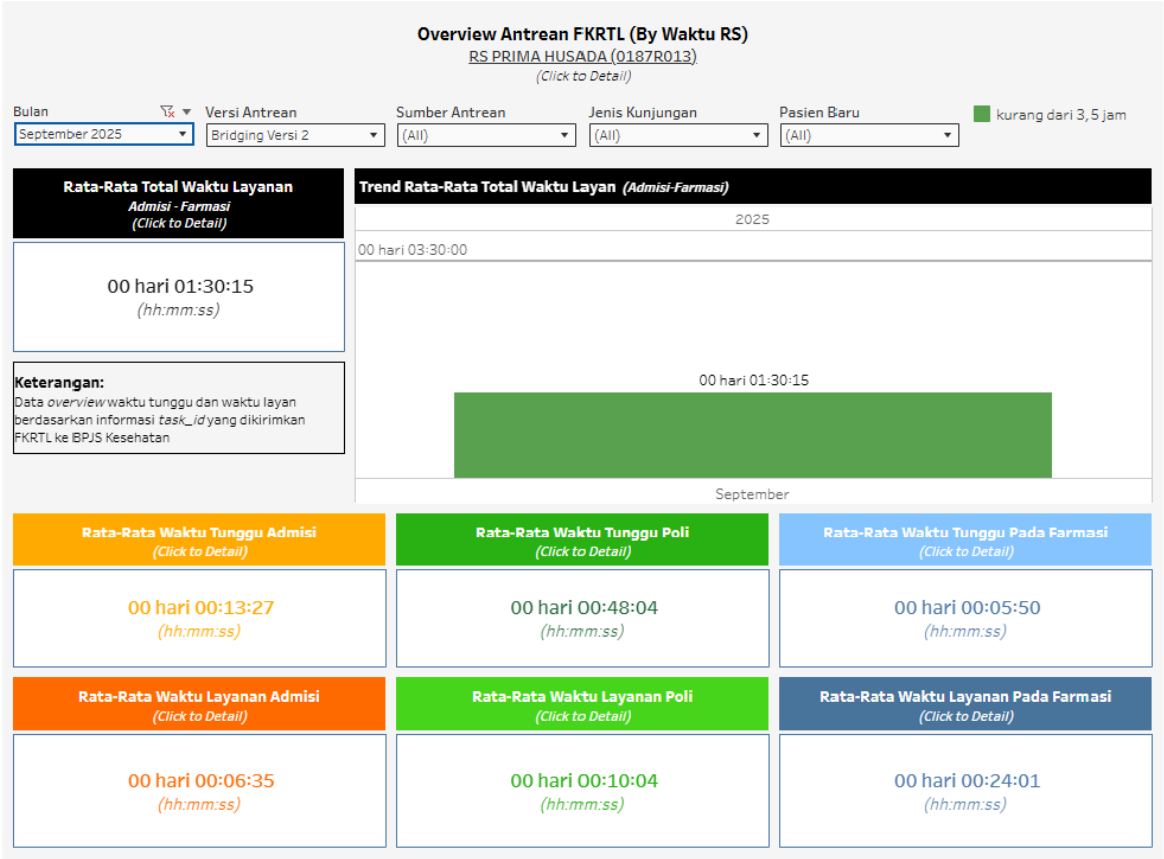
3. TOI (Turn Over Interval)

- Tetap 1 hari
- Kapasitas terpakai jauh lebih rendah di September sehingga banyak tempat tidur “menganggur”

4. BTO (Bed Turn Over)

- 10 kali → 10 kali → 9 kali
- Penurunan BTO juga mencerminkan bahwa frekuensi penggunaan tiap tempat tidur menurun
- Efisiensi internal relatif stabil (LOS dan TOI) — artinya sistem operasional internal tidak memburuk secara mendadak

3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan



Pendaftaran harus KIE terkait M-JKN kepada pasien.

Plan	Menyampaikan hasil evaluasi ke programmer PT Disa Prima Medika
Do	Koordinasi dengan unit terkait dan factor yang mempengaruhi.hasil dari identifikasi programmer
Study	Data rekap bulan sebelumnya yang menjadi acuan dalam perbandingan perbaikan.
Action	1. Menghubungi programmer 2. Monitoring evaluasi 3. Lakukan Tindak lanjut sesuai hasil Monev

NO	Jenis	Target	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Sumber antrian melalui mobile JKN	>30%	46,43%	47.64%	49.61%	50.19%	48.42%	48.20%	
2	Capaian pemanfaatan antrian (onsite dan online Mobile JKN)	>90%	95.11%	94.28%	92.04%	94.61%	94.20%	94.36%	

Analisis :

Pemanfaatan antrian online data juli 2025 belum mendapat dari BPJS

Plan	Mempertahankan hasil > 30% dan meningkatkan untuk kinerja di bulan selanjutnya
Do	Sosialisasi ke unit terkait
Study	Data bulan-bulan sebelumnya sebagai acuan dari data yang sudah diperbaiki
Action	1. Memanfaatkan aplikasi https://dataviz.bpjs-kesehatan.go.id/ untuk monitoring 2. Monitoring evaluasi <i>feedback</i> 3. Supervisi kabid

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada

3.2.1 Bidang Pelayanan dan Keperawatan

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
BIDANG PELAYANAN DAN KEPERAWATAN				
1	IRNA	Perbaikan penulisan pengkajian awal keperawatan meliputi skrining nyeri, skrining gizi dan risiko jatuh	1. Mengidentifikasi saat lapsus pasien, ditemukan terkait ketidaksesuaian penulisan skrining gizi, nyeri dan kebutuhan ADL 2. Seharusnya kebutuhan pasien dengan keluhan lemas, harus menggunakan kursi roda, tetapi di ADL ditulis mandiri	Implementasi kesesuaian penulisan harus ditingkatkan, rencana tindaklanjut sosialisasi selain pada rapat koordinasi keperawatan, juga saat supervisi harian karu

2	IRNA	Implementasi ERM pemberian dan pengkajian edukasi di ERM	1. Implementasi E-rekam medis rawat inap khusus untuk form bendelan OB hampir 80% sudah memakai ERM 2. Untuk pemberian informasi dan penulisan edukasi, sudah diimplementasikan mulai dari PDF, PIPP, apoteker, perawat, DPJP maupun gizi	Dalam implementasi ERM, ada beberapa kendala : - Nama petugas dan nama keluarga belum muncul – proses TL - Nama keluarga sudah diinput, tetapi di ERM belum muncul, dan tidak muncul saat di fitur cetak – proses TL
3	IRJA	Poli Harmoni STIFIn	1. Ruangan tersedia di poli lantai 4 sakura 2. Ruangan dilengkapi dengan bed , sofa , meja, TV, dan PC untuk mendukung pelayanan poli harmoni 3. Koordinasi dengan PKRS, untuk share ke medsos	Untuk saat ini masih belum ada pasien yang reservasi ke poli harmoni
		Re- Upload dan sharing Poli Sunday Clinic	1. Karena poli Sunday clinic jarang diupload, dan hanya di share di WA channel, beberapa orang tidak tahu kalau poli minggu ready termasuk melayani pasien dengan BPJS kesehatan 2. Pelayanan Sunday clinic meliputi poli anak, saraf, dan peny dalam	Untuk poli sunday clinic khusus pasien bpjs tetap mengikuti prosedur, karena masin-masing dokter mempunyai kuota masing-masing sesuai HFIS
		Re-upload layanan vaksin, MCU, telemedicine, surat bebas narkoba, USG 4D	1. Layanan vaksin internasional ada perpanjangan IKS di bulan Oktober 2025 2. Untuk pasien yang sudah reservasi di bulan Oktober, diberikan waiting list untuk batas waktu menunggu kurang lebih 1-2 hari setelah approve dari BKK	1. Untuk layanan vaksin internasional sudah running kembali per 1 Oktober 2025 2. Peminat telemedicine, surat bebas narkoba, USG 4D tidak begitu banyak, koordinasi dengan PKRS agar setiap hari di share di WA channel dan

				sosmed
4	IGD	Sharing Ilmu kegawatan pada Dokter IGD , Dokter ruangan dan perawat IGD	Untuk meningkatkan skill dan pengetahuan dokter IGD, dokter spesialis bisa memberikan sharing ilmu terkait kegawatan melalui materi zoom maupun offline	Bulan September 2025, ada sharing ilmu : 1. 2 Sep 2025 – dr Fachriy,SpBS – kegawatan bedah saraf 2. 15 Sep 2025 -dr. Dewi, SpS 3. 20 Sep 2025 – dr Anisafira (materi echocardiografi dari hasil pelatihan POCUS)
5	IKO	Pengajuan alat bor craniotomy di IKO	Ada demo dari vendor untuk pemakaian alat bor craniotomy di IKO	Dari hasil demo, apabila dengan harga yang ditawarkan, saran tidak diambil, dan dicari merk yang lebih bagus. Karena penggunaan nya tidak maksimal dan pertimbangan cari merk yang sesuai dan terjangkau

3.2.2 Bidang Penunjang

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT				
1.	Depo Farmasi	1. KPO Elektronik (E-KPO)	a. Penulisan KPO (Kartu Pengambilan Obat) menulis manual sehingga memperlama waktu tunggu obat rawat jalan. b. Pengajuan form penambahan fitur E-KPO ke programmer yaitu data obat di print dengan printer thermal kemudian di tempel ke KPO pasien. c. DPJP bisa mengakses e-KPO di SIMRS. d. Jumlah KPO tertinggal : 111. e. Belum tersedia printer thermal untuk cetak e-KPO.	Dalam antrian progamer
		2. Perbaikan sistem ROP Depo Farmasi dan Gudang Farmasi	a. Melakukan evaluasi dan perbaikan rumus serta sistem permintaan barang dari depo ke Gudang Farmasi melalui rumus ROP.	Monitoring dan evaluasi rumus ROP yang sudah ada

			b. Melakukan evaluasi dan perbaikan rumus serta sistem permintaan pembelian Gudang Farmasi melalui rumus ROP. c. Fitur sisa stok depo pada sistem ROP sudah tersedia.	
		3. Renovasi ruang Pencampuran Obat (LAF) sesuai standart	a. Renovasi Pencampuran Obat (LAF) sesuai standart selesai tanggal 20/03/2025, ruangan steril dilapisi vinyl dan monitoring tekanan ruangan dengan magnehelic dan dicatat pada spreadsheet. b. Form pengajuan penambahan 1 unit Laminar Air Flow (LAF) untuk dispensing sediaan steril dan 1 unit pass-box air lock untuk tempat masuk dan keluarnya alat kesehatan dan bahan obat sebelum dan sesudah dilakukan pencampuran. <i>Pass box</i> ini terletak di antara ruang persiapan dan ruang steril. Form sudah masuk ke Pengadaan PT. Disa Prima Medika.	Follow up form pengajuan LAF dan pass-box air lock
		4. Perluasan ruang Depo Farmasi sesuai standart	a. Pengajuan perluasan ruangan di depo farmasi untuk penggantian lemari pendingin yaitu penyimpanan obat ke lemari pendingin yang lebih besar dan vaksin di letakkan dalam <i>vaccine refrigerator</i> disertai Log tag. b. Perluasan ruang buffer stok 6 Maret 2025, sudah tersedia cctv dan smart door lock.	Koordinasi dengan kepala bidang terkait rencana lokasi penyimpanan showcase 2 pintu (785 liter) dan <i>vaccine refrigerator</i> .
		5. Pendaftaran pengantaran obat primantara di Farmasi	a. Fitur “antar obat” di SIMRS sudah tersedia dan ada laporan penjualan obat diantar. Namun kekurangannya tidak ada kolom asal poli, jam pemesanan, obat selesai, biaya,	Pendataan secara manual, belum bridging dengan SIMRS. Sementara menggunakan spreadsheet.

			cara bayar, jarak pengiriman dan serah terima farmasi dan kurir primantara sehingga pendataan pasien menggunakan google spreadsheet primantara. b. Belum ada penanda resep obat siap dikirim serta diperlukan marking agar terdapat penanda bahwa obat sudah siap di SIMRS. c. Perubahan alur pendaftaran primantara oleh farmasi. a. Perubahan alur pembayaran PRIMANTARA di kasir sudah dilakukan pada tanggal 08/01/2025.	
		6. Rencana pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis	a. Sudah dilakukan pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis namun masih terkendala tenaga TTK kurang (jika ada staf yang sakit). b. Meminimalisir waktu tunggu pasien non kronis dengan obat yang tidak banyak. c. Masih ada komplain pasien terkait waktu tunggu. d. Belum ada fitur pemisahan resep masuk kronis dan non kronis.	Pengajuan fitur ke progamer.
		7. Pengambilan obat dengan TTD elektronik	a. TTD elektronik pengambilan obat rawat jalan sudah berjalan dan memudahkan untuk mengecek retriaksi kelengkapan obat kronis, namun terkendala pada jaringan yang lemah. b. TTD elektronik pengambilan obat IGD rawat jalan dan pasien rawat inap pulang masih belum bisa dan tahap koordinasi dengan progamer.	Dalam antrian progamer. Monitoring dan evaluasi sistem elektronik.
		8. Pelayanan retriaksi obat kronis:	Pengajuan form penambahan fitur agar DPJP input resep dan	Pengajuan fitur ke progamer.

		penambahan fitur Centang "Perlu Hasil Penunjang Lab dan Hasil Pemeriksaan Lab dimunculkan saat DPJP input e-resep; Hasil Pemeriksaan Lab di Fitur Penjualan Farmasi	penjaminan pelayanan obat bagi peserta JKN sesuai dengan ketentuan retriaksi dan/atau peresepan maksimal obat, memudahkan Farmasi mengecek kesesuaian hasil penunjang dan obat yang diresepkan sesuai retriaksi obat kronis.	
		9. Penambahan fitur laporan berkas obat kronis, laporan resep iter, dan laporan reep PRB di SIMRS	Pengajuan form penambahan fitur laporan di SIMRS yaitu : a. Format laporan berkas obat kronis, berisi : nomor, tanggal registrasi, no. registrasi, no. rm, nama pasien, unit asal, nama dokter, no. sep, nama obat, hasil pemeriksaan penunjang. Tujuan untuk memudahkan farmasi melihat kelengkapan berkas klaim obat kronis yaitu Resep, SEP, Hasil Pemeriksaan Penunjang b. Format laporan resep iter, berisi : nomor, tanggal kunjungan, nama pasien, no. rm, no. kartu, no. SEP, unit asal, nama dokter, jumlah iter, nama obat, aturan pakai, jumlah obat, tanggal kunjungan berikutnya, status iter (terlayani/ belum). Tujuan untuk memudahkan farmasi, verifikator, DPJP untuk melihat laporan resep iter dan target iter. c. Format laporan resep PRB, berisi : nomor, nama dokter, tanggal kunjungan, nama pasien, no. rm, no. kartu, no. SEP, alamat, no. telp, diagnosa PRB, asal FKTP perujuk, asal SRB (FKTL/RS), nama obat, aturan pakai, jumlah obat. Tujuan untuk memudahkan farmasi, verifikator, DPJP untuk melihat laporan resep PRB dan target PRB.	Pengajuan fitur ke progamer.

		10. Penambahan fitur warning di SIMRS DPJP “Pasien tidak ambil obat”	Pengajuan form penambahan fitur warning di SIMRS DPJP “Pasien tidak ambil obat” untuk mengurangi retur obat tertinggal.	Pengajuan fitur ke progamer.
		11. Ruang handrub	a. Penambahan ruang handrub pada tanggal 28 mei 2025 untuk pengisian botol cairan handrub yang habis di ruangan agar meminimalkan mikroorganisme. b. Pengisian handrub dilakukan oleh apoteker. c. Sudah dilakukan sosialisasi pengisian botol handrub oleh komite PPI.	Monitoring dan Evaluasi.
		12. Pelayanan vaksin umum (non-pemerintah) tidak melalui poliklinik	Alur pelayanan vaksin umum (non-pemerintah) tidak melalui poliklinik : a. Melakukan edukasi ke pasien terkait harga vaksin dan biaya jasa dokter kemudian dibuatkan copy resep manual (yang berisi identitas pasien, nama vaksin, jumlah dan no telfon pasien) b. Pasien diarahkan ke kasir untuk pembayaran. c. Order vaksin ke gudang farmasi. d. Ketika vaksin datang akan dihubungi oleh marketing. e. Farmasi melakukan cetak nota pasien dan follow up kepada kasir untuk pelunasan berdasarkan kwitansi manual sebelumnya. d. Pasien melakukan suntik di poli vaksin.	Pelayanan vaksin umum (non-pemerintah) tidak melalui poliklinik
2.	Gudang Farmasi	1. Pengembangan fitur scan barcode gudang farmasi dan depo farmasi untuk pemasukan dan pengeluaran stok.	a. Proposal scan barcode sudah diajukan ke PT pada tanggal 01/10/2024. b. Sudah dilakukan presentasi pada tanggal 04/10/2024. c. Pendataan master barcode sudah diserahkan ke	Rencana trial menunggu Programmer PT

			Programmer PT. Tindak lanjut untuk barang yang tidak memiliki barcode yaitu dibuatkan barcode internal oleh progamer. d. Alat scanner barcode, barcode printer, thermal paper sudah tersedia pada tanggal 16/11/2024. e. Software aplikasi barcode dalam tahap dikerjakan oleh progamer.	
		2. Perluasan Gudang Farmasi	a. Perluasan Gudang Farmasi di Lantai 2, karena pallet buffer sudah tidak cukup. b. Pengajuan katrol untuk penurunan buffer dari lantai 2.	Sudah berjalan. Follow up pengadaan katrol.
3.	Floorstok IKO	Perbaiki sistem penyimpanan floorstok IKO	Progres perbaikan Floorstok IKO tahun 2023 : a. Tanggal 03 Januari 2023 dilakukan rapat koordinasi floorstok IKO dengan perawat IKO dan programmer terkait sistem floorstok IKO yaitu : - Tidak adanya petugas farmasi khusus IKO sehingga monitoring stok di IKO tidak berjalan → Pengajuan petugas farmasi di IKO. - Perubahan alur dari depo iko ke floorstok IKO. - Karu IKO menentukan obat dan BMHP yang dimasukkan dalam list floorstok. - Perbaiki alur floorstok iko ke depo farmasi. - List barang yang masuk dalam kategori floorstok dan jumlahnya. - List barang yang masuk dalam kategori BMHP. - Penggunaan BMHP yang diambil dari Gudang Farmasi apakah	Monitoring dan Evaluasi.

			perlu di inputkan tindakan dan ditagihkan ke pasien → Konsul dengan keuangan PT terkait tagihan BMHP yang digunakan IKO. - Koordinasi dengan karu IKO penentuan barang sharing dose. - Konsul dengan keuangan PT terkait tagihan pasien untuk penggunaan obat maupun alkes sharing. - Konsul dengan programmer terkait alur penginputan sharing dose. b. Tanggal 17 Maret 2023 dilakukan sosialisasi alur floorstok IKO oleh progamer yaitu : - Alur input obat dan bmhp oleh perawat IKO di SIMRS → perawat menulis resep manual – barang disiapkan, kemudian input resep setelah operasi sesuai yang terpakai. - Alur permintaan floorstok iko ke depo farmasi oleh perawat IKO di SIMRS. - Alur release stok oleh depo farmasi di SIMRS. - Alur minta barang BMHP IKO ke gudang farmasi oleh perawat di SIMRS. c. SPO alur Pelayanan Sediaan Farmasi Sistem Floorstock Di Instalasi Kamar Operasi terbit tanggal 24 Maret 2023. d. Tanggal 03 April 2023 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO dan programmer terkait	
--	--	--	---	--

			sistem floorstok IKO yaitu : - Petugas IKO ditemukan salah memilih unit tujuan saat input permintaan sehingga dapat menyebabkan selisih stok → Petugas IKO diharap lebih teliti dalam melakukan inputan permintaan (memperhatikan tujuan permintaan BMHP ke Gudang dan permintaan barang floorstok ke depo farmasi). - Melakukan double check oleh petugas farmasi, apabila IKO salah input permintaan maka konfirmasi ke petugas IKO untuk revisi inputan sesuai tujuan permintaan - Pembuatan SPO alur floorstok iko. - Jumlah stok di sistem Floorstok IKO bisa sampai minus → Pengajuan ke programmer untuk stok sistem di lock hanya sampai angka 0 (tidak sampai minus). - Penetapan alur bmhp IKO bahwa list bmhp yang sudah disetor ke keuangan PT dimasukkan dalam paket tindakan operasi sehingga tidak perawat tidak input ke pasien. e. Tanggal 08 Mei 2023 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO dan programmer terkait sistem floorstok IKO yaitu : - Terdapat stok yang tidak sesuai antara kartu stok, jumlah	
--	--	--	---	--

			fisik, dan jumlah sistem. Stok sistem belum di lock. Dengan adanya penyesuaian item dan jumlah floorstok di IKO sehingga terdapat stok yang kelebihan dan atau kurang → Melakukan stok opname floorstok IKO. Mengajukan pemutihan stok IKO untuk penyesuaian dengan kesepakatan jumlah floorstok terbaru. Kelebihan dan atau kekurangan stok dibuatkan berita acara untuk penyesuaian stok. Progres perbaikan Floorstok IKO tahun 2024 : a. Fitur Floorstok unit IKO sudah tersedia dan sudah dijalankan. b. Fitur minta barang floor stock sudah tersedia dan sudah dijalankan. c. Sistem stok IKO sudah dikunci. d. Ada petugas farmasi di IKO untuk monitoring stok. e. Tanggal 15 Juli 2024 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO, Kabid Penunjang, Kabid Keperawatan yaitu : - Ditemukan input permintaan FS menggunakan tipe trans “farmasi” bukan fitur “floor stok unit” sehingga terjadi kelebihan barang yang tidak sesuai jumlah FS, dikarenakan barang yang dikirimkan ada yang kurang dari yang dimintakan. Hal ini terjadi dikarenakan selisih stok di IKO di	
--	--	--	--	--

			sistem stoknya tidak ada namun fisiknya ada sehingga staf farmasi yang diiko tidak mencatat di barang menipis sehingga tidak disiapkan permintaan FS ketika malam hari karena secara fisik stoknya masih ada → Menyamakan persepsi antara permintaan FS dengan permintaan hutang input ke pasien. Jika staf farmasi melakukan random stok dan ditemukan selisih stok lebih disistem maka akan konfirmasi ke perawat untuk diinputkan ke pasien. Jika terdapat selisih stok fisik lebih dan stok simrs 0 maka farmasi mengecek stok yang ada didepo farmasi dan simrs depo farmasi. Jika stok simrs berlebih maka release stok ke iko. - Ditemukan perbedaan barang di resep manual dan inputan simrs, farmasi menuliskan apa yang ada diinputan resep, perawat iko mengambil barang namun tidak ada di tulisan resep manual hari itu → Farmasi melakukan double cek resep manual dan inputan simrs jika ada yang belum diinputkan maka akan di stabilo di resep manual dan resep diserahkan ke perawat untuk diinputkan kembali. Resep akan	
--	--	--	---	--

			dibedakan, untuk resep yang belum selesai diinput akan ada didekat komputer iko. Untuk resep yang sudah diinput akan ditaruh dikeranjang di lemari obat. f. Tanggal 15 Juli 2024 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO, Kabid Penunjang, Kabid Keperawatan yaitu : - Konsinyasi implant IKO belum di lock → dilakukan stok opname. Data diberikan ke progamer agar dilakukan penyesuaian stok. Programmer langsung merubah dan sistem di lock. - Perubahan alur penyiapan obat dan bmhp operasi → perawat input resep sesuai advice DPJP – farmasi menyiapkan – jika ada barang yang tidak terpakai maka di retur penjualan. g. Revisi SPO : - SPO Pelayanan Kefarmasian Di Instalasi Kamar Operasi terbit tanggal 12 November 2024. - SPO Permintaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Instalasi Kamar Operasi Kepada Instalasi Farmasi. h. Tersedia alur penggunaan sediaan sharing dose. Contoh : Isonest. i. Menggunakan tabel penggunaan obat sharing dose. j. Ada petugas farmasi di IKO	
Instalasi Rekam Medis				
1.	Rekam Medis	1. Mengaplikasikan E-RM (IRJA dan	Poli gizi dan kia belum menjalankan ERM	1. Poli Gizi dan Poli KIA belum

		IRNA).		menjalankan ERM. 2. Beberapa kendala teknis dan keterbatasan SDM dalam penggunaan sistem.
		3. Kirim ke Satu Sehat untuk Pasien Rawat Jalan (Baik ERM ataupun Non ERM)	Pengiriman data ke satu sehat (untuk data kunjungan dan diagnosis) dilakukan setiap hari. Temuan dan TL : a. ERM yang belum lengkap dan valid. TL : Koordinasi dengan Tim Pendaftaran terkait identitas pasien yang tidak lengkap. b. Bayi baru lahir yang belum mempunyai NIK. TL : Kie ke keluarga pasien agar segera pengurusan KK. c. Pasien yang tidak membawa identitas dengan lengkap. TL : KIE ke keluarga pasien untuk mengirimkan identitas melalui chat WA.	Monitoring dan Evaluasi.
		4. Formulir rekapitulasi kegiatan pelayanan laboratorium pada SIMRS	Rekapitulasi jumlah pemeriksaan lab dengan kriteria jenis kelamin dan hasil nilai rata-rata pemeriksaan lab	Keterlambatan pengisian pada web SIRS online → Follow up ke Programmer untuk update fitur di SIMRS

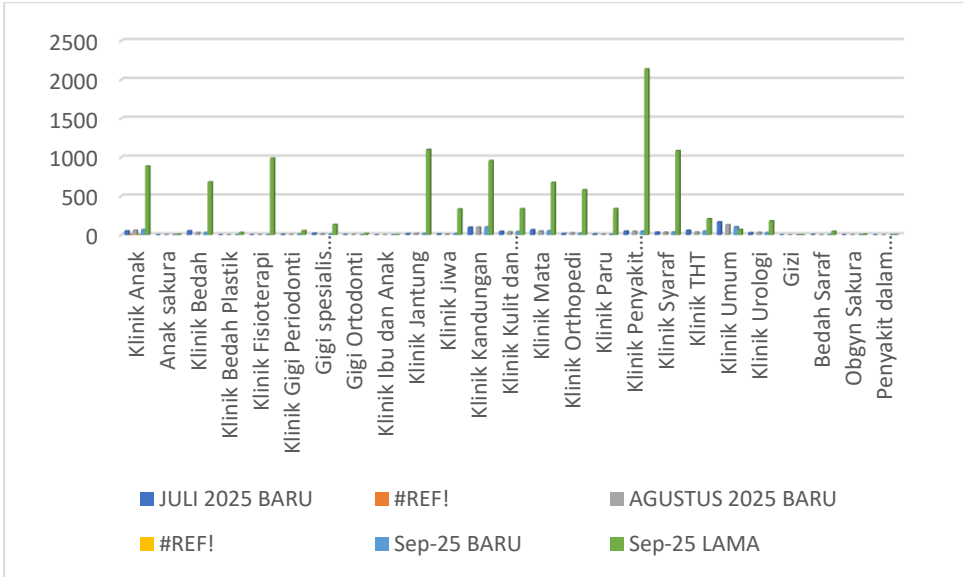
3.3 Kinerja Bidang Pelayanan

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik

3.3.1.1 Kunjungan Pasien Lama dan Baru

NO	NAMA UNIT	JULI 2025			AGUSTUS 2025			SEPTEMBER 2025		
		BARU	LAMA	TOTAL	BARU	LAMA	TOTAL	BARU	LAMA	TOTAL
1	Klinik Anak	51	821	872	58	860	918	68	886	954
2	Anak sakura	0	7	7	1	9	10	1	8	9
3	Klinik Bedah	52	668	720	29	667	696	31	681	712
4	Klinik Bedah Plastik	0	37	37	0	26	26	1	30	31
5	Klinik Fisioterapi	1	1142	1143	1	1130	1131	3	987	990
6	Klinik Gigi Periodonti	6	63	69	4	56	60	10	54	64
7	Gigi spesialis pedodontis	20	190	210	11	163	174	9	134	143
8	Gigi Ortodonti	3	16	19	3	16	19	2	17	19
9	Klinik Ibu dan Anak	0	9	9	0	11	11	0	3	3

10	Klinik Jantung	14	1189	1.203	15	1070	1.085	15	1099	1.114
11	Klinik Jiwa	10	365	375	8	337	345	14	333	347
12	Klinik Kandungan	99	978	1.077	99	881	980	102	956	1.058
13	Klinik Kulit dan Kelamin	45	300	345	38	284	322	42	336	378
14	Klinik Mata	66	783	849	50	756	806	52	675	727
15	Klinik Orthopedi	16	494	510	26	542	568	20	580	600
16	Klinik Paru	10	408	418	7	281	288	8	337	345
17	Klinik Penyakit Dalam	47	2139	2186	44	2208	2.252	48	2134	2.182
18	Klinik Syaraf	36	1161	1197	34	1110	1.144	35	1084	1.119
19	Klinik THT	58	58	246	35	160	195	48	208	256
20	Klinik Umum	167	77	244	130	39	169	104	70	174
21	Klinik Urologi	28	28	337	31	222	253	29	180	209
22	Gizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Bedah Saraf	4	28	32	0	42	42	1	46	47
24	Obgyn Sakura	2	7	9	1	6	7	2	9	11
25	Penyakit dalam sakura	0	7	2	0	1	1	0	1	1
Total		1051	12017	13068	914	11463	12377	645	10848	11.493



Analisis :

1. Kunjungan pasien rawat jalan Agustus ke September 2025 mengalami kenaikan secara keseluruhan sebesar 0,26%
2. Kunjungan tertinggi : Poli Penyakit Dalam dengan kunjungan 2182
3. Kenaikan tertinggi : Poli Obgyn Sakura dengan persentase 54%
4. Penurunan tertinggi : Poli Gigi Pedodontis dengan persentase 18%

Rencana Tindak Lanjut :

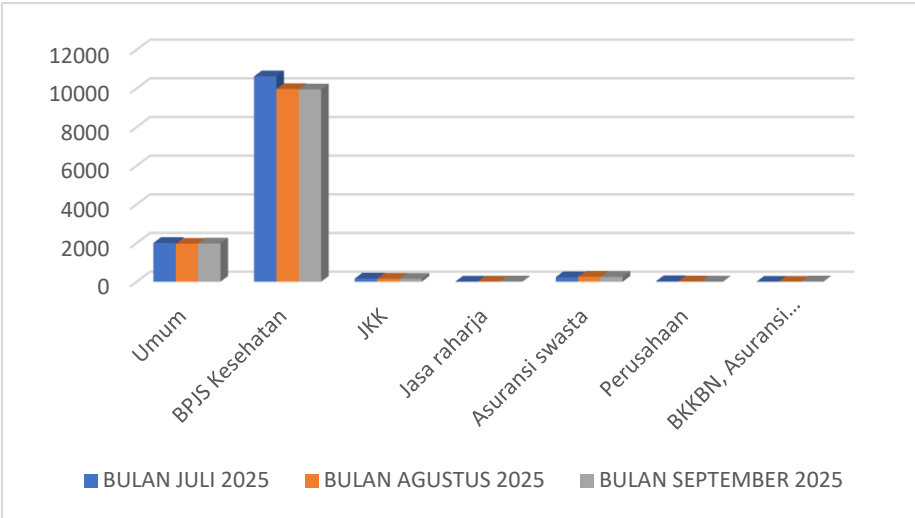
1. Koordinasi dengan pendaftaran penjangkaran pasien umum dan asuransi untuk memperkenalkan pelayanan poli Sakura
2. Menginformasikan kepada seluruh unit rawat inap wajib edukasi saat krs untuk pasien umum,asuransi tentang pelayanan poli Sakura
3. Memisahkan pasien BPJS dengan pasien non BPJS. Pasien Non BPJS di daftarkan di poli Sakura.
4. Koordinasi dengan Humas dan Marketing untuk penjangkaran asuransi dan perusahaan.

- 5. Sosialisasi pada faskes dengan pelayanan baru yang ada di rumah sakit prima husada
- 6. Koordinasi dengan humas marketing untuk rutin menampilkan promo di media sosial
- 7. Koordinasi dengan pendaftaran untuk sellau menanyakan pasien yang mendaftar apakah memiliki asuransi komersil.

1.3.1.2 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran

NO	STATUS PEMBAYARAN	BULAN JULI 2025	%	BULAN AGUSTUS 2025	%	BULAN SEPTEMBER 2025	%
1	Umum	2010	15,38%	1964	15,86%	1980	16,01%
2	BPJS Kesehatan	10625	81,30%	9965	81,51%	9949	80,45%
3	JKK	165	1,26%	154	1,24%	147	1,19%
4	Jasa raharja	3	0,02%	10	0,08%	17	0,14%
5	Asuransi swasta	237	1,81%	261	1,22%	250	2,02%
6	Perusahaan	28	0,22%	20	0,21%	8	0,06%
7	BKKBN, Asuransi Pemerintah	0	0	0	0	16	0,13%
	Total	13068	100%	12377	100%	12367	100%

1.3.1.2.1 Grafik Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran



Analisis :

- 1. Kunjungan dengan cara bayar umum mengalami kenaikan 0,81%
- 2. Kunjungan dengan cara bayar BPJS mengalami penurunan 0,16%
- 3. Kunjungan dengan cara bayar BPJS KETENAGAKERJAAN mengalami penurunan 1,47%

Rencana Tindak Lanjut :

Untuk meningkatkan kunjungan pasien rawat jalan adalah dengan meningkatkan pelayanan terbaik serta berkoordinasi dengan marketing untuk melakukan kunjungan dan menawarkan beberapa pelayanan baru seperti poli sakura yang bisa bekerjasama dengan berbagai asuransi, poli bedah saraf dan poli gigi anak. bekerjasama dengan humas marketing terutama MCU haji dan vaksin internasional (meningitis, polio dan influenza)

3.3.2 Rawat Inap

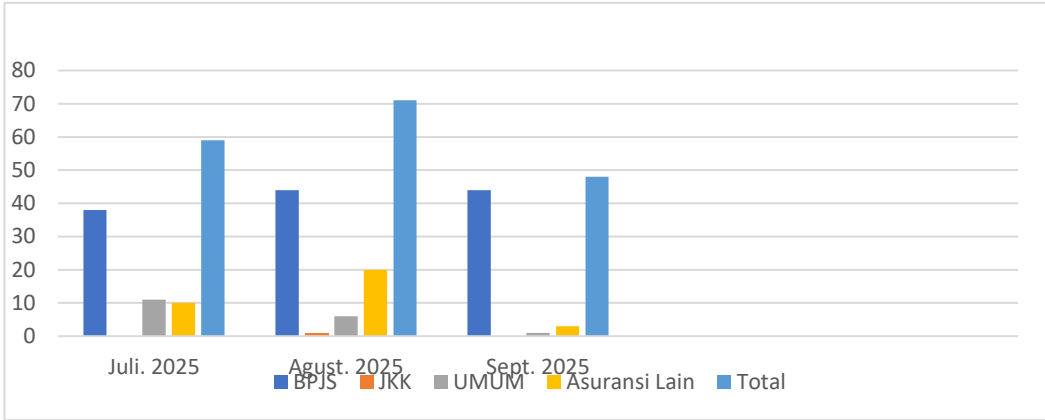
3.3.2.1 Kunjungan Rawat Inap 2C

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli-September 2025)

NO	HAL	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	38	44	44	↑ 15,78%
2	JKK	0	1	0	↑ 100%

3	Umum	11	6	1	↓45,45%
4	Asuransi Lain	10	20	3	↑100%
Total Pasien		59	71	48	↑20,33%

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar (Juli – September 2025)



1.3.2.1.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No.	Bulan	RAWAT INAP				Total Pasien
		BPJS	Umum	JKK	JR/Asuransi	
1	Juli 2025	38	11	0	10	59
	Analisa	Pasien BPJS bulan Juni mengalami penurunan lagi dibandingkan bulan mei	Pasien umum mengalami kenaikan di bulan Juli	Pasien JKK tidak ada	Untuk pasien asuransi bulan Juli stabil sama dengan bulan juni	Total bulan Juli mengalami penurunan daripada bulan Juni
	RTL	Mempertahankan dan meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap				
2	Agutus 2025	44	6	1	20	71
	Analisa	Bulan Agustus pasien BPJS naik seknifikan dari 38 menjadi 44	Pasien umum bulan Agustus turun menjadi 6 dari 11	Pasien JKK ada 1 karena naik ke VIP	Untuk pasien asuransi juga mengalami kenaikan drastis dari 10 px menjadi 20 pasien di bulan Agustus	Total bulan Agustus mengalami kenaikan yang segnifikan dari 59 menjadi 71
	RTL	Mempertahankan dan meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap				
3	SEPTEMBER 2025	44	1	0	3	48
	Analisa	Bulan September pasien BPJS bertahan di angka 44	Pasien umum mengalami penurunan dari 6 ke 1	Pasien JKK tdk ada yg naik kelas	Untuk pasien asuransi menurun drastic dari 20 menjadi 3	Total bulan September jumlah pasien emnurun drastic dari 71

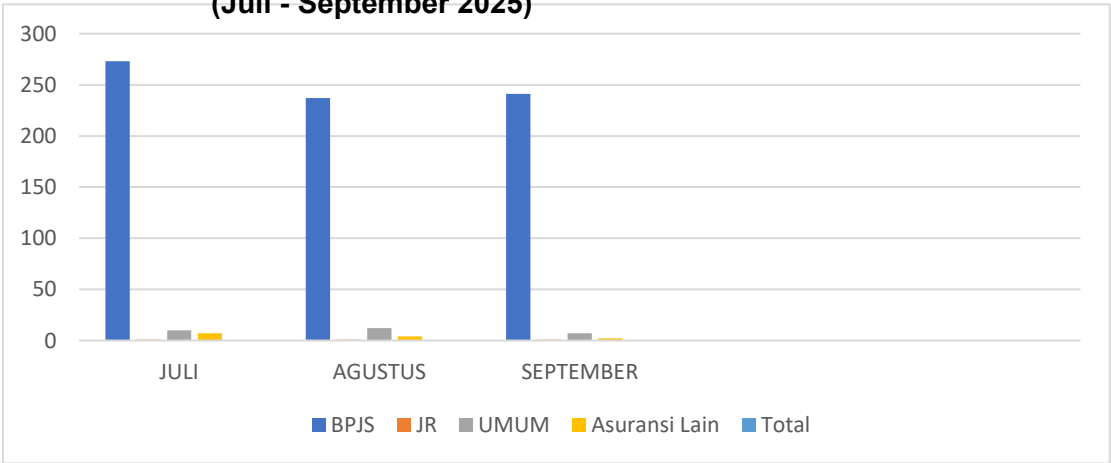
					dikarenakan banyak pasien yg menggunakan BPJS dan COB dengan asuransi	menjadi 48 dikarenakan banyak yg sesuai kelas dan memilih dikelas 3 atau 2
	RTL	Meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap				

3.1.1.1 Kunjungan Rawat Inap 3C Anak

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar (Juli - September 2025)

NO	HAL	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	273	241	241	↑1,7%
2	JR	1	1	1	=
3	Umum	10	7	7	↓71,4
4	Asuransi Lain	7	2	2	↓100%
Total Pasien		291	254	251	↓1,2%

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli - September 2025)



3.3.2.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

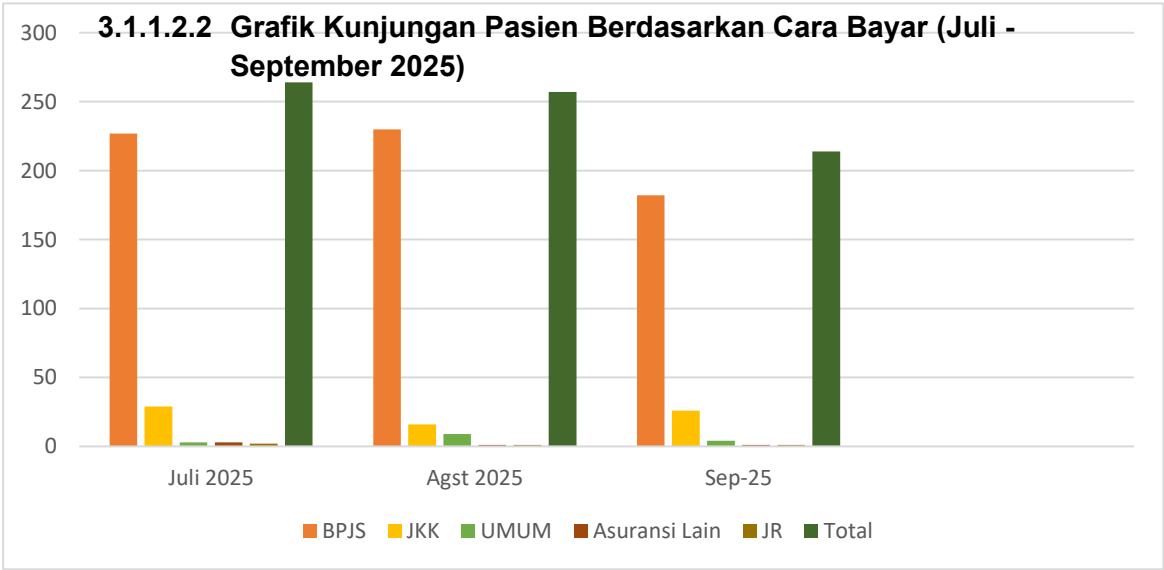
No	Bulan	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	Umum	JR	Asuransi	
	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS ada penurunan selama 3 bulan terakhir pada bulan agustus tetapi mengalami sedikit kenaikan di bulan September	Pasien Umum mengalami peningkatan di bulan agustus dan mengalami penurunan di bulan september sebanyak 71,4%	Pasien JR dari 3 bulan terakhir tetap Dikarenaka KLL kebanyakan tunggal dan jatuh sendiri	Pasien Asuransi mengalami penuruna 75% di bulan agustus dan penurunan 100% di bulan september Karena rata-rata pasien menggunakan penjamin	Peningkatan jumlah pasien selama 3 bulan terakhir banyak terjadi di bulan juli peningkatan di setiap bulannya yaitu 291 dan mengalami penurunan dui bulan agustus

		2025 Sebesar 1,7%	Dikarenaka n pasien sudah memiliki BPJS semua		BPJS	sebanyak 15% yaitu 254 Serta mengalami seddikit penurunan lagi di bulan September sebanyak 1,2%
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Mempromosikan RS prima Husada Melalui media Sosial				

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap 2,3,4 A

3.1.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli - September 2025)

NO	HAL	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	227	230	182	↓ 20,86 %
2	JKK	29	16	26	↑ 62,5 %
3	Umum	3	9	4	↓ 55,55 %
4	Asuransi Lain	3	1	1	↓ 100 %
5	JR	2	1	1	↓ 100 %
Total Pasien		264	257	214	↓ 16,73 %



3.1.1.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No	Bulan	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	Umum	JKK	JR/Asuransi	
1	Analisis capaian Septemb er 2025	Pasien BPJS mengalami penurunan pada bulan September 2025 sebesar 20,86 %	Pasien Umum mengalami penurunan di bulan September 2025 yaitu sebanyak 55,55 %	Pasien JKK mengalami kenaikan pada bulan September 2025 yaitu sebanyak 62,5 %	Jumlah Pasien JR pada bulan September sama sengan bulan Agustus yaitu sebanyak 1 pada pasien	Penurunan jumlah pasien terjadi di bulan September 2025 dengan jumlah pasien sebanyak

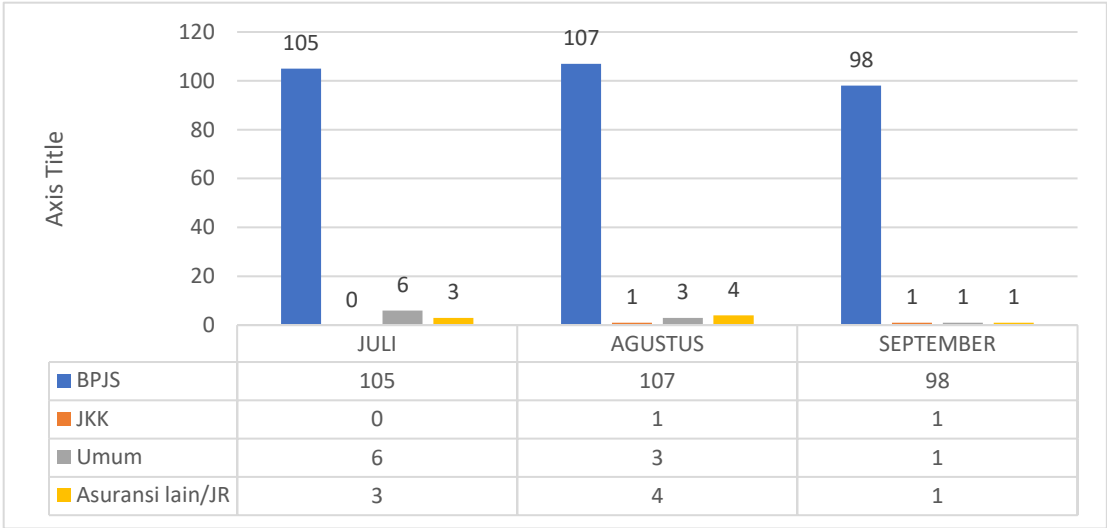
					asuransi dan 1 pada pasien JR.	16,73 %
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif				

3.1.1.3 Kunjungan Rawat Inap 5C

3.1.1.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli – September 2025)

NO	HAL	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	105	107	98	↓9%
2	JKK	0	1	1	0%
3	Umum	6	3	1	↓67%
4	Asuransi Lain	3	4	1	↓21%
Total Pasien		114	115	101	↓27%

3.1.1.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli - September 2025)



3.1.1.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No	Bulan	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	Umum	JKK	JR/Asuransi	
1	Analisis capaian Juli 2025	Total Pasien BPJS mengalami kenaikan sebanyak ↑3,80% dari bulan sebelumnya	Total Pasien Umum sama dengan jumlah kunjungan bulan sebelumnya	Pasien JKK tidak mengalami penurunan maupun peningkatan ↓100% dari bulan sebelumnya	Pasien Asuransi / JR mengalami peningkatan sebanyak ↑33% dari bulan sebelumnya	Pada bulan Juli untuk total kunjungan pasien mengalami Peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar ↑3,50%

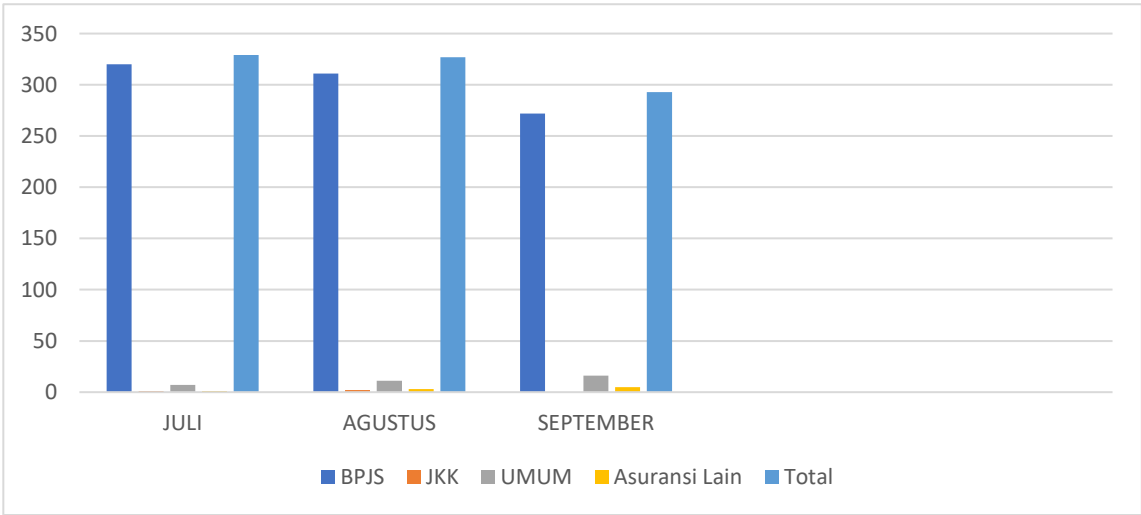
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya				
2	Analisis capaian Agustus 2025	Total Pasien BPJS mengalami kenaikan sebanyak ↑0,01% dari bulan sebelumnya	Total Pasien Umum mengalami penurunan ↓50% dari kunjungan bulan sebelumnya	Pasien JKK tidak mengalami penurunan maupun peningkatan ↓100% dari bulan sebelumnya.	Pasien Asuransi / JR mengalami peningkatan sebanyak ↑25% dari bulan sebelumnya	Pada bulan Agustus untuk total kunjungan pasien mengalami Peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar ↑0.86%
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya				
3	Analisis capaian September 2025	Total Pasien BPJS mengalami penurunan sebanyak ↓9% dari bulan sebelumnya	Total Pasien Umum sama dengan kunjungan bulan sebelumnya	Pasien JKK tidak mengalami penurunan ↓67% dari bulan sebelumnya.	Pasien Asuransi / JR mengalami penurunan sebanyak ↓21% dari bulan sebelumnya	Pada bulan September untuk total kunjungan pasien mengalami Peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar ↓27%
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya				

3.1.1.4 Kunjungan Rawat Inap 6, 7, 8 A

3.1.1.4.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juni – Agustus 2025)

NO	PENJAMIN	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	320	311	272	↓12,5%
2	JKK	1	2	0	↓ 100%
3	Umum	7	11	16	↑ 45.45
4	Asuransi Lain	1	3	5	↑ 66,6%
Total Pasien		329	327	293	↓ 10,3%

3.1.1.4.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli– September 2025)



3.1.1.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

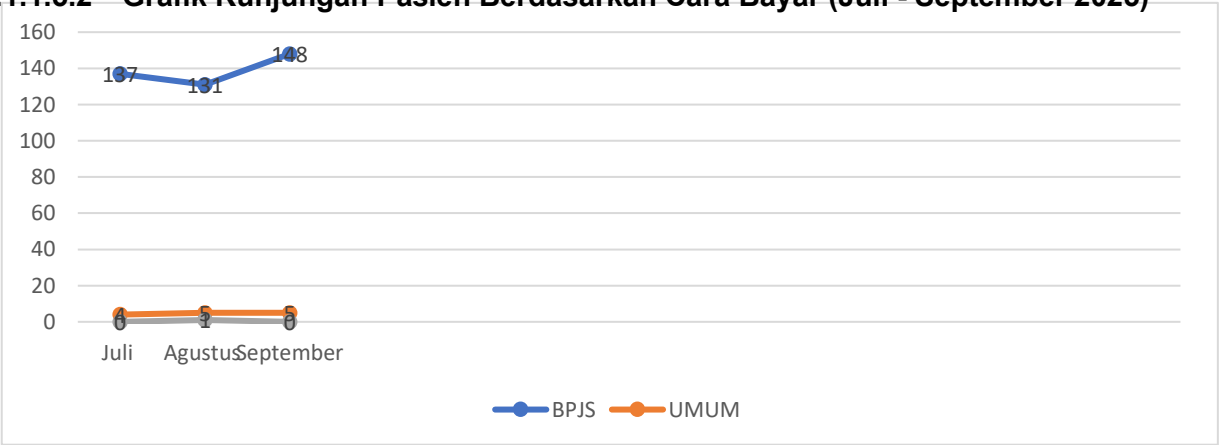
No	Bulan	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	Umum	JKK	JR/Asuransi	
	Analisis pencapaian jumlah pasien 3 bulan terakhir	Pasien BPJS mengalami terjadi peningkatan pada bulan Juli 2025 yaitu sebanyak 320 pasien	Pasien Umum mengalami penurunan pada bulan Juli 2025 yaitu sebanyak 7 pasien	Tidak ada pasien JKK pada bulan September 2025	Jumlah pasien Asuransi / JR mengalami peningkatan pada bulan September 2025	Penurunan jumlah pasien selama 3 bulan terakhir banyak pada bulan Juli dengan jumlah pasien sebanyak 293 pasien.
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Meningkatkan MOU dengan perusahaan				

3.1.1.5 Kunjungan Rawat Inap Maternitas

3.1.1.5.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli - September 2025)

NO	HAL	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	137	131	148	↓9,75%
2	Umum	4	5	5	37,5%
3	Asuransi	0	1	0	100%
Total Pasien		143	137	153	12,06%

3.1.1.5.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli - September 2025)



3.1.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No	Bulan	RAWAT INAP			Kesimpulan
		BPJS	Umum	JR/Asuransi	
1	Analisis capaian Bulan Juli-September	Pasien BPJS pada bulan September mengalami kenaikan 0,11%	Pasien umum pada bulan September Sama dengan bulan sebelumnya	Tidak ada Pasien Asuransi pada bulan September	Kunjungan naik dengan bulan sebelumnya. Selalu melakukan Upaya peningkatan
2	RTL	Meningkatkan	Meningkatkan	Meningkatkan	

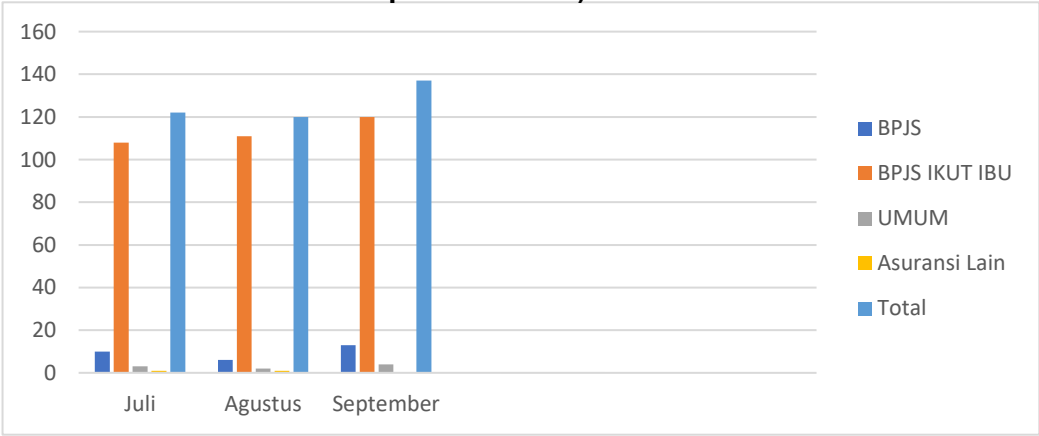
		pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan	pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan	pelayanan serta koordinasi dengan tim IGD	dan evaluasi program telusur sederhana
--	--	---	---	---	--

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap Neonatologi

3.3.2.7.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli - September 2025)

NO	HAL	TARGET/BULAN	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	7	10	6	13	↑9,5%
2	Umum	2	3	2	4	↑2,9%
3	Asuransi Lain	1	1	1	0	= 0%
4	BPJS IKUT IBU	100	108	111	120	↑87,6%
Total Pasien		110	122	120	137	↑14,2%

1.3.2.7.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Juli - September 2025)



3.3.2.7.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No	Bulan	Rawat Inap				Total Pasien
		BPJS	UMUM	ASURANSI	BPJS IKUT IBU	
1	Juli 2025	10	3	1	108	122
	Analisa	Untuk pasien BPJS mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 1,64%	Untuk pasien Umum mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 2,46%	ada 1 pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami kenaikan 90,2%	
	RTL	Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Bekerjasama dengan IGD untuk promosi kesehatan	Meningkatkan pelayanan khususnya pada pasien bayi baru lahir, Koordinasi dengan tim Maternitas dan poli untuk promosi Kesehatan ibu dan bayi melalui senam	

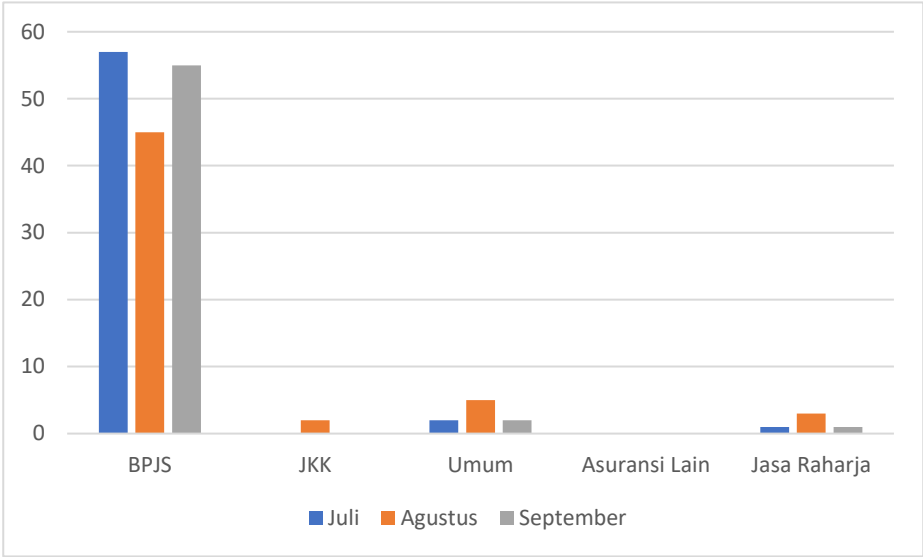
					hamil.	
2	Agustus	6	2	1	111	120
	Analisa	Untuk pasien BPJS mengalami penurunan dengan bulan sebelumnya sebanyak 3,33%	Untuk pasien Umum mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 0,83%	ada 1 pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami kenaikan 2,5%	
	RTL	Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Bekerjasama dengan IGD untuk promosi kesehatan	Meningkatkan pelayanan khususnya pada pasien bayi baru lahir, Koordinasi dengan tim Maternitas dan poli untuk promosi Kesehatan ibu dan bayi melalui senam hamil.	
3	September	13	4	0	120	137
		Untuk pasien BPJS mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 9,5%	Untuk pasien Umum mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 2,9%	Tidakada pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami kenaikan 87,6%	
		Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Bekerjasama dengan IGD untuk promosi kesehatan	Meningkatkan pelayanan khususnya pada pasien bayi baru lahir, Koordinasi dengan tim Maternitas dan poli untuk promosi Kesehatan ibu dan bayi melalui senam hamil.	

3.1.2 Intensive Care Unit (ICU)

3.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli - September 2025)

NO	PENJAMIN	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	57	45	55	↑0,22%
2	JKK	0	2	0	↓100%
3	Umum	2	5	2	↓0,6%
4	Asuransi Lain	0	0	0	tetap
5	JR	1	1	1	↓0,6%
Total Pasien		60	55	58	↑0,05%

3.1.1.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli - September 2025)



3.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

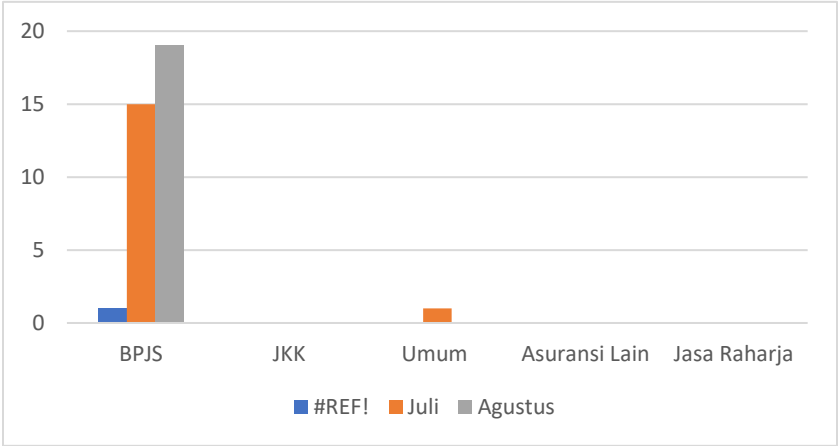
NO.	BULAN	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan September 2025 mengalami kenaikan 0,22% dibandingkan bulan sebelumnya	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan bulan September dibandingkan dengan bulan sebelumnya	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir tidak ada pasien 0	Pasien JR/ Asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan September 2025 ada 1 kunjungan,	Kunjungan pasien rawat inap ICU RS Prima Husada mengalami kenaikan sebesar 0,05% dibandingkan dari bulan sebelumnya karena pasien yang perawatan di ruang ICU adalah sebagian pasien jantung
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama ICU 3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat 5. Meningkatkan kualitas SDM yang ada di ICU				

3.1.2 High Care Unit (HCU)

3.1.2.2 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli - September 2025)

NO	HAL	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	15	19	13	↓0,31%
2	JKK	0	0	0	Tetap
3	Umum	1	0	1	↑100%
4	Asuransi Lain	0	0	0	Tetap
5	JR	0	0	0	Tetap
Total Pasien		16	19	14	↓0,26%

3.1.1.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli - September 2025)



3.1.2.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

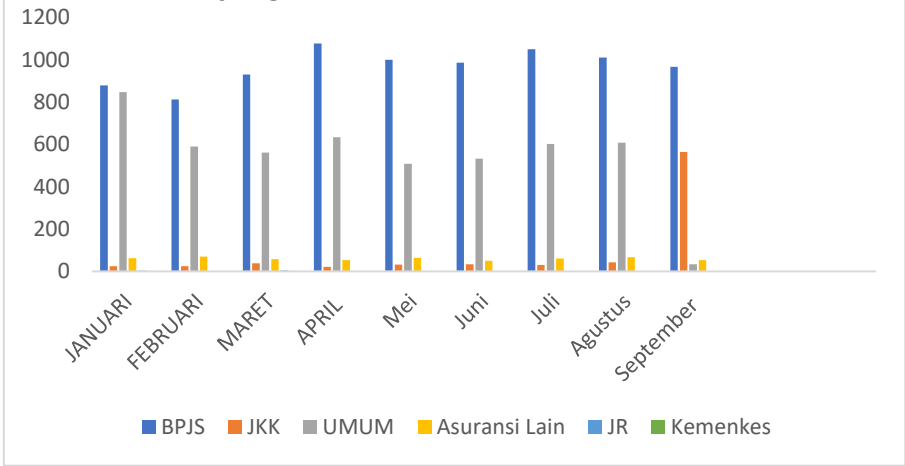
NO.	BULAN AGUSTUS	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil, untuk bulan Septmber 2025 mengalami penurunan di bandingkan bulan lalu	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan September 2025 mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya	Tidak ada pasien JKK selama 3 bulan	Pasien JR/ Asuransi bulan Septmber 2025 tidak ada pasien	Kunjungan pasien rawat inap HCU RS Prima Husada tetap dari bulan sebelumnya
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama HICU 3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat				

3.1.3 Instalasi Gawat Darurat (IGD)

3.1.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Juli - September 2025)

NO	HAL	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	1050	1010	967	↓4,25%
2	JKK	603	608	565	↓ 7,07 %
3	Umum	30	42	34	↓19,04%
4	Asuransi Lain	61	67	54	↓ 19,04%
5	JR	0	0	0	0%
Total Pasien		1.744	1727	1602	↓7,23%

3.1.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara 2025



3.1.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No	BULAN	INSTALASI GAWAT DARURAT					
1	September	BPJS	UMUM	JKK	ASURANSI	JR	TOTAL PASIEN
	Analisis	Kunjungan pasien BPJS di IGD menurun dibandingkan bulan agustus 2025 banyaknya rujukan dari luar yang di tolak terkait fasilitas dan untuk kunjungan menurun,pe nurunan ini juga di sebabkan banyaknya pendingan pasien TF sehingga membatasi pasien terkait TF	Kunjungan pasien UMUM di IGD mengalami penurunan paling tajam .7%	JKK mencatat penurunan paling tajam (masing-masing sekitar 19%), menunjukkan kemungkinan penurunan rujukan dari perusahaan/i nstansi atau masalah administratif/ asuransi.	Asuransi Lain mencatat penurunan paling tajam (masing-masing sekitar 19%), menunjukkan kemungkinan penurunan rujukan dari perusahaan/i nstansi atau masalah administratif/ asuransi.	Tidak ada pasien dari jenis ini selama tiga bulan berturut-turut → perlu dikaji apakah layanan ini masih aktif atau kurang diketahui oleh pasien.	□ Terjadi penurunan total kunjungan pasien sebesar 7,23% dari Juli ke September. □ Penurunan ini bisa mencerminkan faktor musiman, perubahan kebijakan, atau faktor eksternal lain seperti cuaca, libur panjang, atau isu kepercayaan pasien. 0,9 %
	RTL	Meningkatk an capaian kunjungan jaminan pasien BPJS IGD bekerjasama dengan marketing untuk menambah kerja sama	Memperta hankan dan meningkat kan capaian kunjungan IGD dengan jaminan UMUM dengan	Mempertaha nkan dan meningkatka n capaian kunjungan IGD jaminan JKK dengan berkoordinas i dan bekerjasama dengan marketing	Meningkatka n capaian kunjungan jaminan Asuransi swasta IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama	Meningkatk an capaian kunjungan jaminan JR IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan memperbaiki pelayanan dan bekerjasama dengan pihak terkait (marketing, asuransi centre)

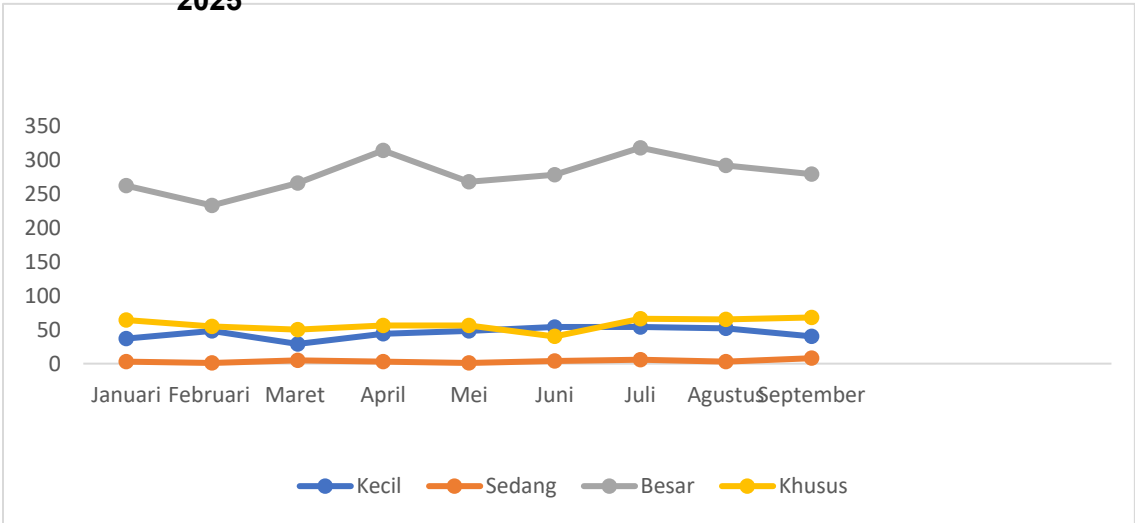
		dengan beberapa faskes I area kabupaten Malang	memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan maksimal	untuk memperluas kerjasama dengan beberapa Perusahaan Kabupaten Malang	dengan perusahaan asuransi	perusahaan asuransi	
--	--	--	--	--	----------------------------	---------------------	--

3.1.4 Instalasi Kamar Operasi (IKO)

3.1.4.1 Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Juli - September 2025)

NO	HAL	JULI 2025				AGUSTUS 2025				SEPTEMBER 2025			
		k	s	k	s	k	s	k	s	k	s	b	kh
1	BPJS	52	4	52	4	49	3	278	29	40	8	269	31
2	JR	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	1	3
3	Umum	2	0	2	0	1	0	5	6	0	0	5	9
4	Asuransi Lain	0	0	0	0	2	0	6	3	0	0	2	2
5	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BPJS TK	0	0	0	0	0	0	2	22	0	0	2	23
	Total Pasien	444				412				395			

3.1.4.2 Grafik Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin 2025



3.1.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No.	BULAN	Instalasi Kamar Operasi			
1	September	Kecil	Sedang	Besar	Khusus
	Analisis	Jumlah pasien mata dibagi setiap bulannya jadi jika tidak ada kendala jumlah pasien operasi kecil relative tetap namun di bulan September DPJP sempat sakit sehingga pasien operasi kecil ditunda	Pasien Iridectomy meningkat	Pasien cito dari IGD tidak sebanyak bulan sebelumnya, jumlah pasien loadingan dari poli juga menurun	Jumlah pasien urologi dan jkk meningkat.

	RTL	Tingkatkan capaian dengan mengawal pasien-pasien yang menunda dilakukan tindakan	Meningkatkan capaian dengan sosiali ke pihak luar tindakan apa saja yang dapat di lakukan di IKO RSPHM	Memilah pasien-pasien di IGD yang benar-benar bisa dilakukan tindakan di sini agar dikerjakan di sini dan tidak dirujuk	Pertahankan capaian dengan memberikan pelayanan kepada pasien agar pasien-pasien kecelakaan kerja tetap dibawa ke RSPHM.
--	-----	--	--	---	--

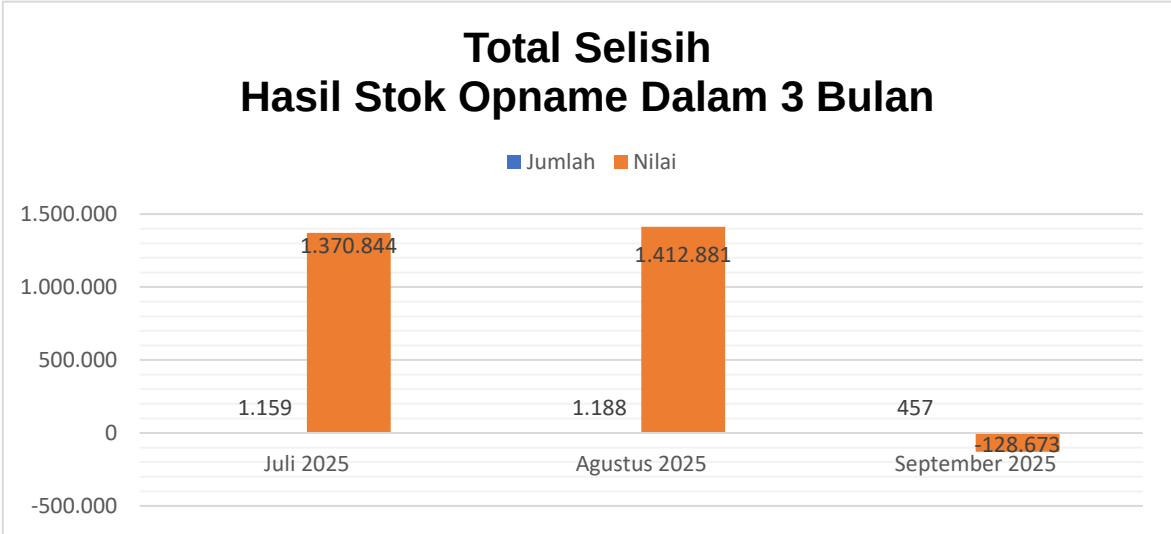
3.2 Kinerja Bidang Penunjang

3.2.1 Instalasi Farmasi

3.2.1.1 Tabel Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Juli- September 2025

UNIT	STOK	JULI 2025		AGUSTUS 2025		SEPTEMBER 2025	
		JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI
GUDANG	Fisik	781.394	1.348.925.757	804.320	1.583.025.196	752.721	1.527.749.098
	Sistem	781.394	1.348.925.757	804.620	1.583.511.196	752.621	1.527.722.972
	Selisih	0	0	-300	-486.000	+100	+26.126
DEPO FARMASI	Fisik	185.996	594.215.843	225.591	610.008.889	288.883	680.780.122
	Sistem	184.837	592.844.999	224.104	608.110.008	288.526	680.934.921
	Selisih	+1.159	+1.370.844	+1.488	+1.898.881	+357	-154.799
IKO	Fisik	2.270	86.545.010	2.624	100.070.771	2.548	93.388.930
	Sistem	2.270	86.545.010	2.624	100.070.771	2.548	93.388.930
	Selisih	0	0	0	0	0	0
Total Selisih		1.159	+1.370.844	+1.188	+1.412.881	+457	-128.673

3.2.1.2 Grafik Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Juli- September 2025



3.2.1.3 Analisis dan Tindak Lanjut

NO	ANALISIS	RENCANA TINDAK LANJUT
Gudang Farmasi : Dari tabel 3.1 tampak bahwa hasil stok opname masih sangat jauh dari target (0) yaitu sebesar Rp +26.126 , hal ini disebabkan karena :		
1	Penandaan nama pada rak sudah tertata dan kartu stok sudah berjalan	Supervisi secara berkala
2	Kode barang F04900 Handscoon non steril s - safeglove/onemed selisih lebih 100 pcs (1 Box) dikarenakan permintaan BMHP unit sudah di release namun tidak diambil oleh unit.	1. Penggunaan scan barcode atau RFID dalam proses serah terima barang → follow up ke programmer terkait dengan program scan. 2. Pelaksanaan double check oleh petugas gudang dan unit.

		3. Dilakukan retur barang unit jika tidak diambil oleh unit.
Depo Farmasi : Dari tabel 3.1 tampak bahwa hasil stok opname masih sangat jauh dari target (0) yaitu sebesar Rp -154.799 , hal ini disebabkan karena :		
1	Ketidaksesuaian dalam proses INPUT (tidak menulis perubahan jumlah di resep) dan SIAP menyebabkan kesalahan dalam jumlah obat yang disiapkan, yang seharusnya dapat dihindari dengan melakukan double check dengan penerima obat.	1. Double check wajib di lakukan dengan alur kerja ISEP obat yang sudah di tentukan. 2. Supervisi oleh kains farmasi terkait penyiapan obat hingga alur penyerahan secara berkala. 3. Monitoring dan evaluasi oleh Kabid Jangmed terkait dengan proses Input hingga penyerahan obat. Jika ada kesalahan dalam proses langsung di tegur dan langsung diperbaiki.
2	Ketidaksesuaian antara barang yang diambil perawat IGD menggunakan resep manual dengan inputan resep di SIMRS, seperti : F04724 dermafix s iv 6x7cm - onemed = +26 F03302 iv cannula plus no 18 - hospitech = -8 F01495 jarum 18 g x 1½" (precision glide) – bd = -1 F01642 masker nebulizer set anak - onemed = +1 F04803 masker nebulizer set dewasa - safelock = +1 F02191 wing needle no 27 - onemed = +1 F04697 cairan inf rl 500 ml - satoria = +1	1. Penegasan kembali kepada perawat IGD terkait kewajiban penulisan resep yang sesuai → kolaborasi dengan Karu IGD. 2. Petugas farmasi wajib double crosscheck sebelum obat atau BMHP di serahkan dan supervisi oleh kains farmasi. 3. Perbaiki alur resep akan diarsipkan oleh Petugas Farmasi dan dilakukan double crosscheck, jika ada yang belum terinput maka akan dishare di Grup dan meminta bukti inputan.
3	Ketidaksesuaian antara inputan resep dan barang yang diberikan disebabkan perbedaan nama barang sama namun beda pabrik atau beda ukuran yang digunakan, seperti: F00425 lafalos cr 20 g – sanbe = -9 F00426 lafalos cr plus 20 g – sanbe = +10	1. Memperbaiki sistem pengeluaran barang dari gudang ketika ada nama barang sama namun beda pabrik dengan memastikan stok depo dihabiskan terlebih dahulu sebelum dinonaktifkan. 2. Sosialisasi kepada perawat perbaikan fitur pencarian dalam SIMRS untuk meningkatkan akurasi pemilihan barang. 3. Memperbaiki sistem penyiapan barang bertanggungjawab atas input penjualan.
4	Selisih lebih terjadi karena proses retur ODD harian yang tidak optimal dari rawat inap (Resep ODD harian tidak diinput retur di SIMRS oleh perawat IRNA sementara pasien sudah KRS).	1. Dilakukan pemahaman kembali proses return sesuai alur dan dilakukan supervisi berkala oleh Karu IRNA dan PJ Shift ruangan untuk mengontrol terkait proses return ke farmasi sesuai dengan alur yang sudah di sepakati 2. Melakukan double crosscheck oleh petugas farmasi saat akan melakukan return di supervisi setiap hari oleh kains farmasi 3. Melakukan audit dan evaluasi berkala oleh Kabid keperawatan dan Kabid penunjang terkait obat-obatan yang belum tereturn sesuai dengan alur
5	Pengeluaran stok obat untuk IGD yang terus berjalan saat stock opname, sehingga menyulitkan proses verifikasi dan perhitungan ulang yang menyebabkan tidak tercatatnya pengeluaran di lembar kerja. F01475 infusion set dewasa y set - otsuka = -4 F01500 jarum 25 terumo - terumo = -1 F01504 jarum neolus 23 g x 1¼" - bd = -7	1. Evaluasi alur rekapan barang yang keluar saat perhitungan stok opname. Tunjuk satu PJ untuk proses keluar barang saat SO berjalan.

	F01505 jarum neolus 25 g x 1" - bd = -5	
IKO : Dari tabel 3.1 tampak bahwa hasil stok opname mencapai target (0). Analisa :		
1	Perawat patuh melakukan input resep; retur penjualan barang yang tidak terpakai sudah rutin dilakukan; tidak ada anomali data di SIMRS	Supervisi secara berkala

3.2.1.4 Tabel Daftar Obat-obat Near ED <6 bulan (September 2025 - Maret 2026)

No.	Kode	Nama Barang	Satuan	Harga Beli	Tgl. Expired	No. Batch	Jumlah Fisik Baik			Total Harga	Laporan Penjualan Mar 24 - Ags 25
							Juli	Agt	Sep		
1.	F01400	Foley cath silicon no 8 - rusch	Pcs	222.000	30/08/2025	KME20B1263	7	7	7	1.554.000	5
2.	F01337	Dj stent 6 fr close end - medika	Pcs	280.000	30/09/2025	76122032	10	10	10	2.800.000	21
3.	F01394	Foley cath silicon no 10 - rusch	Pcs	110.000	30/09/2025	KME20K3008	3	3	3	330.000	4
4.	F01680	Nelaton cath no 12 - rusch	Pcs	16.500	30/09/2025	KMA2030441	1	1	1	16.500	1
5.	F00586	Oxoferin sol 30 ml - pharos	Btl	80.500	30/10/2025	B3K953C	6	3	2	161.000	15
6.	F01390	Foley cath no 20 - rusch	Pcs	20.570	30/11/2025	P20L04	22	22	22	452.540	18
7.	F00176	Cendo pantocain 2% - cendo	Flash	13.250	30/01/2026	3p30117	5	4	3	39.750	16
8.	F01395	Foley cath silicon no 12 - rusch	Pcs	77.000	30/01/2026	KME21B1823	19	19	19	1.463.000	3
9.	F00558	Obat suntik kb 1 - harsen (hibah)	Vial	0	30/01/2026	3A020100	0	38	28	0	146
10.	F04476	Susu dancow full cream 780 g (hibah) - nestle	Box	0	01/01/2026	12578064	57	33	21	0	87
11.	F00812	Vaksin vaxigrip tetra - sanofi	Vial	179.550	31/01/2026	5DA67D1	8	5	3	508.725	117
12.	F00111	Cairan inf gelafusal 500 ml - dextra medica	Flash	161.500	28/02/2026	823226	15	15	15	2.422.500	170
13.	F04628	Ethambutol tab 250 mg (hibah)	Tab	0	28/02/2026	T24D005	32	130	44	0	618
14.	F005	Nebacetin	Btl	23.000	28/02/2026	Y3B054	4	4	4	92.000	3

	14	powder 5 g - pharos			26	A					
15.	F008 23	Velcasma xr tab 250 mg - novell	Tab	1.800	28/02/20 26	26B194	128	95	60	108.000	799
16.	F009 68	Benang t-vio 2-0 v9 - triton	Pcs	83.000	01/03/20 26	2303046 0	12	13	12	996.000	61
17.	F013 82	Foley cath 3 way no 20 - rusch	Pcs	83.625	01/03/20 26	183430	16	22	10	836.250	31
TOTAL										7.819.321	

3.2.1.5 Analisis Obat Near ED < 6 bulan (Bulan September 2025 - Maret 2026)

No	Analisis	Tindak Lanjut
1	Rekap Near ED < 6 bulan (Bulan September 2025 - Maret 2026 karena obat dan alkes slow moving: 1. Foley cath silicon no 8 – rusch dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Penggunaan alat kesehatan slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 26/03/2024 dari distributor sejumlah 10 pcs. 2. Dj stent 6 fr close end – medika dimasukkan ke dalam ureter untuk mencegah atau menangani penyumbatan aliran urine dari ginjal. Penggunaan alat kesehatan slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 26/11/2024 dari distributor sejumlah 5 pcs. 3. Foley cath silicon no 10 – rusch dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Penggunaan alat kesehatan slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 17/01/2023 dari distributor sejumlah 10 pcs. 4. Nelaton cath no 12 – rusch, digunakan untuk kateterisasi kandung kemih jangka pendek. Penggunaan alat kesehatan slow moving. 5. Oxoferin sol 30 ml – pharos digunakan untuk luka terinfeksi, penyembuhan luka yang lambat sesudah traumatik atau sesudah operasi, ulkus decubitus, ulkus kaki kronis pada insufisiensi vena, ulkus dan luka akibat aliran darah arteri, ulkus diabetik, ganggren, luka bakar. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 27/02/2024 dari distributor sejumlah 3 botol. 6. Foley cath no 20 – rusch dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Faktur pembelian terakhir tanggal 24/09/2024 dari distributor sejumlah 10 pcs. Penerimaan alkes dengan ed < 1 tahun dari distributor. 7. Cendo pantocain 2% - cendo digunakan sebagai anestesi untuk meredakan nyeri pada mata selama operasi atau pemeriksaan mata. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 10/07/2023 dari distributor sejumlah 16 flash. 8. Foley cath silicon no 12 – rusch dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Penggunaan alat kesehatan slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 04/02/2023 dari distributor sejumlah 20 pcs. 9. Obat suntik kb 1 - harsen (hibah) sebagai obat KB. Penggunaan obat slow moving. Penerimaan hibah dari BKKBN dengan ed < 1 tahun pada tanggal 22/08/2025 sejumlah 40 vial. 10. Susu dancow full cream 780 g (hibah) – nestle. Penggunaan susu slow moving diberikan untuk pasien anak yang mengkonsumsi obat TB. Penerimaan hibah dari Dinkes Kabupaten Malang dengan ed < 1 tahun pada tanggal 16/10/2024 sejumlah 120 box. 11. Vaksin vaxigrip tetra – sanofi untuk mencegah penyakit Influenza yang disebabkan oleh 4 tipe virus influenza yaitu 2 tipe A dan 2 tipe B yang sangat mudah menular melalui air liur (droplet). Pembelian terakhir tanggal 23/08/2025 dari	1. Sediaan farmasi near ED akan dilakukan koordinasi dengan PHS jika barang lebih berjalan di PHS akan diberikan ke PHS untuk lainnya akan dilakukan koordinasi dengan DPJP untuk peresepan. 2. Membuat surat edaran ke DPJP untuk meresepkan obat/ alkes yang near ed. 3. Koordinasi dengan karu untuk menggunakan alkes yang near ed. 4. Koordinasi dengan PT. DPM untuk melakukan retur ke distributor. 5. Koordinasi dengan DPJP obat yang <i>death moving</i> di <i>stop order</i> dan dikeluarkan dari Formularium RS.

	distributor sejumlah 11 vial. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor karena adanya program harga promo dari PT. Sanofi dan penyediaan stok di RS untuk paket vaksin dengan harga promo. 12. Ethambutol tab 250 mg (hibah) digunakan untuk terapi TB paru yang resisten. Penggunaan susu slow moving diberikan untuk pasien anak yang mengkonsumsi obat TB. Penerimaan hibah dari Dinkes Kabupaten Malang dengan ed < 1 tahun pada tanggal 24/05/2025 sejumlah 224 tablet. 13. Nebacetin powder 5 g – pharos digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi kulit superfisial (permukaan) yang disebabkan oleh bakteri. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 16/06/2023 dari distributor sejumlah 5 botol. 14. Velcasma xr tab 250 mg – novel untuk mengatasi gejala mengi dan sesak napas pada penderita asma atau penyakit paru obstruktif kronis, termasuk bronkitis kronis dan emfisema. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 29/04/2024 dari distributor sejumlah 450 tablet. 15. Benang t-vio 2-0 v9 – triton digunakan untuk operasi. Penggunaan alat kesehatan slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 25/03/2023 dari distributor sejumlah 48 pcs. 16. Cairan inf kaen mg3 500 ml – otsuka digunakan untuk membantu pengobatan ketidakseimbangan karbohidrat dan elektrolit pada keadaan insufisiensi asupan makanan per oral, prosedur pembedahan, neonatologi, dan asidosis diabetikum. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 13/01/2025 dari distributor sejumlah 20 flash. Penerimaan obat dengan dengan ed < 1 tahun dari distributor. 17. Foley cath 3 way no 20 – rusch dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Penggunaan alat kesehatan slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 26/06/2024 dari distributor sejumlah 20 pcs.	
--	--	--

3.2.1.6 Managemen Resiko dan Aksi Mitigasi

No Risk	Divisi	Spesialis terkait	Pemilik Risk	Tipe Risk	Deskripsi Risk	Pengendalian yang sudah ada	Skor Risk Sebelumnya	Dampak	Kemungkinan	Status Perubahan Rating Risiko	Mitigasi yang sedang dijalankan	Target Penyelesaian	Target Skor Risk	Indikator Kunci Mitigasi	Rencana Review
1	Komite medik	Dokter/ Dokter spesialis	Pasien	Klinis	Kesalahan input e-resep	Kontrol dan supervisi	9	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	SPO penulisan dan input resep serta supervisi	Meninjau ulang setiap tahun terkait kompete

															nsi dokter
2	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Kesalahan penyiapan obat	Kontrol dan supervisi	14	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi serta pelatihan berkelanjutan	3 bulan - 6 bulan	6	SPO alur pelayanan resep rawat jalan dan resep pulang pasien rawat inap. Jumlah Tenaga Vokasi Farmasi/ apoteker terpenuhi sesuai dengan kebutuhan tenaga. Terdapat diklat dan motivasi kerja	Meninjau ulang kemamp uan dan kompete nsi petugas
3	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Kesalahan penulisan pada etiket obat	Kontrol dan supervisi	7	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	Motivasi dan kinerja petugas meningkat. SPO penulisan etiket di Instalasi Farmasi	Meninjau ulang kemamp uan dan kompete nsi petugas
4	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Obat tidak dilengkapi <i>expired date/ beyond use date</i>	Kontrol dan supervisi	7	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	Motivasi dan kinerja petugas meningkat. SPO penulisan etiket di Instalasi Farmasi	Meninjau ulang kemamp uan dan kompete nsi petugas

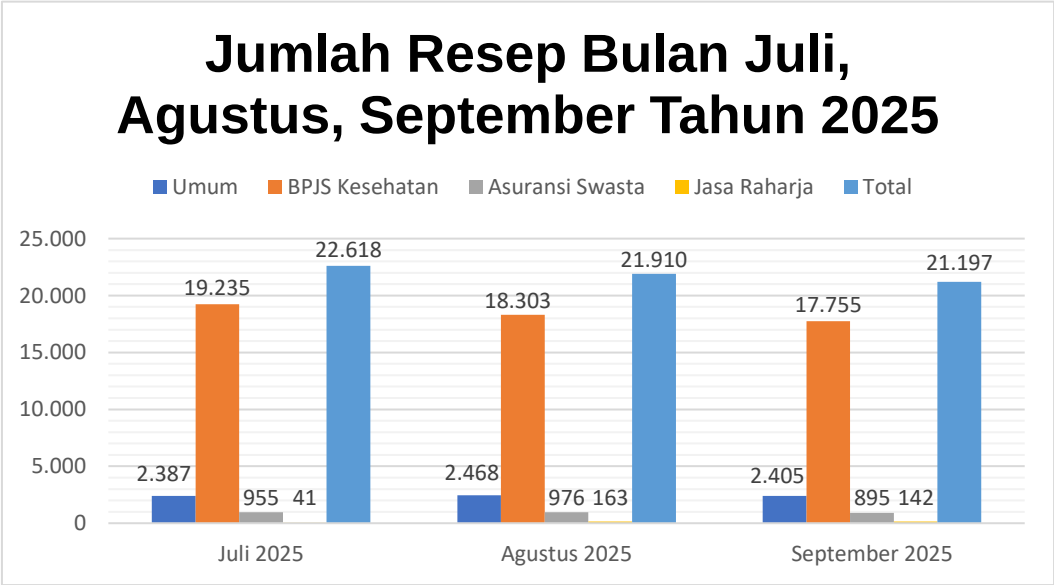
5	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Kesalahan identifikasi pasien	Kontrol dan supervisi	5	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	2	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemamp uan dan kompete nsi petugas
6	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Kesalahan pemberian obat pada pasien	Kontrol dan supervisi	14	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	SPO telaah obat, SPO verifikasi pemberian obat rawat inap. Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemamp uan dan kompete nsi petugas
7	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Insiden kelebihan/ kekurangan penyerahan obat pada pasien rawat jalan	Kontrol dan supervisi	5	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	3	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemamp uan dan kompete nsi petugas
8	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Insiden kelebihan/ kekurangan penyerahan obat pada pasien rawat inap	Kontrol dan supervisi	3	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	2	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemamp uan dan kompete nsi petugas
9	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Insiden reaksi alergi obat	Kontrol dan supervisi	11	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemamp uan dan kompete nsi petugas

10	IFRS	Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi	Pasien	Klinis	Insiden kesalahan dosis obat	Kontrol dan supervisi	8	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemamp uan dan kompete nsi petugas
----	------	--	--------	--------	------------------------------------	--------------------------	---	---------	----------------------	-------	--------------------------	----------------------	---	---	---

3.2.1.7 Tabel Jumlah Pelayanan Resep pada Bulan September 2025

No	Instalasi	Umum	BPJS Kesehatan	BPJS Ketenagakerjaan	Asurans i Swasta	Jasa Raharja	Total
1	Instalasi Rawat Inap						
	Jumlah Resep Obat Racikan	8	244	0	1	1	254
	Jumlah Resep Obat Jadi	317	6862	0	358	69	7606
	Jumlah Resep Obat	325	7106	0	359	70	7860
2	IGD						
	Jumlah Resep Obat Racikan	68	53	0	0	0	121
	Jumlah Resep Obat Jadi	716	1613	1	148	27	2505
	Jumlah Resep Obat	784	1666	1	148	27	2626
3	Instalasi Rawat Jalan						
	Jumlah Resep Obat Racikan	317	1534	0	0	0	1851
	Jumlah Resep Obat Jadi	953	6579	0	293	10	7835
	Jumlah Resep Obat	1270	8113	0	293	10	9686
4	IKO						
	Jumlah Resep Obat Racikan	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Resep Obat Jadi	26	870	0	94	35	1025
	Jumlah Resep Obat	26	870	0	94	35	1025
TOTAL		2405	17755	1	894	142	21197

3.2.1.8 Grafik Jumlah Pelayanan Resep pada Bulan Juli - September 2025



Analisis :

1. Kunjungan pasien Umum pada bulan September 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2025, dengan total resep yaitu : bulan Agustus 2025 sebanyak 2.468 resep umum dan bulan September 2025 sebanyak 2.405 resep umum.

2. Kunjungan pasien BPJS Kesehatan pada bulan September 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2025, dengan total resep yaitu : bulan Agustus 2025 sebanyak 18.303 resep BPJS Kesehatan dan bulan September 2025 sebanyak 17.755 resep BPJS Kesehatan.
3. Kunjungan pasien Asuransi Swasta dan Jasa Raharja pada bulan September 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2025, dengan total resep yaitu : bulan Agustus 2025 sebanyak 1.139 resep Asuransi Swasta dan Jasa Raharja, sedangkan bulan September 2025 sebanyak 1.037 resep Asuransi Swasta dan Jasa Raharja
4. Secara keseluruhan total resep pada bulan September 2025 mengalami penurunan, hal ini disebabkan untuk pasien rawat jalan adanya pembatasan kunjungan pasien per poli, adanya target PRB dimana pasien rujuk balik ke FKTP jika pasien sudah stabil, retur obat tertinggal rawat jalan yang tidak diambil pasien, kurangnya promo tarif vaksin di poli, kurangnya promo tarif poli sakura untuk poli lain, DPJP tidak praktek karena cuti; untuk pasien IGD ada batasan diagnosa yang tidak bisa di layani di FKRTL; untuk pasien rawat inap adanya batasan plafon BPJS Kesehatan sehingga tidak semua obat dapat di cover sesuai kebutuhan pasien dengan pertimbangan biaya obat.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Meningkatkan promosi tarif dan tindakan RS di sosial media RS agar kunjungan pasien meningkat.
2. Meningkatkan pelayanan resep yang tepat, cepat, dan akurat sehingga meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan di Farmasi. Evaluasi pelayanan ODD.
3. Mengajukan fitur cek hasil laboratorium dalam batas waktu 6 bulan dari IRNA dan IRJA untuk memudahkan pemberian obat sesuai dengan retriksi yang ditentukan.
4. Menciptakan inovasi pengembangan pelayanan pengantaran obat dengan penambahan jumlah driver.
5. Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan. Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru dan obat tertinggal.
6. Perubahan alur distribusi obat, petugas melebur menjadi satu. Penambahan petugas shift malam supaya tidak terjadi lembur menyelesaikan obat rawat jalan.
7. Penambahan admin IKO untuk focus pada mutase barang di Floorstok IKO.

3.2.1.9 Tabel Hasil Kinerja Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juli - September 2025

No	Kegiatan	Standard	Pencapaian			Keterangan
			Juli 25	Ags 25	Sept 25	
1	Pengkajian resep	100%	99.14%	99.01%	99,29%	Jumlah pengkajian resep yaitu Juli 2025 = 22.618 Agustus 2025 = 21.912 September 2025 = 21.197 Jumlah ketidaklengkapan penulisan resep yaitu Juli 2025 = 195 Agustus 2025 = 218 September 2025 = 151
2	Dispensing Sediaan Steril	100%	100%	100%	100%	Dispensing sediaan steril dilakukan oleh apoteker di ruang pencampuran obat steril.
3	Pemantauan Terapi Obat (PTO)	100%	100%	100%	100%	Form PTO sudah terlaksana dimana apoteker melakukan seleksi pasien berdasarkan kriteria PTO. Form PTO

						diletakkan dalam RM.
4	Kejadian Efek Samping Obat	0	0	0	0	Tidak ada kejadian pelaporan efek samping obat
5	Edukasi Obat pada pasien dan keluarga	100%	100%	100%	100%	Data berdasarkan rekam medis dan resep yang di ttd penerima obat
6	Konseling	100%	100%	100%	100%	Konseling sudah dilakukan apoteker dibuktikan dengan bukti edukasi di form edukasi (pasien rawat inap) dan ttd penerima obat di resep (pasien rawat jalan)
7	Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah	TDD	TDD	TDD	TDD	Tidak punya alat untuk pemantauan kadar obat dalam darah. TTD RS tipe C tidak wajib.
8	Visite Ronde Besar	100%	0%	0%	0%	Koordinasi dengan PPA (Professional Pemberi Asuhan) agar dilakukan visite ronde besar.
9	Visite Pasien/ Farmasi Klinik	100%	100%	100%	100%	Seluruh pasien rawat inap dilakukan visite mandiri dibuktikan dengan pengisian CPPT oleh apoteker di RM.
10	Pelayanan Informasi Obat (PIO)	100%	100%	100%	100%	Data berdasarkan map informasi obat, MIMS, aplikasi medscape
11	Obat tertinggal yang tidak diambil pasien	0	35	17	15	Obat tertinggal yang tidak diambil pasien dilakukan Penerimaan Hibah Lainnya ke gudang retur

3.2.1.10 Tabel Analisa dan Tindaklanjuti Hasil Kinerja Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada pada Bulan Juli - September 2025

KINERJA	ANALISA	TINDAKLANJUT
Pengkajian Resep	Penulisan resep yang lengkap bulan September 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2025, dengan prosentase resep yang tidak lengkap yaitu : bulan Agustus 2025 sebanyak 99.01% dan bulan September 2025 sebanyak 99.29%. Dari data di atas ditemukan pengkajian resep : - Dari segi telaah adminitrasi : sudah lengkap karena menggunakan e-resep melalui SIMRS. - Dari segi telaah farmasetik : ditemukan 218 resep dimana dokter salah input dosis dan jumlah obat, aturan dan cara penggunaan serta rute pemberian tidak lengkap terisi. - Dari segi telaah klinis : sudah terlaksana oleh apoteker karena jika ada interaksi obat langsung diberi jeda pemberian obat oleh apoteker.	- Koordinasi dengan tim SIMRS untuk membuat sistem jika resep tidak terinput dengan lengkap maka resep tidak dapat masuk ke Depo Farmasi. - Inputan resep harus dilakukan oleh dokter/ dokter spesialis yang kompeten dan berwenang mulai dari identitas pasien, nama obat, dosis, rute pemberian, waktu pemberian, nama dan tandatangan dokter (untuk resep manual). - Pelatihan penulisan resep untuk semua dokter dan dokter spesialis.

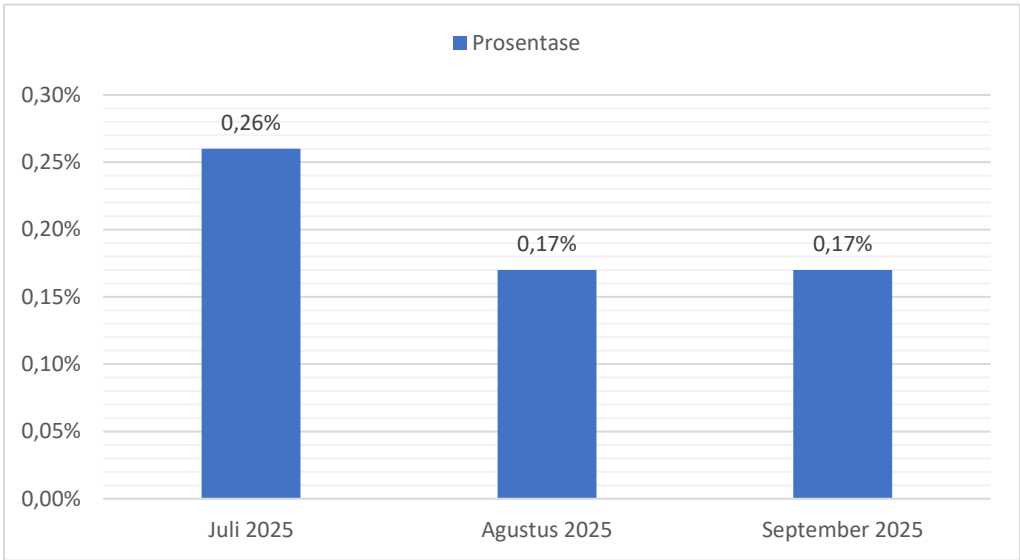
Kejadian Efek Samping Obat	- Hasil monitoring pelaporan MESO bulan Agustus 2025 tidak ditemukan terjadinya efek samping obat. - Kurangnya pelaporan kejadian efek samping obat oleh tenaga kesehatan.	- Kolaborasi dengan komite medik, kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis untuk sosialisasi pentingnya pelaporan kejadian efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD oleh tenaga kesehatan. - Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) dilaksanakan secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ditulis di dalam dokumen rekam medik pasien dan dilaporkan selambat - lambatnya 1 x 24 jam dalam bentuk laporan MESO dan dicatat dalam status pasien. - Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki (ESO). - Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO. - Menganalisa laporan ESO. - Mengisi formulir ESO (lihat di lembar pelaporan ESO). - Melaporkan ke Tim MESO dan ROTD.
Edukasi Obat Pada Pasien dan Keluarga	- Hasil supervisi dari rekam medis di rawat inap pada form edukasi bahwa apoteker sudah melakukan edukasi dibuktikan dengan ttd pasien/ keluarga di form edukasi. - Hasil supervisi dirawat jalan petugas farmasi sudah melakukan edukasi ke pasien dibuktikan dengan ttd penerima obat beserta KIE.	Supervisi berjenjang terkait pelaksanaan edukasi obat di rawat inap dan rawat jalan.
Pelayanan Informasi Obat (PIO)	PPA dapat mengakses Map informasi obat berisi : daftar dosis maksimal prorenata (jika perlu), daftar obat automatic stop order, daftar obat high alert update, daftar obat resiko jatuh, informasi cara pengenceran obat, informasi pembatasan resep, tabel rekonstitusi untuk pemberian intravena; MIMS; aplikasi Medscape di Nurse Station atau di Poli.	Map informasi obat, MIMS, aplikasi Medscape sudah tersedia di unit pelayanan
Obat Tertinggal Yang Tidak Diambil Pasien	Data obat tertinggal yang tidak diambil pasien bulan Agustus 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Juli 2025, dengan total resep yang di retur yaitu bulan Juli 2025 sebanyak 56 dan bulan Agustus 2025 sebanyak 17. Hal ini disebabkan beberapa pasien tidak mengetahui mendapatkan resep sehingga obat ditinggal dalam waktu 3x24 jam, keterlambatan penyiapan obat sehingga waktu tunggu obat lama, dan pasien tidak rutin minum obat sehingga obat kunjungan sebelumnya masih ada.	- Farmasi tiap hari menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal. - Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan. - Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru.

1.2.1.11 **Tabel Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Juli - September 2025**

No	Tanggal	Nama Obat	Golongan Obat	Distributor	Tindak Lanjut
1	1/7/2025-31/7/2025	Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
2	1/7/2025-31/7/2025	Methylelgometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Substitusi dengan Bledstop tab 0,125 mg

3	1/7/2025-30/7/2025	Itraconazole caps 100 mg	Anti fungi	PT. Tri Sapta Jaya	Tanpa saran substitusi
4	1/7/2025-4/7/2025	Divalproex sodium tab 500 mg	Anti konvulsan	PT. Parit Padang Global	Tanpa saran substitusi
Total prosentase Juli 2025 = 0.26%					
1	1/8/2025-31/8/2025	Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
2	1/8/2025-31/8/2025	Methylegometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
Total prosentase Agustus 2025 = 0.17%					
1	1/9/2025-30/9/2025	Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
2	1/9/2025-30/9/2025	Methylegometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
Total prosentase September 2025 = 0.17%					

1.2.1.12 Grafik Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Juli - September 2025



Analisis :

- Hasil monitoring ketersediaan obat selama 3 bulan ditemukan kekosongan di distributor karena kekurangan bahan baku, delisting produk (pabrik tidak produksi), stok di distributor habis, kekosongan produk originator, dan kosong nasional seperti Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg dan Methylegometrin tab 0,125 mg (paten dan generik) sehingga tidak tersedia di pabrik lain dengan kandungan yang sama.
- RS belum bisa melakukan pembelian lewat e-purchasing sehingga belum bisa order obat fast moving khusus obat kronis

Rencana Tindak Lanjut :

- Evaluasi mutu perjanjian kerjasama dengan distributor untuk memberikan konfirmasi apabila stok barang tidak tersedia di distributor setelah menerima pesanan dari RS.
- Mencari substitusi obat lain yang isi/ kandungannya sama.
- Evaluasi stok minimal depo farmasi dan Gudang farmasi serta alur pengadaan.
- RS sudah mempunyai akun e-purchasing dan koordinasi dengan pengadaan terkait e-purchasing.
- Memberitahukan info kekosongan obat di distributor ke DPJP melalui surat edaran beserta saran substitusi.

1.2.1.13 Tabel Pemusnahan Obat, BMHP/ Alat Kesehatan Rusak (Substandar), dan Recall Bulan September 2025

No	Kegiatan	Nama Obat/ BMHP/ Alat Kesehatan	Jumlah	Alasan	Keterangan
1	Pemusnahan Obat	-	-	-	Tidak ada pemusnahan
2	BMHP/ Alat Kesehatan Rusak (Substandar)	Sprit 50 cc lubang tengah – Onemed No. Batch : 31072588	Semua produk yang terpakai	1. Penggunaan sprit 50 cc LT – onemed mudah lepas dorongannya, suit seret, kaku, sehingga jika di tarik lebih kuat cairannya langsung muncrat. 2. Karena dorongan sprit seret dan harus di tarik kuat, bisa menyebabkan posisi jarum bergeser, dan jika sudah bergeser berpotensi cairan pungsi pleuranya macet dan tidak terambil.	Form keluhan alat kesehatan substandar dari dr. Catur Elvi, Sp.P dan dr. Andy, Sp.P dilaporkan tanggal 24/09/2025 sudah diajukan ke Pengadaan PT. Tindak lanjut : diganti barang dengan merk terumo
		Three way stopcock - Onemed	2 pcs	Three way patah setelah di buka dari bungkusnya. No. Batch : 02122488	Form keluhan alat kesehatan substandar dari ruang IGD dilaporkan tanggal 29/09/2025 sudah diajukan ke Pengadaan PT untuk diganti sejumlah yang patah.
3	Recall	-	-	-	Tidak ada recall

3.2.1.14 Tabel Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Farmasi Pada Bulan September 2025

No	Monitoring dan Evaluasi	Hasil	Tindak Lanjut
1	Perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP	Perencanaan dilakukan dengan metode konsumsi dan rumus VEN-ABC. Evaluasi terhadap perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP digudang farmasi menggunakan sistem ROP dan Non ROP farmasi di SIMRS, dikarenakan sistem ROP belum mendeteksi penjualan obat slow moving namun tetap harus disediakan jadi petugas mendata obat menipis secara manual kemudian diinput Non ROP farmasi	Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP menggunakan sistem ROP di gudang farmasi.
2	Pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP ke distributor	Pengadaan sediaan farmasi dan BMHP dengan pembelian langsung, repacking dan donasi/ hibah. Tersedia PKS dengan distributor; Semua pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, termasuk obat vaksin harus menjamin garansi keaslian yakni : a. Sediaan farmasi - No.Ijin Edar dari BPOM b. Alkes - No.Ijin Edar dari Dirjen Binfar dan CoA c. BMHP - No ijin edar dari Binfar d. B3 - MSDS; Kunjungan ke distributor; Surat Pesanan obat, alkes, dan BMHP di tandatangan oleh APJ	Monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP
3	Pemantauan suhu dan kelembaban	Form monitoring suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin sudah tersedia namun petugas masih tidak rutin mengisi.	Monitoring dan evaluasi pengisian monitoring suhu dan kelembaban

	ruangan serta suhu lemari pendingin		ruangan serta suhu lemari pendingin di depo dan gudang farmasi oleh apoteker setiap hari																								
4	Supervisi box emergency, trolley emergency, kit emergency, box HPP dan Eklamsi	Pengecekan obat dan alat kesehatan yang mendekati ED (<i>expired date</i>) 6 bulan segera diganti dilakukan tiap 3 bulan sekali. Bedah box triwulan 3 pada Bulan Juli Tahun 2025 sudah dilakukan. Berikut temuan obat yang mendekati ED 6 bulan dan diganti dengan ED jauh yaitu : <table><tr><th>No</th><th>Temuan obat near ED < 6 bulan</th><th>Pergantian obat near ED</th></tr><tr><td>1</td><td>Box emergency poli lantai 1: Clopidogrel Tab (5 tab) 1/26</td><td>Clopidogrel Tab (5 tab) 1/27</td></tr><tr><td>2</td><td>Box emergency poli treadmill: Amiodaron inj 8/26, Dobutamine inj 1/26, Atropin sulfat inj 11/26, Valisanbe inj 2/26, Clopidogrel tab 1/26, IV canul no. 20 1/26, Sput 1 cc 1/26</td><td>Amiodaron inj 1/27, Dobutamine inj 2/27, Atropin sulfat inj 9/27, Valisanbe inj 1/27, Clopidogrel tab 4/27, IV canul no. 20 4/29, Sput 1 cc 5/29</td></tr><tr><td>3</td><td>Box emergency poli lantai 2: Clopidogrel (5 tab) 1/26 Mannitol (1 flash) 1/26</td><td>Clopidogrel (5 tab) 3/27 Mannitol (1 flash) 1/27</td></tr><tr><td>4</td><td>Box emergency poli vaksin: Mannitol (1 flash) 1/26 Phenytoin inj (1 amp) 1/26 Diphenhydramine Inj (1 amp) 1/26 Furosemid (2 amp) 2/26</td><td>Mannitol (1 flash) 1/27 Phenytoin inj (1 amp) 1/28 Diphenhydramine Inj (1 amp) 1/27 Furosemid (2 amp) 12/26</td></tr><tr><td>5</td><td>Trolley emergency IGD: Amiodaron Inj (4 amp) 11/25</td><td>Amiodaron Inj (4 amp) 1/27</td></tr><tr><td>6</td><td>Box emergency infant Ponek IGD: Terfusion Terumo (1 pcs) 2/26 Dopamin Inj (1 amp) 2/26</td><td>Terfusion Terumo (1 pcs) 12/26 Dopamin Inj (1 amp) 12/26</td></tr><tr><td>7</td><td>Box HPP – Eklamsi IGD: MgSO4 20% (1 flash) 11/25</td><td>MgSO4 20% (1 flash) 9/26</td></tr></table>	No	Temuan obat near ED < 6 bulan	Pergantian obat near ED	1	Box emergency poli lantai 1: Clopidogrel Tab (5 tab) 1/26	Clopidogrel Tab (5 tab) 1/27	2	Box emergency poli treadmill: Amiodaron inj 8/26, Dobutamine inj 1/26, Atropin sulfat inj 11/26, Valisanbe inj 2/26, Clopidogrel tab 1/26, IV canul no. 20 1/26, Sput 1 cc 1/26	Amiodaron inj 1/27, Dobutamine inj 2/27, Atropin sulfat inj 9/27, Valisanbe inj 1/27, Clopidogrel tab 4/27, IV canul no. 20 4/29, Sput 1 cc 5/29	3	Box emergency poli lantai 2: Clopidogrel (5 tab) 1/26 Mannitol (1 flash) 1/26	Clopidogrel (5 tab) 3/27 Mannitol (1 flash) 1/27	4	Box emergency poli vaksin: Mannitol (1 flash) 1/26 Phenytoin inj (1 amp) 1/26 Diphenhydramine Inj (1 amp) 1/26 Furosemid (2 amp) 2/26	Mannitol (1 flash) 1/27 Phenytoin inj (1 amp) 1/28 Diphenhydramine Inj (1 amp) 1/27 Furosemid (2 amp) 12/26	5	Trolley emergency IGD: Amiodaron Inj (4 amp) 11/25	Amiodaron Inj (4 amp) 1/27	6	Box emergency infant Ponek IGD: Terfusion Terumo (1 pcs) 2/26 Dopamin Inj (1 amp) 2/26	Terfusion Terumo (1 pcs) 12/26 Dopamin Inj (1 amp) 12/26	7	Box HPP – Eklamsi IGD: MgSO4 20% (1 flash) 11/25	MgSO4 20% (1 flash) 9/26	Dilakukan supervisi oleh apoteker terhadap penyimpanan obat <i>emergency</i> dan segera diganti apabila dipakai, kedaluwarsa, atau rusak. Pelaksanaan supervisi dilakukan sebagai berikut : a. Pengecekan segel, pengecekan kedaluwarsa di list daftar obat dan pengecekan suhu penyimpanan dilakukan setiap hari. b. Pengecekan jumlah dan dipakai dilakukan saat segel terbuka. c. Pengecekan obat yang mendekati ED (<i>expired date</i>) 6 bulan segera diganti dilakukan tiap 3 bulan sekali untuk mencegah kedaluwarsa saat dibutuhkan.
No	Temuan obat near ED < 6 bulan	Pergantian obat near ED																									
1	Box emergency poli lantai 1: Clopidogrel Tab (5 tab) 1/26	Clopidogrel Tab (5 tab) 1/27																									
2	Box emergency poli treadmill: Amiodaron inj 8/26, Dobutamine inj 1/26, Atropin sulfat inj 11/26, Valisanbe inj 2/26, Clopidogrel tab 1/26, IV canul no. 20 1/26, Sput 1 cc 1/26	Amiodaron inj 1/27, Dobutamine inj 2/27, Atropin sulfat inj 9/27, Valisanbe inj 1/27, Clopidogrel tab 4/27, IV canul no. 20 4/29, Sput 1 cc 5/29																									
3	Box emergency poli lantai 2: Clopidogrel (5 tab) 1/26 Mannitol (1 flash) 1/26	Clopidogrel (5 tab) 3/27 Mannitol (1 flash) 1/27																									
4	Box emergency poli vaksin: Mannitol (1 flash) 1/26 Phenytoin inj (1 amp) 1/26 Diphenhydramine Inj (1 amp) 1/26 Furosemid (2 amp) 2/26	Mannitol (1 flash) 1/27 Phenytoin inj (1 amp) 1/28 Diphenhydramine Inj (1 amp) 1/27 Furosemid (2 amp) 12/26																									
5	Trolley emergency IGD: Amiodaron Inj (4 amp) 11/25	Amiodaron Inj (4 amp) 1/27																									
6	Box emergency infant Ponek IGD: Terfusion Terumo (1 pcs) 2/26 Dopamin Inj (1 amp) 2/26	Terfusion Terumo (1 pcs) 12/26 Dopamin Inj (1 amp) 12/26																									
7	Box HPP – Eklamsi IGD: MgSO4 20% (1 flash) 11/25	MgSO4 20% (1 flash) 9/26																									

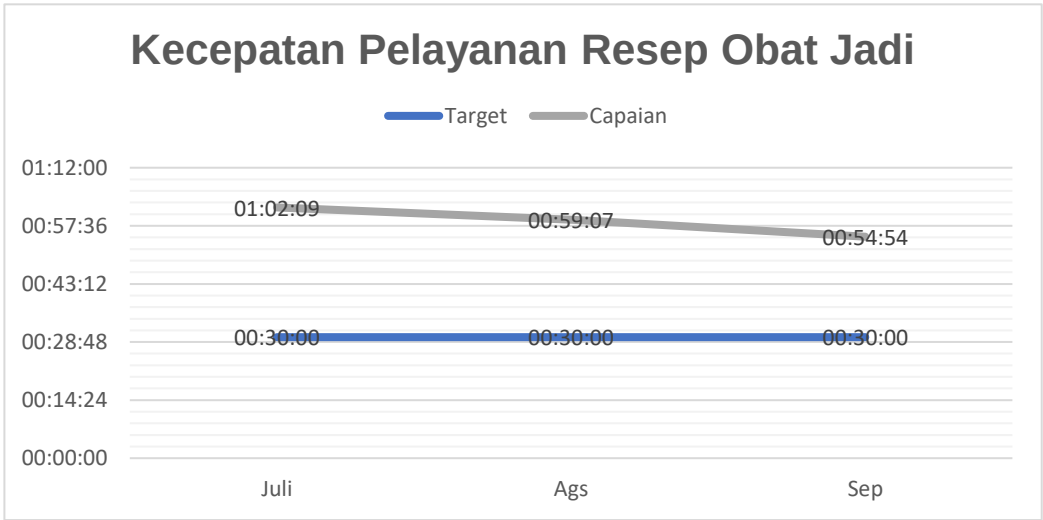
			Misoprostol tab (1 tab) 1/26	Misoprostol tab (1 tab) 12/26	
		8	Kit emergency IGD 1: Tidak ada obat near ED	-	
		9	Kit emergency IGD 2: Tidak ada obat near ED	-	
		10	Box emergency ambulance: Tidak ada obat near ED	-	
		11	Trolley emergency IKO: Tidak ada obat near ED	-	
		12	Box emergency infant IKO: Suction cath no. 8 12/25 Suction cath no.6 01/26	Suction cath no. 8 03/27 Suction cath no.6 12/27	
		13	Box HPP-Eklamsi IKO: Tidak ada obat near ED	-	
		14	Box emergency 2C: Amiodaron 06/26 Aspilet 06/26 Clopidogrel tab 06/26 Dexamethasone 06/26 Furosemide 05/26	Amiodaron 01/27 Nospirinal tab 04/27 Clopidogrel tab 01/27 Dexamethasone 03/27 Furosemide 12/26	
		15	Box emergency ICU: Dexamethason 06/26 Inzana 03/26 Furosemide 05/26	Dexamethason 03/27 Inzana 04/27 Furosemide 12/26	
		16	Box emergency ICU ventilator: Dexamethason 06/26 ISDN 05/26 Norepinephrin 04/26 Manitol 04/26	Dexamethason 03/27 Inzana 12/26 Norepinephrin 07/26 Manitol 01/27	
		17	Box emergency HCU: Amiodaron 06/26 Inzana tab 06/26 Clopidogrel tab 05/26 Dexamethason 05/26 Manitol 03/26 Infusion set dewasa 07/26	Amiodaron 01/27 Nospirinal tab 04/27 Clopidogrel tab 01/27 Dexamethason 03/27 Manitol 01/27 Infusion set dewasa 01/30	
		18	Box emergency 3C anak: Tidak ada obat near ED	-	
		19	Box emergency PICU Ventilator: Tidak ada obat near ED	-	

		20	Box emergency PICU: Tidak ada obat near ED	-	
		21	Box emergency 2A: Inzana 06/26 Amiodarone 06/26 Dexamethasone 04/26 Natrium phenytoin 02/26 Manitol 03/26	Inzana 04/27 Amiodarone 01/27 Dexamethasone 03/27 Natrium phenytoin 09/27 Manitol 01/27	
		22	Box emergency 3A: Tidak ada obat near ED	-	
		23	Box emergency 4A: Dexamethasone 04/26 Nospirinal tab 07/26 Phenytoin 03/26 Valisanbe 03/26 IV cannul no. 20 02/26 Manitol 03/26	Dexamethasone 03/27 Nospirinal tab 04/27 Phenytoin 09/27 Valisanbe 01/27 IV cannul no. 20 09/29 Manitol 01/27	
		24	Box emergency infant Maternitas: D10% 04/26 Sput 10cc Terumo 02/26 Dobutamin 01/26	D10% 11/26 Sput 10cc Terumo 01/30 Dobutamin 02/27	
		25	Trolley emergency Maternitas: Amiodaron 06/26 Nospirinal 06/26 Valisanbe 03/26 Furosemide 04/26 Clopidogrel tab 04/26	Amiodaron 01/27 Nospirinal 04/27 Valisanbe 01/27 Furosemide 12/26 Clopidogrel tab 01/27	
		26	Box emergency infant Perinatologi: D10% 07/26 Dobutamin 12/26 Dopamin 09/26 Infus Gelafusal 02/26 ETT uncuff no.2 02/26	D10% 11/26 Dobutamin 02/27 Dopamin 12/26 Infus Gelafusal 01/27 ETT uncuff no.2 08/29	
		27	Box emergency 5C: Amiodaron 06/26 Clopidogrel tab 10/26 Nospirinal 11/26 Furosemide 11/26 Dopamin 09/26	Amiodaron 01/27 Clopidogrel tab 11/27 Nospirinal 04/27 Furosemide 12/26 Dopamin 12/26	
		28	Box emergency 6A: Atropine 02/26 Dobutamin 12/26 Inzana tab 04/26 Furosemide 04/26 Natrium Phenytoin 06/26 Clopidogrel tab 06/26 Manitol 04/26	Atropine 09/27 Dobutamin 02/27 Nospirinal tab 04/27 Furosemide 12/26 Natrium Phenytoin 01/28 Clopidogrel tab 01/27 Manitol 01/27	
		29	Box emergency 7A:		

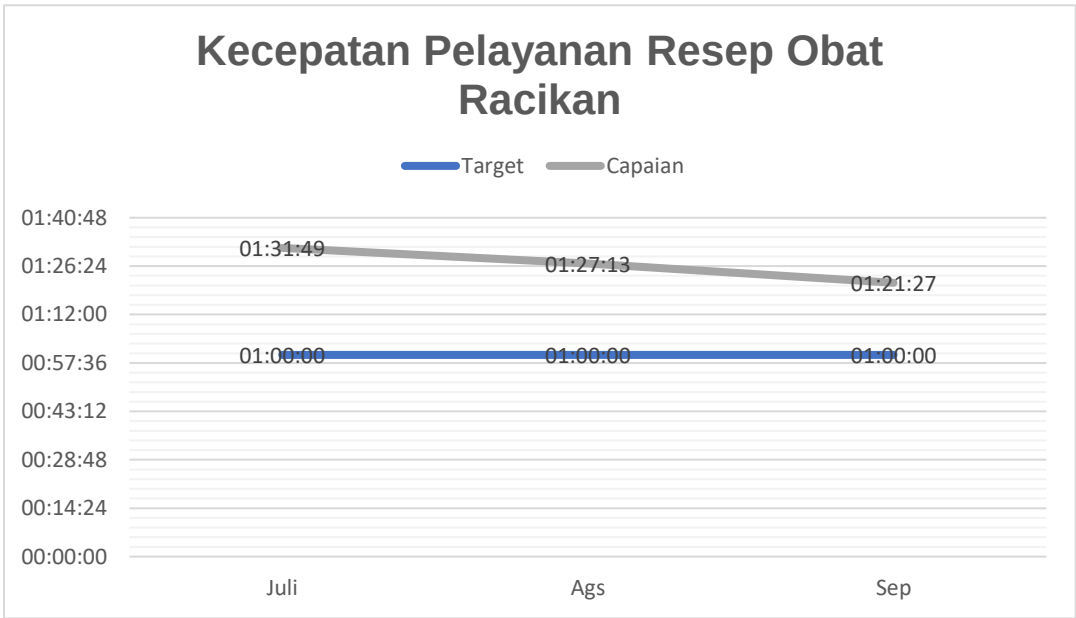
		Amiodaron 02/26 Dopamin 04/26 Inzana tab 04/26 Furosemide 04/26 Gelafusal 02/26 Manitol 04/26 30 Box emergency 8A: Hi-Oxy dewasa 01/26 31 Box emergency Radiologi: Tidak ada obat near ED	Amiodaron 01/27 Dopamin 12/26 Nospirinal tab 04/27 Furosemide 12/26 Gelofusan 01/27 Manitol 01/27 Hi-Oxy dewasa 04/29 -	
5	Kartu stok obat	Kepatuhan penulisan kartu stok 70% di depo farmasi, petugas masih merapel pengeluaran kartu stok dan belum menulis sisa stok. Kepatuhan penulisan kartu stok 100% di gudang farmasi.	- Supervisi petugas farmasi dalam melakukan pelayanan (barang masuk dan keluar) dengan tetap menuliskan pada kartu stok - Petugas lebih teliti ketika menghitung pemasukan atau pengeluaran.	
6	Penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3)	Penyimpanan bahan berbahaya dan beracun di ruangan terpisah dan didalam lemari B3 tersedia APAR dan diberi label B3 sesuai sifat dan risiko bahan.	Monitoring dan evaluasi terhadap penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3)	
7	Penyimpanan produk steril di unit	Ditemukan perawat menyimpan sisa infus NS 0.9% dan sisanya digunakan kembali besok hari (lebih dari 1x24 jam) sehingga melewati batas BUD.	Supervisi secara berkala dan edukasi ke perawat BUD produk steril tidak boleh lebih dari 3 jam	
8	Pelaksanaan double check untuk pemberian obat high alert	● Rawat inap : Double check obat dan bmhp resep ODD (One Daily Dose) dilakukan oleh farmasi sebelum distribusi ke ruangan rawat inap. Pelaksanaan double check obat high alert secara independen menggunakan resep dan daftar pemberian obat (DPO) antara farmasi dan perawat/ bidan. Perawat/ bidan penerima obat melakukan double check secara independen dengan PJ Shift/ kepala ruang menggunakan daftar pemberian obat (DPO) sebelum obat diserahkan/ disuntikkan ke pasien secara UDD (Unit Dose Dispensing). ● Rawat Jalan : Pelaksanaan double check obat high alert secara independen menggunakan resep antara petugas verifikasi dan petugas penyerah sebelum obat diserahkan ke pasien.	Supervisi secara berkala terkait pelaksanaan double check obat high alert di rawat inap dan rawat jalan	

3.2.1.16 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Rawat Jalan Bulan Juli, Agustus, dan September 2025

Grafik Pelayanan Resep Obat Jadi Bulan Juli – September 2025



Grafik Pelayanan Resep Obat Racikan Bulan Juli – September 2025



Analisis :

1. Kecepatan pelayanan resep obat jadi belum mencapai 100% dengan realisasi 00:54:54 dari target yang di tetapkan sebesar ≤ 30 menit.
2. Kecepatan pelayanan resep obat racikan belum mencapai 100% dengan realisasi 01:21:27 dari target yang di tetapkan sebesar ≤ 60 menit.
3. Waktu tunggu obat rawat jalan pada bulan September 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2025 dan belum mencapai target 100% dikarenakan:
 - DPJP tidak praktek karena cuti sehingga menyebabkan penumpukan kunjungan pasien pada saat hari berikutnya ketika DPJP praktek,
 - Pembatasan kunjungan pasien rawat jalan,
 - Penurunan angka keterlambatan obat di rawat jalan karena komposisi farmasi sudah lengkap (cuti melahirkan sudah masuk bekerja) dengan 5 apoteker rawat jalan, 25 Tenaga Vokasi Farmasi, dan 2 Admin Farmasi.

Rencana Tindak Lanjut:

- 1. Evaluasi kebijakan alur penyiapan sampai penyerahan obat ke pasien dan mengulang sosialisasi kebijakan alur penyiapan sampai penyerahan obat ke pasien.
- 2. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi dalam klik obat selesai maupun ambil obat, sehingga petugas farmasi diharapkan *real time* dalam pelaksanaannya.
- 3. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terkait alur pemberian obat kepada pasien, bahwa harus dihindari terjadi penumpukan obat yang telah siap diberikan.
- 4. Terdapat program pengantaran obat melalui Primantara sehingga mengurangi antrian pasien menunggu obat.
- 5. Petugas input dibagi menjadi resep kronis dan resep non kronis oleh Tenaga Vokasi Farmasi, resep iter dan PRB oleh apoteker.

1.2.1 Laboratorium

1.2.1.11Tabel Jumlah Pemeriksaan Laboratorium

	Target	Jul	%	Agt	%	Sep	(Persentase terhadap bulan sebelumnya)
HEMATOLOGI	1950	1813	>2,2 %	1817	>0,2%	1628	<10,4%
FAAL HEMOSTASIS	716	831	>11,7%	779	<6,2%	741	<4,8%
HEMATOLOGI LAIN	1	0	0%	0	0%	0	0%
URINALISIS	418	256	>29,6%	283	>9,5%	267	<5,6%
ANALISA FEACES	30	14	>42,8%	11	<21,4%	9	<18,1%
FUNGSI HATI	611	373	>14,7%	315	<15,5%	306	<2,8%
LEMAK DARAH	806	797	>9,9%	808	<1,3%	787	<2,5%
GINJAL HIPERTENSI	1394	1383	>13,4%	1401	<1,2%	1402	>0,07%
GULA DARAH	1187	1962	>21,8%	2115	>7,2%	1876	<11,3
JANTUNG	583	577	>4,332 %	545	<5,5%	497	<8,8%
ELEKTROLIT DAN BGA	334	235	>65,9%	164	< 30,2%	208	>21,1%
IMUNO SEROLOGI	481	469	>1,7%	425	<9,38%	266	>37,4%
REMATIK	6	3	<57,1%	5	>40%	3	>40%
ENDOKRINOLOGI	60	93	>11,8%	72	>22,5%	69	<4,1%
REPRODUKSI	44	26	<19,2%	92	>71,7%	86	<6,5%
MIKROBIOLOGI	32	43	<29,5%	46	>6,5%	54	>14,8%
Jumlah	8654	8875	< 12,8%	8878	>0,3%	8199	<7,6%

Analisis :

Jumlah Pemeriksaan Pada bulan September 2025 mengalami penurunan sebanyak 7,6%

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Proses pengembangan pelayanan dengan menggunakan LIS.
- 2. Perbaiki serah terima hasil laboratorium menggunakan system digital.

- Melakukan pencatatan keluar masuk stok reagen pada kartu stok dan dilakukan SO.
- Follow up pengadaan reagen yang lama kosong.
- Mengajukan pengadaan Laboratorium PA di RS Prima Husada Malang.
- Membuat kesepakatan batas akhir bacaan hasil PA dan follow up secara berkala kepada Dokter Penanggungjawab Patologi Anatomi.
- Mengajukan review tarif pemeriksaan laboratorium kepada Kepala Keuangan PT.

1.1.1.5 Tabel Pelaporan Kerusakan Sampel pada Bulan April - Agustus 2025

NO	NAMA PASIEN	NO RM	TANGGAL PENGAMBILAN SAMPEL	UNIT ASAL	SAMPEL YANG DITERIMA
Bulan April 2025					
1.	Abd Rohman	229923	18/04/2025	ICU	Sampel Vena BGA
2.	Aqilla Putri	160607	19/04/2025	IRNA 3C	Sampel Clotting
3.	Rochmad	102166	29/04/2025	IRNA 5C	Sampel Clotting
Bulan Mei 2025					
1.	Andara	224145	01/05/2025	IGD	Sampel Clotting
Bulan Juni 2025					
Tidak ditemukan sampel rusak					
Bulan Juli 2025					
1.	Kuseran	183848	16/07/2025	IGD	DL clotting
2.	Juri	069001	21/07/2025	IGD	DL clotting
Bulan Agustus					
1	Ra'im	125436	12/08/1952	IGD	DL Cloting
2	Budiarjo	155739	15/08/2025	3A	SE Lisis
3	Suyatmi	235823	03/03/1948	ICU	SE Lisis
4	Suyatmi	235823	03/03/1948	7A	SE Lisis
Bulan September					
1	Abdul Rosyid	236733	09/09/2025	IGD	DI Cloting
2	Ngatijam	229509	13/09/2025	6A	Fh Cloting
3	Kasti	073280	13/09/2025	ICU	Se lisis
4	Fadjar Satria	230297	13/09/2025	ICU	BGA Vena
5	Mila	156030	21/09/2025	8A	DI Cloting

Analisis :
Ditemukan 5 sampel rusak ketika diterima oleh petugas laboratorium pada Bulan September

- Rencana Tindak Lanjut :**
- Monitoring dan Evaluasi.
 - Memberikan pemahaman bahwa pengambilan sampel sesuai dengan batas garis indicator.
 - Kolaborasi dengan Kabid Keperawatan terkait training prosedur pengambilan darah, penyimpanan dan pengiriman sampel.
 - Supervisi ED reagen.

1.1.1.6 Tabel Pelayanan BDRS Bulan April - Agustus 2025

Bulan	Permintaan Labu Darah				Total	Return Labu Darah				Total
	A	B	O	AB		A	B	O	AB	
April 2025	13	10	25	20	68	2	7	5	4	18
Mei 2025	20	27	42	9	98	4	-	-	-	4
Juni 2025	15	29	27	8	79	2	1	-	-	3
Juli 2025	18	14	29	6	67	1	4	-	3	8
Agustus 2025	15	32	30	6	83	6	2	0	2	10
September 2025	21	22	33	3	79	3	4	0	6	13

1.1.1.7 Tabel Hasil Incompatible pada Crossmatch pada Bulan Maret - Mei 2025

NO	NAMA PASIEN	JUMLAH PASIEN DAN PERMINTAAN LABU DARAH INCOMPATIBLE				TOTAL PERMINTAAN LABU DARAH
		A	AB	O	B	
Bulan April 2025						
Tidak ada						
Bulan Mei 2025						
Tidak ada						
Bulan Juni 2025						
1.	Siti Rahajuningsih				√	2 Labu
Bulan Juli 2025						
Tidak ada						
Bulan Agustus 2025						
Tidak ada						
Bulan September 2025						
Tidak ada						

Analisis :
Pada periode pertama bulan September 2025 tidak ditemukan pasien Incompatible

Rencana Tindak Lanjut :
Pertahankan Tetap telili dan berhati hati dalam melakukan crossmatch

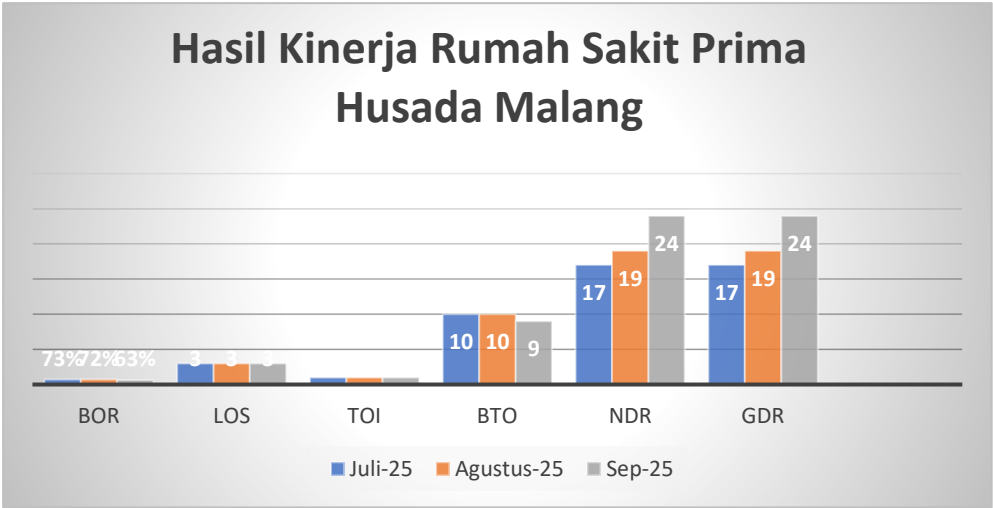
1.2.3 Rekam Medis – Pendaftaran

3.1.1.1 Tabel Kinerja Unit Rawat Inap Bulan September 2025

Indikator	Keterangan	Rumus	Data	Standar Depkes	Laporan	Ruang												
						LT 2C	LT 3 A	LT 3 C	LT 4ab	LT 5C	LT 6	LT 7	LT 8	MTS	NICU	HCU	ICU	TOTAL
BOR (Bed Occupancy Rate)	Prosentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu	$(\sum HP / (\sum TT \times \text{jumlah hari dalam satu periode})) \times 100$	Jumlah hari perawatan, jumlah TT, jumlah hari dalam satu periode	60 - 80 %	Juli 25	83	111	71	79	58	66	77	69	66	39	24	28	73
					Agustus 25	63	76	64	91	60	82	81	81	64	12	32	25	72
					September 25	47	11	65	79	43	67	66	70	74	30	25	31	63
ALOS (Average Length of Stay)	Rata-rata lama rawat seorang pasien	$LD / \sum px \text{ keluar } (H+M)$	jumlah lama dirawat, jumlah pasien keluar	6 - 9 hari	Juli 25	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	2	2	3
					Agustus 25	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	2	2	3
					September 25	4	2	3	3	3	3	4	4	3	4	2	2	3
TOI (Turn Over Interval)	Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati	$((\sum TT \times \sum \text{hari}) - HP) / \sum \text{pasien keluar } (H+M)$	Jumlah tempat tidur, hari perawatan, pasien keluar	1 - 3 hari	Juli 25	1	0	1	1	2	1	1	1	1	7	3	3	1
					Agustus 25	1	1	1	0	2	1	1	1	1	14	2	4	1
					September 25	3	9	1	1	3	1	1	1	1	6	3	3	1
BTO (Bed Turn Over)	Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode	$\sum Px \text{ keluar } (H+M) / \sum TT$	jumlah pasien. Jumlah TT	4 - 5 kali	Juli 25	7	10	10	11	8	9	9	10	11	3	8	7	10
				(dalam hitungan bulan)	Agustus 25	9	10	9	12	8	9	9	9	11	2	10	6	10
					September 25	6	3	9	11	5	9	8	8	12	3	7	6	9
NDR (Net Death Rate)	Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000	$(\sum Px \text{ Mati } > 48 \text{ jm}) / \sum Px \text{ keluar } (H+M) \times 1000\%$	Jumlah pasien meninggal >48jm, jumlah pasien	<25%	Juli 25	35	12	0	0	0	27	9	43	0	0	0	167	17

	penderita keluar rumah sakit		keluar		Agustus 25	0	0	0	7	0	19	9	46	0	0	211	172	19
					September 25	0	0	0	0	0	19	32	0	0	100	71	351	24
GDR (Gross Death Rate)	Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit	$(\sum Px \text{ mati} / \sum Px \text{ keluar (H+M)}) \times 1000\%$	Jumlah pasien keluar mati, jumlah pasien keluar	<45%	Juli 25	35	12	0	0	0	27	9	43	0	0	0	167	17
					Agustus 25	0	0	0	7	0	19	9	46	0	0	211	172	19
					September 25	0	0	0	0	0	19	32	0	0	100	71	351	24

3.1.1.2 Grafik Kinerja Unit Rawat Inap Bulan September 2025 2025



Analisis :

Indikator	Nilai September 2025	Standar Ideal	Evaluasi Singkat
BOR	63%	60%-85%	Masih dalam standar ideal
LOS	3 hari	BPJS : 3 hari UMUM : 6-12 hari	Dibawah standar BPJS, perlu dicermati
TOI	1 hari	1-3 hari	Sesuai standar, efisien
BTO	9 kali	4-5 kali	Konsisten tinggi, perlu evaluasi

Update Tren Tahun 2025

Indikator	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Catatan
BOR	81%	75%	72%	68%	69%	73%	72%	63%	Penurunan signifikan sejak Bulan April
LOS	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	Penurunan LOS, dibawah standar SE PT DPM
TOI	2 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	Stabil, efisien
BTO	9 kali	10 kali	10 kali	9 kali	9 kali	10 kali	10 kali	9 kali	Konsisten tinggi, diluar standar ideal

Masalah :

1. BOR (Bed Occupancy Rate)

Fluktuatif walaupun masih dalam batas ideal → perlu perhatian agar tetap stabil dan tidak menurun di bawah standar.

2. LOS (Length of Stay)

Indikasi pasien dirawat relatif singkat, bisa karena:

- a) Kasus yang ditangani sebagian besar ringan.
- b) Tekanan efisiensi rawat inap (lebih banyak diarahkan rawat jalan).
- c) Atau kemungkinan pasien pulang cepat namun berpotensi readmisi.

3. TOI (Turn Over Interval)

Mengindikasikan perputaran pasien cepat, tetapi bila tidak diimbangi dengan mutu pelayanan bisa meningkatkan beban kerja tenaga medis.

4. BTO (Bed Turn Over)

Mengindikasikan perputaran pasien cepat, tetapi bila tidak diimbangi dengan mutu pelayanan bisa meningkatkan beban kerja tenaga medis.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Untuk BOR:

Lakukan monitoring tren kunjungan pasien dan optimalkan pemasaran layanan unggulan agar BOR tetap stabil.

2. Untuk LOS:

- a) Evaluasi clinical pathway: apakah perawatan sudah sesuai standar atau pasien pulang terlalu cepat.
- b) Lakukan monitoring readmisi untuk mendeteksi apakah pasien yang pulang cepat sering kembali ke RS.

3. Untuk TOI:

Sudah sesuai standar, tetap dipertahankan dengan manajemen bed yang baik.

4. Untuk BTO:

- a) Pastikan mutu pelayanan tetap terjaga meski perputaran pasien tinggi.
- b) Perkuat manajemen SDM (tenaga medis dan paramedis) agar tidak terjadi kelelahan kerja (burnout).
- c) Evaluasi ketersediaan fasilitas dan sarana agar tetap seimbang dengan volume pasien.

3.1.1.3 Tabel Diagnosa Terbanyak Rawat Jalan Bulan Agustus 2025

NO	KODE	DIAGNOSA	TOTAL
1.	E11.9	DM Tanpa komplikasi / Without complications	424
2.	E11.4	With neurological complications	346
3.	I11.9	HHD / Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure	338
4.	I25.9	Chronic ischemic heart disease, unspecified	295
5.	I51.9	Decomp Cordis / Heart disease, unspecified	280
6.	R50.9	Fever, unspecified	234
7.	I63.9	CVA Infark / Cerebral infarction, unspecified	218
8.	J47	Bronchiectasis	196
9.	J44.9	COPD / Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified	195
10.	R10.4	Colic Abdomen / Other and unspecified abdominal pain	171

3.1.1.4 Tabel Diagnosa Rawat Inap Bulan Agustus 2025

NO	KODE	DIAGNOSA	TOTAL
1.	A01.0	Typhoid Fever	130
2.	J18.9	Pneumonia	45
3.	I63.9	Cerebro Vaskuler Accident	39
4.	A09	Gastroenteritis Akut	21
5.	A90	Dengue Fever	19
6.	E14.9	Dm Hyperglikemia	17
7.	J18.0	Broncho Pneumonia	17
8.	E11.9	Diabetes Mellitus Type 2	13
9.	D24	Tumor Mammae	12
10.	N20.0	Nephrolithiasis	12

Analisis :

Diagnosa terbanyak pasien rawat inap bulan September 2025 adalah typhoid fever sejumlah 130 Pasien. Diagnosa tersebut diambil dari hasil analisa pada resume medis saat pasien pulang.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan analisa pada resume medis saat pasien pulang berdasarkan diagnose sekunder.

3.1.1.5 Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Agustus 2025

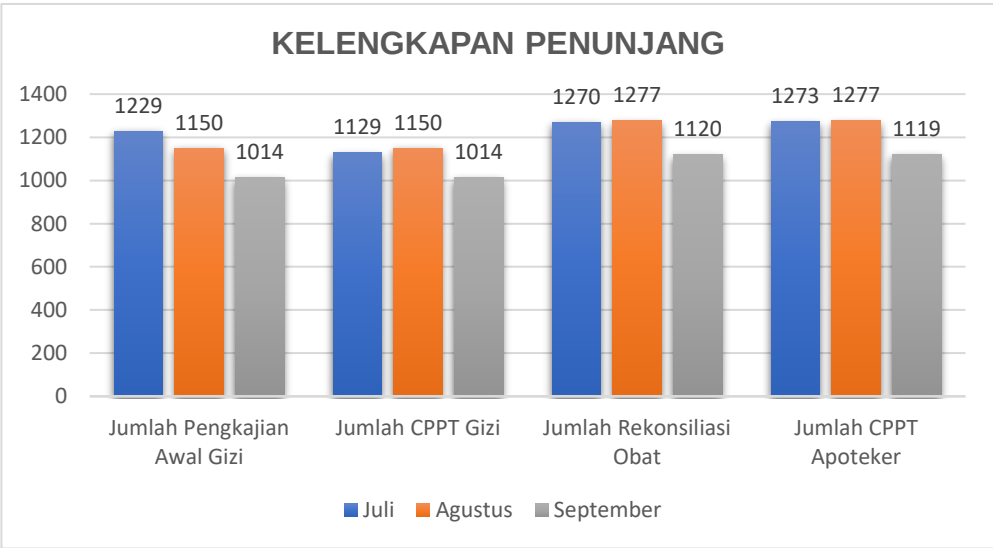
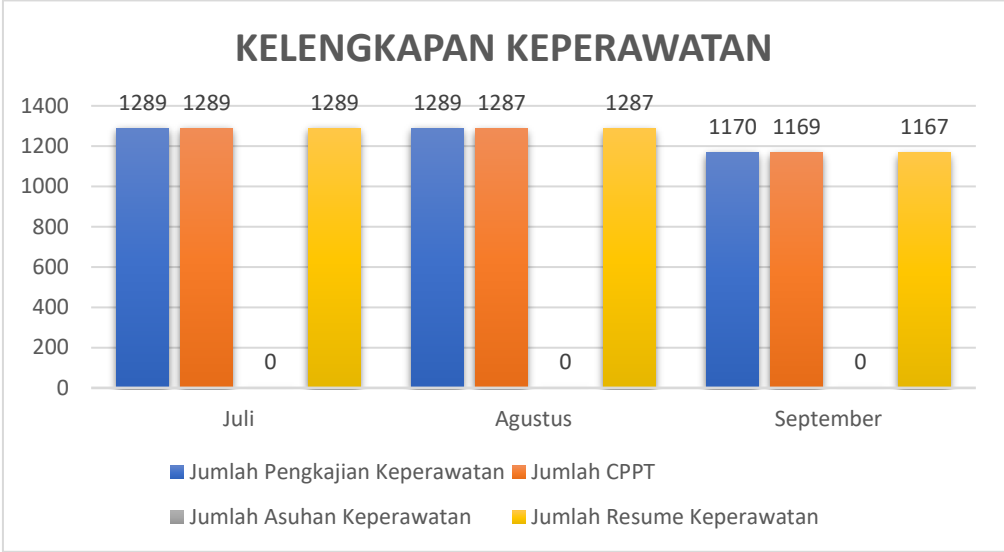
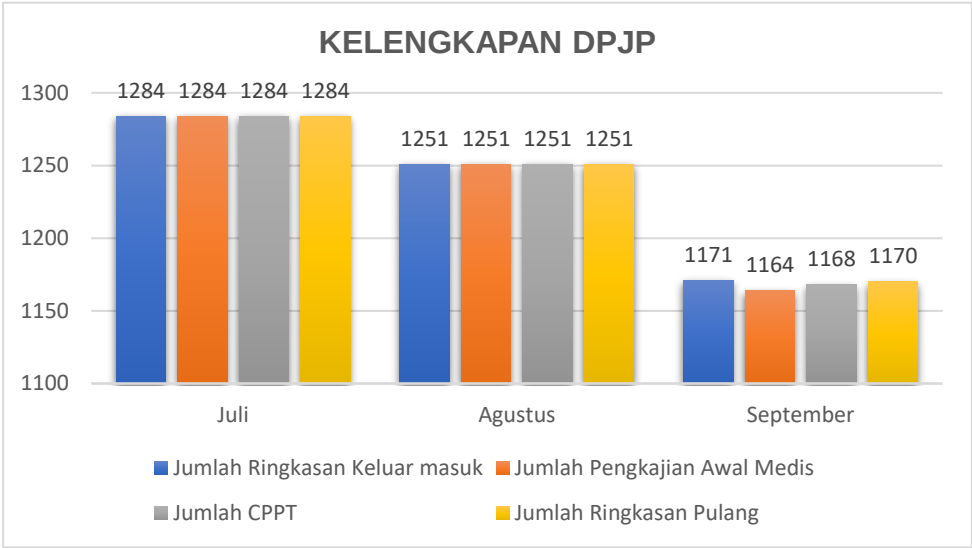
KELENGKAPAN																
DPJP																
BULAN	Ringkasan Keluar Masuk				Pengkajian Awal Medis				CPPT				Ringkasan Pulang			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	1055	98.1	20	1.9	1019	94.8	56	5.2	1026	95.4	49	4.6	1061	98.7	14	1.3
Maret	1201	99.17	10	0.83	1128	93.15	83	6.85	1196	98.76	15	1.24	1187	98.02	24	1.98
April	1204	99	12	1	1148	94	69	6	1200	99	16	1	1185	97	31	3
Mei	1265	98	12	2	1175	92	99	8	1229	94	50	6	1246	97	28	3
Juni	1164	99.87	4	0.13	1127	96.87	41	3.13	1150	98.31	19	1.69	1162	99.72	6	0.28
Juli	1281	99,89	3	0,10	1281	99,89	3	0,11	1281	99,89	3	0,11	1281	99,89	3	0,11
Agustus	1247	97	4	3	1241	99	10	1	1250	100	1	0	1250	100	1	0
September	1171	100	0	0	1164	98,14	7	1,86	1168	99,73	4	0,33	1170	99,84	1	0,16

KELENGKAPAN																
PERAWAT																
BULAN	Pengkajian Keperawatan				CPPT				Asuhan Keperawatan				Resume Keperawatan			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	1070	99.5	5	1048	1048	1048	1048	1.8	1056	98.2	1	0.1	1074	99.9	1	0.1
Maret	1200	98.68	16	1.32	1189	97.78	27	2.22	1214	99.84	2	0.16	1193	98.11	23	1.89
April	1240	99	10	1	1233	99	17	1	1242	99	8	1	1229	98	21	2
Mei	1270	99	7	1	1240	98	37	2	-	-	-	-	1267	99	10	1
Juni	1184	100	0	0	1177	99.49	7	0.51	-	-	-	-	1182	99.80	2	0.20
Juli	1289	100	0	0	1289	100	0	0	-	-	-	-	1289	100	0	0
Agustus	1289	100	0	0	1287	100	0	0	-	-	-	-	1287	100	0	0
September	1170	99,52	1	0,48	1169	99,33	2	0,67	-	-	-	-	1170	99,52	1	0,48

KELENGKAPAN																
BULAN	AHLI GIZI								APOTEKER							
	Pengkajian Awal Gizi				CPPT				Rekonsialisasi Obat				CPPT			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	944	92	82	8	944	92	82	8	1010	98	16	2	912	89	114	11
Maret	1049	97.6	26	2.4	1074	99.9	1	0.1	1066	99.2	9	0.8	1067	99.3	8	0.7
April	1249	99.9	1	0.1	1250	100	0	0	1247	99.8	3	0.2	1250	100	0	0
Mei	753	72	266	25	1019	100	0	0	1298	100	0	0	1298	100	0	0
Juni	661	66	372	34	1032	99.91	1	0.09	1173	99.95	1	0.05	1172	98.8	2	1.2
Juli	666	58	563	48	1124	99,65	5	0,35	1269	96,67	1	3,33	1272	96,67	1	3,33

Agustus	1150	100	0	0	1150	100	0	0	1277	100	0	0	1274	100	0	0
September	1014	100	0	0	1014	100	0	0	1120	100	0	0	1119	99,96	1	0,4

3.1.1.6 3.1.1.6 Grafik Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Agustus 2025



Analisis :

- 1. Ketidaklengkapan DRM Ahli Gizi terisi lengkap 100% , sebanyak 1014 dokumen
- 2. Pengkajian keperawatan 99,52% pada Bulan September 2025.
- 3. Masih ditemukan ketidaklengkapan pengkajian awal medis oleh DPJP pada Bulan September 2025.

Rencana Tindak Lanjut :

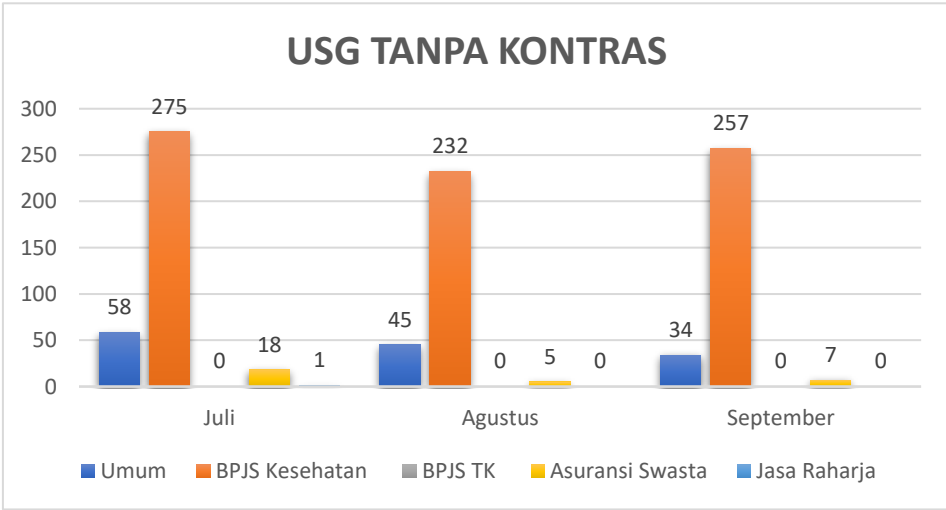
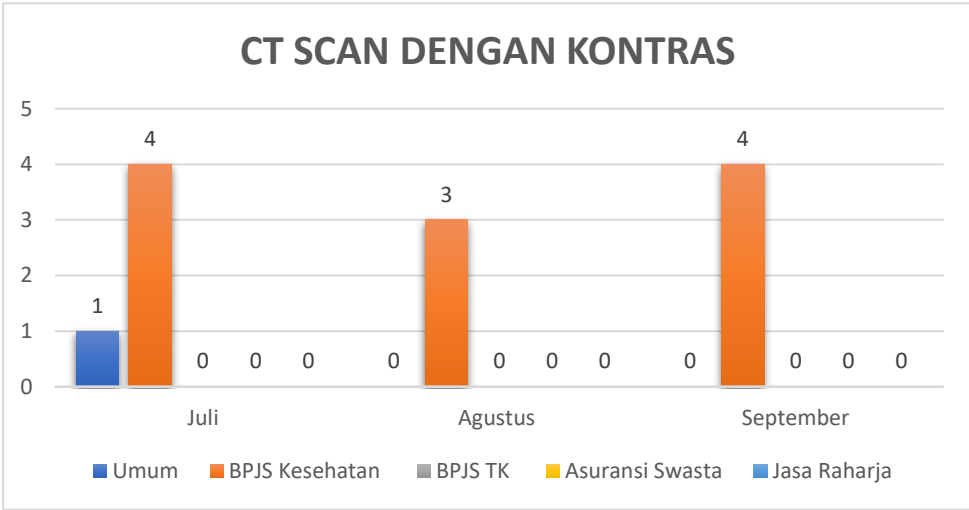
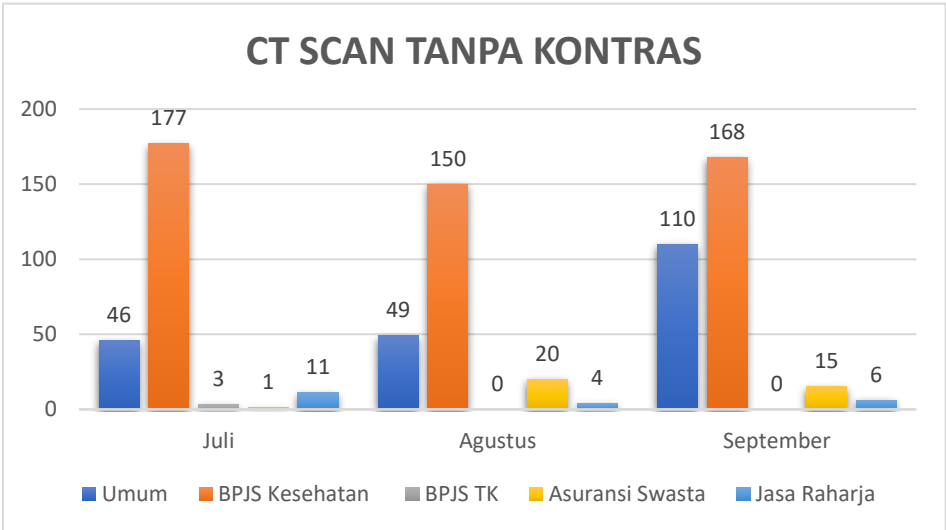
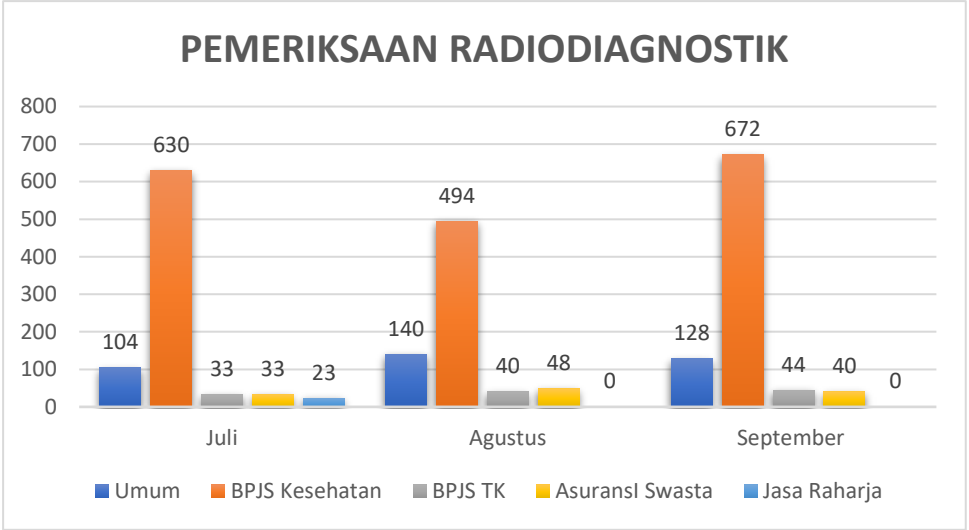
- 1. Menginformasikan kepada KARU hasil audit ketidaklengkapan DRM untuk melengkapi kekurangannya.
- 2. Melakukan supervise secara berkala.
- 3. Trial ERM Rawat Inap, diperlukan warning jika form belum terisi lengkap sehingga tidak bisa melanjutkan ke menu berikutnya.
- 4. Sosialisasi saat Rapat Unit, cara pengisian DRM.
- 5. Membuat raport ketidaklengkapan .
- 6. Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan dan Kabid Keperawatan.

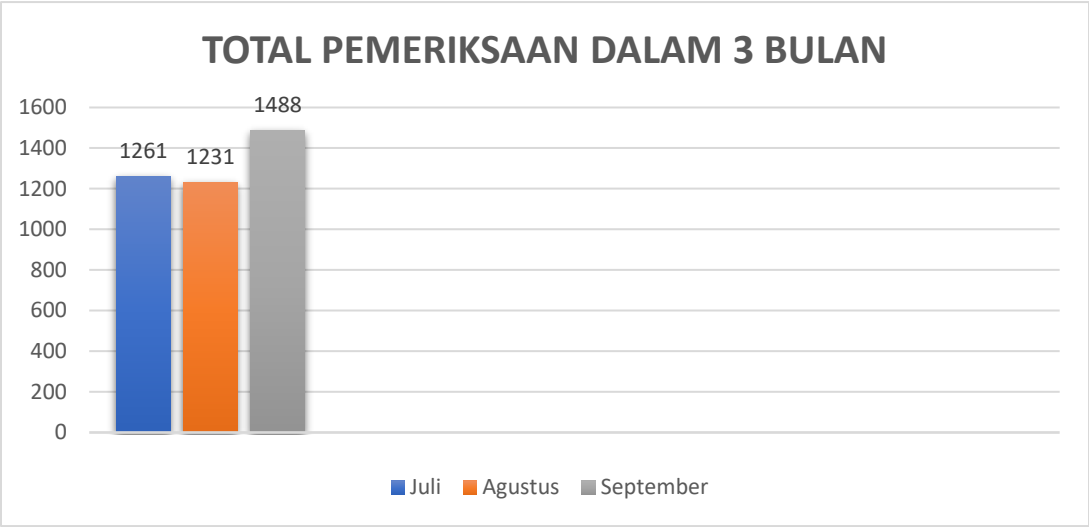
6.2.4 Radiologi

6.2.4.1 Tabel Jumlah Pemeriksaan Radiologi Juni - Agustus 2025

NO	JENIS PEMERIKSAAN	PENJAMIN	BULAN		
			JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
1.	RADIO DIAGNOSTIK	UMUM	104	140	128
		BPJS KESEHATAN	630	494	672
		BPJS TK	36	40	44
		ASURANSI SWASTA	33	48	40
		JASARAHARJA	23	0	0
	TOTAL		826	722	884
2.	CT SCAN TANPA KONTRAS	UMUM	46	49	110
		BPJS KESEHATAN	177	150	168
		BPJS TK	3	0	0
		ASURANSI SWASTA	1	20	15
		JASARAHARJA	11	4	6
	TOTAL		78	220	294
3.	CT SCAN DENGAN KONTRAS	UMUM	1	3	0
		BPJS KESEHATAN	4	0	4
		BPJS TK	0	3	306
		ASURANSI SWASTA	0	0	306
		JASARAHARJA	0	0	
	TOTAL		5	3	4
4.	USG TANPA KONTRAS	UMUM	58	45	34
		BPJS KESEHATAN	275	232	257
		BPJS TK	0	0	0
		ASURANSI SWASTA	18	5	7
		JASARAHARJA	1	0	0
	TOTAL		352	286	306
TOTAL KESELURUHAN			944		

6.2.4.2 Grafik Jumlah Pemeriksaan Radiologi Juni - Agustus 2025





Analisis :

- Pelayanan pemeriksaan selama Bulan September 2025 meliputi Radiodiagnostik, USG dan CT Scan, terbagi menjadi pasien UMUM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Swasta dan Jasaraharja.
Pada Bulan September 2025 pemeriksaan terbanyak, yaitu :
 - Radiodiagnostik : 884
 - USG Tanpa Kontras : 306
 - CT Scan Tanpa Kontras : 294
- Jumlah total pemeriksaan selama Bulan September 2025 adalah sebanyak 1488 pemeriksaan.

Rencana Tindak Lanjut :

- Koordinasi dengan Humas & Marketing untuk meningkatkan kunjungan di Radiologi dengan cara :
 - Melakukan kerja sama dengan RS yang belum memiliki CT Scan untuk meningkatkan pendapatan.
 - Mengajukan MCU kepada perusahaan-perusahaan besar di Kab/Kota Malang.
- Kolaborasi dengan Humas & Marketing untuk mengawal Polisi LAKA supaya tetap melakukan rujukan LAKA LANTAS ke RS Prima Husada Malang.
- Mendokumentasikan respon time pelayanan Radiologi menggunakan Google Spreadsheet, sambil menunggu waktu selesai hasil dimunculkan di Hasil Bacaan oleh Programmer PT.

6.2.4.3 Tabel Laporan Ulang Hasil Bulan Maret - Agustus 2025

NO	NAMA DOKTER	NAMA PASIEN	BACAAN AWAL	BACAAN ULANG	TOTAL
Bulan Maret 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	By Ny Zaimatus (227984)	Normal	Pneumonia	2
2.		Kasti (073280)	Normal	Infark Akut	
3.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	Agus Wahyu (114824)	Spondylosis	Compresi Fractura	1
Bulan April 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	Ny Sri Asnanik (224631)	CVA Infark	CVA Infark	2
2.		Dian Nihayatul (212732)	Normal	Normal	
3.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	0	0	0	0
Bulan Mei 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	Sumroti (231733)	Cardiomegali	Cardiomegaly dan Pneumonia	2
2.		Roeskandar	Lung Tumor	Lung Tumor dan Pneumonia	
1.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	Rizka Anada	Normal	Fracture Scapulla	1

Bulan Juni 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	0	0	0	0
2.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	Kiki Nur Ika Sari (232011)	Normal	Tetap Normal	1
Bulan Juli 2025					
1	dr. AgungSp.Rad (K)	- Eko sutaji (189842) - Sabar (195701)	-Normal -Normal	- Pulmonary hipertension - Pneumonia	2
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad	0	0	0	0
Bulan Agustus 2025					
1	dr. AgungSp.Rad (K)	Sabar / 195701	Normal	Pneumonia	1
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.Rad	Andrianto / 234437	Normal	Ada garis fraktur	1
Bulan September 2025					
1	dr. AgungSp.Rad (K)	-	-	-	-
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.Rad	ry wahyu /177112	Normal	Fraktur linear costae	1

Analisis :
 Pada Bulan September Tahun 2025 terdapat pembacaan ulang pemeriksaan ke radiologi. Hal ini disebabkan karena klinis tidak ditulis secara lengkap pada surat permintaan radiologi.

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Kolaborasi dengan MOD dan Kabid Pelayanan jika ada complain DPJP untuk melaporkan ke Radiologi dan Kabid Penunjang Medis.
 2. Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan dan Kabid Keperawatan untuk melengkapi pemeriksaan klinis pada surat pengantar supaya dapat menunjang hasil pemeriksaan.

6.2.4.4 Tabel Rata-Rata Respon Time Pembacaan Pemeriksaan Radiologi

NO	PEMERIKSAAN	RATA-RATA WAKTU (menit)			
		dr Agung, Sp.Rad (K)		dr Yudho, Sp.Rad	
		SELESAI PERIKSA	SELESAI PEMBACAAN	SELESAI PERIKSA	SELESAI PEMBACAAN
1.	Ro Thorax PA/AP	00:03:20	00:25:00 (waktu efektif) 00:180:00 (diatas jam 12 malam)	00:03:04	0:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)
2.	Ro Vertebrae	-	-	00:04:00	0:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)
3.	Ro Abdomen	-	-	00:10:00	:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)
4.	Ro Extremitas	-	-	00:02.00	0:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)
5.	Ro Skull	-	-	00:02:00	0:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)
6.	USG Abdomen	00:08:00	00:05:00		
7.	CT Scan Non Kontras	00:05:00	00:30:00 (waktu efektif) 24:00:00 (diatas jam 12	0:02.00	0:10:00 (pada saat jam praktek)

			malam)		24:00:00 (diluar jam praktek)
8.	CT Scan Dengan Kontras	00:15:00	0:25:00 (waktu efektif) 24:00:00 (diatas jam 12 malam)	-	-
9.	Radiologi CITO	00:10:00	00:04:00 (waktu elektif) 00:25:00 (diatas jam 12 malam)	00:10:00	00:10:00

Analisa :

1. Rata Rata waktu pemeriksaan radiologi rontgen Thorax 3 menit 4 detik dan rata- rata hasil pembacaan radiologi 1440 menit/24 jam. Hal ini disebabkan karna kebanyakan pasien rontgen dibaca keesokan harinya sesuai jam dokter praktek. (Tidak Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
2. Rata Rata waktu pemeriksaan radiologi rontgen Vertabrae 4 menit dan rata-rata hasil pembacaan radiologi 1440 menit/24 jam. Hal ini disebabkan karna kebanyakan pasien rontgen dibaca keesokan harinya sesuai jam dokter praktek. (Tidak Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
3. Rata Rata waktu pemeriksaan radiologi rontgen Ekstremitas 2 menit dan rata-rata hasil pembacaan radiologi 1440 menit/24 jam. Hal ini disebabkan karna kebanyakan pasien rontgen dibaca keesokan harinya sesuai jam dokter praktek. (Tidak Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
4. Rata Rata waktu pemeriksaan radiologi rontgen Abdomen 10 menit dan rata-rata hasil pembacaan radiologi 1440 menit/24 jam. Hal ini disebabkan karna kebanyakan pasien rontgen dibaca keesokan harinya sesuai jam dokter praktek. (Tidak Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
5. Rata Rata waktu pemeriksaan radiologi rontgen Skull 2 menit dan rata-rata hasil pembacaan radiologi 1440 menit/24 jam. Hal ini disebabkan karna kebanyakan pasien rontgen dibaca keesokan harinya sesuai jam dokter praktek. (Tidak Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
6. Rata Rata waktu pemeriksaan radiologi USG 15 menit dan rata-rata hasil pembacaan radiologi 10 menit. Hal ini disebabkan karna hasil usg langsung dibaca oleh radiolog. (Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam)
7. Semua pemerikaan CT Scan di alihkan ke dokter Agung Setyawan, Sp.Rad berdasarkan kesepakatan antar radiolog
8. Terdapat pembacaan CITO selama bulan Agustus 2025 dan hasil ekspertise sesuai target yakni kurang dari 30 menit

Rencana Tindak Lanjut :

1. Menemui kedua DPJP Radiologi untuk menambah jam praktik.
2. Memberikan surat pemberitahuan kepada Kepala Kolegium Radiografer bahwa RS membutuhkan tambahan DS Radiologi untuk mengisi jadwal praktik siang hari, sudah diterima oleh dr Agung, Sp.Rad.
3. Melakukan supervise pencatatan respon time pada Google Spreadsheet.
4. Membuat perjanjian dengan Kains Radiologi (dr Agung, Sp.Rad (K)) selama belum terpenuhi dokter untuk merespon konsulan secara cepat.

6.2.4.5 Tabel Angka Komplain DPJP Terhadap Keterlambatan Hasil Pembacaan Radiologi pada September 2025

NO	NAMA PASIEN	NAMA DPJP	PEMERIKSAAN	WAKTU	
				SELESAI PERIKSA	SELESAI HASIL
1.	-	-	-	-	-

Analisis :

-

Rencana Tindak Lanjut :

Kolaborasi dengan MOD dan Kabid Pelayanan jika ada complain DPJP untuk melaporkan ke Radiologi dan Kabid Penunjang Medis.

6.2.4.6 Tabel PMI dan PME di Radiologi

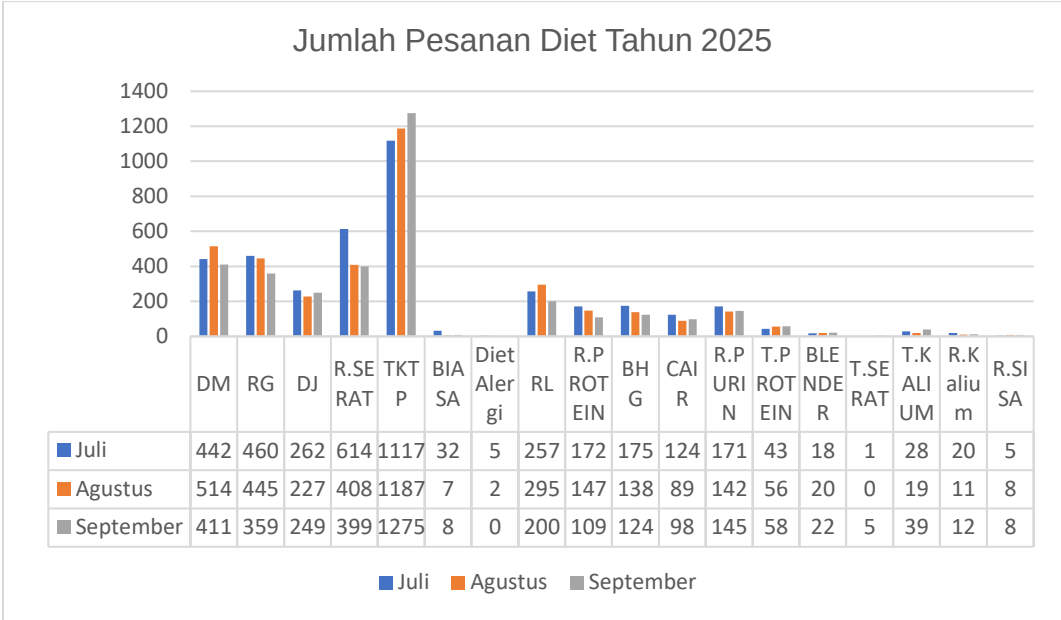
No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Sasaran Kegiatan
Pemantapan Mutu Internal (PMI)			
1.	Mencatat waktu tunggu pelayanan foto	Mencatat waktu mulai pengerjaan hingga hasil diserahkan.	1. Respons time pelayanan radiologi terukur dan sesuai standar.
2.	Mencatat jumlah Reject Film	Mencatat kegagalan foto (review pembacaan dan review hasil radiograf)	
3.	Memonitor pemakaian BMHP	Memonitor penyimpanan, pemeliharaan dan pemakaian bmhp.	2. Pengendalian kegagalan foto dan meminimalkan pengulangan. 3. Mengendalikan penggunaan BMHP radiologi.
Pemantapan Mutu Eksternal (PME)			
1.	Melakukan uji paparan radiasi	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	1. Peralatan radiologi dalam kondisi siap pakai. 2. Standarisasi pelayanan radiologi rujukan.
2.	Melakukan uji akurasi tegangan	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	
3.	Pengukuran TLD Badge	Kegiatan pengukuran dilakukan setiap 3 bulan sekali ke BPFK (Balai Pengaman Fasilitas .Kesehatan)	
4.	Kalibrasi alat radiologi	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali.	
5.	Uji kesesuaian	Pengujian kondisi alat dilakukan setiap 4 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	
6.	Sertifikat kalibrasi	Memastikan sertifikat kalibrasi rs rujukan masih berlaku	

2.4.5 Gizi

2.4.5.1 Tabel Pemesanan Diit Juli - September 2025

No.	Nama Diet	Jumlah pesanan diet			Persentase terhadap bulan sebelumnya (%)
		Bulan Juli	Bulan Agustus	Bulan September	
1.	Diabetes Mellitus	442	514	411	16,2
2.	Rendah Garam	460	445	359	-19,3
3.	Jantung	262	227	249	9,6
4.	Rendah Serat	614	408	399	-2,2
5.	TKTP	1117	1187	1275	7,4
6.	Makanan Biasa	32	7	8	14,2
7.	Diet Alergi	5	2	0	-100
8.	Rendah Lemak	257	295	200	-32,2
9.	Rendah Protein	172	147	109	-25,8
10.	Bubur Halus	175	138	124	-10,1
11.	Cair	124	89	98	10,1
12.	Rendah Purin	171	142	145	2,1
13.	Tinggi Protein	43	56	58	3,5
14.	Blender	18	20	22	10
15.	Tinggi Serat	1	0	5	0
16.	Tinggi Kalium	28	19	39	105
17.	Rendah Kalium	20	11	12	9,1
18.	Rendah Sisa	5	8	8	0
Jumlah		3946	3715	3616	-2,66

2.4.5.2 Grafik Jumlah Pesanan Diit Juli - September 2025



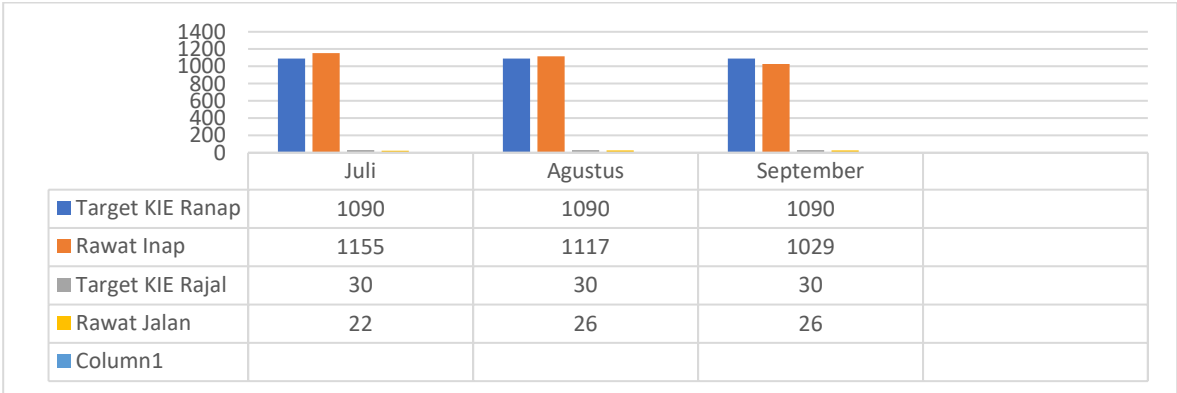
Analisis :
Jumlah pesanan diet pasien rawat inap menurun seiring dengan menurunnya jumlah pasien di rawat inap. Dari hasil survey kepuasan pasien terhadap menu makanan ditemukan penurunan kepuasan terhadap variasi makanan. Pemberian diet TKTP meningkat karena banyaknya pasien rawat inap dengan diagnosa post partum normal, post sc, post op, TF, DHF tanpa komplikasi. Diet yang mengalami penurunan adalah diet Rendah lemak dan rendah protein karena menurunnya pasien dengan gangguan metabolisme protein dan lemak.

Rencana Tindak Lanjut :
Koordinasi dengan humas dan marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap. Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien terhadap variasi menu makanan dan mengajukan perubahan siklus menu. Melakukan konseling kepada karyawan perusahaan yang memiliki MOU dengan RSPHM.

2.4.5.3 Tabel Jumlah Konsultasi Gizi Juli - September 2025

NO	INDIKASI	JUMLAH PASIEN		
		JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
1.	Konsultasi Rawat Inap	1155	1117	1029
2.	Konsultasi Rawat Jalan	22	26	26

2.4.5.4 Jumlah Konsultasi Gizi pada Bulan Juli - September 2025



- Analisis :**
- 1. Jumlah konsultasi gizi rawat inap pada Bulan September 2025 meningkat
 - 2. Jumlah konsultasi gizi rawat jalan pada Bulan September 2025 kondisi stabil.
 - 3. Tidak semua DPJP memberikan rujukan ke Poli Gizi, rujukan diterima dari Poli Jantung dan Poli IPD saja ketika pasien bertanya terkait pantangan makan saat control ke Poli Spesialis.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Merancang pengembangan pelayanan MCU Konsultasi Gizi dengan perusahaan.
- 2. Koordinasi dengan Humas Marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan.
- 3. Koordinasi dengan Kabid Pelayanan agar DPJP merujuk pasien ke Poli Giz

2.4.5.5 Tabel Rekap Data Komplain Pasien Terhadap Gizi Bulan Agustus 2025

NO	JENIS KOMPLAIN	NAMA PASIEN	ANALISIS	RENCANA TINDAK LANJUT	TOTAL
Bulan Februari 2025					
1.	Makanan yang disajikan dan penjelasan mengenai menu makanan.	An Yuan (B3C-4 IRNA 3C Anak) Isi Komplain : Menu yang didapat tidak bervariasi dibandingkan dengan terakhir kali pasien rawat inap (siklus menu berulang)	1. Siklus menu yang berlaku di RS Prima Husada Malang adalah siklus menu 10 hari+1 hari 2. Pasien MRS pada hari dimana siklus menu yang sama dengan hari MRS sebelumnya.	Melakukan analisis asupan makan pasien selama rawat inap untuk melihat daya terima pasien tersebut terhadap menu yang disajikan	1
Bulan Maret 2025					
Tidak ada komplain					
Bulan April 2025					
Tidak ada komplain					
Bulan Mei 2025					
1.	Keluhan pasien dan OB yang belum mendapatkan makanan	An Abimanyu Putra Herlambang (C3C-8, IRNA 3C Anak) Isi Komplain : Ayah pasien menyampaikan bahwa jika pasien belum selesai makan maka jangan mengambil makanan pasien terlebih dahulu.	1. Jam pengambilan makan adalah 1 jam setelah pembagian makan. 2. Pasien mengalami penurunan nafsu makan sehingga mengkonsumsi makanan dalam waktu lebih lama.	1. Koordinasi dengan tim penyaji untuk memberikan edukasi terkait jam pengambilan alat makan yaitu 1 jam setelah pembagian makan. 2. Koordinasi dengan CS pantry untuk cara edukasi yang benar sebelum mengambil alat makan pasien.	1
Bulan Juni 2025					
1.	Makanan yang disajikan dan penjelasan mengenai menu makanan.	Ny Nadiah Firliani Komplain melalui google review "makanannya kurang enak"	a. Pasien sakit mengalami penurunan nafsu makan dan penurunan citarasa	Koordinasi dengan seluruh petugas pengolahan dalam pembuatan standar resep masakan agar	1

			b. Antara satu petugas pengolahan dan pengolahan lain memiliki selera rasa yang berbeda sehingga ketika memberi rasa pada makanan disesuaikan dengan selera petugas masing-masing	masakan yang dihasilkan sama antara satu petugas dengan petugas lain	
Bulan Juli 2025					
1	Keluhan adanya benda asing dalam makanan pasien	- Ani Puji Lestari (C3a-6) komplain ada benang wol saat makan siang menu mie bihun, benang dikunyah saat makan oleh pasien. Pasien tidak langsung lapor, tapi mengisi kuesioner saat KRS. - Hana Rizki Anjani (3c anak) komplain sebaiknya pasien sering diberi menu sayur dan buah.	- Ahli gizi kurang teliti dalam melakukan QC makanan pasien - Petugas pengolahan tidak teliti dalam mengolah bihun. Tidak menggunting benang bihun dengan teliti sehingga ada benang yang tertinggal - Pasien anak dengan diagnosa TF diberikan advice DPJP diet rendah serat (tidak boleh mengonsumsi sayur dan buah). Ahli gizi sudah menjelaskan diet kepada keluarga pasien. Keluarga pasien yang dijelaskan tidak mengoperkan kepada anggota keluarga yang lain. Ahli gizi tidak konfirmasi	- Koordinasi dengan seluruh petugas pengolahan, pemorsia, dan ahli gizi dalam menjaga kebersihan makanan dari benda asing - Sosialisasi kepada seluruh ahli gizi jika setelah memberikan penjelasan melakukan konfirmasi terkait informasi yang diberikan.	2

			terkait informasi yang diberikan.		
Bulan Agustus 2025					
1	Keluhan tentang variasi makanan	- Etik Hariani (2c) komplain jika masakannya tolong bervariasi, - Komplain dari kuisisioner (3 Agustus) Untuk menu makanan bisa bervariasi lagi - Komplain kuisisioner (30 Agustus) Masukan untuk bagian gizi supaya lebih fariatif menu, untuk rasa kurang asin.	Menu makan pasien pada siklus yang berjalan ada yang diulang dalam waktu berdekatan, sehingga jika pasien dirawat dalam waktu 3 hari berisiko masih menemukan menu yang sama dengan hari sebelumnya	- Koordinasi dengan Instalasi gizi RSPHS terkait komplain variasi menu yang muncul - Mengajukan perubahan siklus kepada PT DPM untuk menghindari pengulangan menu dalam waktu dekat (proses pengajuan)	3
Bulan September 2025					
Tidak ada komplain					

2.4.5.6 Tabel Rekap Food Waste (Sisa Makanan) bulan Juli - September 2025

No	Menu	Rincian Menu	Total Sisa Makanan (kg)			Keterangan
			Juli 2025	Ags 2025	Sep 2025	
1.	Karbohidrat	Nasi	134,5	135,5	107	75% dari sisa makanan berasal dari karbohidrat.
		Nasi Tim	204,5	198,2	173	
	Total		339	333,7	280	
2.	Snack	Roti Kukus	0,3	0	0,3	Snack yang memiliki sisa paling banyak adalah bubur sagu
		Setup Pisang	0,8	0,4	0	
		Kacang Hijau	0,4	1,4	0,4	
		Kue Hongkong	0,2	0	0	
		Terang Bulan	1,4	0	0	
		Bubur Sagu	1,9	1,0	0,7	
		Kue Lumpur	0,8	0	0	
		Puding	0,5	0,6	0,5	
		Donat	0,8	0,5	0,2	
		Tahu Fantasi	1,0	0,4	0,4	
		Sagu Mutiara	0,7	0	0	
	Total		8,8	4,3	2,2	
1.	Menu 1					Menu 4 adalah menu paling tidak diminati, sisa makanan sebanyak 12,3 Kg
	Bulan		Juli 2025	Ags 2025	Sep 2025	
	Pagi	Semur (Tahu, Buncis, Bakso)	3,4	2,4	2,9	
		Rolade Ayam				
	Tambahan VIP	Tempe Goreng				
	Siang	Sup Kemangi (Jagung, Wortel, Oyong, Kemangi)	4,1	3,9	2,3	
		Ayam Kecap				
		Tahu Bumbu				

		Tomat			
	Tambahan VIP	Telur Ceplok			
	Sore	Rawon (Daging Slice, Manisah Dadu, Cambah Pendek)	4,4	4,1	2,6
		Tempe Goreng			
	Tambahan VIP	Perkedel			
	Total		11,9	10,4	7,8
2.	Menu 2				
	Bulan		Juli 2025	Ags 2025	Sep 2025
	Pagi	Sup (Manisah, Ayam Dadu, Wortel, Bihun)	3,5	3,5	2,5
		Tahu Rempah (Remet)			
		Abon			
	Tambahan VIP	Telur Rebus			
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Jagung, Wortel, Manisah)	3	3,1	2,4
		Ayam Wijen			
		Bakwan Jagung			
	Tambahan VIP	Telur Gulung			
	Sore	Koloke (Ayam Goreng Fillet, Timun, Wortel)	3,2	2,9	3,2
		Tempe Goreng			
	Tambahan VIP	Bakso Goreng Mekar			
	Total		7,2	9,5	8,1
3.	Menu 3				
	Bulan		Juli 2025	Ags 2025	Sep 2025
	Pagi	Sup (wortel, Sawi Putih, Ayam Dadu)	3,3	2,7	2,6
		Tahu Krispy			
		Abon			
	Tambahan VIP	Telur Ceplok			
	Siang	Sayur Asem (Wortel, Kacang Panjang, Manisah)	3,8	4	3,2
		Rolade Ayam			
		Tahu Goreng			
	Tambahan VIP	Tempe Bacem			
	Sore	Oseng (Jamur Kuping, Wortel, Bakso, Kacang Polong)	4,4	4,5	2,5
		Ayam Bombay			
		Tempe Orek			

	Tambahan VIP	Telur Dadar			
	Total		10,9	11,2	8,3
4.	Menu 4				
	Bulan		Juli 2025	Ags 2025	Sep 2025
	Pagi	Sayur Bobor (Selada Air, Manisah, Kemangi)	3,6	3,4	2,7
		Tahu Nugget			
		Abon			
	Tambahan VIP	Oseng Bakso Mekar			
	Siang	Sup (Oyong, Wortel, Jagung)	4,1	3,6	2,6
		Ayam Kecap			
		Jamur Krispy			
	Tambahan VIP	Tahu Bacem			
	Sore	Soto Ayam (Soun, Kubis, Seledri, Ayam Suwir)	4,6	3,8	2
		Telur Rebus			
		Tempe Goreng			
	Tambahan VIP	Keripik Kentang			
	Total		14,1	10,8	7,3
5.	Menu 5				
	Bulan		Juli 2025	Ags 2025	Sep 2025
	Pagi	Sup (Bunga Kol, Sawi Daging, Bakso, Wortel)	3,4	4,4	3
		Opor Tahu			
		Oper Telur			
	Tambahan VIP	Tempe Goreng			
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Jagung, Manisah)	3,4	3	2,4
		Ayam Bombay			
		Bakwan Jagung			
	Tambahan VIP	Tahu Krispy			
	Sore	Sup Merah (Bakso, Ayam Dadu, Polong, Wortel)	2,7	5,2	2,6
		Tempe Goreng			
		Telur Dadar			
	Total		9,5	12,6	8
6.	Menu 6				
	Bulan		Juli 2025	Ags 2025	Sep 2025
	Pagi	Semur (Tahu, Buncis, Bakso)	3,1	4,5	2,2
		Orak Arik (Wortel, Kubis, Daun			

		Bawang, Telur)				
		Tempe Goreng				
	Tambahan VIP	Ayam Goreng				
	Siang	Sup Kemangi (Jagung, Wortel, Oyong, Kemangi)	1,6	4,1	2,1	
		Ayam Laos				
		Tahu Bumbu Tomat				
	Tambahan VIP	Telur Ceplok	2,4	4,3	2,3	
	Sore	Rawon (Daging Slice, Manisah Dadu, Cambah Pendek)				
		Tahu Krispy				
	Tambahan VIP	Perkedel	7,1	12,9	6,6	
Total						

7.	Menu 7				
	Bulan		Juli 2025	Ags 2025	Sep 2025
	Pagi	Cah Sawi (Sawi Putih, Wortel Serut, Ayam Dadu)	2,9	3,6	2,7
		Telur Ceplok Bumbu Kuning			
		Abon			
	Tambahan VIP	Tempe Bacem	3,8	3,4	2,5
	Siang	Sup (Wortel Dadu, Jamur Es, Polong, Bakso)			
		Ayam Ungkep			
		Perkedel			
	Tambahan VIP	Jamur Krispy	5,5	5,7	3
	Sore	Koloke (Ayam Goreng Fillet, Timun, Wortel)			
		Tempe Goreng			
	Tambahan VIP	Telur Dadar	12,2	12,7	8,2
	Total				

8.	Menu 8				
	Bulan		Juli 2025	Ags 2025	Sep 2025
	Pagi	Sayur Bobor (Manisah, Sawi Hijau)	3,7	3,4	2,7
		Tahu Nugget			
		Abon			
	Tambahan VIP	Ayam Fillet Tepung	3,7	3,5	3,2
	Siang	Sayur Asem (Wortel, Jagung, Manisah)			
		Ayam Bakar			

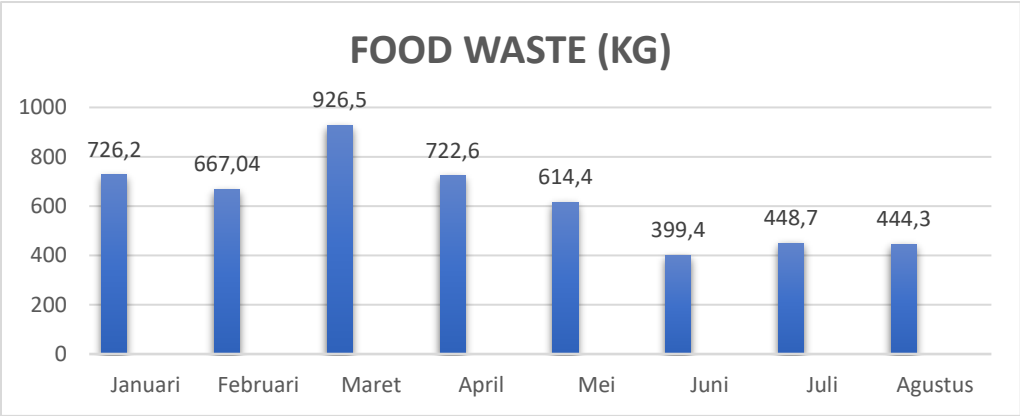
		Tahu Goreng			
	Tambahan VIP	Nugget Ayam			
	Sore	Semur (Ayam Fillet, Soun, Daun Bawang, Tomat)	3,8	3,6	3,1
		Botok Tahu			
		Abon			
	Tambahan VIP	Tempe Goreng			
	Total		11,2	10,5	9
9.	Menu 9				
	Bulan		Juli 2025	Ags 2025	Sep 2025
	Pagi	Tumis (Bakso, Wortel, Buncis)	3,6	3	2,6
		Tahu Rempah			
		Abon			
	Tambahan VIP	Telur Dadar			
	Siang	Sup (Bihun, Wortel, Pokcoy)	3,2	2,8	3,7
		Ayam Kemangi			
		Tahu Krispi			
	Tambahan VIP	Bakso Goreng Mekar			
	Sore	Soto Ayam (Soun, Kubis, Seledri, Ayam Suwir)	3,4	2,6	3
		Telur Rebus			
		Tempe Goreng			
	Tambahan VIP	Keripik Kentang			
	Total		10,2	8,4	9,3
10.	Menu 10				
	Bulan		Juli 2025	Ags 2025	Sep 2025
	Pagi	Sup (Wortel, Bakso, Sawi Putih)	3	2,8	2,8
		Telur Ceplok			
		Abon			
	Tambahan VIP	Tempe Bacem			
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Wortel, Jagung, Manisah)	2,8	2,4	3,6
		Ayam Wijen			
		Tahu Goreng			
	Tambahan VIP	Telur Orak Arik			
	Sore	Capjay (Wortel, Kembang Kol, Sawi, Bakso, Ayam Dadu)	3,9	4,3	3,4
		Tempe Goreng			
	Tambahan VIP	Oseng Bakso Mekar			
	Total		9,7	9,5	9,8
11	Menu 11				
	Bulan		Juli	Ags	Sep

		2025	2025	2025	
Pagi	Sapo Tahu (Tahu, wortel,kembang kol, bakso)	1,8	0,6	-	
	Tempe Goreng				
	Abon				
Tambahan VIP	Telur rebus				
Siang	Sayur asem (Wortel, kacang panjang, manisah)	0,7	0,7	-	
	Ayam bakar				
	Bakwan jagung				
Tmbahan VIP	Tahu Goreng				
Sore	Semur (Ayam fillet, soun, daun bawang,tomat)	1,9	0,8	-	
	Tahu Rempah				
	Abon				
Tambahan VIP	Jamur krispy				
Total		4,4	2,1	-	
Total Sisa Menu tanpa KH		109,7	110,6	82,4	
Total Keseluruhan dengan KH		448,7	444,3	362,4	

1.4.5.7 Tabel Rekap Food Waste Tahun 2025

No	Bulan	Total Sisa Makanan (kg)	Rata-Rata/Hari
1.	Januari 2025	726.2	23,42
2.	Februari 2025	667.04	23,82
3.	Maret 2025	926.5	29,88
4.	April 2025	722.6	24,08
5.	Mei 2025	614,4	19,81
6.	Juni 2025	399,4	13,3
7.	Juli 2025	448,7	14
8.	Agustus	444,3	14

1.4.5.8 Grafik Food Waste pada Bulan Juni Tahun 2025



Analisis :

1. Terdapat perubahan perhitungan sisa makanan pada Bulan Maret 2025, dimana perhitungan dipisahkan per menu dengan tujuan mengetahui menu makanan yang kurang diminati.

2. Dari data diatas, dapat diketahui bahwa ada penurunansisa makanan pada Bulan Agustus 2025, yaitu sebanyak 444,3 kg, setelah dilakukan tindaklanjut mengurangi porsi nasi pada setiap penyajian dan memperbaiki dalam segi rasa dan penampilan.
3. Masih ditemukan sisa makanan selain karbohidrat, hal ini dipengaruhi beberapa faktor, antara lain :
- a. Ada batasan diit yang dapat mempengaruhi rasa dan tampilan sehingga kurang menggugah selera.
 - b. Tidak ada pantangan dari keluarga pasien, sehingga konsumsi makanan dari luar / dibawa dari rumah, komunikasi/edukasi Ahli Gizi kurang diperhatikan.
 - c. Suasana lingkungan perawatan dan kondisi fisik pasien.
4. Tidak ada keterlambatan pengiriman makanan, jadwal makan sesuai.
5. Menu snack yang tidak diminati adalah setup pisang, bubur kacang hijau, bubur sagu dan tahu fantasi.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Melakukan edukasi kepada keluarga dan pasien terkait pemberian diit dan pembatasan makanan dari luar.
- 2. Melakukan plating secara menarik.
- 3. Mengadakan cooking class.
- 4. Memperbaiki dari segi rasa, tampilan dan menu.
- 5. Mengurangi porsi nasi pada setiap penyajian.
- 6. Mengganti menu snack yang tidak diminati.
- 7. Menimbang sisa makanan tanpa kuah.

2.4.5.7 Lampiran Pemantauan Air Panas di Pencucian Alat Makan



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

BULAN :
TEMPAT : PENCUCIAN ALAT DAPUR

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
Monitoring Suhu Air Panas (Suhu Normal = 75° - 80° Celcius)

		TANGGAL																	
		1			2			3			4			5			6		
		P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr
Batas suhu min (°C)		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Batas suhu maks (°C)		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Nilai Suhu (°C)		72	71	70	77	78	75	72	71	70	72	71	70	72	71	70	77	75	70
Inisial Staff		wn	wn	wn	Rt	Rt	Rt	Dk	Dk	Dk	wn	wn	wn	wn	wn	wn	yn	yn	TY
Supervisi Karu																			



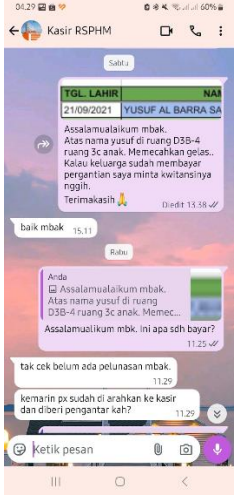
19			20			21			22			23			24			25		
P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
74	76	74	70	72	72	76	73	75	77	77	76	72	71	70	72	70	72	76	75	74
Dw	Dw	Dw	wn	wn	wn	sb	sb	dk	sb	sb	dk	Dk	Dk	Wn	wn	wn	wn	sb	sb	sb

(---) Suhu air panas tidak lebih dari 80°C (---) Suhu air panas tidak kurang dari 75°C

2.4.5.8 Lampiran Rekap Data Kehilangan Alat Makan

NO	TANGGAL	NAMA PASIEN	RUANGAN	NAMA ALAT	BUKTI KUITANSI	DOKUMENTASI	KETERANGAN
Januari 2025							
1.	19/01/2025	Suratman	D7A-9	Sendok			Kasir salah nama
2.	21/01/2025	Anissa Octaviafitri	B5C-2	Sendok			Pasien sudah KRS

		Widodo					
3.	26/01/2025	Aqilla Rassi Susanto	B2	Mangkuk Kecil			Sudah kembali
4.	31/01/2025	Ilma Ayuningsi	T4C-3	Gelas			Sudah pembayaran
Februari 2025							
1.	01/02/2025	Abid Fadhul Abyan	B3C-4	Sendok			Sendok hilang pasien sudah pulang
2.	01/02/2025	Cholifah	B5C-4	Sendok			Sendok hilang pasien sudah pulang
3.	04/02/2025	Widya Dwi Anandita	D6A-11	Sendok			Sendok hilang pasien sudah pulang
4.	05/02/2025	Arzanka Daneswara Ghazali	A1	Sendok Makan			Sendok terbawa pulang
5.	05/02/2025	Arzanka Daneswara Ghazali	A1	Sendok Snack			Sendok terbawa pulang
6.	06/02/2025	Chabibatul Aziizah	B3C-1	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
7.	06/02/2025	Mimi Eka	D4C-7	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
8.	19/02/2025	Ni'matul Udhma Himza	D3B-3	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
Maret 2025							
1.	11/03/2025	Muhammad Syifa	V3 (VIP)				Sendok hilang pasien sudah pulang
2.	24/03/2025	Pranata Dimas Ariansyah	C3C-10				Sendok hilang pasien sudah pulang
3.	25/03/2025	Mistianingsih	C3A-4				Sendok hilang pasien sudah pulang
April 2025							
1.	17/04/2025	Achmad Yogie Septiansyah	B2-5C	Gelas			Sudah pembayaran
Mei 2025							
1.	05/05/2025	Kasiati	D8A-12	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
2.	12/05/2025	Adhibah Mahirah Azizah	C3C-3	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
3.	28/05/2025	Ika Rodyana	D6A-8	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
Juni 2025							
Juli 2025							

1	04/07/2025	Ahmad Subandi	D7A-1	Sendok Makan			Sendok Hilang Px Pulang
2	06/07/2025	Lili Anita	B3C-6	Gelas			Memecahkan Gelas
3	11/07/2025	Eka Maulidia Sari	V3 (VVIP)	Sendok Snack			Sendok Snack Hilang Px Sudah Pulang
4	11/07/2025	Arnemelia Ayunda Lestari	A2 (VIP)	Sendok Snack			Sendok Snack Hilang Px Sudah Pulang
5	11/07/2025	Arnemelia Ayunda Lestari	A2 (VIP)	Garpu			Garpu Hilang Px Sudah Pulang
6	11/07/2025	Sophia Alya Khairani	B3C-4	Sendok Makan			Sendok Makan Hilang Px Sudah Pulang
7	20/07/2025	Arya Raka Pratama	C3C-7	Sendok Makan			Sendok Makan Hilang Px Sudah Pulang
Agustus 2025							
1	04/08/2025	Aisyah Bulan Jewel Gandhi	D3C-7	Sendok Makan	-	-	Sendok Makan Hilang Px Sudah Pulang
2	12/08/2025	Farieza Dayn Za-Zahra	D3B-2	Sendok Makan	-	-	Sendok Makan Hilang Px Sudah Pulang
3	02/08/2025	Yusuf Al Barra Saputra	D3B-4	Gelas Pasien			Memecahkan Gelas, Pasien Pulang Tanpa Membayar
September 2025							
1	23/09/2025	D7A-2	DENI IRAWAN		-	GELAS PASIEN	Pasien memecahkan gelas dan sudah membayar penggantian ke kasir

- Analisis :**
- Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 1 kerusakan alat makan pada Bulan September 2025.
 - Ada perubahan alur dan dilakukan supervisi oleh Koordinator CS.

- Rencana Tindak Lanjut :**
- Mencantumkan tata tertib menjaga fasilitas pada GC, sehingga petugas admisi dapat mengedukasi saat melakukan pendaftaran, jika pasien menghilangkan atau merusak fasilitas maka wajib mengganti. Sementara menggunakan catatan tertulis selama GC yang lama belum habis.
 - Melakukan supervisi “SPO Pengecekan Fasilitas RS Sebelum Pasien KRS”, sebagai panduan

petugas dalam pelayanan dimana terdapat kolaborasi antara Instalasi Gizi, Perawat Ruang , CS Pantry dan Ruang, dan Kasir.

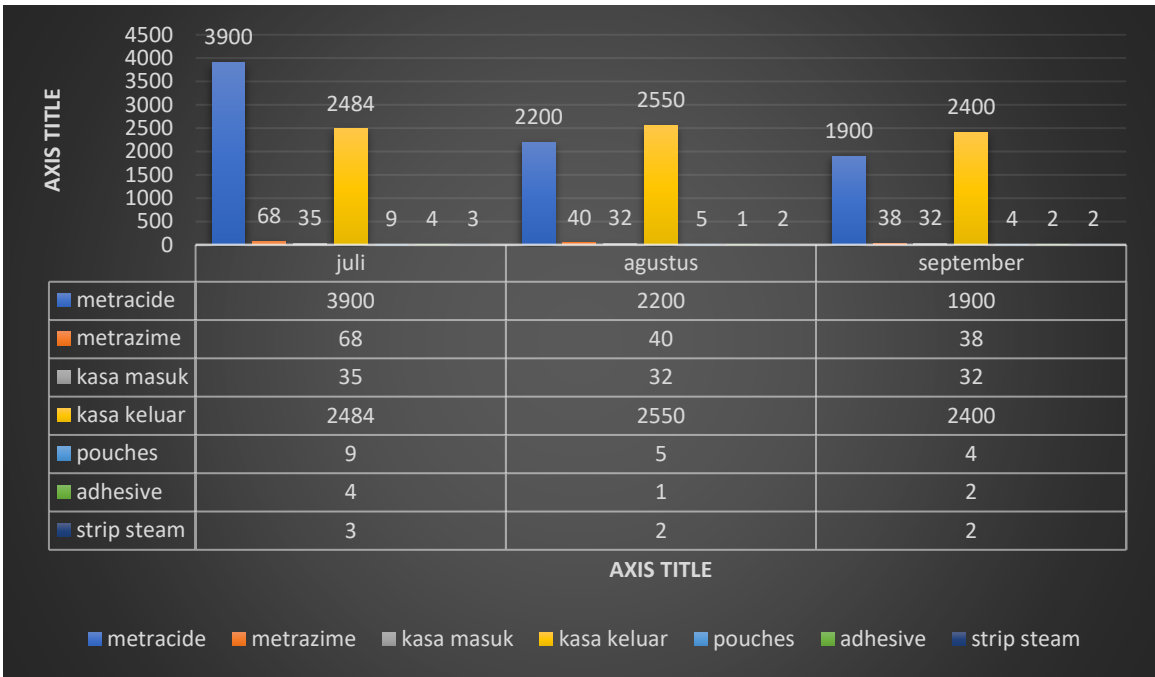
4.4.7 CSSD – Laundry

4.4.7.1 CSSD

4.4.7.2 Tabel Jumlah Pengeluaran Bahan Habis Pakai dan Alat yang Disetor ke CSSD Juli - September 2025

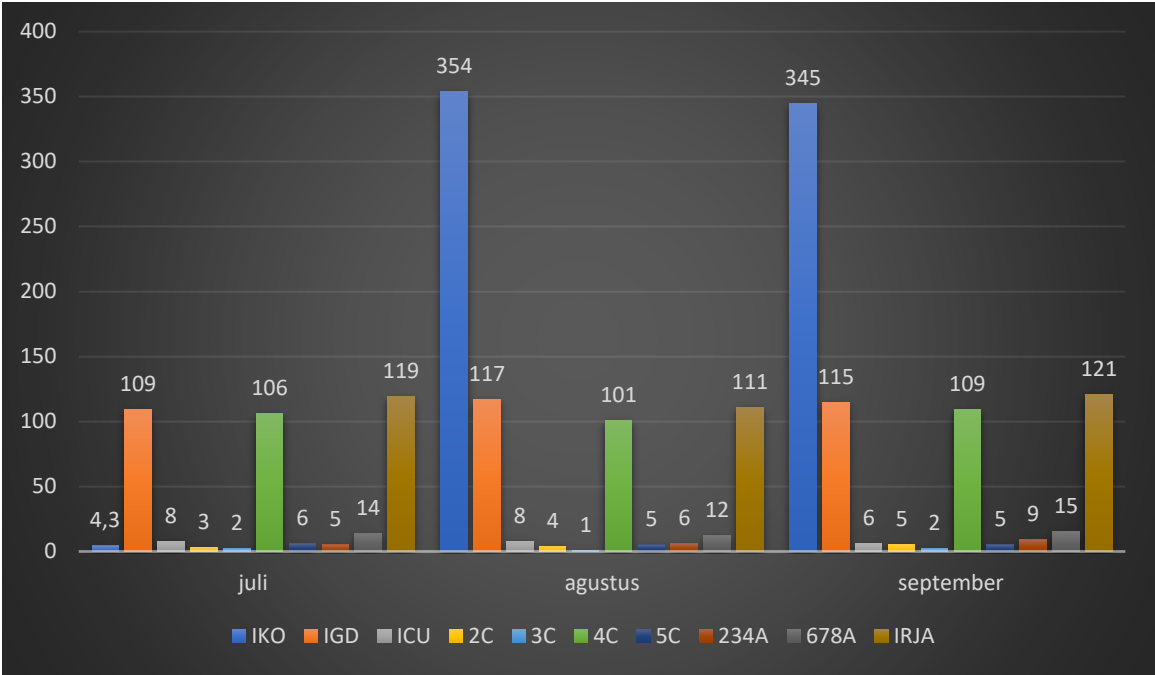
NO	HAL	BULAN TAHUN 2025		
		JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
1.	Chemical Alcacide (ml)	2900	2200	1900
2.	Chemical Alkazyme (pcs)	43	40	38
3.	Kassa Masuk (roll)	35	32	32
4.	Kassa Keluar (pouches)	2484	2550	2400
5.	BHP Pouces (roll)	6	5	4
6.	Indikator Adhesive (roll)	3	1	2
7.	Indikator Strip Steam (roll)	2	2	2
8.	IKO	368	354	345
9.	IRJA	119	111	121
10.	IRNA 5C	6	5	5
11.	IRNA 2A, 3A dan 4A	5	6	9
12.	IRNA 3C ANAK	2	1	2
13.	IRNA 6A, 7A dan 8A	14	12	15
14.	IRNA 2C VIP	3	4	5
15.	IRNA ICU	8	8	6
16.	IGD	109	117	115
17.	MATERNITAS	106	101	109
18.	NEONATOLOGI	37	33	31
Jumlah		777	742	763

4.4.7.3 Grafik Jumlah Alat Yang Disetor ke CSSD Bulan Juli - September 2025



Analisis :

Pada bulan September hamper semua bmhp yang mengalami penurunan yaitu : metrazime , metracide, pouches, indicator strip, adhesive tape, kassa masuk



- Analisis :**
- 1. Pada bulan september jumlah alat yang disetor di CSSD yang mengalami peningkatan yaitu: IRJA, 234A, 3 C, 678 A, 2C VIP, MATERNITAS
 - 2. Sementara Pada bulan september alat yang disetor di CSSD yang mengalami penurunan yaitu lantai IKO, 5C, ICU , IGD, NEO

- Rencana Tindak Lanjut :**
- 1. Memperbaiki pencatatan keluar masuk alat bersih dan kotor per bulan dengan kesepakatan alat yang dihitung.
 - 2. Pendistribusian kasa steril dalam bentuk pouches terpusat di Gudang Farmasi, dengan jadwal permintaan BMHP seminggu 2x.
 - 3. Monitoring dan Evaluasi pencatatan digital.
 - 4. Melakukan orientasi petugas baru di CSSD.

4.4.7.4 Tabel Penggunaan Reuse Pada Bulan September Tahun 2025

Nama Alat	Reuse ke1
Junctionrees	-
Breating circuit	-

Analisis :
Tidak ada permintaan alat reuse pada Bulan Agustus 2025.

4.4.7.4 Tabel Hasil Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit CSSD

UNIT	BULAN						TOTAL
	APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025	JULI 2025	AGT 2025	SEP 2025	
	Kejadian Instrument Kurang						
IKO	1	4	1	2	-	-	8
IGD	0	0	0	0	-	-	0
IRNA	0	0	0	0	-	-	0
IRJA	0	1	0	0	-	-	1
	Kejadian Instrumen Hilang						
IKO	0	0	0	0	-	-	0
IGD	2	0	0	0	-	-	2
IRNA	0	0	0	0	-	-	0
IRJA	0	0	1	0	-	-	1

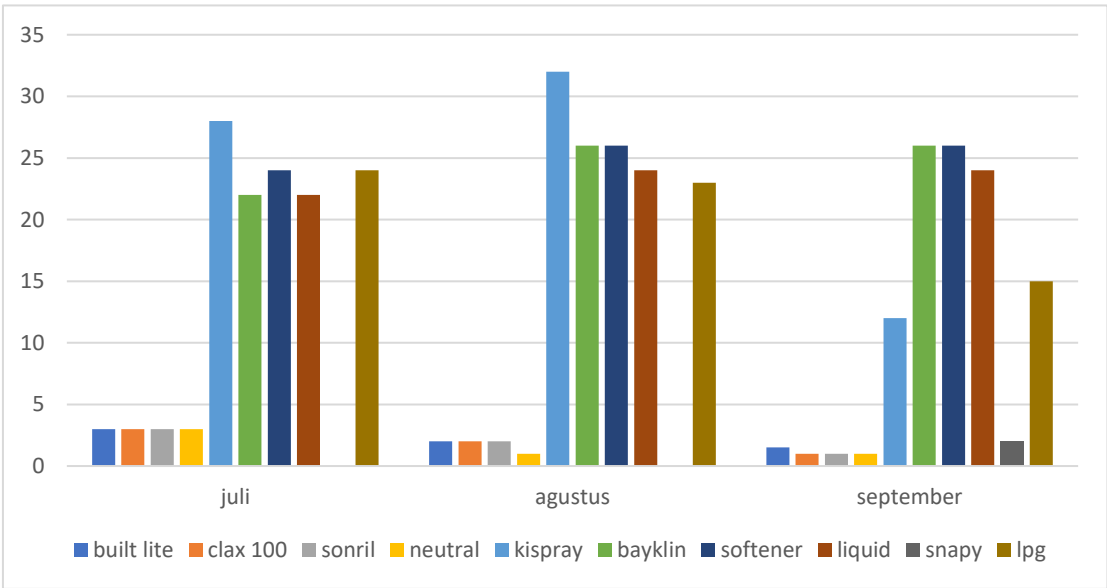
- Analisis :**
-
- Rencana Tindak Lanjut :**
-

1.4.7.2 Laundry

1.4.7.2.1 Tabel Jumlah Pencucian Linen di Laundry pada Bulan Juli – September Tahun 2025

NO	HAL	BULAN		
		JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
1.	Chemical Clax Buit Lite (dirigen)	3	2	1,5
2.	Chemical Clax 100 Ob (dirigen)	3	2	1,5
3.	Chemical Clax Sonril Ultra (dirigen)	3	2	1
4.	Chemical Clax Anti Chlor (dirigen)	3	1	1
5.	Pewangi Kispray 300ml (pcs)	28	32	12
6.	Pemutih Bayclean (liter)	22	26	26
7.	Softener (liter)	24	26	26
8.	Liquid matic (liter)	22	24	24
9.	Tabung LPG 12 kg (tabung)	24	23	15
TOTAL		132	138	108
LINEN (kg)				
1.	Linen Infeksius	2370	2401	2437
2.	Linen Non Infeksius	1983	2282	2097
3.	IRNA 2,3,4 A	458	425	361
4.	IRNA 6,7,8 A	503	501	571
5.	IRNA 2C/ICU/HCU	295	301	375
6.	IRNA 3C	413	399	315
7.	IRNA 4C/MATERNITAS	326	345	311
8.	IRNA 5C	260	333	267
9.	IKO	1713	1883	1865
10.	IRJA	66	70	67
11.	IGD	216	206	211
12.	LABORATORIUM	8	5	5
13.	RADIOLOGI	4	4	3
14.	DAPUR/GIZI	4	4	5
15.	CSSD	8	9	7
16.	Linen MS	62	73	55
17.	Umum	21	125	117
Total		4353	9366	7204

1.4.7.2.2 Grafik Jumlah Pencucian Linen di Laundry Pada Bulan Juni - Agustus 2025

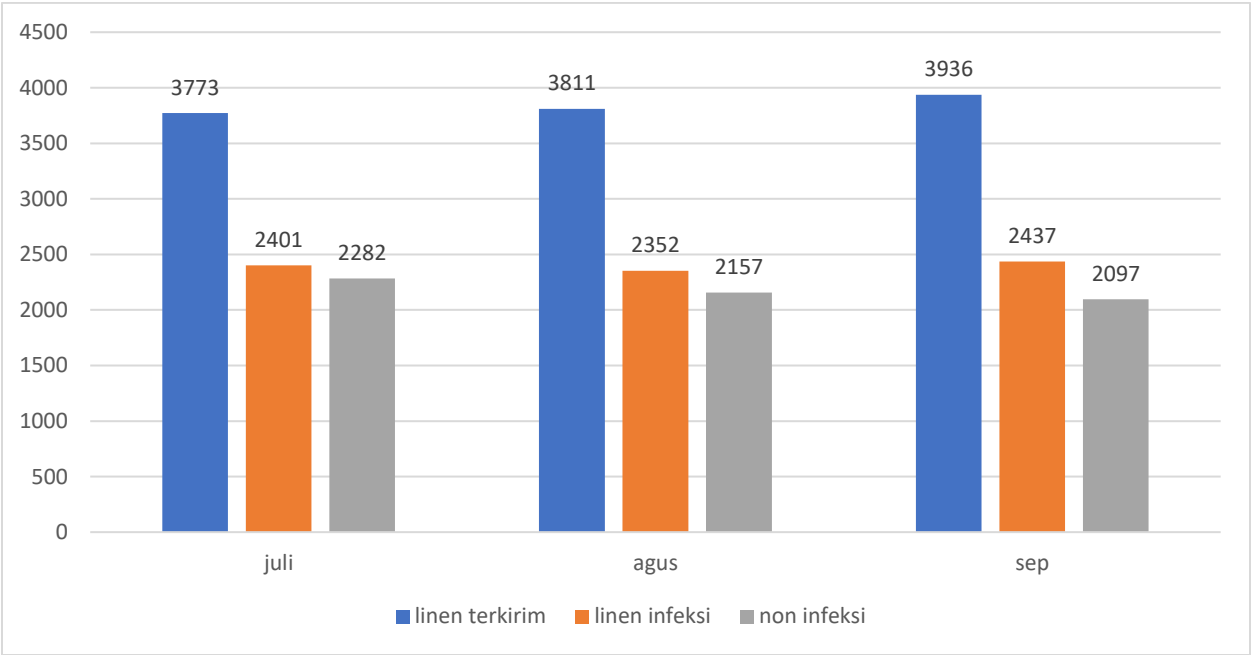


Analisis :

1. Pada bulan September BMHP yang mengalami penurunan pemakaian yaitu : Buit Lite, Clax 100, Sonril Ultra, Neutral
2. Pada bulan agustus pemakaian chemical yang meningkat yaitu; softener bayclin kispray dan liquid

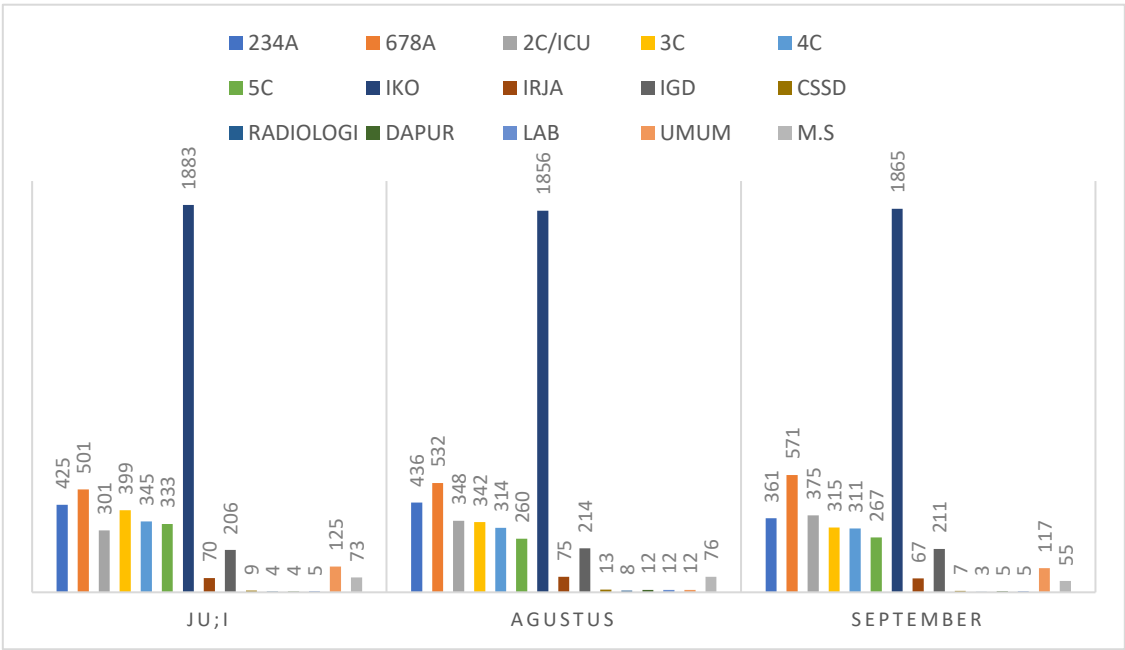
Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Melakukan breakdown pencatatan linen infeksius/non infeksiun per unit.
- 2. Dilakukan perubahan alur permintaan linen bersih menggunakan digital form per unit, dilakukan pendistribusian sehari 2 kali untuk memenuhi kebutuhan unit sesuai dengan permintaan, yang dilaksanakan mulai awal Tahun 2025.
- 3. Rencana akan dilakukan pencatatan keluar masuknya linen menggunakan google spreadsheet per hari nya.
- 4. Rencana akan dilakukan stok opname setiap bulan.
- 5. Pemampatan jadwal dinas malam untuk memaksimalkan pekerjaan.
- 6. Perubahan alur pengambilan linen yang perlu disterilisasi, dilakukan oleh petugas CSSD karena petugas laundry yang kurang.



Analisis :

- 1. Terjadi peningkatan di linen terkirim dari 3811 ke 3936
- 2. Untuk linen infeksi dari 2352 ke 2437
- 3. Untuk linen non infeksi dari 2157 ke 2097



Analisis :

- 1. Linen IKO mengalami peningkatann dari 1856 ke 1865
- 2. Linen IRJA di bulan juli mengalami penurunan pemakaian APD dari 75 kg ke 67 kg
- 3. Linen IRNA di bulan juli mengalami peningkatan yaitu lantai, 678 A, 2C/ICU, 5C sementara lantai 4 C, 3 C, 234 A menurun
- 4. Linen kotor IGD juga menurun, penggunaan linen selimut di IGD menurun
- 5. Terjadi peningkatan di cucian umum sebesar 117 kg yaitu korden

4.4.7.2.3 Tabel Inventarisasi Linen Laundry Pada Bulan Juli - September 2025

NO	NAMA / JENIS LINEN	JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
1.	Sprei	142	133	122
2.	Sarung bantal	265	253	241
3.	Selimut	170	164	158
4.	Baju tim IKO	110	110	105
5.	Baju ganti pasien	36	33	28
6.	Skort	145	145	145
7.	Perlak	19	18	15
8.	Baju ganti laundry	14	14	14
9.	Duk lubang besar	20	20	20
10.	Duk pembungkus	54	53	50
11.	Duk kecil 1 meter	45	43	41
12.	Duk ortho	14	14	12
13.	Duk lubang kecil	17	17	16
14.	Duk kaki	11	11	11
15.	Meja mayo	20	19	18
16.	Skort IKO	61	61	58
17.	Waslap	55	55	51
18.	Handuk CSSD	10	10	10
19.	Bantal	126	123	121
20.	Baju Pasien	28	25	21

1.4.7.2.3 Tabel Rekap Kerusakan Linen dan Pemusnahan Pada Bulan Juli - September 2025

NO	NAMA / JENIS LINEN	JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
1.	Sprei	18	11	11
2.	Sarung bantal	11	10	12
3.	Selimut	8	8	6
4.	Duk Pembungkus	2	0	3
5.	Duk Lubang Kecil	5	0	1
6.	Celana Tim IKO	0	1	5
7.	Baju Tim IKO	0	1	5
8.	Baju Pasien	1	2	5
9.	Skort	3	0	1
10.	Perlak	3	4	3
11.	Baju Ganti Laundry	0	1	0
12.	Duk Kecil	5	7	2
13.	Waslap	4	0	4
14.	Handuk CSSD	0	0	0
15.	Bantal	3	2	2
16.	Kerudung	0	2	0
17.	Kantung L	0	0	0
18.	Meja Mayo	0	1	1

Analisis :

- 1. Untuk linen rusak bulan agustus yaitu jenis sprei, sarban, selimut, duk kecil, baju pasien, perlak, duk pembungkus dan meja mayo

2. Sprei, sarban dan selimut rusak karena terdapat noda yang membandel dan sudah dilakukan spoting berulang

Rencana Tindak Lanjut :
Follow up Pengadaan PT

1.4.7.2.4 Tabel Pelaporan Limbah atau Benda Asing Tercampur Linen Pada Bulan Juni Tahun 2025

NO	NAMA BENDA	JUMLAH		
		JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
1.	Masker IKO	1	3	2
2.	Tissue	4	2	2
3.	Jarum	0	0	0
4.	Bumbu Dapur	0	0	0
5.	Uang	0	0	0
6.	Alat Tulis	0	0	0
7.	Benda lainnya	1 (selang oksigen)	0	2 (Underpad)

- Analisis :**
1. Benda asing yang sering tercampur di bulan September yaitu tissue dari IKO, Masker dari IKO, Underpad dari 5 C
2. Ketidakterdisiplinan paling banyak dari Unit IKO.
3. Hal ini dapat menyebabkan kontaminasi terhadap linen lainnya dan dapat menyebabkan kerusakan pada mesin.

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Melakukan sosialisasi kepada unit.
2. Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kemudian dilaporkan kepada Kabid Keperawatan dan SDM terkait hasil evaluasi.

4.4 Kinerja Bidang Umum dan Keuangan
4.4.7 SDM

3.5.7.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	0	0
2	Kabid Pelayanan Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
3	Kabid Penunjang Medis	D3 Kebidanan	0	0	0	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	0	0	0	0	0
5	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Satuan Pengawas Internal	SMK	1	1	1	0	0
7	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
8	Dokter Casemix	Dokter Umum	1	1	0	1	0
9	Farmasi	Profesi Apoteker	40	12	6	6	0
		S1 Farmasi		3	2	1	0
		D3 Analisis Farmasi dan Makanan		1	1	0	0
		D3 Farmasi		22	14	8	0
		SMK		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
10	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	10	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	7	1	0

		SMK		0	0	0	0
		SMA		1	1	0	0
11	CSSD	D3 Keperawatan	5	3	2	1	0
		SMA		1	1	0	0
		SMK		1	0	1	0
12	Fisioterapi	S1 Fisioterapi	5	1	0	1	0
		D3 Fisioterapi		3	2	1	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	0
13	Gizi	S1 Ilmu Gizi	17	2	2	0	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	2	0	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		7	0	7	0
		SMA		1	0	1	0
		SMP		3	2	1	0
14	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	1	0	1	0
		S1 Teknik Informatika		1	0	1	0
15	ICU dan HCU	Profesi Ners	12	5	5	0	0
		D3 Keperawatan		7	6	1	0
16	IGD	Profesi Ners	24	11	8	3	0
		D3 Keperawatan		8	6	2	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
17	IKO	Profesi Ners	12	8	8	0	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		0	0	0	0
18	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
19	IPSRs	S1 Tenik Elektro	6	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	3	0	0
20	IRJA	Profesi Ners	27	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		15	13	2	0
		D4 Keperawatan Gigi		1	1	0	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
21	IRNA 2C	Profesi Ners	6	5	4	1	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
22	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	18	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		11	7	4	0
23	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	13	4	2	2	0
		D3 Keperawatan		8	7	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
24	IRNA 5C	Profesi Ners	8	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		5	4	1	0
25	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	21	8	4	4	0
		D3 Keperawatan		13	10	3	0
26	Maternitas	Profesi Kebidanan	10	1	0	1	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		7	7	0	0
27	Neonatologi	Profesi Ners	8	3	2	1	0

		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
28	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	9	3	3	0	0
		S1 Akuntansi		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
29	Laboratorium	D4 Analis Kesehatan	9	1	0	1	0
		D3 Analis Kesehatan		8	7	1	0
30	Laundry	SMK	4	1	0	1	0
		SMA		2	1	1	0
		SMP		1	0	1	0
31	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	7	7	7	0	0
32	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	15	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Asuransi Kesehatan		1	0	1	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		7	5	2	0
		D1 Administrasi Perkantoran		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
33	PIPP & MPP	Profesi Ners	4	0	0	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
		D3 Kebidanan		2	2	0	0
34	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	0	0
35	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	5	2	0
36	SDM	S1 Psikologi	1	1	1	0	0
37	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	0	0
38	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	0	0
39	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
40	Cleaning Service	SMK	40	14	8	6	0
		SMA		21	17	4	0
		SMP		5	5	0	0
41	Security	SMK	12	5	2	3	0
		SMA		7	6	1	0
42	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	5	1	1	0	0
		SMA		3	2	1	0
		SMP		1	1	0	0
43	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
44	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	5	5	1	4	0
45	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
46	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
47	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
48	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
49	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
50	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0

51	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
54	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
56	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
59	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
61	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total			429	429	282	147	0

Keterangan :
 Pada bulan September tidak ada staf resign

3.5.1.1 Update STR / SIP

NO	NAMA	PROFESI	TANGGAL KEJADIAN	KETERANGAN
1	dr. I Gede Made Oka R, Sp. OT	Dokter Spesialis	02 September 2025	SIP Perpanjangan Terbit
2	dr. Rudi Priyo Utomo, Sp. OG	Dokter Spesialis	02 September 2025	SIP Perpanjangan Terbit

Keterangan :
 Pada bulan September terdapat 2 SIP perpanjangan yang terbit

3.5.1.2 Rekrutmen

NO	PROFESI	JUMLAH YANG DIBUTUHKAN	TERPENUHI	KEKURANGAN	PENYEBAB	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Terapi Okupasi	1	0	1	Sulit mencari kandidat terapis okupasi	Menghubungi sosial media komunitas terapis okupasi, menghubungi kampus dengan jurusan terapis okupasi
2	Dokter Spesialis Bedah Mulut	1	0	1	Sulit mencari kandidat Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	Menguhubungi kampus dengan jurusan tersebut
3	Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	1	0	1	Sulit mencari Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	Sudah mendapat kandidat dengan drg. Khadijah, Sp. KG. Sedang dalam proses penerbitan STR dan pengurusan SIP
4	Dokter Spesialis Radiologi	1	0	1	Belum mendapatkan kandidat	Dibutuhkan yang Perempuan
5	Fisioterapis	5	4	1	Belum mendapatkan kandidat yang cocok	Sedang proses pemenuhan
6	Perawat Gigi	2	1	1	Sudah ACC dari PT DPM	Sudah dilakukan rekrutmen dan staf akan masuk 1 minggu sebelum dokter spesialis konservasi gigi

						masuk
7	Terapis Wicara	2	1	1	On proses pengajuan ke PT DPM	On proses pengajuan ke PT DPM

3.5.1.3 Orientasi Staf Baru

3.5.1.3.1 Orientasi Staf

NO	TANGGAL	JENIS ORIENTASI	NAMA STAF	PENDIDIKAN	PROFESI	SPMJ (TANGGAL MASUK)	KETERANGAN
-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :
 Pada bulan Agustus 2025 tidak ada staf dengan orientasi khusus

3.5.1.4 Diklat

NO	JUDUL DIKLAT	JENIS DIKLAT	JUMLAH PESERTA		TANGGAL PELAKSANAAN	SERTIFIKAT		HASIL EVALUASI DALAM KINERJA SEHARI-HARI	
			HADIR	TIDAK HADIR		ADA	TIDAK	PATUH	TIDAK PATUH
1	Diklat BHD	Internal All staf	263	102	10-12 September 2025	v			
2	Diklat Drill Emergency	Inetrnal unit tertentu	24	13	16 September 2025	v			

3.5.1.5 Evaluasi Kinerja Staf

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
1	Direktur	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit Direktur secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
2	Kabid Pelayanan Medis	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Pelayanan Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
5	Kabid Umum & Keuangan	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Umum & Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
6	Satuan Pengawas Internal	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Satuan Pengawas Internal secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
7	Farmasi	Umum	40	0	28	11	1	0	Unit Farmasi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
8	Asuransi Center	Umum	10	0	10	0	0	0	Unit Asuransi Center secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
9	CSSD	Umum	5	0	5	0	0	0	Unit CSSD secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
10	Fisioterapi	Umum	5	0	2	3	0	0	Unit Fisioterapi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
11	Gizi	Umum	17	0	17	0	0	0	Unit Gizi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
12	Humas & Marketing & PKRS	Umum	2	0	2	0	0	0	Unit Humas Markrting & PKRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
13	ICU dan HCU	Umum	12	0	2	9	1	0	Unit ICU & HCU secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
14	IGD	Umum	24	0	19	4	0	1	Unit IGD secara keseluruhan mendapatcatatan baik dalam penilaian kinerja umum.
15	IKO	Umum	12	0	12	0	0	0	Unit IKO secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
16	IPCN	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit IPCNsecara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja

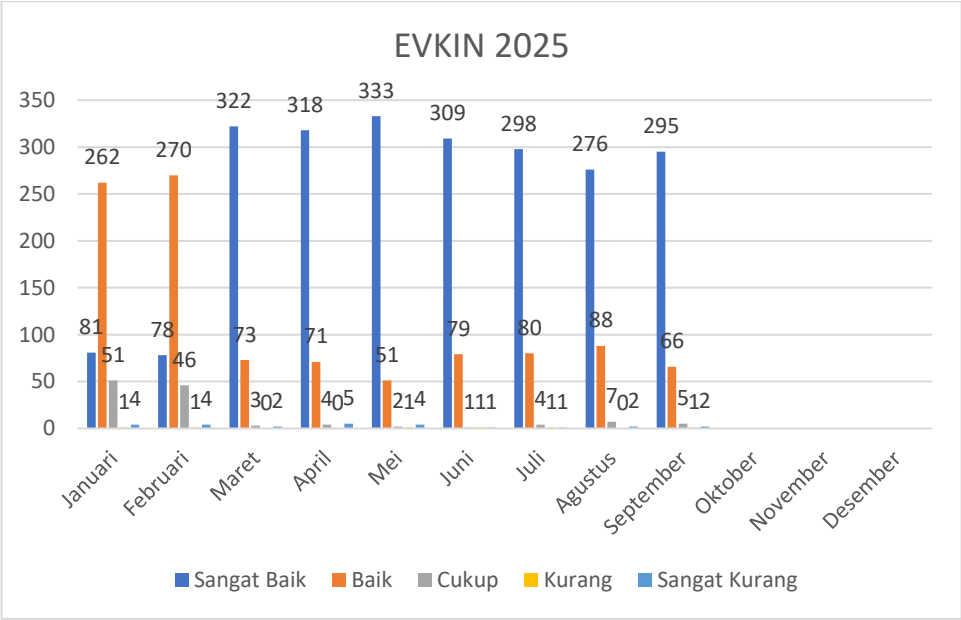
NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
									umum.
17	IPSRS	Umum	6	0	5	1	0	0	Unit IPSRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	IRJA	Umum	27	0	23	3	1	0	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	IRNA 2C	Umum	6	0	6	0	0	0	Unit IRNA 2C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
19	IRNA 2A, 3A, & 4A	Umum	18	0	16	1	0	1	Unit IRNA 234A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
20	IRNA 3C Anak	Umum	13	0	11	2	0	0	Unit IRNA 3C Anak secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
21	IRNA 5C	Umum	8	0	7	1	0	0	Unit IRNA 5C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
22	IRNA 6A, 7A, & 8A	Umum	21	0	18	3	0	0	Unit IRNA 6A, 7A & 8A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
23	Maternitas	Umum	10	0	10	0	0	0	Unit Maternitas secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
24	Neonatologi	Umum	8	0	8	0	0	0	Unit Neonatologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
25	Keuangan & Akuntansi	Umum	9	0	3	6	0	0	Unit Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
26	Laboratorium	Umum	9	0	6	3	0	0	Unit Laboratorium secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
27	Laundry	Umum	4	0	2	2	0	0	Unit Laundry secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
28	Rekam Medis	Umum	7	0	5	2	0	0	Unit Rekam Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
29	Pendaftaran	Umum	15	0	11	4	0	0	Unit Pendaftaran secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
30	PIPP & MPP	Umum	4	0	4	0	0	0	Unit PIPP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum. Terdapat 1 staf dengan evaluasi kinerja sangat kurang dikarenakan cuti melahirkan.
31	PMKP	Umum	0	0	0	0	0	0	Unit Mutu & PMKP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
32	Radiologi	Umum	7	0	7	0	0	0	Unit radiologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
33	SDM	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit SDM secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
34	Sekretaris	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Sekretaris secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
35	SIMRS & IT	Umum	3	0	2	1	0	0	Unit IT SIMRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
36	Umum & Rumah Tangga	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
37	Cleaning Service	Umum	40	0	34	5	1	0	Unit Cleaning Service secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
38	Security	Umum	12	0	10	2	0	0	Unit Security secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
39	Driver	Umum	5	0	3	1	1	0	Unit Driver secara keseluruhan mendapat

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
									catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
40	Gudang Umum	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit Gudang Umum secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

Analisis :
 Hampir seluruh unit di RS Prima Husada Malang berada pada kategori Sangat Baik pada penilaian umum periode September 2025.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi

3.7.1 Grafik Evaluasi Kinerja Karyawan

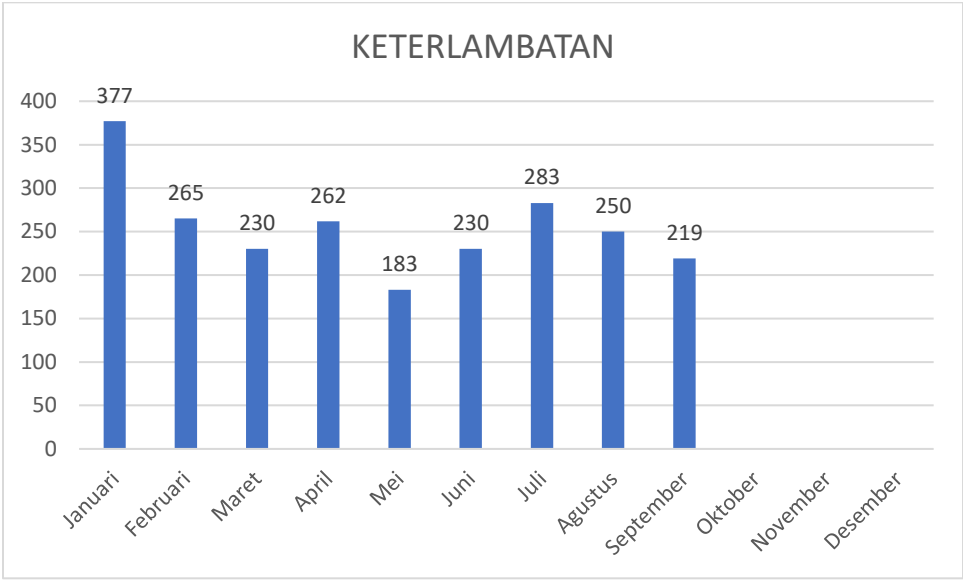


Kategori	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Sangat Baik	81	78	322	318	333	309	298	276	295			
Baik	262	270	73	71	51	79	81	88	66			
Cukup	51	46	3	4	2	1	4	7	5			
Kurang	1	1	0	0	1	1	1	0	1			
Sangat Kurang	4	4	2	5	4	1	1	2	2			
TOTAL	399	399	400	398	391	391	385	373	369			

Analisa :
 Secara umum terdapat peningkatan kinerja dari staf dilihat dari jumlah kategori cukup yang naik menjadi kategori diatasnya.

- Rencana Tindakanlanjut :**
1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
 2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
 3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
KETERLAMBATAN	377	265	230	262	183	230	283	250	219			



Analisa :
Secara umum terdapat penurunan keterlambatan karyawan dari bulan sebelumnya.

- Rencana Tindak Lanjut :**
- 1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
 - 2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
 - 3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.

3.5.1.6 Konseling

3.5.1.6.1 Tabel Capaian Konseling Perbulan Tahun 2025

NO	UNIT	JUMLAH KONSELING GRUP	JUMLAH KONSELING INDIVIDU					
			KONTRAK N-ED	TERKAIT TATA TERTIB	TERKAIT KETIDAKPATUHAN MUTU	TERKAIT KETIDAKPATUHAN PPI	TERKAIT MANRISK	KARIR
1	Manajerial RS	0	0	0	0	0	0	0
2	SDM	0	0	0	0	0	0	0
3	Asuransi Center	0	0	0	0	0	0	0
4	IRNA 2C	0	0	0	0	0	0	0
5	IRNA 3C Anak	0	0	0	0	0	0	3
6	IRNA 3A & 4A	0	0	0	0	0	0	0
7	IRNA 5C	0	0	0	0	0	0	0
8	IRNA 6A & 7A	0	0	0	0	0	0	0
9	Maternitas	0	0	0	0	0	0	0
10	Neonatologi	0	1	0	0	0	0	0
11	IGD	0	0	0	0	0	0	0
12	ICU	0	0	0	0	0	0	0
13	HCU	0	0	0	0	0	0	0
14	IKO	0	0	0	0	0	0	0
15	Gizi	0	0	0	0	0	0	0
16	Farmasi	0	0	0	0	0	0	0
17	Laboratorium	0	0	0	0	0	0	0
18	Radiologi	0	0	0	0	0	0	0
19	Rekam Medis	0	0	0	0	0	0	0
20	Pendaftaran	0	0	0	0	0	0	0

21	CSSD	0	0	0	0	0	0	1
22	Laundry	0	0	0	0	0	0	0
23	Keuangan & Akuntansi	0	0	0	0	0	0	0
24	PIPP	0	0	0	0	0	0	1
25	MPP	0	0	0	0	0	0	0
26	Umum Cleaning Service	0	0	0	0	0	0	0
27	SIMRS	0	0	0	0	0	0	0
28	DRIVER	0	0	0	0	0	0	0
29	Security	0	0	0	0	0	0	0
30	IRJA	0	0	0	0	0	0	0
31	Rehab Medik	0	0	0	0	0	0	0
32	Kasir Parkir	0	0	0	0	0	0	0
33	Parkir	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	1	0	0	0	0	4

Analisis :
Konseling staf dilaksanakan sesuai kebutuhan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

Jenis	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desembe
Supervisi (2x/bulan)	0	100%	50%	100%	100%	100%	0%	100%	50%			

Analisais:
Dilaksanakan pada tanggal 17 September 2025. - Masih ditemukan staf yang tidak menggunakan nametag (an. Rahma)

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.1.7 Supervisi

Tabel Pelaksanaan Supervisi

JENIS	Janu ari	Febr uari	Ma ret	Apr il	Mei	Ju ni	Juli	Agus tus	Septe mber	Okto ber	Nove mber	Dese mber
Supervisi (2x/bulan)	0	100 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50%			

3.5.1.8 Mutasi

Tabel Daftar Staf Mutasi

NO	NAMA STAF	UNIT ASAL	UNIT BARU
1	Yanti	Dapur RS PHM	Dapur RSDH

Analisis : pada bulan September 2025 terdapat 1 Mutasi staf

3.5.2 IPSRS

3.5.2.1 Pemeliharaan Alat Medis

Perhitungan capaian berdasarkan jumlah kunjungan per unit oleh elektromedis ke unit-unit di rumah sakit (33 unit) dalam satu bulan

3.5.2.1.1 Tabel Capaian Maintenance Alat Medis

	Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Capaian Maintenance Ruang	90%	84.61	66.6	92.3	76,92	89,74	69.2%	82.05%	64.10%	53,8%			

BULAN	TOTAL ALAT	CAPAIAN	PROSENTASE
Januari	268	154	57.46%
Februari	270	135	50.00%
Maret	276	153	55.43%
April	276	150	54.34%
Mei	275	142	51.64%
Juni	276	165	59.78%
Juli	276	166	60.14%
Agustus	276	194	70%
September	276	77	27,8%

TOTAL ALAT (PERBAIKAN)	TOTAL ALAT
Januari	21
Februari	22
Maret	21
April	17
Mei	26
Juni	15
Juli	25
Agustus	29
September	17

Analisa :

Pada bulan ini dilakukan kalibrasi sekaligus cek alat medis sebanyak 283 alat. Sehingga jika ditambah dengan capaian kalibrasi maka maintenance 100% untuk bulan ini

Rencana Tindak Lanjut :

Koordinasi dengan PT untuk ATEM sesuai ABK

3.5.2.2 Pemeliharaan Alat Non Medis

3.5.2.2.1 Air Conditioner

3.5.2.2.1.1 Tabel Capaian Pemeliharaan AC Split

BULAN	MAINTENANCE / 1 BULAN	MAINTENANCE / 2 BULAN	MAINTENANCE / 3 BULAN	TOTAL
TARGET/BULAN	42	30	23	95
JANUARI	11	6	16	33
FEBRUARI	23	17	11	51
MARET	14	41	6	61
APRIL	7	30	6	43
MEI	19	18	18	45
JUNI	7	16	2	25
JULI	15	21	12	48
AGUSTUS	3	4	16	23
SEPTEMBER	9	21	20	50
OKTOBER				
NOVEMBER				
DESEMBER				

Analisa :

Pada Awal Juni dengan adanya instruksi untuk perbantuan maintenance seluruh AC di 3 klinik Mutiara Sehat membuat pelaksanaan maintenance AC dari tim IPSRS bertambah. Bulan September sudah dibuatkan pemetaan untuk maintenance AC RS dan Klinik.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.3 Genset

1.5.2.2.3.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Genset

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
3	Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
4	April	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
5	Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
6	Juni	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
7	Juli	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
8	Agustus	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
9	September	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target

Analisis :

Pada bulan ini, pemeliharaan genset dilakukan 4x dan sudah terlapor dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi berkala

Melalui link :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/110WG4QS8bLSVMEPsinZvqSZrNmPuELgYBKbs oUd89Eo/edit?gid=2003963143#gid=2003963143>

1.5.2.2.4 Panel Listrik

3.7.2 Tabel Capaian Pemeliharaan Panel

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
3	Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
4	April	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
5	Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
6	Juni	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
7	Juli	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
8	Agustus	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
9	September	4x/bulan	4x/bulan	100%	Ssudah mencapai target

Analisis :

Pemeliharaan panel listrik di Gedung A,B,C,D dilakukan 4x dalam satu bulan dan dilakukan rekapan dokumentasi. Kegiatan ini sudah berjalan sesuai target

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan Evaluasi

1. Link Pemeliharaan Panel Gedung A

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K3AmeFpNj9z9LRM1HECH586kvHODUBC2dxtMaMTx1WQ/edit?gid=1843933243#gid=1843933243>

2. Link Pemeliharaan Panel Gedung B

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wHFESDvzTLN0KBqURQnOMLsTCiqXqpLWCMAG6OMZK7k/edit?gid=1243237048#gid=1243237048>

3. Link Pemeliharaan Panel Gedung C

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vg3l7 SLF6JsafyAZHxZKoPBLPgAbgEV92qYIFZj4M/edit?gid=183386497#gid=183386497>

4. Link Pemeliharaan Panel Gedung D

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fj662P7GKprEiZdfb8deF4N2QJmVQGokfuJtxTLk8DQ/edit?gid=462403140#gid=462403140>

5. Link Pemeliharaan Panel Gedung E

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pBsP-cAEM1iC5zDKXn4KuGJAyz1vEbGXE73obF9jQ80/edit?gid=0#gid=0>

6. Link Pemeliharaan Panel LVMDP

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HH5lmQzu3mwtuMa1Qj72tGD5eDJHUXIzD63VM4qWdNQ/edit?gid=0#gid=0>

1.5.2.2.5 Liquid Oksigen

1.5.2.2.5.1 Tabel Pencatatan Liquid Harian

September							
Tanggal	Stok Liquid	Sebelum pengisian	Penggunaan	Satuan	Keterangan	Pengiriman	Satuan
01/08/2025	2460	2240	220	MMHG			MMHG
02/08/2025	2240	1982	258	MMHG			MMHG
03/08/2025	1982	1349	633	MMHG			MMHG
04/08/2025	1349	3234	0	MMHG	sesudah pengisian	1885	MMHG
05/08/2025	3234	2959	275	MMHG			MMHG
06/08/2025	2959	2641	318	MMHG			MMHG
07/08/2025	2641	2324	317	MMHG			MMHG
08/08/2025	2324	2076	248	MMHG			MMHG
09/08/2025	2076	1842	234	MMHG			MMHG
10/08/2025	1842	1396	446	MMHG			MMHG
11/08/2025	1396	3296	0	MMHG	sesudah pengisian	1900	MMHG
12/08/2025	3296	2988	308	MMHG			MMHG
13/08/2025	2988	2743	245	MMHG			MMHG
14/08/2025	2743	2511	232	MMHG			MMHG
15/08/2025	2511	2277	234	MMHG			MMHG
16/08/2025	2277	2025	252	MMHG			MMHG
17/08/2025	2022	1565	457	MMHG			MMHG
18/08/2025	1565	3165	0	MMHG	sesudah pengisian	1600	MMHG
19/08/2025	3165	2813	352	MMHG			MMHG
20/08/2025	2813	2548	265	MMHG			MMHG
21/08/2025	2548	2265	283	MMHG			MMHG
22/08/2025	2265	2005	260	MMHG			MMHG
23/08/2025	2005	1759	246	MMHG			MMHG
24/08/2025	1759	1039	720	MMHG			MMHG
25/08/2025	1039	3190	0	MMHG	sesudah pengisian	2151	MMHG
26/08/2025	3190	3102	88	MMHG			MMHG
27/08/2025	3102	2828	274	MMHG			MMHG
28/08/2025	2838	2535	303	MMHG			MMHG
29/08/2025	2535	2285	250	MMHG			MMHG
30/08/2025	2285	2044	241	MMHG			MMHG
31/08/2025	2044	1822	222	MMHG			MMHG
Jumlah total pemakaian oksigen bulan ini			8181	MMHG			MMHG
Jumlah total pengisian liquid oksigen bulan ini						7536	MMHG
Rata-rata penggunaan okisgen per hari			544.6785714	MMHG			
Rata- rata pengisian liquid per bulan ini						3014.4	MMHG

Analisis :

Kegiatan sudah dilakukan dengan baik sesuai target, setiap hari dilakukan pengecekan. Stok oksigen selalu terjaga.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.6 IPAL

1.5.2.2.6.1 Tabel Capaian Pemeliharaan IPAL

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
September	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :

Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan. Pencatatan debit IPAL juga dilakukan dan di dokumentasikan.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi melalui link :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fuh93fV8dr-elBhq4_WnFYCEM3i7Q8OnspbTdrherYs/edit?gid=1709907740#gid=1709907740

1.5.2.2.7 Filter Air

3.7.3 Tabel Capaian Pemeliharaan Filter Air

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
September	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi melalui
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1utB1tcauU1Xi-rY4On3PymLDuNIIV0egQRdVkhgSayw/edit?gid=392489547#gid=392489547>

1.5.2.2.8 Lift

1.5.2.2.8.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Lift

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
September	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi melalui link
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/16wmsJe6qBbbD63O5DgfOA6YujFNommAsXIHlsi0g3o0/edit?gid=289224812#gid=289224812>

1.5.2.2.9 UPS

1.5.2.2.9.1 Tabel Capaian Pemeliharaan UPS

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
September	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W11Uen83_wiMyVk-BL2oB4Nc24b7pgBOK6Lufn7skng/edit?usp=sharing

1.5.2.2.10 Air Minum

NAMA	LOKASI	KONDISI
Instalasi Air Minum 1	Lantai 1 Gedung C	Baik

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai

				target
April	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
September	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisa :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan
RTL :
monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMBnSKVuoMC4Z1Wj1dya_t19f-XM272Mf0hcWAsBak4/edit?gid=0#gid=0

1.5.2.2.11 Filter Air Bersih Poli Gigi 1 dan Poli Gigi 2

NAMA	LOKASI	KONDISI
Filter Air Bersih Poli Gigi 1	Lantai 2D	Baik
Filter Air Bersih Poli Gigi 2	Lantai 2D	Baik

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
September	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisa :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan
RTL :
monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMBnSKVuoMC4Z1Wj1dya_t19f-XM272Mf0hcWAsBak4/edit?gid=0#gid=0

1.5.2.2.12 Rekapitan Kegiatan External

BULAN	JUMLAH KEGIATAN (HARI)
Januari	4
Februari	4
Maret	4
April	15
Mei	12
Juni	15
Juli	6
Agustus	12
September	13

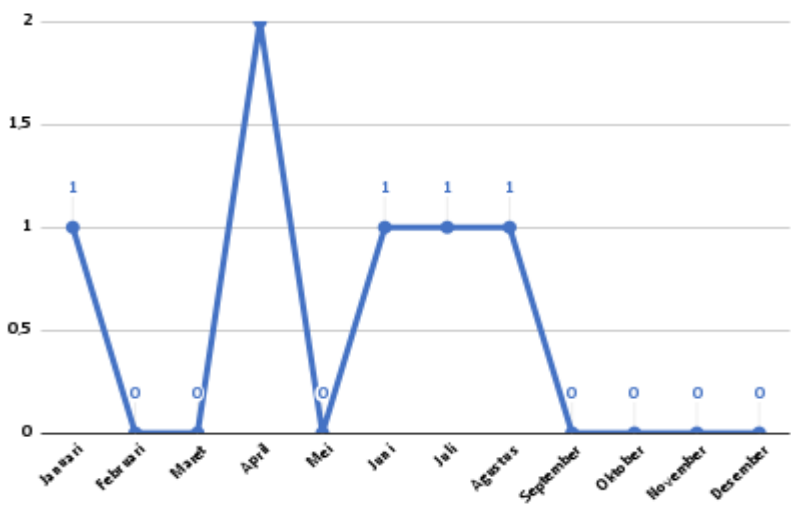
Keterangan :
Perbantuan eksternal ke instansi lain pada bulan ini adalah 10 Mutiara Sehat, 2 RSDH Probolinggo

1.5.3 Security

3.5.3.1 Tabel Angka Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Angka kejadian kehilangan barang	1	0	0	2	0	1	1	1	0		

3.5.3.2 Grafik Kejadian Kehilangan Barang



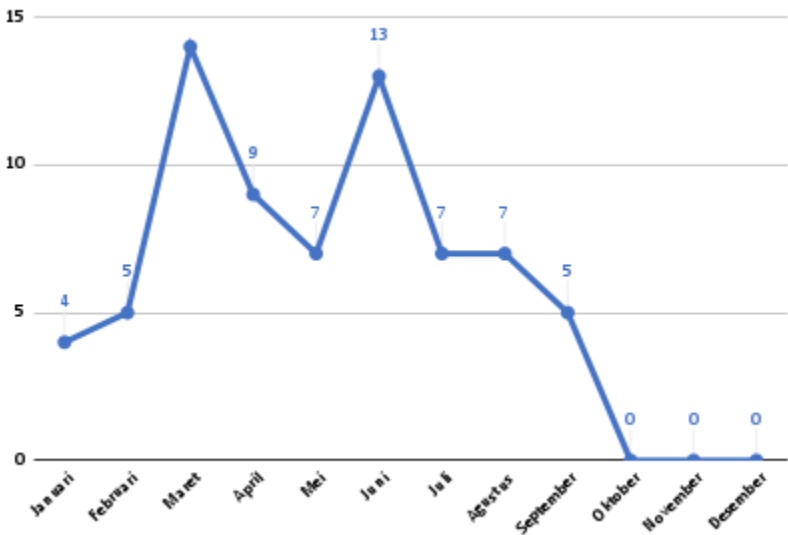
Analisa :
Tidak ada kehilangan barang bulan ini

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.7.4 Tabel Angka Potensi Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Angka kejadian kehilangan barang	4	5	14	9	7	13	7	7	5		

3.7.5 Grafik Angka Kejadian Kehilangan Barang



ANGKA KEJADIAN BARANG BERPOTENSI HILANG		
TANGGAL	KETERANGAN	RTL
02-09-2025	Ditemukan kunci mobil diarea masjid di amankan di pos igd	Sudah diambil pemilik
16-09-2025	Ditemukan kunci motor tertinggal di parkir an karyawan diamankan di pos igd	Sudah diambil pemilik
24-09-2025	Ditemukan kunci motor tertinggal di parkir an karyawan diamankan di pos igd	Sudah diambil pemilik
29-09-2025	Ditemukan hp milik pasien di ruang tunggu poli spesialis diamankan di pos igd	Sudah diambil pemilik
29-09-2025	Ditemukan hp milik pasien di ruang tunggu poli spesialis diamankan di pos igd	Sudah diambil pemilik

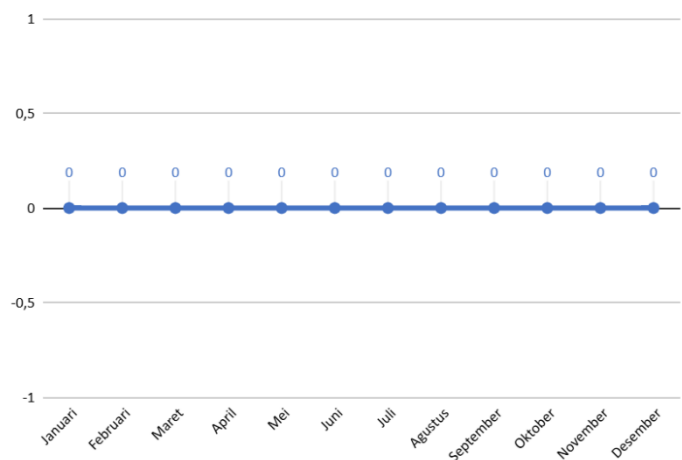
Analisis :
Barang hilang sudah dikembalikan ke pemilik. Alur berjalan baik. Pencatatan telah dilakukan dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.3.3 Tabel Angka Kekerasan di Lingkungan Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1.	Angka kejadian kekerasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kekerasan

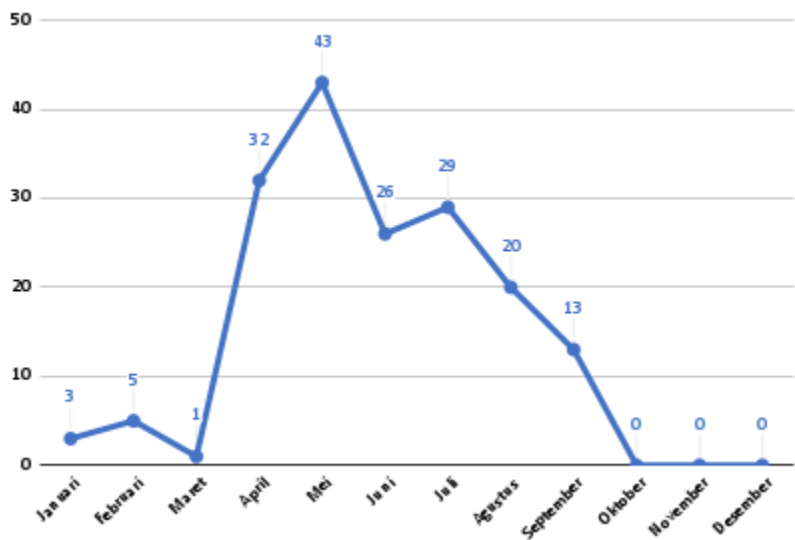


Analisis :
Tidak terdapat kejadian kekerasan karena pelayanan dilakukan dengan baik oleh seluruh karyawan dan tidak ada oknum yang menciptakan kerusakan.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.3.5 Tabel Angka Kejadian Merokok di Area Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Angka kejadian merokok di area Rumah Sakit	3	5	1	32	45	26	29	20	13			

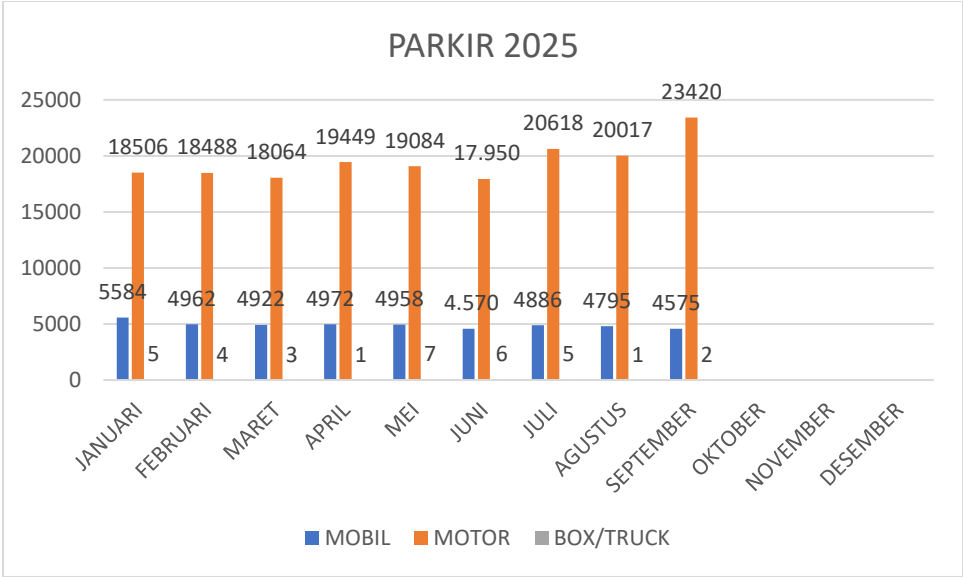


Analisis :
Angka 13 ini terindikasi masih belum terekap semua, hal ini ditunjukkan dari rata-rata per hari yang telah diedukasi karena merokok bisa lebih dari 1x.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring evaluasi. Pencatatan melalui WA grup dan operan shift dengan instrument dashboard spreadsheet.

3.5.4 Parkir

3.5.4.1 Grafik Jumlah Parkir Keluar Non Member



Analisis :
Progres parkir fluktuatif sesuai dengan kunjungan pasien dan jumlah hari libur

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.5 Humas Marketing

3.5.5.1 Perjanjian Kerjasama (PKS)

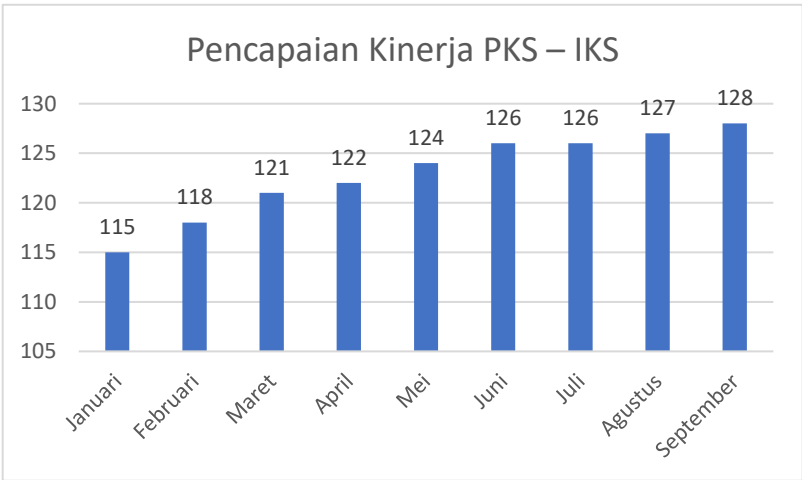
3.5.5.1.1 Pencapaian Kinerja PKS – IKS Juni 2025

No	Bulan	Target	Jumlah				Progres	Total Kurang
			Berlaku	ED	Baru	Kurang Baru		
1	Januari 2025	1 IKS baru	115	6	0	0	(review pihak kedua) 1 (107lastic107 evaluasi) 1 (tdk diperpanjang)	4
2	Februari 2025	1 IKS baru	118	1	1	0	3 (Proses Tanda Tangan Pihak kedua)	3
3	Maret 2025	1 IKS baru	121	1	1	0	1 (Proses review)	1
4	April 2025	1 IKS baru	122	1	1	0	1 (Proses Review Pihak ke 2)	1
5	Mei 2025	1 IKS baru	124	0	1	0	1 (Proses Review Pihak ke 2)	1
6	Juni 2025	2 IKS Baru	126	0	1	1	(2 Proses Review Pihak ke 2)	2
7	Juli 2025	1 IKS Baru	126	1	0	0	1 (Proses Review)	1
8	Agustus 2025	1 IKS	127	1	0	1	1 (Klinik Utama Kedungdoro)	1
9	September 2025	1 IKS	128	1	1	0	1 (Proses Review)	1

Analisis ; - ada bulan Agustus 2025, Perpanjangan PKS dengan Pihak Asuransi Halodoc dan PKS baru dengan Klinik Utama Kedungdoro dalam tahap Review, PKS dengan Hotel Sanaya Ressorst sudah dikirimkan - Draft yang dikirim ke Pihak kedua dalam tahap Review Rencana Tindak Lanjut : - Memfollow up PKS yang sudah dikirim ke pihak kedua
--

3.5.5.1.2 Tabel Progres IKS Baru Juli 2025

No	Nama PKS	Progres Pengurusan	Kendala
1	PT Nayaka Era Husada	Review pihak kedua	Selesai
2	Klinik Brawijaya Lawang	Review pihak kedua	Selesai
3	PT. Asuransi Mandiri Inhealth Manage Care Indonesia	Review pihak kedua	Selesai
4	PT. Kasoem Hearing	Proses TTD	Selesai
5	PT Global Excel	Review	Perbedaan template draft PKS
6	PT Malang Intermedia Pers	Review	Proses Perpanjangan
7	PT BNI Life Insurance	Penambahan Addendum	Selesai
8	Dispenduk Kab. Malang Ketan Ireng	Review (konfirmasi terakhir bulan April masih menunggu pihak sekda)	Proses pihak Dispenduk
9	PT Softex Indonesia (Kimberly-Clark Softex)	Review	Proses Perpanjangan
10	Kirim Proposal Nestle Event Lacto Club	Proses Event	Kirim Dokumen Tambahan
11	PT Mane Indonesia	Review	Proses Pihak Kedua
12	PT Pindad (Persero)	Review	Proses Pihak Kedua
13	RS Panti Nirmala	Review	Proses Review
14	BRI Life	Review	Proses
15	Klinik Utama Kedungdoro	Review	Proses
16	TPA Halodoc	Review	Proses Review



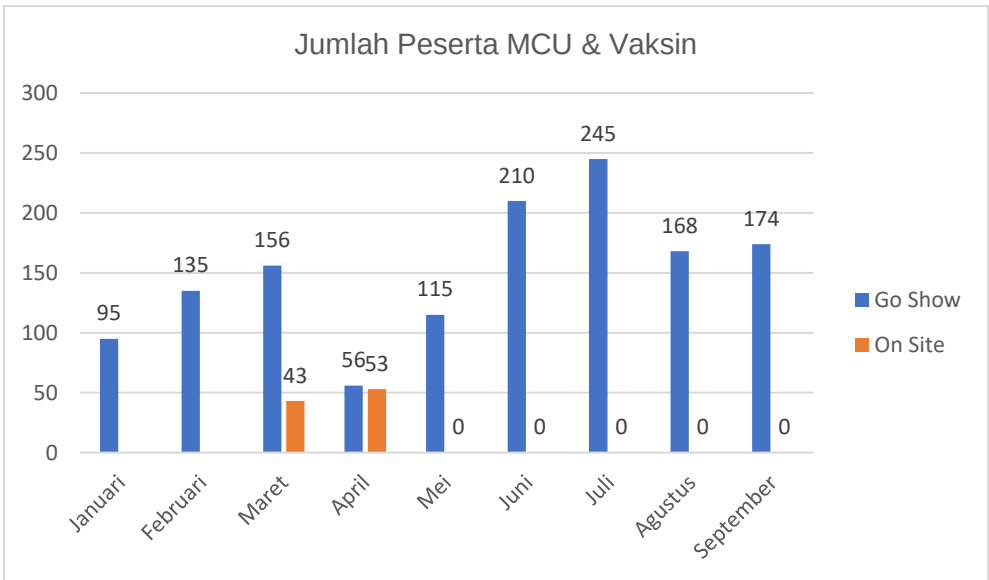
3.5.5.2 Medical Check Up (MCU)

3.5.5.2.1 Pencapaian Hasil Kinerja MCU dan Vaksin Agustus 2025

NO	BULAN	TARGET	JUMLAH PASIEN GOSHOW	ON SITE
1	Januari	25	95	-
2	Februari	25	135	-
3	MARET	150	156	43
4	APRIL	150	56	53
5	MEI	150	115	-
6	JUNI	150	210	-
7	JULI	150	254	
8	AGUSTUS	150	168	
9	SEPTEMBER	150	174	
10	OKTOBER	150		
11	NOVEMBER	150		
12	DESEMBER	150		

Analisis ;
Jumlah peserta MCU dan Vaksin bulan September meningkat 3,57% dari bulan September

Rencana Tindak Lanjut :
1. Melakukan Promosi rutin melalui Social Media dengan update berkala
2. Kunjungan ke SMA dan SMK untuk menawarkan program MCU



3.5.5.2.2 Tabel Evaluasi Hasil Penawaran MCU Tahun 2025

NO	BULAN	INSTANSI	HASIL
1	Januari	PT Berca Kawan Sejati Cab. Malang Official	Tidak ada konfirmasi dan Jawaban setelah di lakukan Follow Up
2	Februari	PT Pesta Pora	Tidak ada konfirmasi dan Jawaban setelah di lakukan Follow Up
		PT Green Mountains Natural Food	Konfirmasi untuk Peserta 106 orang
3	Maret	Meteor Cell Singosari	Sudah terlaksana
		PT Green Mountains Natural Food	Konfirmasi untuk Perubahan Peserta menjadi 53 orang dan pengajuan dengan Bus MCU
4	April	PT Green Mountains Natural Food	Sudah terlaksana
5	Mei	PT Kencana Tiara Gemilang	Sudah terlaksana 10 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
		Laboratorium Radika Diagnostik	Sudah terlaksana 11 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
6	Juni	PT Puninar Jaya	Sudah terlaksana 7 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit

		Laboratorium Radika Diagnostik	Sudah terlaksana 1 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
7	Juli	PT Puninar Jaya	Sudah terlaksana 5 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
		PT Indonesian Marine	Sudah terlaksana 5 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
8	Agustus	PT Arjaya Mukti Santosa	Sudah terlaksana 4 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
9	September	Sjava Travel Indonesia	Sudah terlaksana Vaksin dengan 32 Jamaah di Rumah Sakit

3.5.5.2.3 Kegiatan Kunjungan Eksternal

3.5.5.2.3.1 Tabel Jumlah Kunjungan Eksternal

NO	KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Jumlah Kunjungan	5	10	2	2	2	17	6	6	10		

Analisa :

Kunjungan eksternal disesuaikan dengan permasalahan yang ada, komunikasi sekarang juga dilakukan dengan online pada beberapa target klinik dan mitra. Untuk kegiatan umum seperti pengenalan RS dll sudah dilakukan di akhir Juli FKTP Gathering.

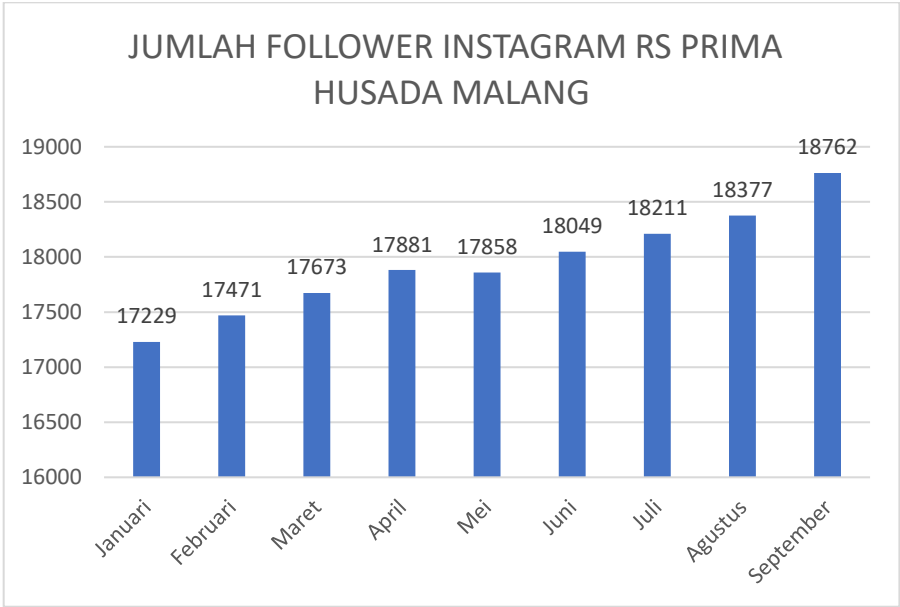
Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi berkala.

1.5.5.2.4 Digital Marketing

1.5.5.2.4.1 Daftar Kegiatan Digital Marketing

Platform Instagram

JUMLAH KONTEN BARU	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
FEED FOTO	3	7	9	10	10	9	10	8	6			
REELS	5	5	11	5	1	1	6	7	3			
STORY	6	10	14	8	12	10	18	11	17			
TOTAL	14	22	34	28	23	19	34	26	26	0	0	0
JUMLAH TOTAL POSTINGAN (BARU + LAMA)	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
FEED FOTO	6	11	16	19	10	12	14	8	10			
FEED VIDEO	0	0	0	0	1	1	6	7	3			
REELS	3	4	5	7	1	1	6	7	3			
STORY	29	33	28	38	12	29	74	24	51			
TOTAL	38	48	49	64	24	20	100	46	67	0	0	0
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH FOLLOWER (CUT OFF TANGGAL 1)	17,229	17,471	17.673	17.881	17850	18049	18.211	18.377	18.762			
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH PENINGKATAN FOLLOWER	496	242	202	208	374	286	346	283	385	0	0	0
TARGET	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300



Analisa :

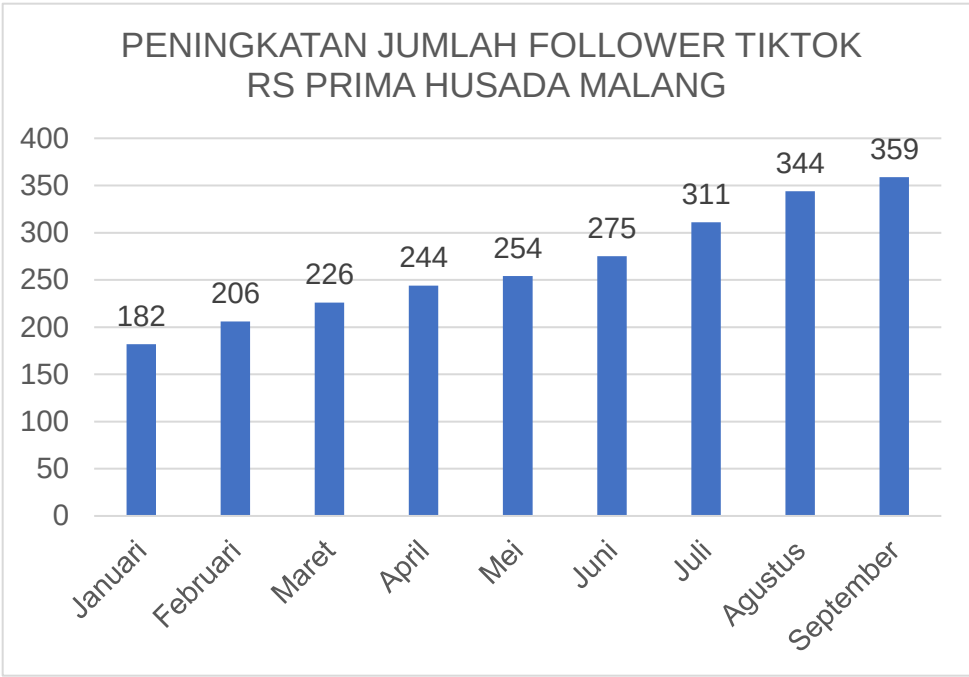
Jumlah Follower Instagram RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebesar 2,10%. dari bulan Agustus

Rencana Tindal Lanjut :

- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS setiap harinya
- 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
- 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Platform Tik Tok

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH KONTEN BARU	2	3	4	0	2	1	3	3	3			
TARGET	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH FOLLOWER (CUT OFF TANGGAL 1)	182	206	226	244	254	275	331	344	359			
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH PENINGKATAN FOLLOWER	16	24	20	18	10	21	36	33	15	0	0	0
TARGET	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH LIKE	45	72	1023	1085	1187	1222	1336	1476	1585			



Analisa :
Jumlah Follower Tiktok RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebesar 4,36% dari bulan Agustus

- Rencana Tindal Lanjut :**
- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
 - 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 - 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

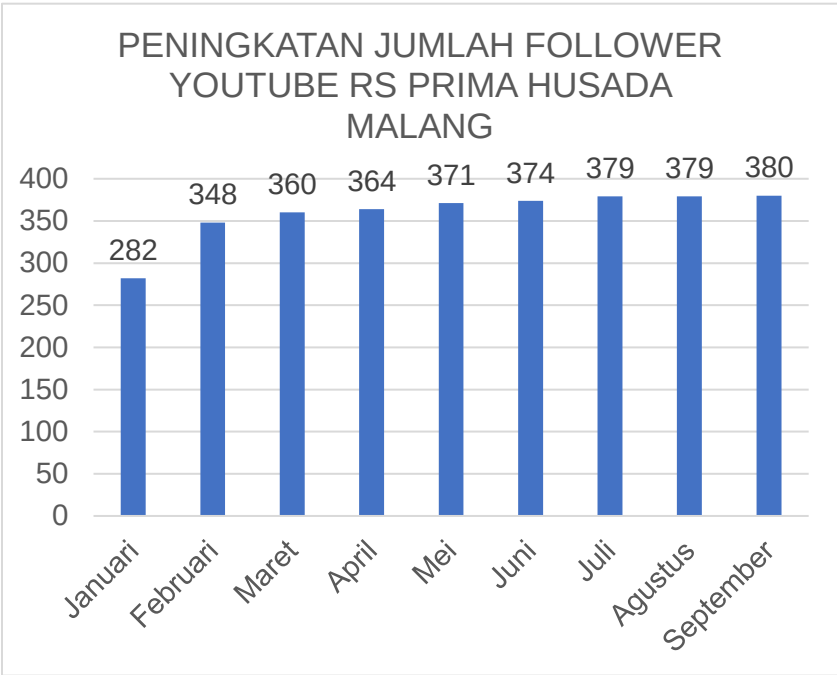
Platform Youtube

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH KONTEN BARU	0	2	0	0	0	0	0	0	0			
TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH SUBS	282	348	360	364	371	374	379	379	380			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH PENINGKATAN SUBS	4	66	12	4	7	3	5	0	1	0	0	0
TARGET	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

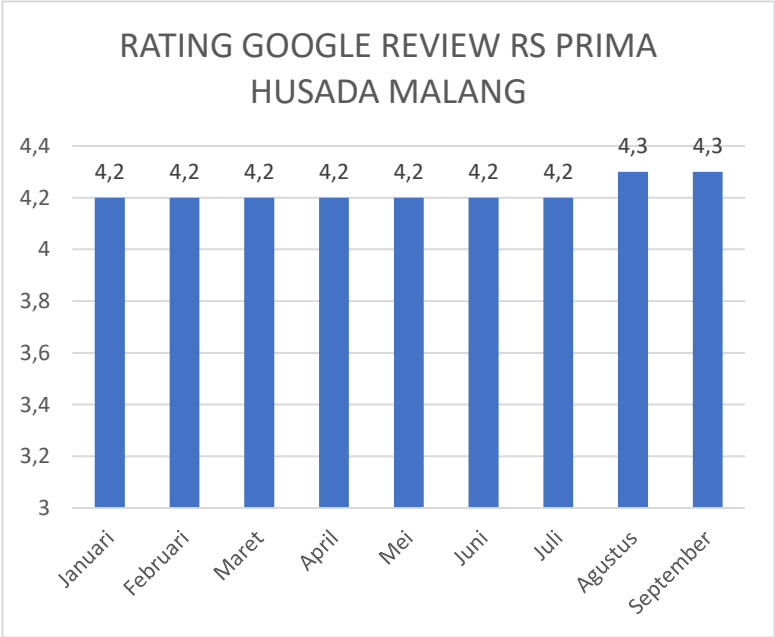


Analisa :
Jumlah Follower Youtube RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan Sebesar 0,26% dari bulan Agustus

- Rencana Tindal Lanjut :**
- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
 - 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 - 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Google Review

PROGRESS	JAN	FEB	MAR	AP	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH RATING	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3			



NO	BULAN	KOMENTAR POSITIF	KOMENTAR NEGATIF
1	Jan-25	18	6
2	Feb-25	13	6
3	Mar-25	7	5
4	Apr-25	25	10
5	May-25	15	7
6	Jun-25	19	3
7	Jul-25	60	3
8	Aug-25	44	10
9	Sep-25	0	5
10	Oct-25	0	0
11	Nov-25	0	0
12	Dec-25	0	0

Analisa :
 Progres untuk Rating Google Review RS Prima Husada Malang tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dari bulan September. Namun Komentar positif meningkat.

Rencana Tindal Lanjut :
 Meningkatkan Survei kepuasan pasien dengan melakukan pengisian Google Review

3.5.5 Penjaminan

3.5.5.1 Piutang

3.5.5.1.2 Analisa Progres Penyelesaian Piutang

NO	DESKRIPSI	SALDO AWAL PIUTANG	PEMBAYARAN (BULAN SEBELUMNYA)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN SEBELUMNYA)	SISA PIUTANG (BULAN SEBELUMNYA)	PENAMBAHAN PIUTANG (BULAN BERJALAN)	PEMBAYARAN (BULAN BERJALAN)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN BERJALAN)	SISA PIUTANG (BULAN BERJALAN)	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR PIUTANG					JUMLAH PIUTANG
											0-30 HARI	31-60 HARI	61-90 HARI	91-120 HARI	>120 HARI	
		a	b	c	(a-b-c=d)	e	f	g	(e-f-g=h)	d+h						Total
PERIODE SEPTEMBER 2025																
1	Asuransi	434.895.439	239.880.592	3.718.837	191.257.647	201.489.744	23.883.416	896.528	175.886.789	367.143.836	323.437.889	24.870.487	11.859.741	6.879.383	3.986.170	387.143.836
2	Perusahaan	822.050.712	153.700.011	20.001	368.370.702	338.685.476	-	-	338.685.476	707.063.179	574.594.779	99.446.887	-	26.267.721	87.263.741	707.063.179
3	Mandiri Inhealth	91.526.312	36.022.319	1.782.044	51.716.949	42.132.170	-	-	42.132.170	93.849.119	93.477.889	-	-	-	372.639	93.849.119
4	Jasa Raharja	1.791.685	1.523.312	268.370	-	343.821.158	149.579.431	0	94.241.727	94.241.727	-	-	-	-	94.241.727	94.241.727
5	BPKS Ketersapakerjaan	652.061.764	628.089.870	47.691	23.924.203	559.370.244	-	-	559.370.244	583.294.447	-	-	-	-	583.294.447	583.294.447
									Total Saldo	1.845.592.307	1.521.619.831	37.585.693	35.077.494	23.176.199	75.020.804	1.845.592.307

Keterangan : Cut off 31 Juli 2025 sebesar Rp 1.845.592.307

3.5.5.2 Klaim Pending

NO	MASALAH	DAMPAK	TINDAK LANJUT
RAWAT INAP			
1.	Tidak sesuai kaidah pengkodean klinis, pasien sequele cva gunakan kode I69.3	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
2	Penunjang aki tidak sesuai dengan BA kesepakatan, reseleksi N19 (unspecified renal failur)	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
3	Tidak sesuai standar pelayanan, serologi igm+4 rajal, tidak di temukan indikasi ditagihkan rawat inap	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
4	Berdasarkan hasil ur, data anomali di kc malang penagihan tertinggi dengan tf	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending

	yaitu RSPH, jika benar di RSPH dengan tf maka KLB tidak dijamin JKN		
5	Intubasi kurang lebih 3 jam, sebelum meninggal, indikasi upcoding hapus 96.71 (ventilator)	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
6	Tidak sesuai standar pelayanan, pterigium tanpa penyulit dapat dilakukan di rawat jalan	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending
RAWAT JALAN			
1	Fragmentasi	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending

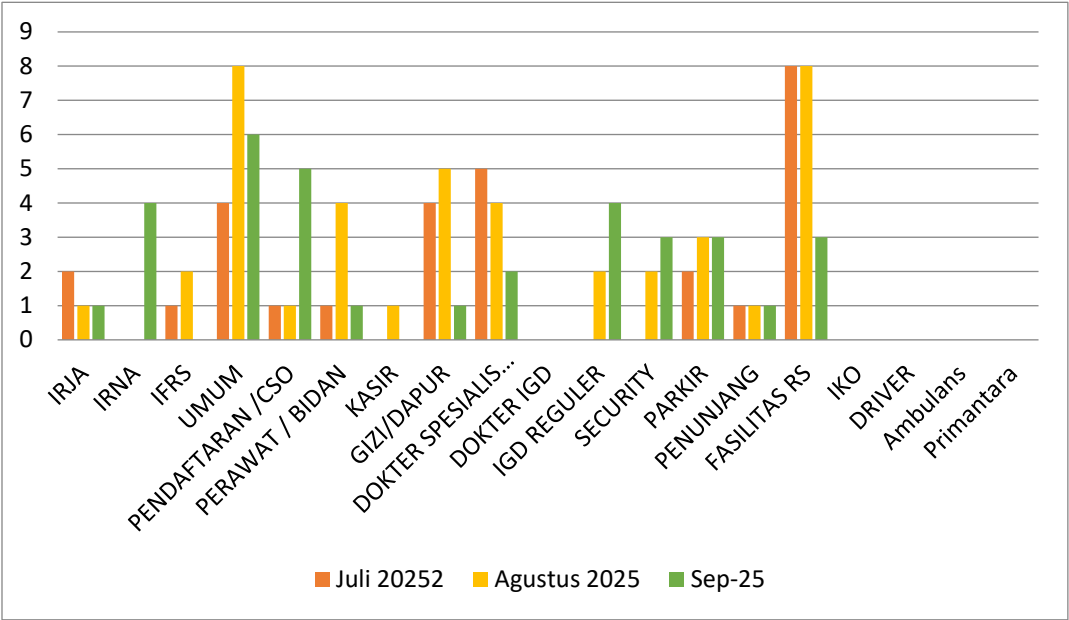
3.5.6 PIPP – MOD – MPP

3.5.6.1 Laporan Komplain Pasien

1.5.6.1.1 Tabel Distribusi Laporan Komplain Pasien Per Unit Bulan September 2025

NO	JUMLAH KOMPLAIN PASIEN TERHADAP UNIT	JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
1.	IRJA	2	1	1
2.	IRNA	0	0	4
3.	IFRS	1	2	0
4.	UMUM	4	8	6
5.	PENDAFTARAN /CSO	1	1	5
6.	PERAWAT / BIDAN	1	4	1
7.	KASIR	0	1	0
8.	GIZI/DAPUR	4	5	1
9.	DOKTER SPESIALIS (KOMITE MEDIS)	5	4	2
10.	DOKTER IGD	0	0	0
11.	IGD REGULER	0	2	4
12.	SECURITY	0	2	3
13.	PARKIR	2	3	3
14.	PENUNJANG	1	1	1
15	FASILITAS RS	8	8	3
16	IKO	0	0	0
17	DRIVER	0	0	0
18	Ambulans	0	0	0
19	Primantara	0	0	0
Total		29	42	34

3.5.7.1.1 Grafik Laporan Komplain Pasien Per Unit September 2025



- Analisis :**
- Jumlah pasien komplain selama Bulan September 2025 mengacu pada komplain pasien. Asal complain pasien ditemukan dari beberapa unit yang ada di RS.
1. Jumlah complain Pada bulan September 2025 menurun dibanding pada bulan sebelumnya. Pada bulan Juli 2025 sebanyak 28 pasien, pada bulan agustus 2025 sebanyak 42 pasien. Sedangkan pada bulan September 2025 sebanyak 34 pasien.
 2. Komplain terbanyak pada bulan September 2025 yaitu dari bagian UMUM dan pendaftaran RS sebanyak 8 kasus yang disampaikan secara kuesioner, WA maupun tatap muka langsung.
 3. Jumlah complain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 10 kasus complain dengan rincian :
 - a) Parkir sebanyak 2 kasus yaitu terkait pembayaran parkir yang terlalu mahal, permintaan diberikan kartu bebas parkir untuk pasien rawat inap,
 - b) Fasilitas RS sebanyak 2 kasus yaitu perlebar ruangan rawat inap dan perbaharuan kamar mandi.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

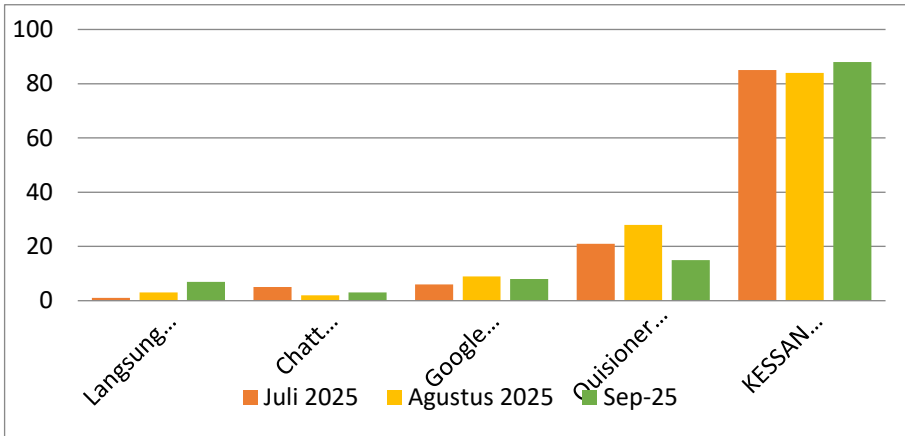
3.5.7.2 Tabel Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan September 2025

NO	JENIS PASIEN COMPLAIN	JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
1.	Langsung tatap muka	1	3	7
2.	Tidak Langsung :			
a	Chatt (Whatsapp)	5	2	3
b	Google reviuw	6	9	8
3.	Quisioner/kolom kritik saran	21	28	15
4	KESSAN	85	84	88

Rincian KESSAN

KESSAN (Kesan dan Pesan Setelah Layanan) merupakan aplikasi dari BPJS Kesehatan untuk mendorong FKTP dalam meningkatkan layanan bagi peserta JKN-KIS serta memenuhi kewajiban terhadap kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan

3.5.7.3 Grafik Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan September 2025



Analisis :

Pada bulan September 2025 jumlah jenis pasien complain terbanyak didapatkan dari Quisioner yaitu sebanyak 15 kasus complain. Sedangkan terbanyak kedua yaitu dari Google viuw sebanyak 9 kasus.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.4 Tabel Waktu Tanggap dan Penyelesaian Komplain Bulan September 2025

NO	Jenis pasien complain	Waktu tanggap		Waktu penyelesaian		< 3 hr Manajerial RS	7 hr ke PT
		Standard < 5 ‘	Pencapaian (dari waktu total dibagi jml komplai atau rata2 waktu tanggap)	Standard < 60 ‘	pencapaian		
1.	Langsung tatap muka	100%	100%	100%	100%	0	0
2.	Chatt (WA/Tele/SMS/IG)	100%	100%	100%	100%	0	0
3.	Google reviuw	100%	100%	100%	70%	30%	0
4.	Quisioner/kolom kritik saran	100%	100%	100%	60%	40%	0
5.	KESSAN	100%	100%	100%	100%	0	0

Analisis :

Waktu tanggap dan penyelesaian komplain pasien pada bulan September 2025 masih ada yang belum sesuai target 100% yaitu complain melalui Quisioner dengan capaian 60% hal ini dikarenakan ada beberapa kasus complain yang tidak bisa langsung diselesaikan seperti fasilitas RS yang memerlukan diskusi dengan manajemen.

Jumlah komplain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 4 kasus complain dengan rincian :

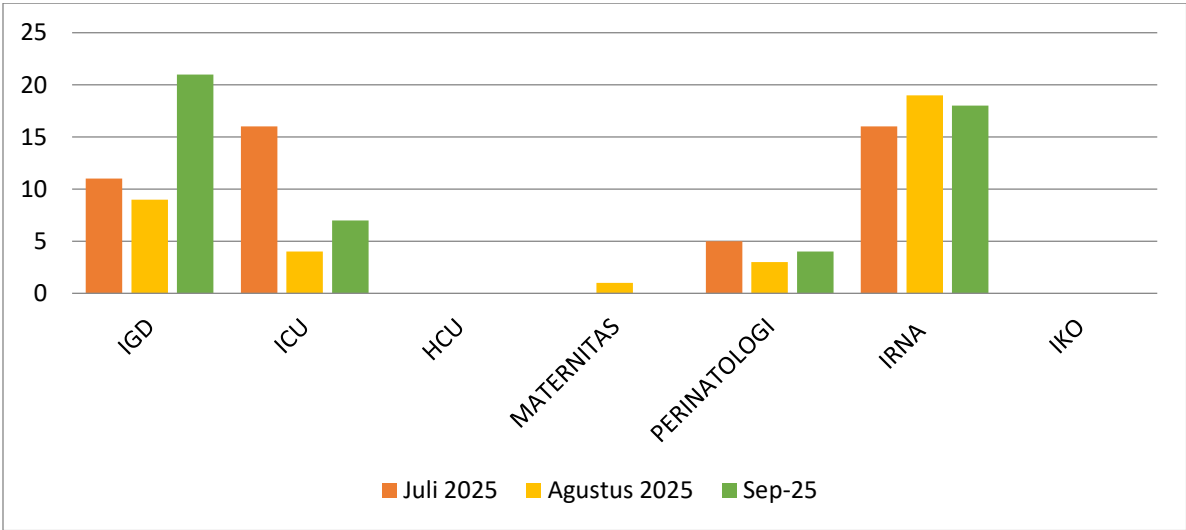
- 1) Parkir sebanyak 3 kasus yaitu terkait pembayaran parkir yang terlalu mahal, permintaan diberikan kartu bebas parkir untuk pasien rawat inap,
- 2) Fasilitas RS sebanyak 2 kasus yaitu perlebar ruangan rawat inap dan perbaharuan kamar mandi.
- 3) IRNA sebanyak 1 kasus, yaitu terkait ketersediaan vaksin Hbo unijec. Untuk RS swasta untuk vaksin Hb.O unijec tidak diberikan, bisa Kerjasama dengan PKM setempat
- 4) UMUM sebanyak 4 kasus yaitu terkait penertiban pengunjung saat berkunjung, anak kecil masih bisa masuk

Rencana Tindak Lanjut :
Penyelesaian komplain dilakukan dengan melakukan telusur lapangan sederhana dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.5 Laporan Pasien Rujuk
3.5.7.5.1 Tabel Distribusi Pasien Rujuk Per Unit Bulan September 2025

NO	UNIT PERUJUK	JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
1.	IGD	11	9	21
2.	ICU	16	4	7
3.	HCU	0	0	0
4.	MATERNITAS	0	1	0
5.	NEONATOLOGI	5	3	4
6	IRNA	16	19	18
7	IKO	0	0	0
Total		33	48	36

3.5.7.5.2 Grafik Jumlah Pasien Rujuk Eksternal Bulan Agustus 2025



3.7.7 Tabel Rincian Pasien Rujuk September 2025

NO	Nama Pasien	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP	RS TUJUAN	ALASAN RUJUK	LAMA RAWAT	PLAVON HABIS
1	Mariatin	IGD	ALO ec CKD	dr. Ardhi. Sp. PD	RS Lavalete	pro HD	2	Tidak
2	Khotimatus Sholihah	IRNA	NSTEMI, post HT Emergency, LV Failure, HHD, AKI dd ACKD st 5 + oliguria	dr. Mira. Sp. JP	RS Lavalete	pro HD	6	Tidak
3	Ngudi Sugeng Prasetya	IGD	COB 111 + Fr. Nasal et Frontal et Parietal Dextra + Pneumocephalus + Contusional Hemorrhage	DR Fachriy, Sp.BS	RSKarsa Husada	pro Perawatan lebih lanjut	1	Tidak

			Occipital					
4	Muhammad Isra Gaus	IGD	Susp. SOL Supratentorial + susp. tumoral Bleeding + Edema Cerebri	dr. Farid Sp. S	RS Karsa Husada	pro Eksisi Tumor	1	Tidak
5	Sri Wigati	IRNA	Fatty Liver + Melena	dr. Ardhany Sp.PD	RSSA	pertimbangan endoskopi dan perawatan SpPD-KGEH	4	Tidak
6	Rony Agus Flouryanto	IGD	EFUSI PLEURA DEXTRA	dr. Elvi Sp.P	RS LAVALETTE	PRO PERAWATAN LEBIH LANJUT (PRO EVAKUASI CAIRAN)	1	Tidak
7	Ny. Umul Faiza	IRNA	Nodul Metastase Multiple di Hepar	dr. Heri, sp. pd	RSSA Malang	KEMOTERAPI	3	Tidak
8	Ny Badriyah	IRNA	ILEUS OBSTRUKTIF+MELENA	dr. ardhany, sp. pd	RSSA Malang	pertimbangan endoskopi dan Sp.PD KGEH	2	Tidak
9	An. Safa Nabila Putri	IRNA	MENINGITIS+LEUKOSITOSIS	DR DICKY, SP.A	RSSA Malang	perawatan subspesialis + PICU	2	Tidak
10	Tn Toni Dwi Putra	ICU	DM TYPE 2+HIPERKALEMIA+SYOK+CKD STAGE V	dr. ardhany, sp. pd	RS LAVALETTE	PRO HD	2	Tidak
11	By Ny Sri Bawon	NEO	RDS ok HMD neonatal pneumonia	DR FIONA, SP.A	RS LAVALETTE	pro subspesialis konsultan neonatologi	2	Tidak
12	By Ny Erwin	NEO	RDS ok HMD dd neonatal pneumonia	DR FIONA, SP.A	RST Malang	pro subspesialis konsultan neonatologi	2	Tidak
13	Tn Suwaji	IRNA	CVA ICH+Hemiparese Dextra	dr. Farid Sp.S+dr.Eko Sp.KFR	RSSA	Pro evakuasi hematome, Stroke unit	4	Tidak
14	Dina Ulyana	IGD	G1 P0000 AB0 UK 28-30 MG T/H DG PPR0M	DR AIDA, SP.0G	RSSA	penanganan lanjutan untuk bayi (bayi prematur + BBLSR)	2	Tidak
15	Agus Suciati	IRNA	Diare Kronis	DR ARDHANY, SP.PD	RSSA	Pro pertimbangan colonscopy dan perawatan Sp.PD-KGEH	4	Tidak
16	Rodiatul Fitriah	IGD	CKD + DM HIPERGLIKEMIA+ HEMATEMESIS+ HT	DR HERIYATMO, SP.PD	RS LAVALETTE	PRO HD CITO	1	Tidak
17	Padi	IRNA	CKR 456, CRUSH INJURY DAN OPEN DEGLOVING INJURY ANTEBRACHII ET MANUS DEXTRA	DR KUNTADI SP OT	RSSA	Pro Perawatan Lebih lanjut	2	Tidak
18	Mudjilah	ICU	CVA ICH, CVA INFARK, HT EMERGENCY	DR DEWI SP S	RSSA	Pro Stroke Unit	3	Tidak
19	Suryanto	ICU	DOC EC CVA ICH IVH	DR FARID SP S	RST DR SOEPRAOEN	Pro Sub Spesialis	5	Tarif rs : 6.147.745 Plavon : 4.860.600 Minus : 1.287.145
20	Laticah	ICU	ACUTE DOC dengan konvulsi	DR ARDHI SP PD	RSSA	Pro back up HD dan penegakkan diagnosis AVM dan CTA	2	Tidak
21	Ny. Sukartini	NEO	Open Fraktur Impresi Frontal	dr. Fachriy, Sp.BS	RSSA	Pro Craniotomy Elevasi Fraktur	3	Tidak
22	By. Ny. Lia Rosalina	IRNA	Np- Spt, BBLASR, obs. dyspnea ok neonatal penumonia dd HMD, Asfiksi, N.E.C	dr. Ratih, Sp. A	RS Lavalette	pro subspesialis konsultan neonatologi	4	Tidak
23	Umayah	IGD	stemi inferolateral	dr. Mira.Sp.JP	RSI Aisiyah	Pro PCI	2	Tidak
24	Suliyanto	IRNA	uremic encephalopathy	dr. Ardhi.SP.PD	RS.SUTOMO SURABAYA	Pro HD CITO	5	Tidak
25	Ny.Warti	ICU	Acute on CKD	dr. Ardhi.SP.PD	IGD Reguler RSSA	Pro HD CITO	4	Tidak
26	Ny.Likamah	IGD	Acute on CKD	dr. Ardhi.SP.PD	RSI Aisiah	Pro HD CITO	1	Tidak
27	Tn Muh Saifudin	IGD	fr zygoma d/s", "fr os radius d	dr. Sigit .SP.bp konsul dr. kuntadi sp.ot	RS Karsa Husada Batu	Pro Plating multiple	2	Tidak
28	By. Ny. Apsah	NEO	Neonatal Bronchopneumonia	dr. Fiona, Sp. A	RS Lavalette	pro subspesialis konsultan neonatologi + Tatalaksana Lanjutan	4	Tidak
29	Ny Indah Sulis Setyowati	IRNA	B24+Seizure+SOP	dr Farid, Sp.S	RSSA	Pro penatalaksanaan B24	3	Tidak
30	Ny. Malichah	IGD	Bullous Pemphigoid	dr Vita Sp KK	RSSA	Pro perawatan Lama	2	Tidak

31	Ny. Sri Utami	IRNA	DF, Gum Bledding, Pansitopeni	dr Ard hany Sp PD	RSSA	Pertimbanagn Sub Spesialis IPD- KHOM	3	Tidak
32	Tn. Hadi Santoso	IGD	STEMI ANTEROSPTAL, CAD POST PCI	dr Mira Sp JP	RS UMM	PRO PCI	2	Tidak
33	Tn. Agus Purnomo	IRNA	CVA SAH susp Ruptur Aneurisma Otak post op VP Shunt	dr. Fachriy, Sp. BS	RSSA	PRO CT Angiografi, clipping aneurismia	3	Tidak
34	Ny. Suparti	IRNA	CF Head Femur Dext	dr. Arianto SP. OT	RS Karsa Husada Batu	Pro alat khusus	2	Tidak
35	Misnaeni	IGD	SEPTIC SHOCK, AKI	dr Mira Sp JP	RSUB	Pro back up HD	1	Tidak
36	Ny. Siti Aisyah	IRNA	PANSITOPENIA SUSP KEGANASAN, HEMATOLOG ANEMIA APLASTIC, MULTIPLE MILOMA	dr Heri SP PD	RSSA	Pro BMP + Kemo	2	Tidak
37	Tn.Djoko Prayitno	IRNA	Pansitopenia w/o organomegaly	dr Aji Sp PD	RSSA	Pro BMP + perawatan KHOM	3	Tidak
38	Tn.Syamsul Wibisono	ICU	CVA ICH, HT Emergency	dr Syahrir Sp N	RSSA	Pro Stroke Unit	2	Tidak
39	Tn.Agus Wahyu Utomo	IRNA	CVA Sequele, Pneumonia	dr. farid Sp.N	RS lavalette malang	Pro Stoke Unit	5	Tidak
40	An. Achmad Zen	IGD	COS, CONTUSIO CEREBRI	dr. Fachriy, Sp. BS	RST SOEPRAOEN	PRO BEDAH SARAF dan BTKV	2	Tidak
41	Wakinem	IGD	DOC EC CVA	dr. Farid Sp. N	RSUD BANGIL	Pro Stoke Unit	2	Tidak
42	Edy Setyawan	IGD	Susp Emboli Paru (Well Score High Risk)	dr. Miryanti Sp.JP	RSSA	Pro CT Scan Paru dan Pro Penanganan Emboli Paru	1	Tidak
43	Enik Hidayati	IGD	STEMI inferior onset >12jam	dr. Miryanti Sp.JP	RS UMM	Pro primary PCI	1	Tidak
44	Abd Kadir	IGD	OF OS RADIUS ULNA	dr. Arianto SP. OT	RSSA	pro penanganan susp ruptur a ulnaris	1	Tidak
45	Muhammad Fadil Satya Dirga	IGD	COB + ICH + SAH	dr. FACHRI SP.BS	RST	pro penanganan lebih lanjut	1	Tidak
46	Ester Ningmawati	IRNA	DIABETIC FOOT+SEPSIS+DM TYPE 2+ANEMIA	dr. Ardhi,Sp.PD	RSSA	Pro Tatalaksana lebih lanjut penanganan sepsis pemberian AB sesuai kultur (deeskalasi AB)	4	Tidak
47	Yuliasih	ICU	Syok kardiogenik+STEMI Inferoposterior dan RV infarct pasca fibrinolitik (berhsl)+AV block derajat 1	dr. Miryanti Sp.Jp	RS UMM	Pro PCI	2	Tidak
48	Daijar	IGD	CLOSE FRAKTUR COLUM FEMUR SINISTRA+CKR 456 + FRAKTUR ZIGOMA	dr ARIANTO, Sp.OT	RST	pro penanganan lebih lanjut	1	Tidak
49	Nursiyah	IGD	SOL supra tentorial+Hydrocephalus	dr. Farid., Sp. N	RST	pro evakuasi tumor	1	Tidak
50	Lilis	IGD	G2P0ab 1 UK 30-32 MGG DG EKLAMSIA+HT EMERGENCY+PRIMITUA PRIMER++RIW INFERTIL 11 TH+HSVB	dr. HUMAIRA,SP.OG	RSSA	pro penanganan lebih lanjut	1	Tidak

- Analisis :**
- Terjadi peningkatan jumlah pasien yang dirujuk ke RS lain dalam bulan September 2025. Pada bulan juli 2025 sebanyak 48 pasien. pada bulan agustus 2025 sebnayak 36 pasien Sedangkan pada bulan September sebanyak 50 pasien
 - Alasan rujuk karena sarana dan prasarana tidak dimiliki oleh RSPH Malang, seperti :
 - Pro PCI
 - Pro CVCU
 - Pro stroke unit
 - Pro HD
 - Pro Bedah digestif
 - MRI
 - Pro bedah saraf lanjutan
 - Membutuhkan alat khusus
 - Membutuhkan pengobatan ARV
 - Alasan rujuk karena plavon habis menurun dari bulan sebelumnya. Pada bulan Agustus 2025 terdapat minus sebanyak : Rp. 5.340.634 Sedangkan Pada bulan September 2025 terdapat Minus sebanyak Rp.1.287.145

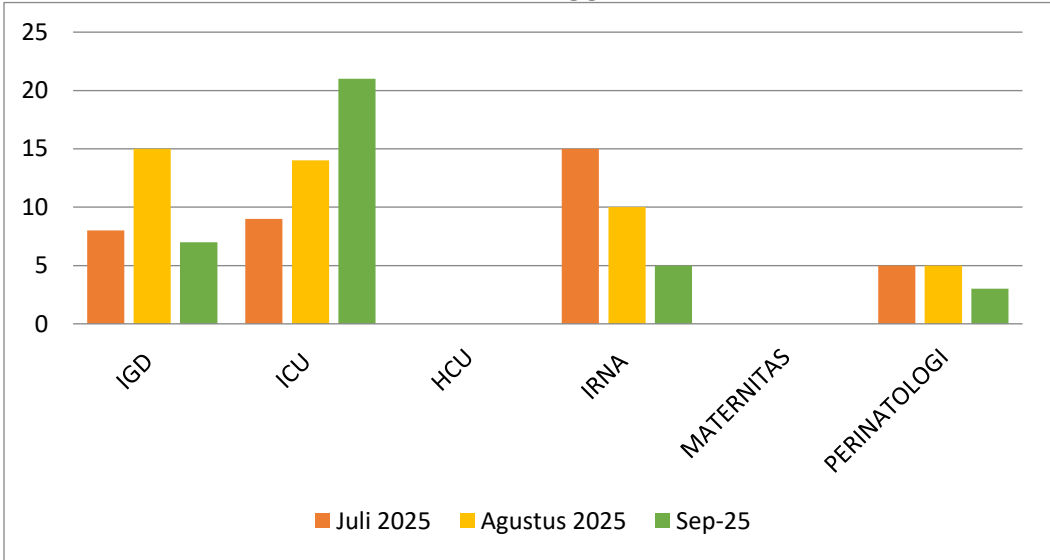
Rencana Tindak Lanjut:

- 1. Dilakukan evaluasi alasan terhadap rujukan pasien keluar yang semakin meningkat
- 2. Dilakukan komunikasi dengan DPJP melalui rapat komdik terkait plavon minus.

3.5.7.5.3 Jumlah Pasien Meninggal Bulan September 2025

NO	UNIT ASAL PASIEN MENINGGAL	Juli 2025	Agustus 2025	September 2025
1.	IGD	8	15	7
2.	ICU	9	14	21
3	HCU	0	0	0
4.	IRNA	15	10	5
5.	MATERNITAS	0	0	0
6	NEONATOLOGI	5	5	3
Total		37	39	36

Grafik Jumlah Pasien Meninggal September 2025



Tabel Rincian Pasien Meninggal September 2025

NO	Nama Pasien	UNIT	Diagnosis	DPJP
1	Ny. Yuni Isaroh	IGD	CARDIAC ARREST	dr. ARDHANI SP.PD konsul dr HERU SP.AN
2	By. Ny. Anggun	NEO	NEONATAL IMATUR, MULTIPLE CINGENITAL	DR HUMAIRA, SP.OG
3	Tn Rochmat	IGD	COB E1V1M1 + Fraktur Depressed Occipital + Fraktur Linier Parietal + ICH + Contusio Cerebri + SAH	DR ZAKI, SP.B
4	Ponadi	ICU	Hidrosefalus+CVA ICH post Op Vp Shunt+IVH+DM 2	DR FACHRIY, SP.BS
5	Tn. Agus Dwi Suyanto	ICU	DOC+CVA 2nd ATTACK+Hidrosefalus post Op Vp Shunt+CVA ICH+IVH+SUSP PNEUMONIA VP SHUNT	DR FACHRIY, SP.BS
6	By. Ny. Ratih Retnaningtyas	NEO	IUFD	DR HUMAIRA, SP.OG
7	Muhammad Yusron Mustaufidi	ICU	CVA ICH + IVH, Edema Cerebri, HT Emergency	DR SYAHRIR, SP.N
8	Nasiami	IGD	DOA	DR RINO
9	Ny. Sunarsih	IRNA	Gangren Necrotic diabetic pedis (D)	dr. Anton Sp.B

10	Tn. Martawi	ICU	CA Paru	dr. Elvi Sp P
11	Tn. AHCMAD WAHYU	IGD	DOC ec CVA	dr. Farid Sp.N
12	Tn. SUCITRO	IGD	DOC ec Susp CVA	dr. Farid Sp.N
13	Tn. Fadjar Satria	ICU	CVA ICH, DM Pneumonia, AF	dr. Farid Sp S,
14	Tn. Abd Rouf	ICU	CVA CVA ICH DOUBLE HEMIPARESE	dr. Farid Sp S,
15	Ny Kasti	ICU	CVA Trombosis 2nd Attack	dr. FahimmaSp S,
16	Tn Ifan Nurdiansyah Re	ICU	syok cardiogenic+dilacted cardiomyopat+PVC+SVT	dr. Miryanti Sp.JP
17	Ny. Romlah	ICU	syok cardiogenic	dr Yoga Sp JP
18	Tn . Hari Subagyo	ICU	DOC, COPD, Anemia	dr Andy Sp P
19	By. Ny. Rena Ackhuria	NEO		dr Dicky Sp A
20	Tn . Sumantri	ICU	ARDS, DM Type 2, Hipoglikemia	dr Aji Sp PD
21	Tn. BAMBANG SUDARMO	IRNA	Post laparotomy explorasi, Cuci usus, repair gaster, jejunostomy feeding	dr Anton Sp B
22	Ny. Sulianah	ICU	DOC ec CVA ich + ht emergency	dr Farid Sp N
23	Tn. Pani	ICU	ARDS, CVA INFARK, PNEUMONIA, NEOPLASMA CEREBRI,	dr Farid Sp N
24	Rofi'ah	IGD	DOC EC STEMI	
25	Tn. Djuma'in	IRNA	1. Cholelithiasis	dr Heri, Sp.PD
26	Djuma'atin	ICU	CVA Infark + Fetty liver + nefrolithiasis + ortostatik pneumonia + ARDS	dr.Farid.,Sp.N Raber dr.Heru.,Sp.An Raber dr.Ardhani.,Sp.PD
27	Tn DASRUM	ICU	ICH Frontal + SAH + edema cerebri + Fr linear frontal + Susp tumor suprasella	dr.Fachri Sp. BS
28	Tn SUPRAPTO	ICU	ARDS	dr. Andy Sp. P
29	Ny MAGHFIROH	ICU	ARDS	dr Elvi, Sp.P
30	Nur Hayati	ICU	TROMBOSITOPENI, susp efusi perikardium	dr Mira Sp JP
31	Ny. Dasiyah	ICU	post laparotomy, tetanus	DR ZAKI, SP.B
32	Ny. Siti Machmudah	IRNA	Colic abdomen, Hepatoma	dr. Ardhandy, Sp.PD
33	Ny. Djumaiyah	IRNA	DEHIDRASI RINGAN SEDANG+AKI DD CKD+HIPERKALEMIA	dr. ardhandy Sp.PD
34	Lailatul Qodriyah	ICU	CVA ICH PONS, HIDROSEFALUS, HT KRISIS	dr. Fachri Sp. BS Raber dr.Farid.,Sp.N
35	Wahyu Priono	IGD	syok kardiogenik+post VT unstable+CAD post PCI	dr. Mira.Sp.JP
36	Agus Sukowati Sulistina	ICU	CVA ICH Pons+HT+Pneumonia ortostatik+ARDS	dr. Farid Sp. N Raber dr. Heru Sp. An

Analisa :

1. Jumlah pasien meninggal dunia pada bulan September 2025 sebanyak 36 pasien
2. Jumlah terbanyak yaitu dari IGD : 7 pasien, ICU : 21 pasien IRNA : 5 pasien Neo : 3 pasien
3. Pada bulan September 2025 Jumlah kasus DOA di IGD sebanyak 1 kasus.
4. Pengisian EWS sudah dilakukan di IGD dan IRNA

Rencana Tindak Lanjut

Dilakukan evaluasi terhadap pasien datang ke IGD dengan kasus DOA

3.5.7.6 Laporan MPP

3.5.7.6.1 Tabel Rekap Berdasarkan Skrining Pasien

NO	IDENTIFIKASI / SKRINING PASIEN	BULAN / JUMLAH		
		JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
1	Usia lanjut	-	-	-

2	Kasus penyakit kronis / terminal katastrofik	-	-	-
3	Riwayat penggunaan alat bantu (kursi roda, walker, tongkat, dll)	-	-	-
4	Perkiraan biaya tinggi	-	-	-
5	Kemungkinan sistem pembiayaan yang kompleks (2 asuransi)	-	-	-
6	Pasien dengan fungsi kognitif rendah	-	-	-
7	Potensial 123lastic123 tinggi	-	-	-
8	Kasus yang melebihi rata-rata lama rawat	-	-	-
9	Kasus yang diidentifikasi rencana pemulangnya	-	-	-
10	Berisiko membutuhkan kontinuitas pelayanan	-	-	-
11	Berpotensi masalah hukum	-	-	-
12	Naik kelas pelayanan	-	-	-
13	Lain – lain	-	-	-

3.5.7.6.2 Tabel Jumlah Lain-Lain (Permasalahan Cara Bayar)

NO	IDENTIFIKASI / SKRINING PASIEN LAIN-LAIN (PERMASALAHAN CARA BAYAR)	BULAN / JUMLAH		
		JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
1	Habis PKS	-	-	-
2	BPJS status Denda	-	-	-
3	BPJS status Premi	-	-	-
4	BPJS status Denda dan Premi	-	-	-
5	BPJS staus Usia lebih dari 21 tahun	-	-	-
6	BPJS status keluar atas kemauan sendiri	-	-	-
7	BPJS status penanguhan pembayaran	-	-	-
8	Rencana pengurusan BPJS	-	-	-
9	BPJS status tidak ditanggung	-	-	-
10	BPJS tidak aktif akhir bulan	-	-	-
11	BPJS peralihan Mandiri ke PBI	-	-	-

3.5.8 Cleaning Service

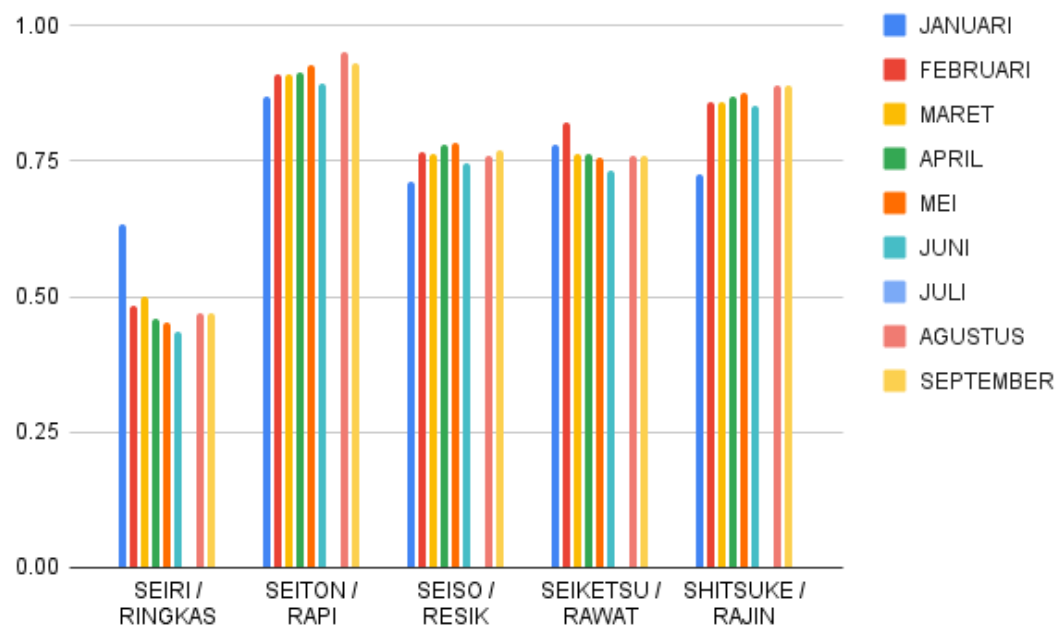
3.5.8.1 Indikator Kerja Cleaning Service

KATEGORI	DESKRIPSI
Seiri	Penempatan Alat Kebersihan Di Janitor/ Trolly
	Penempatan Alat Kebersihan Di Janitor/ Trolly
Seiton	Kerapian Baju Dan Kebersihan, Penampilan Petugas Cs
	Kerapian Baju Dan Kebersihan, Penampilan Petugas CS
Seiso	Membersihkan Area Kerja Secara Rutin Sesuai Jadwal
	Membersihkan Area Kerja Secara Rutin Sesuai Jadwal
Seiketsu	Mematuhi Sop Kebersihan
	Mematuhi SOP Kebersihan
Shiketsu	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan
	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan
	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan

3.5.8.2 Tabel Produktifitas Cleaning Service

NO	JENIS SPV	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SEIRI / RINGKAS	63%	48%	50%	50%	45%	44%		47%	47%
2	SEITON / RAPI	87%	91%	91%	91%	93%	89%		95%	93%
3	SEISO / RESIK	71%	77%	76%	76%	78%	75%		76%	77%

4	SEIKETSU / RAWAT	78%	82%	76%	76%	76%	73%		76%	76%
5	SHITSUKE / RAJIN	72%	86%	86%	86%	88%	85%		89%	89%



Analisa :
 Terdapat progress pada semua factor penilaian bulan ini. Peningkatan perlu dipertahankan.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan Evaluasi

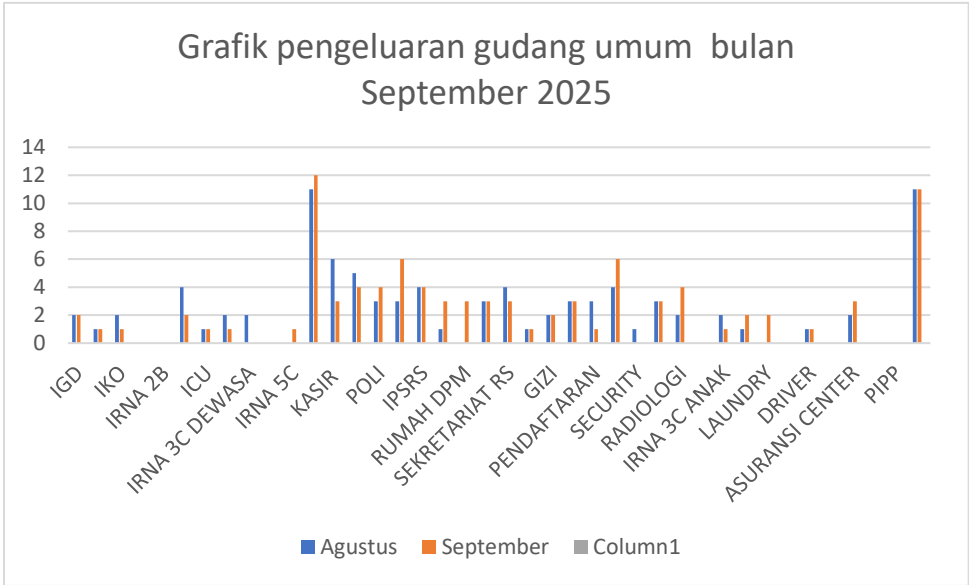
3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum

3.5.9.1 Tabel Laporan Pencatatan Pengeluaran Barang

No	Unit Asal	Jumlah Barang		Persentase
		Agustus	September	
1	IGD	2	2	↑0%
2	MATERNITAS	1	1	↓0%
3	IKO	2	1	↓-100%
4	IRNA 2A	0	0	↓0%
5	IRNA 2B	0	0	↓0%
6	IRNA 2C	4	2	↓-100%
7	ICU	1	1	↓0%
8	IRNA 3A+4A	2	1	↓-100%
9	IRNA 3C DEWASA	2	0	↓0%
10	IRNA 4C	0	0	↓0%
11	IRNA 5C	0	1	↓100%
12	MS PTP , MS LAWANG,MS KARLOS	11	12	↑8,33%
13	KASIR	6	3	↓-100%
14	DAPUR	5	4	↓ -25%
15	POLI	3	4	↓25%
16	CLEANING SERVICE	3	6	↑50%
17	IPSRS	4	4	↓0%
18	GUDANG FARMASI	1	3	↑66,66%
19	RUMAH DPM	0	3	↑100%
20	SEKRETARIAT PT	3	3	↓0%

21	SEKRETARIAT RS	4	3	↓-75%
22	CSSD	1	1	↓0%
23	GIZI	2	2	↓0%
24	REKAM MEDIS	3	3	↑0%
25	PENDAFTARAN	3	1	↓-100%
26	DEPO FARMASI	4	6	↑33,33%
27	SECURITY	1	0	↓0%
28	LABORATORIUM	3	3	↓0%
29	RADIOLOGI	2	4	↓50%
30	FISIOTERAPI	0	0	↓0%
31	IRNA 3C ANAK	2	1	↓-100%
32	NS NICU	1	2	50%
33	LAUNDRY	0	2	↓100%
34	LANTAI 6A,7A,8A	0	0	↓0%
35	DRIVER	1	1	↓0%
36	SIMRS	0	0	↓0%
37	ASURANSI CENTER	2	3	↑33,33%
38	DPW	0	0	↓0%
39	PIPP	0	0	↑0%
40	RS DH	11	11	↑0%

3.5.9.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Barang Berdasarkan Asal Unit



Analisis :
 Pada grafik diatas dapat kita lihat bahwa data barang paling banyak ada pada unit Mutiara sehat dan RSDH

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Mendisiplinkan kepatuhan jadwal pengambilan barang
 2. Memberi edukasi ke unit agar tidak salah input barang atau salah unit
 3. Menyarankan ke seluruh unit agar punya data inventaris ATK secara terperinci

3.5.10 IT SIMRS

3.7.8 Capaian Tata Laksana Keluhan

NO	JENIS KELUHAN	JUMLAH LAPORAN	JUMLAH TERSELESAIKAN	PROSENTASE (%)
1	Keluhan terkait	9	9	100%

	software			
2	Keluhan terkait hardware	98	98	100%

Analisis

: Untuk Keluhan dapat terselesaikan oleh Tim IT

Rencana Tindak Lanjut

: Monitoring dan Evaluasi

3.7.9 Rekapitulasi Kejadian Downtime

NO	TANGGAL KEJADIAN DOWNTIME	JENIS DOWNTIME (TERENCANA/TIDAK TERENCANA)	LAMA DOWNTIME	PENYEBAB DOWNTIME	RTL
1	9/9/2025	Tidak terencana	60 menit (14.30-15.30)	Server Bridging dan Sipp down	Edukasi menunggu estimasi 30 menit info dari IT bpjs dan Vcalaim Manual
2	16/9/2025	Tidak Terencana	(11.00-12.00)	Maintenance provider dnet	Edukasi proses pencarian data peserta secara manual (vclaim by web)
3	30/9/2025 s/d 1/10/2025	Terencana	17.00-05.00	Maintenance bulanan server bridging bpjs	Edukasi proses pencarian data peserta secara manual

Analisis

: Untuk Keluhan dapat terselesaikan oleh Tim IT

Rencana Tindak Lanjut

: Monitoring dan Evaluasi

3.6 Komite dan Tim

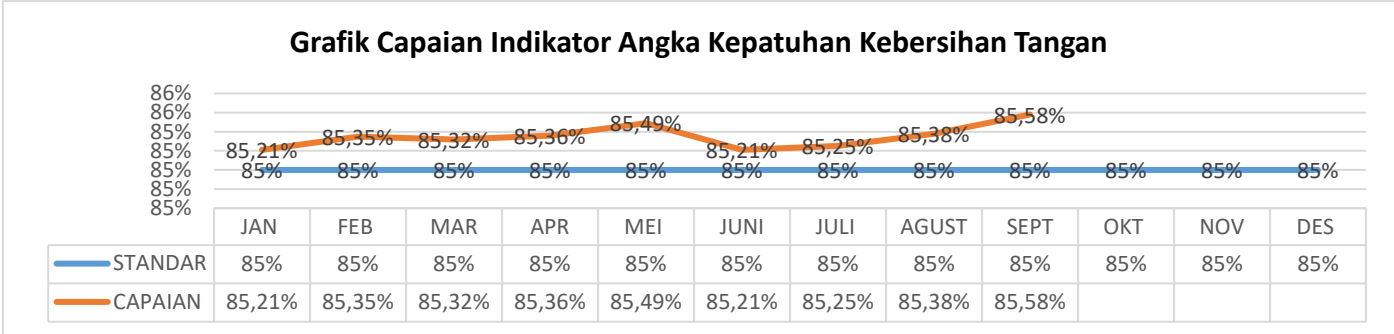
3.6.1 Komite Mutu

3.6.1.1 Indikator Mutu Nasional

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Juli '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	85,21%	85,35%	85,32%	85,36%	85,49%	85,21%	85,25%	85,38%	85,58%				85,35%
2.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	93,01%	93,06%	93,1%	93,22%	93,54%	96,3%	93,79%	94,3%	94,33%				93,85%
3.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	99,55%	99,92%	99,77%	99,96%	99,88%	100%	93,93%	99,94%	99,83%				99,19%
4.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%
5.	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥ 80%	89,16%	89,38%	99,1%	98,21%	97,58%	97,33%	96,23%	96,60%	96,62%				95,69%
6.	Penundaan Operasi Elektif	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,32%				0,03%
7.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	75,9%	76,21%	74,93%	74,19%	72,26%	78,28%	66,22%	60,55%	70,4%				72,15%
8.	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%	96,9%	97,31%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				99,36%
9.	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%
10.	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%
11.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	99,75%	98,64%	99,1%	99,44%	97,65%	99,09%	96,33%	95,04%	93,45%				97,62%
12.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥ 80%	100%	99,92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				99,99%
13.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	99,81%	99,79%	100%	99,88%	99,76%	97,12%	99,46%	99,56%	99,89%				99,47%

3.6.1.1Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

3.6.1.1.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



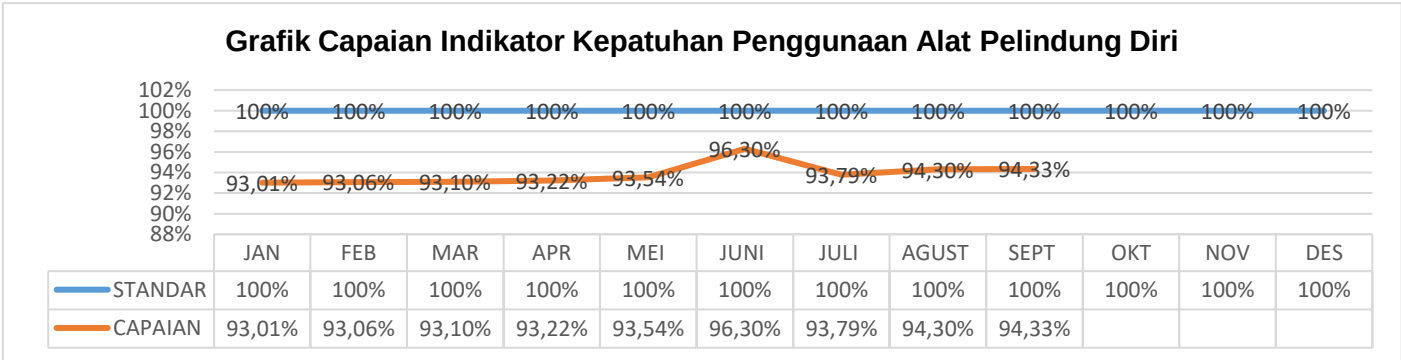
Dari grafik indikator angka keptuhan kebersihan tangan bulan Januari tahun 2025 diketahui bahwa capaian telah mencapai standart yaitu 85,21% dan pada bulan Februari capaian meningkat menjadi 85,35%, capian di bulan Maret yaitu 85,32%, capaian di bulan April yaitu 85,36%, capaian di bulan Mei 85,49%, capaian di bulan Juni adalah 85,21 dan capaian di bulan Juli adalah 85,25% serta Agustus sebesar 85,38% dan bulan September dengan rata rata bulan Januari hingga September yaitu 85,35%. Meskipun belum mencapai 100% tetapi nilai tersebut telah mencapai standart. Petugas masih dengan anggapan bahwa tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Di harapkan capaian ini dapat ditingkatkan di bulan berikutnya.

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin hingga 100%.					
DO	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.					
STUDY	Dari grafik indikator angka keptuhan kebersihan tangan bulan Januari tahun 2025 diketahui bahwa capaian telah mencapai standart yaitu 85,21% dan pada bulan Februari capaian meningkat menjadi 85,35%, capian di bulan Maret yaitu 85,32%, capaian di bulan April yaitu 85,36%, capaian di bulan Mei 85,49%, capaian di bulan Juni adalah 85,21 dan capaian di bulan Juli adalah 85,25% serta Agustus sebesar 85,38% dan bulan September dengan rata rata bulan Januari hingga September yaitu 85,35%. Meskipun belum mencapai 100% tetapi nilai tersebut telah mencapai standart. Petugas masih dengan anggapan bahwa tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Di harapkan capaian ini dapat ditingkatkan di bulan berikutnya.					
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		PELAKSANA	WAKTU

Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan
---------------------------------	---	----------------------------------	--	--	------------

3.6.1.1.1 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

3.7.10 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri



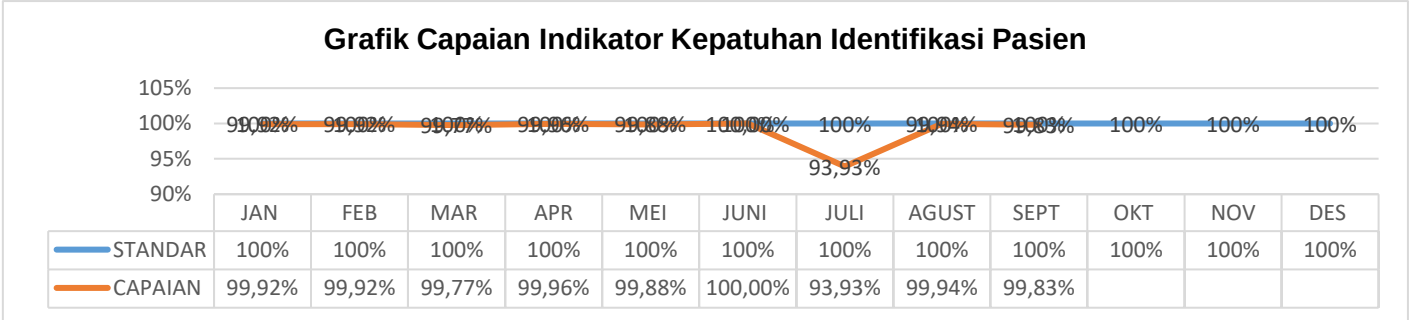
Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan penggunaan alat pelindung alat pelindung diri pada bulan Januari hingga September Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan penggunaan APD semaksimal mungkin hingga 100%.
DO	1. Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 2. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 3. Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 4. Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD petugas dapur). 5. Sudah dikeluarkan edaran terkait penggunaan jas dokter.

	6. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.				
STUDY	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart. Capaian di bulan Januari tahun 2025 yaitu 93,01%, bulan Februari sebesar 93,06%, bulan Maret sebesar 93,1%, bulan April 93,22%, bulan Mei 93,54%, bulan Juni 96,3% dan bulan Juli 93,79% serta bulan Agustus sebesar 94,3% dan September yaitu 94,33% dengan rata-rata 93,85%. Dari hasil monitoring dan supervise, masih ditemukan petugas perawat yang memakai APD tidak sesuai dengan jenis tindakan dan transmisi penyakit, misalnya seperti injeksi lewat selang infus / hanya TTV ke pasien non infeksi namun menggunakan handscoon. Kepatuhan APD petugas dapur terutama pengolah makanan masih sangat kurang terutama penggunaan masker. Untuk petugas medis, masih ditemukan DPJP yang masih menggunakan handscoon meskipun hanya visite tidak melakukan tindakan. Untuk petugas CS ditemukan masih menggunakan handscon medis untuk mengepel yang seharusnya menggunakan handscoon kerja.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Tercapainya kepatuhan APD hingga maksimal 100%.	1. Berkolaborasi dengan IPCD untuk melakukan edukasi terhadap para DPJP. 2. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan. 3. Lakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 4. Berikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 5. Berikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. 6. Tanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu Bulan

3.6.1.1.2 Kepatuhan Identifikasi Pasien

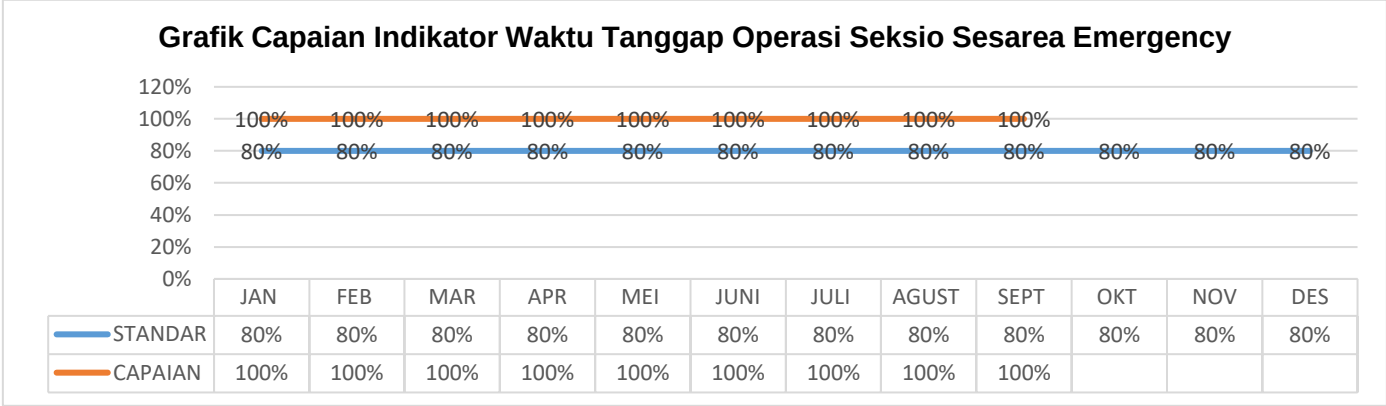
3.7.11 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pas



Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Januari hingga Mei Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, pada bulan Juni tahun 2025 capaian telah meningkat menjadi 100%,namun kembali menurun di bulan Juli yaitu 93,93% dan bulan Agustus yaitu 99,94% serta September yaitu 99,83%.

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	1. Melakukan 131lastic131e pada petugas di unit secara berkelanjutan 2. Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan 131lastic131e dan sosialisasi terkait identifikasi pasien 3. Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart dengan capaian bulan Januari tahun 2025 yaitu 99,92 %, bulan Februari sebesar 99,92%, bulan Maret sebesar 99,77% capaian di bulan April yaitu 99,96%, capaian di bulan Mei 99,88% dan capaian meningkat di bulan Juni menjadi 100%,namun Kembali menurun pada bulan Juli yaitu 93,93% serta bulan Agustus yaitu 99,94% serta September yaitu 99,83% dengan rata rata 99,19 %. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	1. Terus melakukan 131lastic131e pada petugas unit 2. Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu Bulan

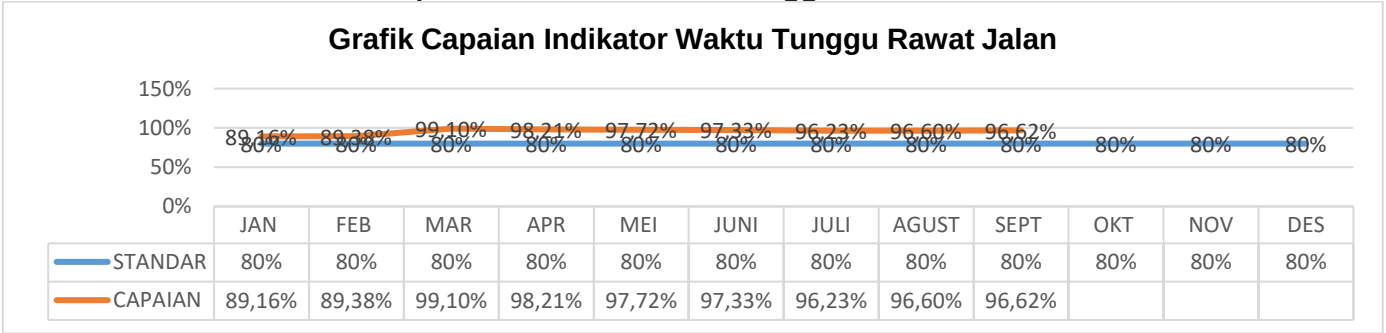
3.6.1.1.3 Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency



Dari grafik indikator waktu tanggap SC emergency bulan Januari hingga bulan September tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini berkat kerjasama yang baik antara unit Instalasi Gawat Darurat, Unit Maternitas dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian waktu SC emergency. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.1.1 Waktu Tunggu Rawat Jalan

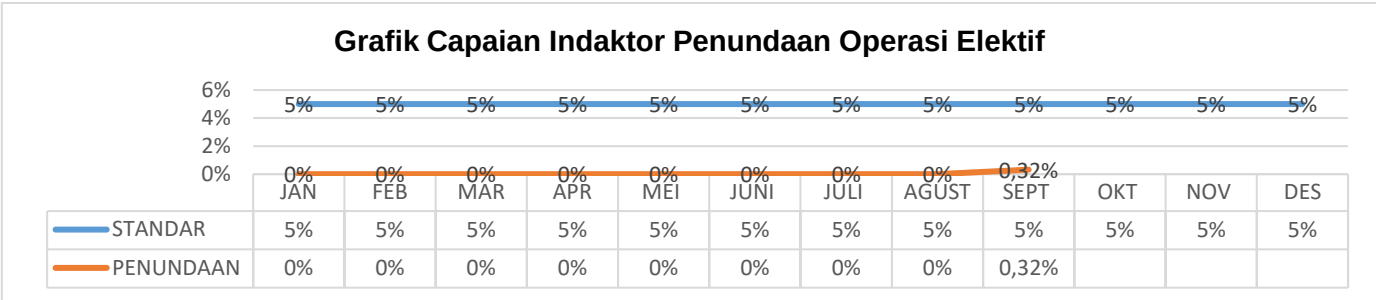
3.7.12 Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan



Berdasarkan grafik capaian indikator waktu tunggu rawat jalan pada bulan Januari Tahun 2025 capaian telah mencapai standart dengan capaian 89,16%, capaian di bulan Februari 89,38%, capaian di bulan Maret 99,1%, capaian di bulan April 98,22%, capaian di bulan Mei 97,71%, capaian di bulan Juni adalah 97,33% dan capaian di bulan Juli adalah 96,23%, serta capaian di bulan Agustus yaitu 96,60% dan di bulan September yaitu 96,52% dengan rata-rata 95,69%. Hal ini berkat kerjasama yang baik antara manajemen dan juga DPJP yang sudah berusaha datang tepat waktu dan evaluasi berkelanjutan yang telah dilakukan manajemen terhadap keterlambatan DPJP. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan dibulan berikutnya.

3.6.1.1.2 Penundaan Operasi Elektif

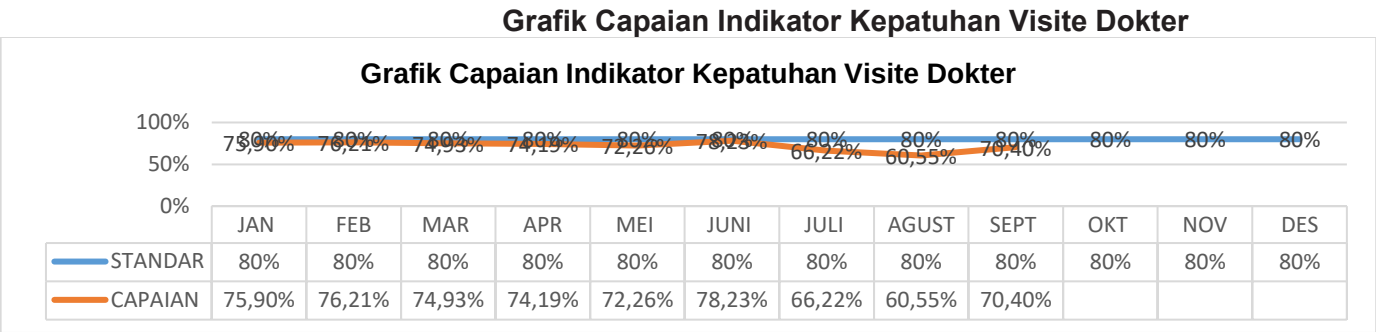
3.7.13 Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif



Dari grafik indikator penundaan operasi elektif bulan Januari hingga September tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart dengan rata rata 0,035, hal ini berkat kerjasama yang baik antara unit Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian indikator penundaan operasi elektif . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025

3.1.7 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

3.6.1.1.3 Kepatuhan Waktu Visite Dokter



Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan visite Dokter pada bulan Januari hingga September Tahun 2025 belum mencapai standart, hal ini disebabkan karena Seluruh dokter Klinisi di Rumah Sakit Prima Husada adalah dokter tamu dari luar, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan waktu visite dokter hingga dapat mencapai standart 80%.				
DO	Memberikan masukan pada SDM dan Kabid pelayanan untuk melakukan rekrutmen home dokter lebih banyak				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian 75,9%, capaian di bulan februari yaitu 76,21%, capaian di bulan Maret yaitu 74,93%, capaian di bulan April yaitu 74,19%, capaian di bulan Mei yaitu 72,26%, capaian di bulan Juni yaitu 78,23%, capaian di bulan Juli yaitu 66,22% dan capaian di bulan Agustus yaitu 60,55% serta September yaitu 70,4% dengan rata-rata 72,15%. Dari hasil supervisi didapatkan Angka kepatuhan waktu visite Dokter belum mencapai standart karena masih banyak dokter yang visite diatas jam 14.00 karena masih bertugas di RS asal karena RS Prima Husada belum memiliki dokter tetap. Dokter visite jam 07.00-14.00 : dr. Ira, Sp.JP, dr. Mira, Sp.JP, dr. Anton, Sp.B, dr. dr. Dicky,Sp.A , dr. Elvi, Sp.P, dr. Dewi, Sp.S, dr. Ardhi, Sp.PD, dr. Humairoh, Sp.Og. , dr. Nimim, Sp.THT.KL, dr. dr. Aji, Sp.PD. Dokter visite jam 14.00-21.00 : dr. Heriyatmo, Sp.PD, dr. Andi, Sp.P, dr. Farid, Sp.S, dr. Yoga, Sp.JP (Tidak menentu), dr. Ardani, Sp.DP (tidak menentu).				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Capaian Kepatuhan Visite dokter bisa meningkat pada bulan selanjutnya	Melakukan KIE dan komunikasi dengan DPJP terkait waktu visite dokter, hal ini menjadi PR yang cukup besar bagi tim mutu dan manajemen karena 134 lastic 134 besar DPJP tidak hanya bertugas di RS Prima Husada.	Manajemen RS	Satu Tahun

3.1.8 Pelaporan Hasil Kritis Labororium

3.7.14 Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

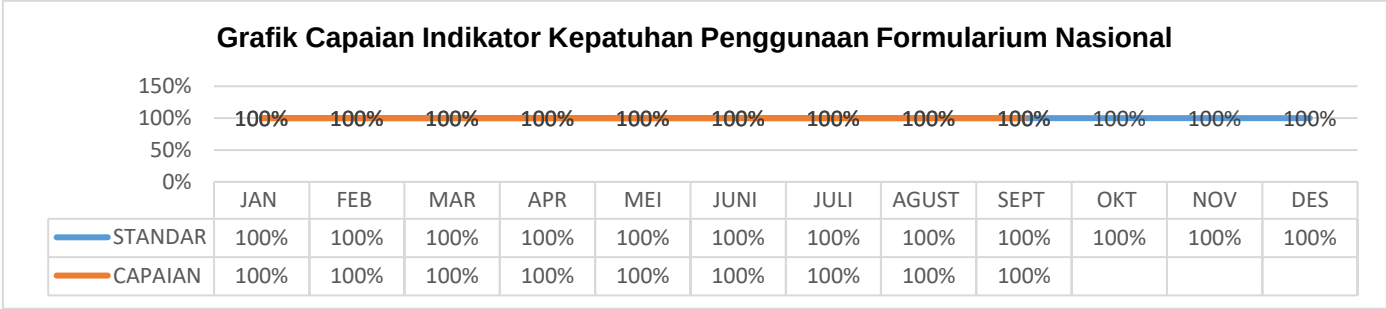


Berdasarkan grafik capaian indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium pada bulan Januari dan Februari Tahun 2025 diketahui capaian belum mencapai standart dan capaian meningkat hingga 100% di bulan Maret hingga September. Capaian meningkat pada bulan Maret hinga Juni yang telah mencapai standart 100%.

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan pelaporan hasil kritis laboratorium hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan 135lastic135e baik dari komite mutu maupun kepala instalasi laboratorium supaya seluruh petugas laboratorium segera melaporkan hasil kritis dan melakukan dokumentasi dengan baik dan lengkap.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator pelaporan hasil kritis laboratorium pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian 96,9% dan bulan Februari 97,31%. Capaian meningkat pada bulan Maret hingga September yang telah mencapai standart 100%. Berdasarkan hasil supervisi masih ada petugas yang melaporkan hasil kritis laboratorium tetapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan lengkap.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Capaian pelaporan hasil kritis laboratorium dapat mencapai standart 100% pada bulan berikutnya	1. Menganalisa jumlah hasil kritis laboratorium yang terlapor dan tidak terlapor 2. Memasukkan catatan ketidak patuhan staf kedalam evaluasi kinerja staf secara langsung kepada petugas laboratorium yang tidak melaporkan hasil kritis laboratorium ataupun yang melapor tapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan baik dan lengkap.	1. Komite mutu 2. Kepala instalasi laboratorium	Satu Tahun

3.6.1.1.4 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

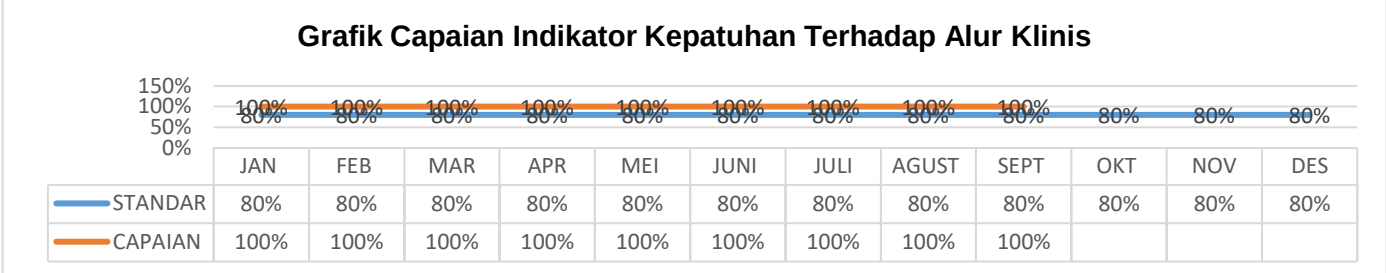
1.6.1.1.9.1 Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



Dari grafik indikator Formularium Nasional bulan Januari hingga September tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini kerjasama yang baik antara dokter penanggungjawab pasien, instalasi farmasi dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepatuhan penggunaan formularium Nasional . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.6.1.1.5 Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)

3.7.15 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis



Dari grafik indikator kepatuhan terhadap alur klinis bulan Januari hingga September tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini kerjasama yang baik antara dokter penanggungjawab pasien, instalasi farmasi dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepatuhan penggunaan formularium Nasional . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

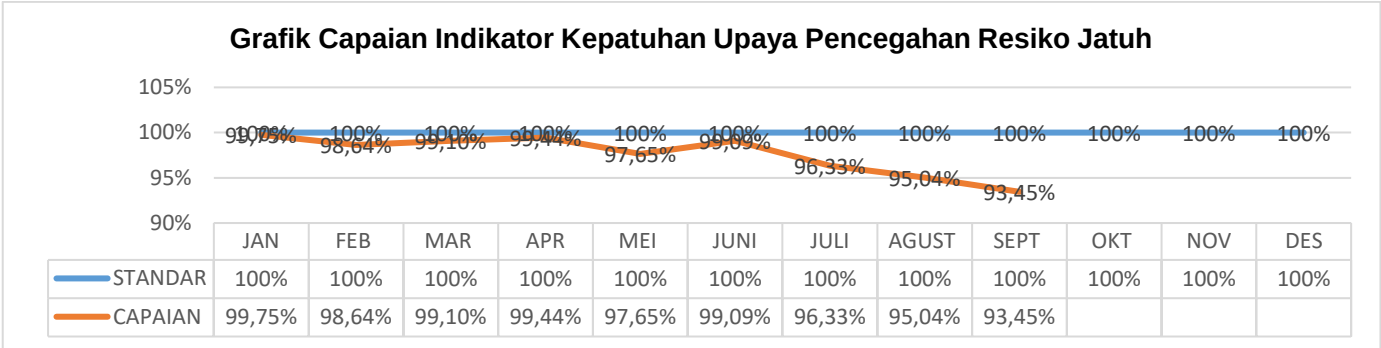
Daftar Clinical Pathway Bulan September 2025

Diagnosa	Jumlah	Patuh	Tidak Patuh
DF			
CVA Infark			
Gastritis			
Batu Ureter			
DM			
GEA			
CHF			
FAM			
TB Paru			
HT			
CA Mammae			
HIV			
STEMI			
NSTEMI/UAP			

Pneumonia			
Sectio Caesarea	32		
Partus Normal	34		
Jumlah	66	66	

3.6.1.1.6 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

3.7.16 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



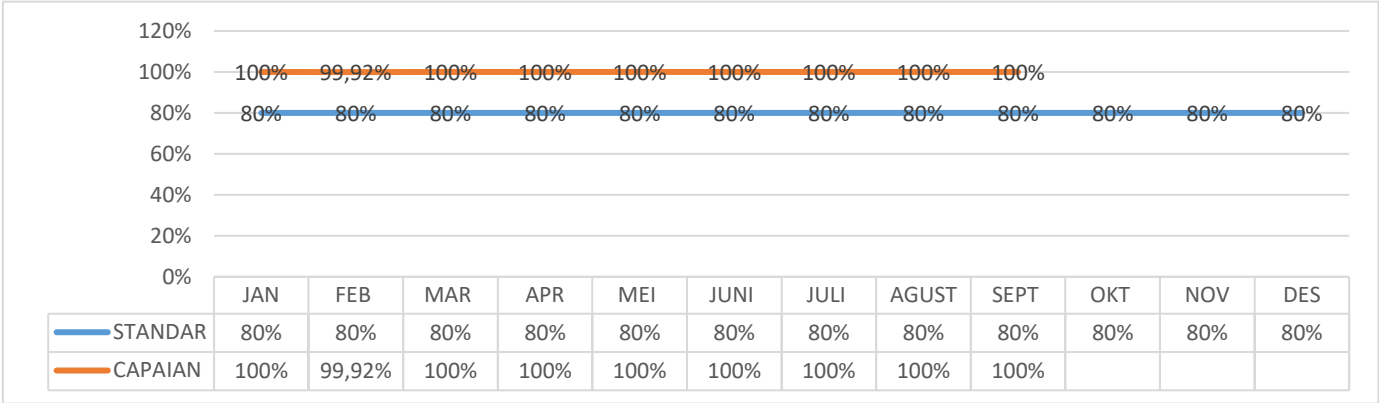
Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari hingga September Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan pencegahan resiko jatuh				
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian yaitu 99,75%, capaian di bulan Februari yaitu 98,64%, capaian di bulan Maret yaitu 99,1%, capaian di bulan April yaitu 99,44%, capaian di bulan Mei yaitu 97.65%, capaian di bulan Juni adalah 99,09%, capaian di bulan Juli adalah 96,33% dan capaian di bulan Agustus yaitu 95,04% dan September 93,45% dengan rata-rata 97,62%. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan	Melakukan 137lastic137e berjenjang mulai dari PJ shift, kepala ruangan, kepala bidang keperawatan dan tim mutu guna memastikan perawat ruangan telah melakukan KIE kepada pasien dan keluarga tentang 137last pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan	Perawat instalasi rawat inap	Satu Bulan

		resiko jatuh bisa mencapai 100%.	dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan.		
--	--	----------------------------------	--	--	--

3.6.1.1.7 **Kecepatan Waktu Tanggap Komplain**

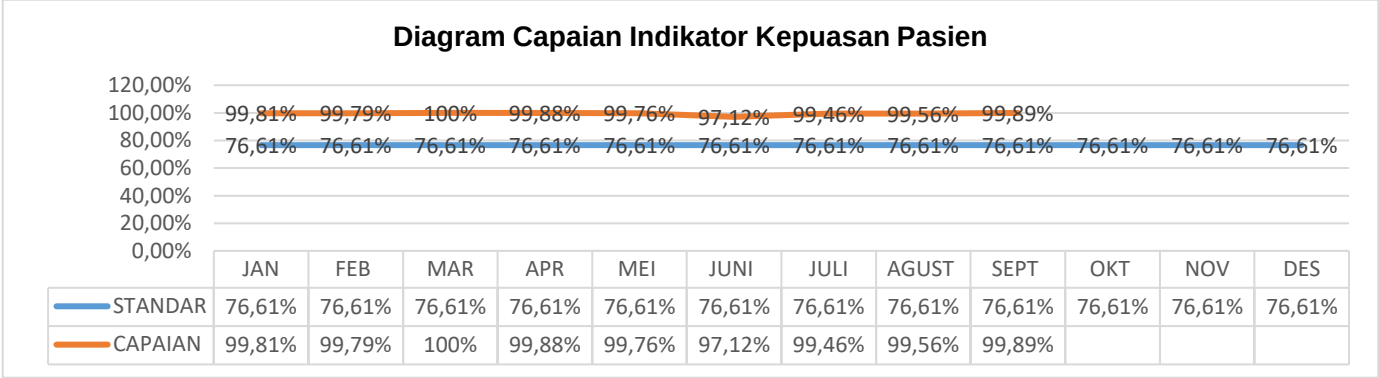
3.6.1.1.12.1 **Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Komplain**



Dari grafik indikator waktu tanggap kompalian bulan Januari hingga September tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart lebih dari 80% dengan rata-rata 99,99%, hal ini berkat kerjasama yang baik antara PIPP dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk segera menanggapi dan melakukan tindak lanjut terkait komplain yang diterima. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.1.12.2 Kepuasan Pasien

3.6.1.1.12.2.1 Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



Dari grafik indikator kepuasan pasien bulan Januari hingga Agustus tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart lebih dari 76,61% dengan rata-rata 99,47%, meskipun belum mencapai nilai sempurna 100% tetapi capaian ini telah melebihi standart. Hal ini karena kerjasama yang baik antara seluruh karyawan Rumah Sakit Prima Husada Malang dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepuasan pasien . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.1.1 Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,55%	99,92%	99,77%	99,96%	99,88%	100%	93,93%	99,94%	99,83%				99,19%
2.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis (IRNA,IRJA, IGD,IKO)	100%	99,55%	99,92%	99,73%	99,51%	99,33%	99,93%	99,37%	99,41%	99,46%				99,57%
3.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi (IRNA,IGD,IKO)	100%	100%	100%	100%	100%	90,86%	100%	100%	100%	100%				98,98%
4.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	91,38%	98,85%	100%	100%	100%				98,91%
5.	Kejadian Ketidaklengkapan Lembar Operan Pasien (IRNA,IRJA, IGD,IKO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0%
6.	Angka Kelengkapan Penyiapan Dan Pengelolaan Obat Yang Perlu di Waspada / High Alert (Farmasi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%
7.	Kepatuhan penyiapan, pengelolaan, pemberian sesuai standar obat elektrolit pekat (Farmasi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%

8.	Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi Sesuai Prosedur (IGD,IRNA,IKO)	100%	100%	100%	99,57%	99,77%	90,41%	97,63%	98,22%	98,48%	98,52%				98,06%
9.	Kepatuhan Pengisian Daftar Tilik Keselamatan Pasien Operasi (IKO)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%
10.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan) (IRNA,IRJA,IGD,IKO)	100%	98,64%	98,64%	99,32%	99,63%	98,74%	99,31%	99,48%	98,71%	98,79%				99,02%
11.	Kepatuhan 140last pencegahan risiko jatuh	100%	98,64%	98,65%	98%	99,44%	97,65%	98,48%	96,33%	95,04%	95,21%				97,5%
12.	Kepatuhan kebersihan tangan	85%	85,21%	85,35%	85,32%	85,36%	85,49%	85,21%	85,25%	85,38%	85,42%				85,33%

3.6.1.1.2 Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Apendicitis akut	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%
2.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi STT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%

3.6.1.1.3 Tujuan Strategis

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Juli '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	99,81%	99,79%	100%	99,98%	99,76%	97,12%	99,46%	99,56%	99,89%				99,47%

3.6.1.14 Perbaikan Sistem

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kesesuaiaan Penarikan Data SIMRS Dengan Data Manual Pada Laporan Unit	100%	80,39%	81,69%	82,73%	87,5%	89,35%	86,4%	80%	87,5%	87,9%				85,68%

1.6.1.2.5 Mutu Unit

1.6.1.2.5.1 Instalasi Gawat Darurat

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Batas waktu pasien menunggu tempat tidur kurang dari 6 jam (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	99,71%	99,7%	97,2%	99,48%	98,79%	98,2%	98,32%				
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	98,2%	98,36%	98,37%	98,44%	98,72%	96,03%	95,23%	95,445	95,68%				
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
5.	Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
6.	Kepatuhan 141last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
7.	Kepuasan pasien	85%	97,36%	97,29%	100%	98,2	98,92%	98,45%	98,92%	98,82%	98,84%				
8.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
9.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
10.	Kepatuhan pelaporan pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
11.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
12.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis di IGD	100%	100%	100%	100%	95,43%	92,7%	100%	100%	100%	100%				
13.	Angka tindak lanjut screening nyeri pasien di IGD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
14.	Angka kepatuhan triage untuk penyakit menular di IGD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
15.	Respon time IGD kurang dari 5 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
16.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	4,65%	3,7%	2,38%	1,9%	1,67%	5,43%	1,96%	1,72%	1,52%				

17.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
18.	Kepatuhan pemasangan gelang identitas pasien kurang dari 30 menit setelah pasien terdaftar rawat inap	100%	73,21%	73,32%	75,11%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
19.	Kejadian merujuk pasien berdasarkan aspek pilihan pasien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
21.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, anak, remaja, risiko bunuh diri)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
22.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
23.	Kegiatan merujuk pasien (horizontal)	0	1	4	3	2	1	0	0	0	0				

1.6.1.2.5.2 IRNA 2A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	5.	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	-				-	-	-	-	-		
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.	Kepatuhan 142last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.	Kepuasan pasien	85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17.	Angka efektivitas discharge planning	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22.	Kepatuhan penandaan 143lasti operasi sesuai prosedur	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

3.7.17 IRNA 3A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	92,8%	94,7%	95,23%	95,31%	97,22%	96,32%	96,88%	95,41%	96,33%				
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	93,7%	94,5%	94,61%	95,22%	96,34%	97,24%	96,9%	95,26%	95,88%				
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	90,6%	89,82%	92,22%	93,33%	98,85%	94,58%	72,31%	69,88%	70,22%				
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7.	Kepatuhan 144last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	88,98%	100%	100%	100%	96,03%	100%	100%	100%	100%				
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	88,98%	100%	100%	100%	98,71%	96,93%	100%	100%	100%				
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	96,04%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	97,93%	100%	100%	100%	97,71%	100%				
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	95,48%	100%	100%	100%	95,27%	100%				
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	87,25%	100%	100%	100%	100%				

16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	0	-	4,52%	1,81%	-	-	-				
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	0	-	100%	100%	-	-	-				
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
21.	Kepatuhan penandaan 145lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	95,31%	100%	82,4%	100%	100%	100%	100%				
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	97,75%	93,79%	100%	100%	100%	100%				

3.7.18 IRNA 4A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25		
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	98,74%	100%	100%	100%	100%	100%				
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	96,72%	96,88%	97,12%	97,22%	98,21%	98,24%	97,22%	95,31%	96,42%				
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,6%	96,9%	96,7%	97,8%	98,88%	97,32%	96,34%	95,22%	96,41%				
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,86%	100%	100%				
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	88,98%	95,17%	96,38%	99,46%	98,3%	92,93%	95,52%	89,30%	89,22%				
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

7.	Kepatuhan 146last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	97,14%	100%	89,11%	89,19%	97,62%	100%	67,38%	100%	100%				
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	97,14%	100%	100%	95,15%	97,79%	100%	90,27%	100%	100%				
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,55%	100%	100%				
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	89,8%	41,67%	100%	100%	100%				
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	95,38%	100%	100%	100%	97,93%	100%				
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	90,75%	96,52%	100%	100%	95,48%	100%				
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	82,41%	100%	41,84%	100%	100%				
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	76,32%	100%	100%	100%				
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	-	-	2,1%	2,3%	-	-	-				
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-				
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	98,7%	59,7%	100%	100%	100%				
21.	Kepatuhan penandaan 146lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	98,06%	84,21%	92,14%	58,82%	82,4%	100%	100%				

22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	96,32%	100%	100%	100%	100%	100%				

3.7.19 IRNA 2C

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	96,55%	100%	100%	100%	100%				
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	98,9%	97,5%	99,2%	99,31%	99,44%	98,79%	97,88%	97,92%	99,36%				
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	95,8%	97,3%	97,8%	98,2%	88,24%	91,23%	93,52%	93,88%	98,8%				
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	81,25%	81,44%	82,47%	80,15%	78,62%	80,95%	74,42%	72,22%	80,15%				
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7.	Kepatuhan 147last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	87,91%	94,07%	94,92%	89,05%	86,09%	96,15%	96,42%	94,92%				
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	87,91%	100%	100%	97,78%	97,14%	100%	100%	100%				
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	97,73%	100%	100%	100%	100%				
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,65%	100%	100%	100%				
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	93,75%	100%	53,85%	100%	100%	100%				
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%				
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,5%	100%	100%	100%				
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	85,71%	75%	100%	100%	100%				
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
21.	Kepatuhan penandaan 148lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	85,71%	45,45%	100%	100%	100%				
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	97,79%	70,83%	90,48%	100%	100%				

3.7.20 IRNA 3C ANAK

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,15%	100%	100%	100%				
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	96,7%	97,1%	97,54%	97,57%	97,22%	97,81%	96,22%	96,82%	96,98%				

3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	94,8%	96,1%	96,19%	96,34%	96,1%	97,8%	98,24%	98,60%	98,84%				
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	100%	80,72%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	100%	-				
7.	Kepatuhan 149last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	88,1%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%				
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	88,1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0,43%	1,53%	1,53%	-	100%	-				

19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-				
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%				
21.	Kepatuhan penandaan 150lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

3.7.21 IRNA 5C

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	92,11%	98,95%	98,78%	100%	100%	100%	100%				
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	99,6%	99,8%	99,7%	99,78%	99,72%	98,92%	97,44%	97,47%	99,92%				
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,7%	99,1%	99,5%	99,62%	99,66%	99,71%	99,62%	99,80%	99,68%				
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	99,61%	94,65%	97,96%	99,4%	99,54%	95,65%				
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	81,25%	81,44%	80,68%	81,44%	75%	68,75%	90,71%	72,22%	85,20%				
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7.	Kepatuhan 150last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	87,91%	100%	100%	84,15%	69,57%	96,43%	96,52%	84,78%				
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	87,91%	97,27%	99,51%	97,9%	91,67%	97,73%	97,6%	97,8%				
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	98,71%	92,24%	96,88%	100%	100%	100%	100%				
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	88,24%	100%	100%	100%	91,3%	100%	100%				
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	99,38%	100%	100%	100%	99,38%				
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	97,47%	97,47%	80,77%	100%	100%	97,57%				
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	75%	95,12%	100%	56,25%	100%	100%	100%				
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	92,64%	98,88%	100%	100%	99,12%	99,72%	100%				
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0,97%	1,06%	0,43%	0%	100%	100%	0%	0%	0%				
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	-	0%	-	-	-	-				
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	99,01%	99,48%	100%				
21.	Kepatuhan penandaan 151lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	100%	100%	0	0	0				
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%				
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%				

3.7.22 IRNA 6A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,78%	100%	100%%				
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89,2%	90,3%	93,3%	93,7%	95,6%	95,92%	99,72%	97,44%	99,72%				
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,1%	97,3%	97,1%	97,31%	98,5%	98,88%	99,66%	99,62%	99,66%				
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,65%	99,4%	94,65%				
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	82,14%	78,72%	82,02%	68,31%	63,64%	65,94%	75%	90,71%	80,60%				
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7.	Kepatuhan 152last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89,13%	84,15%	96,43%	97,82%				
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,9%	97,73%	97,9%				
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,88%	100%	100%				
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,3%	100%				
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,38%	100%	100%				
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,47%	100%	100%				
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89,66%	100%	100%	100%				

16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,12%	100%				
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	1,75%	0%	0,32%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-				
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,01%	100%				
21.	Kepatuhan penandaan 153lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

3.7.23 IRNA 7A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89,98%	93,4%	96,12%	96,16%	97,22%	98,27%	96,62%	98,92%	98,80%				
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	87,24%	89,22%	92,33%	92,41%	94,62%	96,71%	97,66%	97,21%	97,60%				
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	99,1%	88,42%	98,68%	97,92%	98,21%				
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	80,36%	80,58%	63,95%	67,13%	53,89%	69,44%	68,1%	52,88%	66,72%				

6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7.	Kepatuhan 154last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	95,69%	100%	100%	100%	100%				
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	87,15%	100%	100%	100%	100%				
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	81,18%	100%	100%	100%	100%				
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	1,23%	0%	0,64%	0%	0%	1,32%	-	0%	0%				
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	-	100%	-	-	100%	-	-	-				
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

21.	Kepatuhan penandaan 155lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0				
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

3.7.24 10 IRNA 8A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agt'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	97,8%	99,8%	99,62%	99,64%	98,92%	99,02%	97,2%	98,93%	98.70%				
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	92,1%	95,6%	95,71%	95,82%	97,21%	98,34%	97,22%	97,22%	97,54%				
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	97,92%	99,01%	100%	97,93%	98,29%				
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	80,36%	72,79%	82,52%	73,6%	52,88%	66,67%	68,1%	52,90%	68,90%				
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7.	Kepatuhan 155last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	92,86%	100%	100%	92,88%	100%				
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%	0%				
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-				
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
21.	Kepatuhan penandaan 156lasti operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

3.7.25 ICU

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89.9%	95,5%	97,7%	97,8%	98,22%	99,51%	97,22%	98,24%	98,86%				
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,2%	99,8%	99,6%	99,8%	99,88%	99,72%	98,2%	99,89%	99,84%				
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	95,64%	97,81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	96,72%	96,89%	100%	100%	92,14%	94,32%	74,66%	70,21%	72,28%				
6.	Kepatuhan 157last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	92%	93,2%	88,2%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesauaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
8.	Kepuasan pasien	85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
12.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
14.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
15.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

16.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0	0	0	0	1,4%	-	-	-	-				
17.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-				
18.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
19.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU	100%	100%	100%	93,33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
20.	Angka kelengkapan pengkajian pasien tahap akhir kehidupan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
21.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	92,37%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
22.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, pelayanan intensive)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
23.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

3.7.26 HCU

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	88,99%	96,22%	97,61%	98,17%	99,24%	98,22%	85,22%	99,52%	98,54%				
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,5%	99,2%	99,36%	99,42%	99,56%	98,91%	99,2%	99,57%	99,8%				
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	95,71%	98,92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	96,21%	96,71%	95,32%	100%	94,8%	97,3%	74,66%	70,22%	70,21%				

6.	Kepatuhan 159last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	94%	97,1%	82,18%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
8.	Kepuasan pasien	85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
12.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
14.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
15.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
16.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0	0	0	0	0	-	-	0	-				
17.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
18.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
19.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
20.	Angka kelengkapan pengkajian pasien tahap akhir kehidupan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

21.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
22.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, pelayanan intensive)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
23.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

3.7.27 IRJA

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kelengkapan pengkajian medis rawat jalan (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%	100%	S	100%	100%	100%	100%	100%				
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	99,2%	98,72%	99,02%	99,32%	98,72%	96,32%	95,62%	96,22%%	96,62%				
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,35	98,71%	99,24%	99,44%	98,94%	97,44%	96,8%	96,92%	97,1%				
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	99,11%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
5.	Waktu tunggu rawat jalan	≥ 80%	89,16%	89,3%	99,11%	99,02%	98,72%	97,33%	96,23%	96,66%	96,62%				
6.	Kepatuhan 160last pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
7.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
8.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
9.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

10.	Angka kelengkapan pengkajian keperawatan rawat jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
11.	Ketepatan waktu jam praktek dokter	100%	78,92%	77,8%	72,59%	79,58%	79,64%	81,86%	78,6%	82,44%	85,4%%				
12.	Kejadian merujuk pasien	0	0	0	48		15	17	21	34	41				
13.	Angka kelengkapan inform concent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
14.	Angka kelengkapan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
15.	Kelengkapan profil pasien rawat jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

3.7.27 MATERNITAS

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kematian ibu (mutu prioritas unit)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
2.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
3.	Waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergensi.	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
4.	Kepatuhan waktu visite dokter.	≥80%	25,95%	24,56%	34,51%	39,04%	39,06%	43,75%	62,22%	64,43%	72,22%				
5.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
6.	Kepatuhan 161last pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
7.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
8.	Kejadian keterlambatan operasi 161lastic caesaria (SC) > 30 menit	<5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
9.	Angka keterlambatan penyediaan darah > 60 menit	<10%	0%	0%	0%	57,14%	0%	0%	0%	0%	0%				

10.	Kejadian perdarahan post partum	0	0	2	5	4	2	0	0	3	4				
11.	Kejadian partus macet	0	0	0	13	8	12	15	11	13	26				
12.	Kejadian eklamsi	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
13.	Kejadian pre eklamsi	0	5	2	4	4	1	3	1	1	4				
14.	Kejadian infeksi nifas	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1				
15.	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP	100%	13,6%	12,5%	18,75%	11,67%	22%	14,42%	16,31%	17,2%	13,6%				
16.	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	100%	13,6%	12,5%	18,75%	11,67%	22%	14,42%	16,31%	16,5%	12%				
17.	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	0	108	77	86	102	72	90	98	96	123				
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
19.	Kepuasan pasien	≥ 76,61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
20.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
21.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
22.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
23.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
24.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
25.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
26.	Kelengkapan forum edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
27.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

28.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
29.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
30.	Angka kelengkapan pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
31.	Kejadian tidak dilakukan edukasi RSSIB pada pasien post partum dan post SC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
32.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
33.	Kejadian tidak dilakukannya IMD pada bayi baru lahir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

3.7.28 NICU

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian kematian bayi (mutu prioritas unit)	0	0	1	2	0	1	1	3	0	2				
2.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	98,31%	99,02%	99,45%	99,57%	99,88%	99,98%	99,8%	99,88%	100%				
3.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,98%	99,79%	99,71%	99,74%	99,81%	99,84%	99,67%	99,86%	100%				
4.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
5.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	85,11%	85,51%	81,18%	84,09%	78,13%	87,3%	76,2%	62,34%	100%				
6.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesauaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
8.	Kepuasan Pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	95,51%	98,86%	100%	95,54%	100%				

10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
12.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,88%	98,88%	100%	100%				
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
14.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
15.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	88,46%	94,92%	96,8%	88,47%	89%				
16.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
17.	Kelengkapan Follow Up Setelah Discharge	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
18.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,92%	100%	100%	100%				
19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%				
20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%				
21.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
22.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk NICU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
23.	Angka Kelengkapan Pengkajian Pasien Tahap Akhir Kehidupan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
24.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
25.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (164lastic164)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

26.	Kejadian Merujuk Pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
-----	--------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

1.6.1.2.6.16 PICU

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (Anak) (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1005	100%				
2.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	99,23%	99,44%	99,44%	99,61%	99,88%	98,74%	98,8%	98,92%	99,20%				
3.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,11%	98,79%	98,79%	98,82%	98,92%	98,73%	98,78%	99,21%	99,46%				
4.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
5.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
6.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesauaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
8.	Kepuasan Pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
12.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

14.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
15.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
16.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
17.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
18.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
19.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
20.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk PICU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
21.	Angka Kelengkapan Pengkajian Pasien Tahap Akhir Kehidupan	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
22.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
23.	Kejadian Merujuk Pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

3.7.29 IKO

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian tidak dilakukannya skiren pada pasien operasi yg seharusnya diskiren (mutu prioritas unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.	Kepatuhan identifikasi pasien.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
3.	Penundaan operasi elektif.	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,32%				
4.	Kepatuhan 166last pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%	95,61%	100%	100%	100%	100%				
5.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
6.	Kejadian keterlambatan operasi> 30 menit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

7.	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis pemulihan anestesi dan sedasi dalam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8.	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis selama anestesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9.	Kejadian tidak dilaksanakannya pengkajian pra sedasi dan pra anestesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10.	Kejadian diskrepansi diagnose pre dan post op	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11.	Kejadian tidak dilaksanakan SSC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12.	Kejadian tidak lengkapnya pengkajian pra bedah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13.	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan 167lasti operasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14.	Kejadian ketidaklengkapan form daftar tilik pasien operasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15.	Kejadian Ketidapatuhan Prosedur Pasien Yang Menggunakan Implan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16.	Kejadian ketidaklengkapan formular penandaan pasien operasi	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0				
17.	Ketidakhadiran dokter anak saat operasi SC	0	0	0	81,98%	19,84%	21,05%	42,31%	32,6%	100%	100%				
18.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan inform consent	100%	100%	100%	100%	98,37%	92,98%	98,22%	100%	100%	100%				
19.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Apendicitis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
20.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi STT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

21.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
22.	Kepatuhan pencatatan pesan lewat telepon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
23.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
24.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
25.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
26.	Kepatuhan pelaksanaan asesmen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
27.	Kelengkapan forum edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
28.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
29.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
30.	Kelengkapan Asesmen pra sedasi dan pra anestesi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

3.7.30 Laboratorium

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian ketidaktersediaan Reagen esensial di laboratorium (mutu prioritas unit)	0	0	0	3	0	5	0	0	0	0				

2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
3.	Pelaporan hasil kritis laboratorium	100%	96,9%	97,31%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
4.	Ketersediaan kantong darah sesuai golongan	100%	100%	100%	100%	100%	98,44%	100%	100%	100%	100%				
5.	Survilen harian hemofiglen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1005	100%	100%	100%				
6.	Angka kepatuhan Prosedur penggunaan produk darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
7.	Kejadian salah input hasil laboratorium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8.	Waktu tunggu hasil laboratorium >140 menit	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
9.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
10.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
11.	Kepatuhan Pelaporan Kritis Gula Darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
12.	Angka kepatuhan pengelolaan POCT (proses pelaporan nilai kritis, kualifikasi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
13.	Waktu tunggu hasil laborat cito <30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

3.7.31 Radiologi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	97,88%	100%	100%	98,74%	100%	100%	100%	100%	100%				
2	Angka ketidaklengkapan permintaan form radiologi	0%	2,12%	3,54	5,5%	6,99%	7,4%	6,22%	5,2%	4,8%	6,59%				
3	Kepatuhan pelaporan nilai kritis hasil radiologi <30 menit	0	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
4.	Kepatuhan edukasi pada prosedur radiasi	100%	100%	100%	100%	99,49%	100%	100%	100%	100%	100%				

5.	Angka kelengkapan inform consen pada prosedur radiasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
6.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
7.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

3.7.32 Gizi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian pasien baru tidak mendapatkan makan (mutu prioritas unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
3.	Kejadian kesalahan pemberian diit	0	0	0	4	1	2	0	0	0	0				
4.	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.	Kelengkapan pengkajian gizi (awal dam lanjut)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
6.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	99,44%	99,67%	99,21&	99,42%	99,82%	98,92%	99,28%	99,40%	99,48%				
7.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,01%	99,23%	98,92%	99,22%	99,54%	99,31%	999,42%	99,53%	99,60%				

3.7.33 Farmasi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka ketersediaan obat obatan emergency (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
3.	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

4.	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	0	0	1	0	1	0	4	4	4\6				
5.	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6.	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	68,85%	61,98%	74,45%	75,13%	69,23%	55,10%	48,88%	47,72%	43,08%				
7.	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	48,68%	44,17%	59,59%	60,78%	53,23%	31,35%	24,03%	19,97%	15,70%				
8.	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0	1	0	3	1	1	0	0				
9.	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0				
10.	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11.	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0				
12.	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13.	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0	20	13	0	0	0	0	0				
14.	Kejadian obat pasien rawat jalan yang tidak diambil	0	0	0	29	22	42	32	0	0	0				
15.	Kepatuhan penggunaan panduan antibiotik dan efektifitas jangka panjang dan jangka pendek	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
16.	Kepatuhan penyimpanan obat obatan emergency disimpan secara seragam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
17.	Kepatuhan proses pengelolaan obat recal hingga pengembalian atau pemusnahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
18.	Angka Kepatuhan pengelolaan obat kedaluwarsa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
19.	Angka Kepatuhan penyimpanan dan pengelolaan obat yang perlu di waspadi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
20.	Kepatuhan penyimpanan, pengelolaan dan pemberian obat elektrolit pekat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

21.	Angka Kepatuhan peresepan dan interuksi medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
22.	Angka kepatuhan dispensing	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
23.	Angka kepatuhan pemberian obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
24.	Angka kelengkapan pencatatan efek samping obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
25.	Angka Kepatuhan Pelaporan Medication Error	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
26.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%	84,29%	89,92%	100%	87,72%	87,72%				
27.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%	93,10%	97,66%	100%	100%	100%	100%	100%				
28.	Kepatuhan pelaksanaan panduan penggunaan single dose vial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
29.	Kepatuhan penggunaan risk based approach monitoring penggunaan obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
30.	Angka kepatuhan pengkajian risiko penggunaan obat yang dibawa pasien dari rumah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

3.7.34 Pengadaan Farmasi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sep '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kekosongan stok farmasi	0%	0%	0%	0,42%	0,24%	0,35%	0,45%	0,26%	0,17%	0,18%				
2	Angka kepatuhan kolaborasi tim pengadaan obat	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

3.7.35 PPI

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sep '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	0,27%	0,29%	0,29%	0,48%	0,53%	0,27%	0,23%	0,49%	0,51%				

2.	IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤3,5‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰				
3.	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰				
4.	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰				
5.	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 %	0,21%	0,23%	0,23%	0,1%	0,5%	0,61%	0,73%	0,78%	0,42%				
6.	Angka Decubitus	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
7.	Angka kepatuhan kebersihan tangan	>85%	85,21%	85,35%	85,32%	85,36%	85,49%	85,32%	85,25%	85,38%	85,58%				
8.	Angka kepatuhan penggunaan APD oleh petugas	100%	93,01%	93,06%	93,1%	93,39%	93,59%	93,74%	93,79%	94,3%	94,33%				
9.	Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan	100%	93,44%	93,21%	93,27%	93,42%	93,51%	93,74%	93,77%	94,35%	94,35%				
10.	Kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0				

3.7.36 PIPP

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka Terhubungnya Display TT Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
2.	Angk Terhubungnya Operasi Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
3.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain < 1 kali dari 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
4.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain < 1 kali dari 24 jam	100%	100%	1005	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
5.	Kepuasan Pasien	76,61%	99,81%	99,79%	100%	99,88%	99,76%	97,12%	99,46%	99,56%	99,56%				
6.	Kepatuhan Petugas Dalam Mengumpulkan Kuesioner Kompalin dan Kepuasan Pelanggan (Indikator baru 2024)	100%	14,12	18,94%	16,09%%	16,89%	18,12%	16,32%	14,22%	19,16%	19,16%				
7.	Angka Kepuasan Pasien BPJS	100%	99,9%	99,89	100%	100%	99,98%	100%	100%	99,52%	99,52%				
8.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
9.	Kelengkapan Follow Up Setelah Discharge	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

3.7.37 SDM

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0				
2	Angka kedisiplinan staf terhadap finger print.	100%	78%	98,51%	98,69%	98,79%	98,69%	98,66%	99,03%	98,96%	98,54%				
3	Angka keterlambatan kehadiran staf	0%	37%	2,39%	1,91%	2,31%	1,48%	2,03%	2,41%	2,23%	1,99%				
4.	Angka pemenuhan kompetensi sesuai dengan unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
5.	Angka kelengkapan file kepegawaian dimasing masing unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

3.7.38 Rekam Medis

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat Inap (mutu prioritas unit)	100%	91,86%	29,3%	35,83%	51,74%	50,36%	36,06%	80,93%	78,88%	93,95%				
2.	Angka kejadian nomor rekam medis ganda	0%	0,14%	0,23%	0,35%	0,47%	0,32%	0,23%	0,49%	0,27%	0,19%				
3.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat jalan	100%	91,86%	70,8%	98,04%	1,57%	7%	6,67%	100%	100%	100%				
4.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien IGD	100%	100%	100%	90,25%	88,2%	10,23%	2,05%	100%	100%	100%				
5.	Kejadian Kendala Pada SIMRS Dalam Upaya Menunjang Pelayanan Rekam Medis Elektronik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6.	Kelengkapan Keakuratan Pada Penginputan Data Pasien Di SIMRS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
7.	Keterlambatan Pengumpulan DRM Pasien Rawat Inap Lebih Dari 24 Jam	0%	7,56%	7,89%	9,56%	15,3%	12,21%	10,47%	7,54%	7,6%	12%				
8.	Angka keterbacaan dokumen rekam medis	100%	100%	100%	98,17%	95,87%	95,88%	96,2%	95,94%	100%	100%				

3.7.39 K3RS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka kepatuhan petugas melakukan pengecekan APAR.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
2	Kejadian kebakaran di ruangan.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	Kejadian tenaga Kesehatan sakit akibat kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

3.7.40 Asuransi Center

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian dokumen rawat jalan tidak layak klaim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.	Angka pending klaim BPJS	0%	3,05%	2,54%	3,23%	3,23%	1,62%	1,19	1,12%	1,32%	1,24%				
3.	Prosentase readmisi pasien rawat inap	0%	0,91%	1,9%	2,22%	2,18%	2,05%	1,31	1,42%	1,21%	1,32%				
4.	Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS	100%	98,99%	98,96%	99,26%	98,89%	98,9%	98,8%	99,22%	99,425	99,82%				
5.	Kejadian Pasien Tidak Di SEP	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0				

3.7.41 IPSRS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka Keterlambatan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam	0%	46%	65%	78%	61%	68%	78%	80%	95%	95%				
2.	Angka keterlambatan respon dan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam (alat medis)	0%	97%	92%	94%	95%	95%	97%	95%	95%	95%				

3.7.42 UMUM

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Keterlambatan barang datang di Gudang	0	7	8	7	2	4	2	2	3	2				
2	Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit	0	10	8	2	2	4	3	7	3	7				

3.7.43 Cleaning Service

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka ketidakpatuhan penggunaan spillkit	0%	47,5%	59,26%	23,53%	45%	85,22%	35,4%	28,88%	22,35%	20,44%				
2.	Kejadian 176lastic176 Kebersihan Kamar Mandi	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
3.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	88,72%	91,33%	92,47	94,21%	96,62%	97,88%	98,21%	98,40%	98,80%				
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	92%	94,07%	94,28	96,82%	98,24%	99,02%	99,37%	99,55%	99,58%				

3.7.44 KESEKRETARIATAN

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka keterlambatan pengumpulan laporan bulanan unit tanggal 4 setiap bulannya	0%	50%	40,48%	56,52%	50%	22,5%	47,62%	26,19%	23,8%	28,57%				
2	Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS 1x 24 jam hari kerja	0%	27,27%	23,08%	31,82%	27,78%	38,1%	9,09%	18,18%	34,5%	40%				
3	Angka tindakan lanjut balasan surat masuk eksternal lebih dari 2x24 jam	0%	29,41%	29,41%	34,88%	34,78%	31,25%	20%	13,51%	46,7%	20%				

3.7.45 Laundry

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka keterlambatan penyediaan linen	0%	2,14%	1,78%	2,23%	1,32%	2,06%	2,5%	1,15%	1,22%	1,28%				
2	Kejadian linen ruang perawatan hilang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.	Kejadian Tercampur Benda Asing	0	0	0	1	1	1	0	2	0	0				
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	98,82%	99,32%	99,04%	99,22%	99,85%	100%	100%	100%	100%				
5.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	97,23%	96,22%	96,48%	96,92%	98,72%	100%	100%	100%	100%				

3.7.46 CSSD

No	Judul	Stan	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian ditemukannya instrument hilang	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0				
2	Kejadian instrument kurang	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1				
3.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	96,77%	97,11%	97,88%	98,22%	100%	100%	100%	100%	100%				

3.7.47 Humas dan Pemasaran

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka kunjungan rawat inap >90 pasien perhari	100%	98,71%	98,71%	99,86%	79,78%	84,44%	86,73%	89,32%	94,52%	99,32%				
2	Angka kunjungan rawat jalan >350 pasien perhari	100%	86,69%	93,82%	93,82%	79,81%	86,21%	88,21%	91,7%	91,88%	87,16%				
3.	Angka kunjungan pasien rencana operasi 15 pasien perhari	100%	92,34%	91,22%	92,46%	76,14%	79,22%	81,44%	75%	78%	74,3%				
4.	Angka kunjungan MCU dan vaksin 150 perbulan	100%	100%	98,82%	97,92%	72,67%	70,22%	76,22%	100%	92,75%	100%				

1.6.1.2.6.36 IT

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian downtime	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0				
2	Respon time penanganan internet dan billing error < 30 mnt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
3	Respon Time untuk penanganan computer < 15 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

3.6.1.2.6.37 Kamar Jenazah

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan pencatatan pada buku register	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
2	Kelengkapan APD pada ruang jenazah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

3.7.48 PKRS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan pelaksanaan edukasi kelompok	100	53,26%	68,38%	78,88%	82,44%	92,34%	82,75%	86,45%	84,75%	88,90%				

3.6.1.2.6.38 DRIVER

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Respon time Panggilan Driver < 10 menit On Side	100%	99,2%	99,68%	99,88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
2	Respon time Panggilan Driver < 30 menit On Call	100%	100%	99,92%	99,82%	98,88%	98,64%	100%	100%	100%	100%				

3	Kepatuhan pemeliharaan alat transportasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
4	Angka kelengkapan alat emergency untuk ambulance emergency	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
5	Kepatuhan pelaksanaan decontaminasi pasca transport pasien menular pada ambulance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

3.6.1.2.6.39 SECURITY

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian ditemukannya merokok, 179lastic rokok di lingkungan RS (mutu prioritas unit)	0	6	11	7	14	21	13	18	19	16				
2	Kejadian Barang Hilang Di Area Rumah Sakit	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0				
3	Kejadian potensial barang hilang	0	7	9	13	9	8	9	7	4	5				
4	Kejadian kekerasan di lingkungan RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

1.6.2 Komite PPI

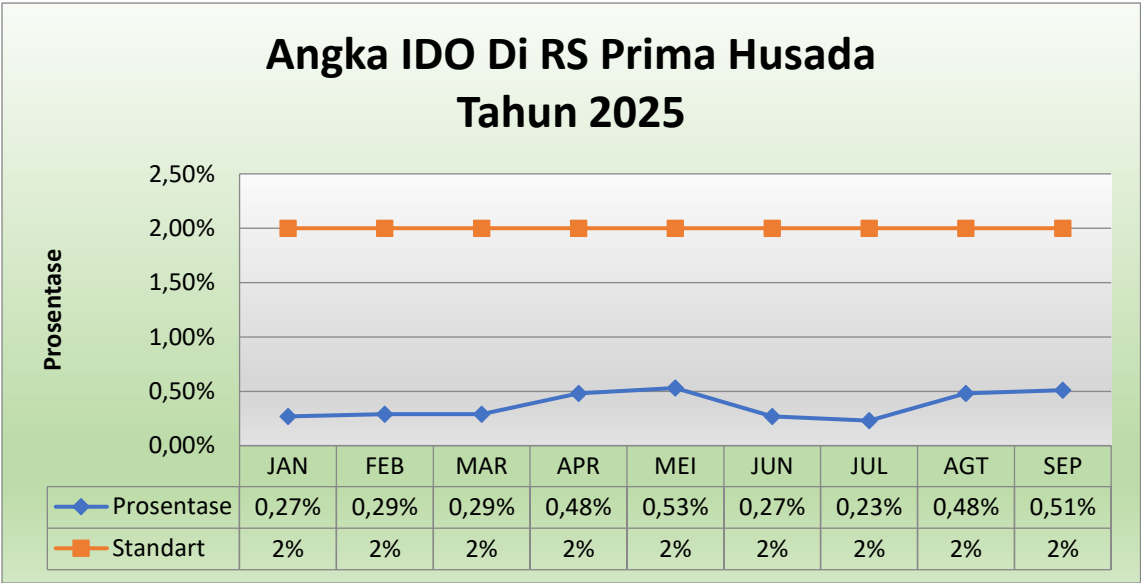
1.6.2.2 Hasil Surveilans dan Mutu PPI

1.6.2.2.5 IDO (Infeksi Daerah Operasi)

1.6.3.5.1 Tabel Data IDO berdasarkan Jenis Tindakan Operasi Sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

Jenis Tindakan Operasi di RS	SSI		
	Jumlah Kasus	Jumlah Tindakan Operasi	Insiden (%)
Bedah Orthopedi	0	79	0%
Seksio Sesar	2	79	2,53%
Apendiktomi	0	13	0%
Herniotomi	0	4	0%
Katarak	0	35	0%
CABG	-	-	-
Tumor Payudara	0	13	0%
Semua Operasi	2	395	0,51%

1.6.3.5.2 Grafik Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO)



Analisa

Dari grafik diatas diperoleh data terdapat kejadian IDO pada 2 orang pasien yang menjalani operasi SC.

- Dari hasil assesmen pasien post SC diperoleh data bahwa pada saat operasi 7 orang staf ikut operasi dan Luka terbuka teridentifikasi saat kontrol dan memerlukan rehecting.

Pencukuran dengan silet manual dan pasien tidak dilakukan kultur pus saat ditemukan luka basah dan Rehecting dilakukan hari ke-13 akibat wound infection.

Pasien sudah menggunakan Dressing transparan, meskipun beresiko kurang protektif namun lebih mudah untuk monitoring kondisi luka.

Suhu ruang OK 22°C, kelembapan 52%, tekanan positif (sesuai standar OK)

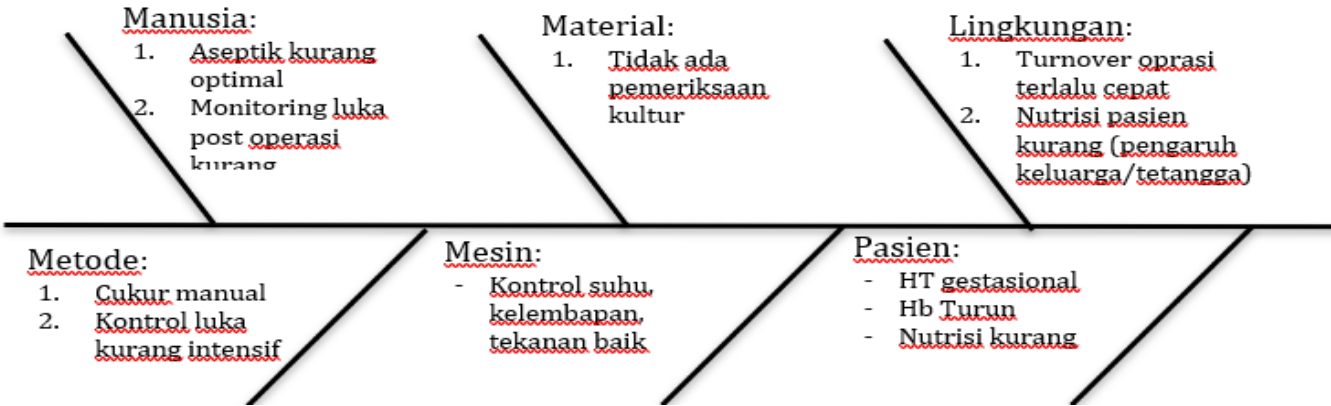
Ruang OK 3 dipakai tidak terlalu berdekatan (operasi sebelumnya jam 06.30, pasien ini jam 12.30), namun proses pembersihan perlu dievaluasi. Turnover ruang operasi cepat berpotensi kurang optimal desinfeksi lingkungan.

Pasien usia 24 tahun, G1P0Ab0, KPD + kala II lama, Berat badan 66 kg, Hb 10 g/dL (12/9), 8,5 g/dL (25/9), naik jadi 11 g/dL post transfusi (26/9), Leukosit naik: 9280 → 14.520.

Nutrisi: konsumsi lebih banyak sayuran hijau & karbohidrat. Penurunan Hb dan nutrisi tidak adekuat (kurang protein) dapat memperlambat penyembuhan luka, risiko IDO meningkat.

Profilaksis yang digunakan: Cefazolin 2 gr, antibiotik yang didapat saat MRS 1: Cefadroxil, Post kontrol 1: Cefixime, MRS 2: Ceftriaxone, Post MRS 2: Cefixime + Metronidazole.

Pemberian antibiotik berlapis namun tidak ada kultur pus untuk memastikan antibiotik yang sesuai.



- Dari kasus IDO pada pasien post SC ditemukan hasil analisa bahwa 7 orang staf ikut operasi, resiko prosedur aseptis kurang optimal. Proses sterilisasi sudah sesuai (internal saja), lebih baik menggunakan dua indikator internal dan eksternal. Luka terbuka baru teridentifikasi saat kontrol ke-8. Pencukuran dengan silet manual, beresiko infeksi lebih tinggi.
- Tidak dilakukan kultur pus, penggunaan antibiotik Profilaksis: Cefazolin 2 gr, Post-op: Cefadroxile oral, post kontrol 1: Metronidazole, post kontrol 2: Gentamicin salf. Tidak ada data kuman spesifik dan penggunaan antibiotik bisa saja tidak sesuai.
- Pasien dirawat luka menggunakan Dressing transparan, dimana resiko kurang protektif namun mudah dikontrol. Indikator alat steril hanya indikator internal dirasa kurang optimal karena resiko sterilitas kurang.
- Suhu ruang OK 21°C, kelembapan 53%, tekanan positif (sesuai standar). Ruang OK dipakai berdekatan (jarak operasi sebelumnya hanya 2 jam). Turn over yang terlalu cepat menyebabkan resiko desinfeksi lingkungan kurang maksimal.

	Pasien Usia 35 tahun, G2P1 - Hb pre-op 10,8 g/dL, Nutrisi rendah protein (lebih banyak sayuran hijau). Imunitas menurun akibat Hb rendah dan kurangnya protein dapat beresiko penyembuhan luka tidak maksimal. Material: 1. Dokumentasi tidak dilakukan dengan baik 2. Tidak ada dokumen evaluasi luka standar Manusia: 1. Kurang patuh SPO pra op. 2. Kurang deteksi dini komplikasi 3. Edukasi pasien kurang Metode: 1. Tidak ada evaluasi penggunaan AB 2. Ceklist pra-intra post tidak dilakukan dengan baik Lingkungan: - Jumlah staf di dalam OK terlalu banyak - Kontrol lalu lintas OK kurang Pasien: - Tidak mandi antiseptic pra op. - Riwayat penyakit tidak lengkap - Nutrisi kurang				
Masalah saat ini	1. Faktor Manusia (kurangnya Teknik aseptik, monitoring luka post operasi kurang, kurang patuh terhadap SPO, kurang deteksi dini komplikasi, edukasi pasien kurang). 2. Faktor Pasien (Riwayat penyakit penyerta pasien tidak lengkap terkaji sehingga tidakan perawatan dan persiapan pra operasi masih kurang, tidak mandi antiseptic, dan nutrisi pasien yang masih kurang). 3. Faktor Lingkungan (Jumlah staf yang memang terlalu banyak di dalam OK dan turn over OK yang terlalu cepat sehingga desinfeksi ruangan tidak maksimal). 4. Faktor metode (Kontrol luka masih kurang maksimal, cukur manual masih digunakan, tidak ada evaluasi AB berdasarkan kultur). 5. Faktor material (dokumentasi tidak dilakukan dengan baik, tidak ada pemeriksaan kultur pus).				
Permasalahan sebelumnya	1. Belum adekuatnya edukasi perawatan pasien pasca operasi terutama perawatan setelah operasi pada ibu yang beresiko tinggi dan belum pernah menjalani operasi sebelumnya. 2. Mandi dengan cairan antiseptic/sabun belum berjalan baik terutama pada pasien dengan operasi cyto.				
Tindakan yang dilakukan	1. Monitoring prosedur klinis dengan baik (monitoring perawatan luka pasien post operasi, kontrol proses pencukuran dan perawatan/desinfeksi alat cukur dan penggunaan pisau cukur disposable). 2. Melakukan edukasi ulang perawat tentang deteksi dini tanda infeksi luka, terutama pasien di poli saat kontrol pertama. 3. Melakukan monitoring kepatuhan aseptik di ruang-ruang perawatan. 4. Mengkonfirmasi pada Karu kamar operasi untuk membantu menjadwalkan operasi dengan jeda minimal 1 jam dari operasi sebelumnya untuk proses desinfeksi ruangan kamar operasi. Termasuk untuk mengurangi padatan jumlah petugas didalam kamar operasi, untuk tim anastesi setelah dilakukan anastesi bisa keluar dari kamar operasi sementara 5. Melakukan koordinasi dengan ahli gizi untuk edukasi terkait kebutuhan nutrisi pasien pasca operasi, terutama pasien dengan operasi saluran cerna.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

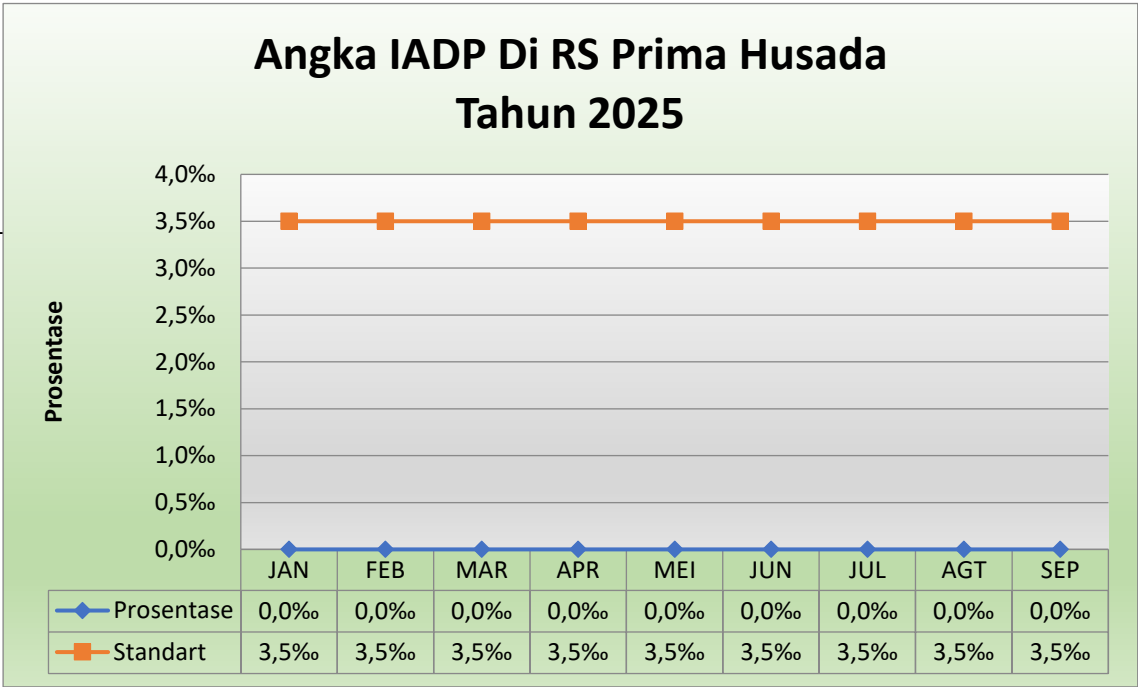
Memastikan bundle IDO berjalan dengan baik.	Resiko IDO pada pasien berkurang/hilang.	Pasien operasi	1. Berkolaborasi dengan PPA terkait kondisi penyakit penyerta serta memberikan edukasi untuk mencegah agar risiko infeksi tidak menjadi aktual. 2. Memastikan bundle IDO (pre, durante, dan post op dilakukan dengan baik) 3. Melakukan monitoring persiapan pasien operasi khususnya pasien dianjurkan untuk mandi antiseptic/sabun untuk mengurangi resiko infeksi. 4. Penggunaan alat tetap diperhatikan proses sterilisasi central di CSSD terutama jika dilakukan operasi estafet dengan kasus yang sama (SC).	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCEN	Satu bulan
Lanjutkan evaluasi pemahaman pemberian edukasi perawatan pasien pasca operasi	Meminimalisir kesalahpahaman penangkapan terkait edukasi perawatan pasien post operasi.	Pasien post operasi.	1. Koordinasi dengan perawat ruangan untuk memastikan pasien dan sudah mendapatkan edukasi terkait perawatan saat di rumah. 2. Pastikan pasien paham saat diedukasi dengan menanyakan kembali inti edukasi yang telah diberikan. (Memastikan komponen edukasi tersampaikan dengan baik/Komunikasikan-komunikasikan-pesan-media-feedback) 3. Lakukan edukasi pada saat pasien terdapat pendamping keluarga terutama yang satu rumah dengan pasien. 4. Bantu berikan dorongan afirmasi positif atas keadaan yang terjadi pada pasien agar tidak mengganggu proses penyembuhan agar pasien lebih semangat untuk sembuh. 5. Berikan tambahan edukasi terkait kontrol pikiran pasien terutama terkait pantangan yang tidak perlu dipercaya di masyarakat.	1. Perawat /Bidan 2. Karu 3. IPCLN/IPCEN	Satu bulan

3.6.1.1.2 IADP

3.6.1.1.2.1 Tabel Data IDP Berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAIs Kemenkes

Ruang	SSI		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian CVC	Insiden (%)
ICU	0	0	0‰
HCU	0	0	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	0	0‰

3.7.49 Grafik Angka Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus IADP pada 6hari total lama pemasangan CVC pada pasien bulan ini.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi IADP				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi IADP				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan tindakan pemasangan CVC. 2. Melakukan evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. 3. Melakukan monitoring kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. 4. Melakukan monitoring 5. perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle IADP.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IADP.	Pasien dengan pemakaian CVC.	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. 3. Monitoring evaluasi kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

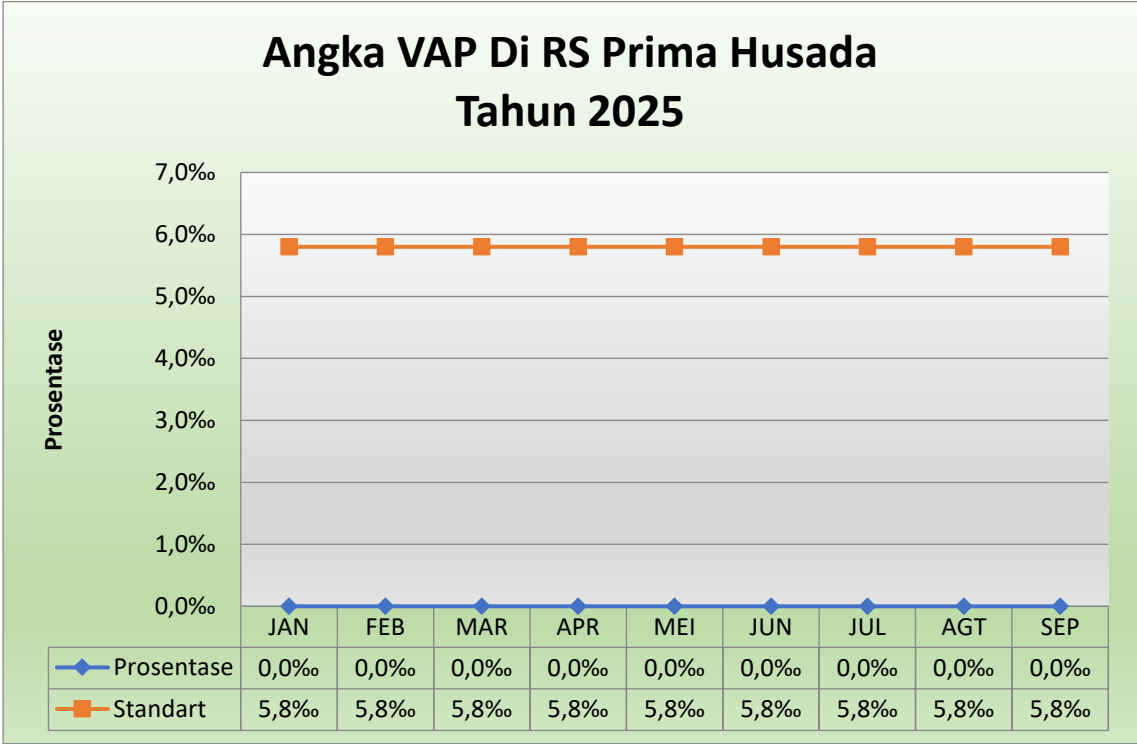
			4. Monitoring evaluasi perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.		
--	--	--	--	--	--

1.6.1.1.3 VAP

1.6.1.1.3.1 Tabel Data VAP berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

Ruang	VAP		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian Ventilator	Insiden (%)
ICU	0	88	0‰
HCU	0	0	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	1	0‰

1.6.1.1.3.2 Grafik Angka Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator (VAP)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus VAP pada 106 hari total lama pemasangan ventilator pada pasien bulan ini.
Masalah saat ini	Tidak terjadi VAP
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi VAP
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan evaluasi perawatan pasien dengan terpasang ventilasi mekanik. 2. Melakukan audit monitoring saat pemasangan ventilator. 3. Melakukan observasi tanda-tanda dehidrasi (bibir kering) pada pasien yang terpasang ventilator. 4. Melakukan evaluasi saat pasien dilakukan penghisapan 185lasti / suction. 5. Melakukan koordinasi dengan Kabid keperawatan terkait edaran kewajiban melakukan oral hygiene pada pasien yang terpasang ventilator dan mendokumentasikan di CPPT/Askep.

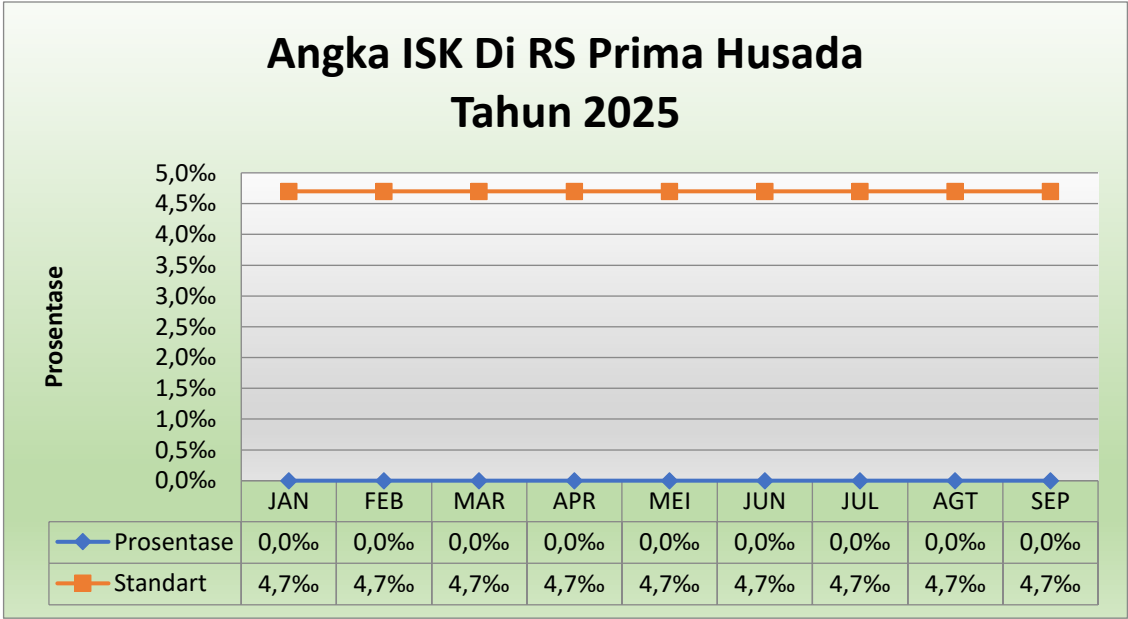
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Tingkatkan kepatuhan bundle VAP, khususnya pelaksanaan oral hygiene.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle VAP (oral hygiene).	Pasien yang terpasang ventilator mekanik	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan ventilator. 3. Monitoring evaluasi posisi tepat pasien <i>head of bed</i> >30°-45°. 4. Monitoring evaluasi tindakan pemasangan ventilator. 5. Monitoring kegiatan oral hygiene dan pendokumentasian di RM. 6. Pemberian tindakan oral hygiene mewajibkan juga diedukasikan pada keluarga pasien, agar keluarga ikut aktif mengingatkan petugas untuk melakukan tindakan tersebut.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPC�	Satu bulan

1.6.1.1.4 ISK

1.6.1.1.4.1 Tabel Data berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR ((Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

Ruang	ISK		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian Ventilator	Insiden (‰)
ICU	0	218	0‰
HCU	0	40	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	0	0‰

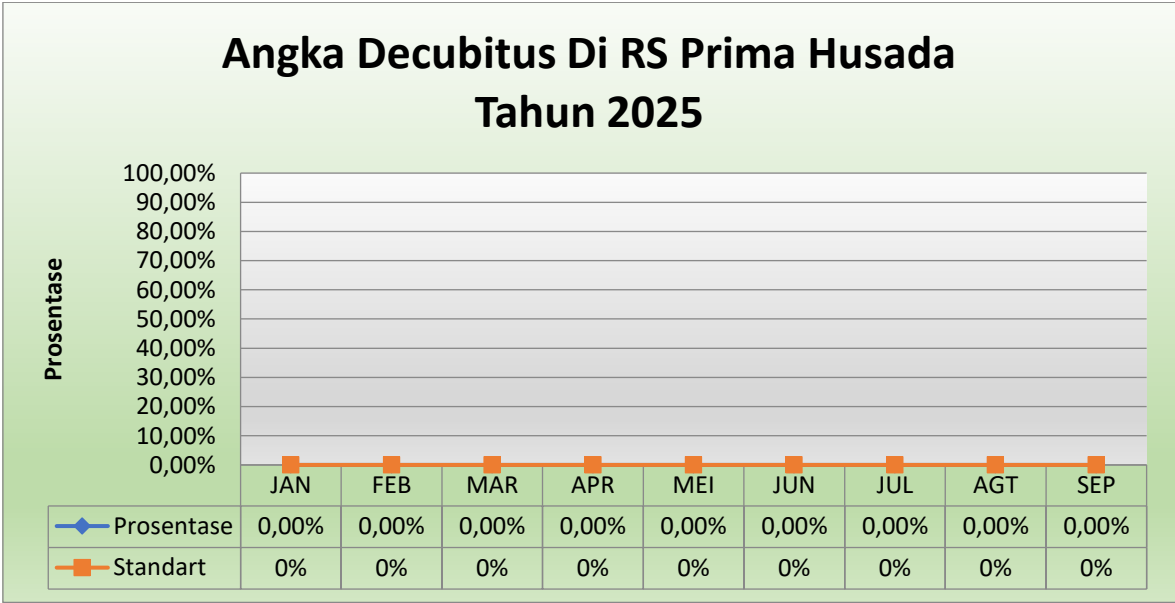
3.7.50 Grafik Angka Infeksi Saluran Kencing (ISK)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus ISK pada total 1151 hari lama pemakaian kateter pasien.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi ISK				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi ISK				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan perawatan pasien. 2. Melakukan monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. 3. Melakukan monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. 4. Melakukan monitoring perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle ISK.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle ISK.	Pasien yang terpasang kateter	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. 3. Monitoring evaluasi teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. 4. Monitoring evaluasi perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/PCPN	Satu bulan

1.6.1.1.5 Decubitus

1.6.1.1.5.1 Grafik Angka Decubitus

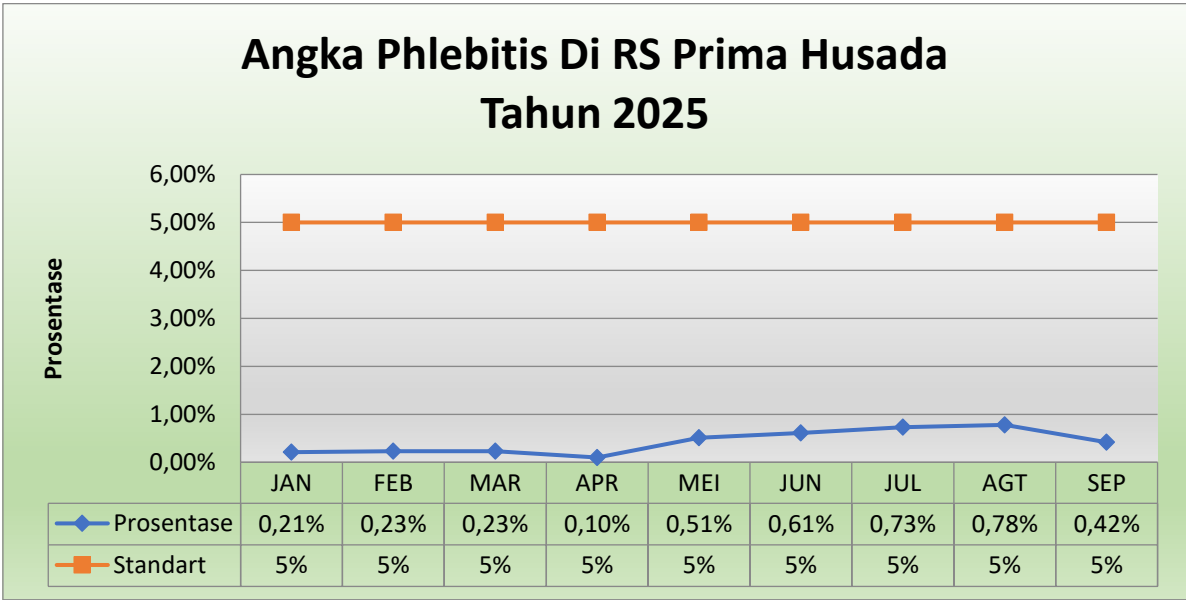


Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus decubitus pada 25 pasien tirah baring lama.
Masalah saat ini	Tidak terjadi decubitus
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi decubitus
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan proses perawatan pasien. 2. Melakukan monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). 3. Melakukan monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin.

	4. Memastikan personal hygiene dilakukan dengan rutin oleh petugas.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan pencegahan 188lastic188e.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan pencegahan dekubitus.	Pasien yang tirah baring lama (> 3x24 jam)	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). 3. Anjurkan penggunaan 188 last anti decubitus atau alternatif lain 4. Monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. 5. Lakukan perawatan luka rutin jika sudah terdapat luka supaya tidak melebar.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

1.6.1.1.6 Phlebitis

3.7.51 Grafik Angka Infeksi Jarum Infus (Phlebitis)

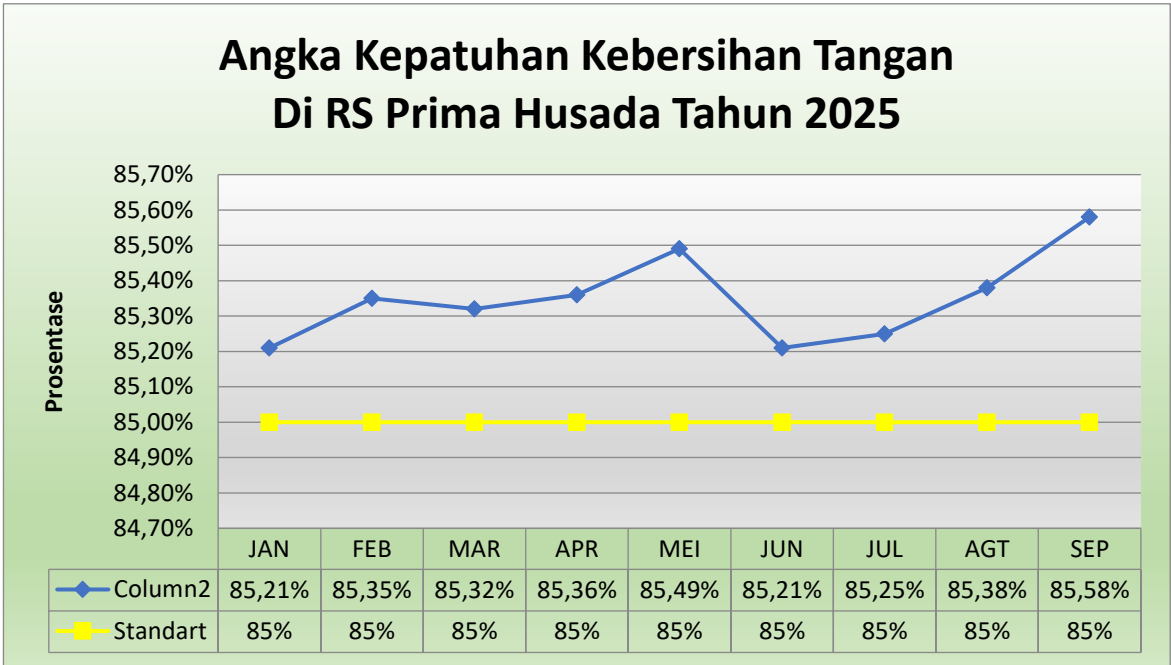


Analisa	Masih ditemukan kasus Phlebitis pada bulan ini dari total 2623 pasien yang terpasang infus setiap harinya dengan prosentase 0,42%, masih memenuhi standar nasional. Dari data yang diperoleh terdapat 11 pasien yang mengalami phlebitis, 2 diantaranya merupakan pasien berusia >60 tahun, 1 pasien anak-anak dan sisanya pasien dewasa, dimana 27% masuk pada faktor usia beresiko phlebitis. 4 diantara 11 pasien tersebut mengalami phlebitis karena mendapatkan cairan pekat seperti D40% dan obat seperti amiodaron dan 1 orang mendapat 2 antibiotik metronidazole dan cefotaxime. Pasien lainnya tidak mendapatkan cairan pekat hanya mendapat 1 antibiotik dan injeksi pekat seperti metamizole. Pemasangan plester tidak transparan juga membuat kesulitan untuk memantau kondisi luka tusukan infus. Dari 12 pasien yang ditanyai, tidak ditemukan pasien yang rawat inap mengalami infus slong (cairan infus pada indikator selang infus habis).
Masalah saat ini	1. Penggunaan cairan pekat masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, termasuk juga pemberian transfusi darah. 2. Faktor internal pasien seperti usia pasien yang beresiko phlebitis juga berpengaruh, perlunya edukasi lanjut terkait ini. 3. Faktor pemilihan lokasi pemasangan infus dan pemilihan pemakaian plester transparan perlu diperhatikan.
Permasalahan sebelumnya	1. Penggunaan cairan pekat masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, termasuk juga infus pekat dan antibiotik dobel..

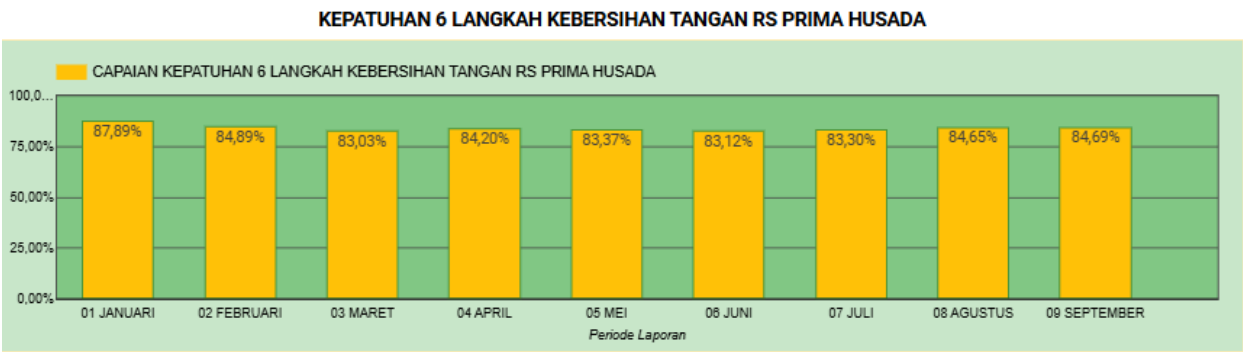
	2. Faktor internal pasien seperti usia pasien yang beresiko phlebitis juga berpengaruh, perlunya edukasi lanjut terkait ini. 3. Faktor pemilihan lokasi pemasangan infus dan pemilihan pemakaian plester transparan perlu diperhatikan.				
Tindakan yang dilakukan	1. Mengkoordinasikan dengan kabid dan komite keperawatan terkait sosialisasi pemasangan infus yang benar dan penanganan phlebitis. 2. Mengajukan pada perawat pemasangan infus benar-benar harus menentukan posisi vena yang tepat dan memberikan edukasi setelah melakukan pemasangan infus terutama pada pasien beresiko tinggi. 3. Mengajukan perawat untuk melakukan monitoring luka tusukan infus terutama pada pasien yang terpasang cairan pekat setiap hari setelah melakukan injeksi. 4. Menyarankan petugas untuk memberikan kompres hangat pada pasien yang mendapatkan cairan pekat pada area tangan yang terpasang infus untuk merilekskan pembuluh darah dan cairan pekat/darah tidak gampang menggumpal. 5. Mengajukan perawat untuk menggunakan plester transparan supaya area luka infus dapat lebih mudah dikontrol.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Perbaiki kepatuhan bundle phlebitis.	Memperbaiki kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	Pasien yang terpasang infus	1. Monitoring penyuntikan yang aman benar dilakukan. 2. Monitoring penggunaan cairan pekat maupun double antibiotic diberikan secara aman. 3. Monitoring kondisi luka tusukan infus setiap selesai melakukan injeksi. 4. Memberikan injeksi obat secara perlahan untuk mengurangi nyeri dan memperkecil resiko phlebitis. 5. Mengedukasi perawat unit untuk mengeset tetesan infus secara benar supaya hitungan jam habis infus dapat diperkirakan dan tidak sampai kehabisan. 6. Monitoring kepatuhan pemakaian APD terutama sarung tangan saat pemasangan infus dan kebersihan tangan sebelum memakai sarung tangan. 7. Monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan infus. 8. Tertibkan pencatatan petugas yang melakukan pemasangan infus pada plester infus pasien beserta tanggal pemasangan untuk mengontrol mutu skill dari perawat.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

1.6.1.1.7 Kebersihan Tangan

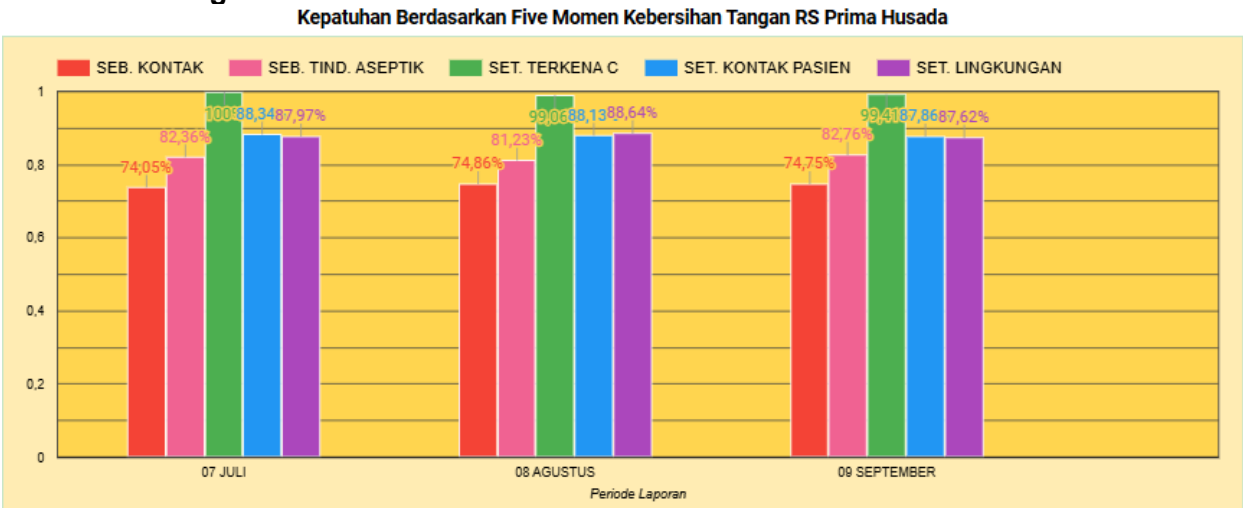
3.7.52 Grafik Angka Kepatuhan kebersihan Tangan (*Hand Hygiene*)



1.6.1.1.7.2 Grafik Kepatuhan 6 Langkah Kebersihan (Hand Hygiene)



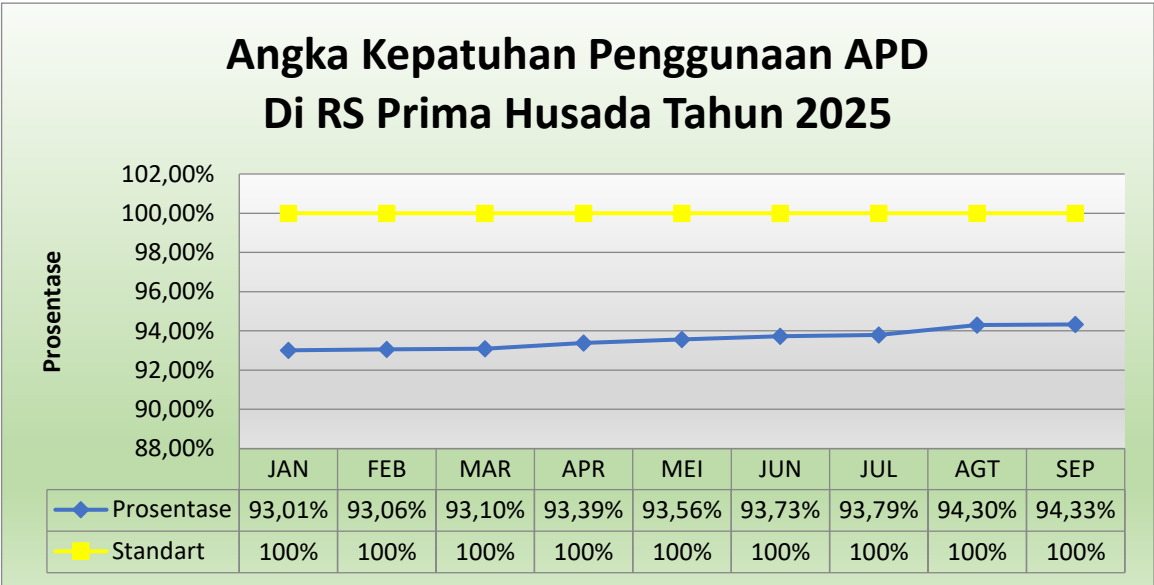
1.6.1.1.7.3 Grafik Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan 5 Momen Cuci Tangan



Analisa	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,58%. Masih belum bisa mencapai target 100% karena memang masih ditemukan petugas yang tidak melakukan cuci tangan terutama pada momen sebelum kontak pasien (74,75%). Terjadi sedikit peningkatan kepatuhan kebersihan tangan hal ini disebabkan karena supervisi yang dilakukan tidak hanya oleh IPCN tetapi IPCLN juga turut bantu mengingatkan untuk melakukan 5 moment 6 langkah cuci tangan dengan baik. Dilihat dari segi kepatuhan 6 langkah cuci tangan, 84,69% dari petugas dapat melakukan 6 langkah cuci tangan dengan baik, karena pada saat audit juga terus diajarkan caranya melakukan 6 langkah yang benar. Namun memang karena belum menjadi kebiasaan dari petugas sehingga masih ada yang tidak urut melaksanakan 6 langkah cuci tangannya.				
Masalah saat ini	Petugas paham terkait 5 momen 6 langkah cuci tangan tetapi tidak dijalankan sepenuhnya saat pelayanan ke pasien (belum terbiasa).				
Permasalahan sebelumnya	Petugas paham terkait 5 momen 6 langkah cuci tangan tetapi tidak dibiasakan dalam melakukan tindakan sehari-hari.				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Mengajarkan cuci tangan yang benar saat melakukan audit di ruangan. 3. Memberikan contoh cara cuci tangan yang benar saat mengisi diklat KE. 4. Melakukan kontrol monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasienlain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik. 6. Lakukan sosialisasi ke petugas langsung pada saat melakukan supervisi untuk mengingatkan kebiasaan petugas dalam kebersihan tangan.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.6.1.1.8 Kepatuhan APD

3.6.1.1.8 .1 Grafik Angka Kepatuhan Penggunaan APD oleh Petugas

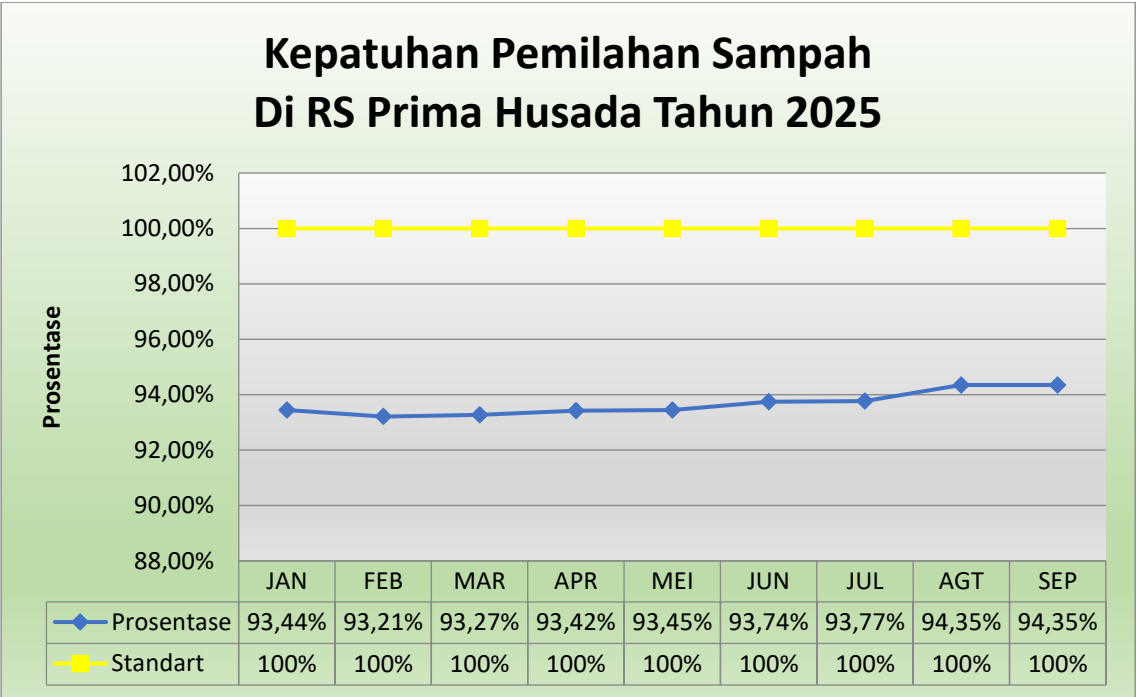


Analisa	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 94,33%. Dari hasil monitoring dan supervise, terjadi sedikit peningkatan kepatuhan pemakaian APD, Namun masih ditemukan 3 kali berlebihan memakai APD sarung tangan dan 4 kali pemakaian APD skort berlebihan salah satunya ada 1 DPJP yang saat visite masih selalu memakai APD lengkap walaupun tidak melakukan tindakan invasif.				
Masalah saat ini	Kurangnya kesadaran petugas terhadap penggunaan APD yang sesuai untuk menghindari penyebaran infeksi dengan mementingkan keuntungan pemakaian APD pribadi dan tidak melihat kerugiannya pada orang lain.				
Permasalahan sebelumnya	Kurangnya kesadaran petugas terhadap penggunaan APD yang sesuai untuk menghindari penyebaran infeksi dengan mementingkan keuntungan pemakaian APD pribadi dan tidak melihat kerugiannya pada orang lain				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 2. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 3. Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 4. Mengingatkan kembali petugas yang memakai APD berlebihan terkait transmisi penyebaran penyakitnya. 5. Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD, konfirmasi Karu dan SDM). 6. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Tingkatkan sosialisasi pada petugas langsung saat melakukan supervisi unit. 2. Koordinasi dengan IPCD untuk membantu meningkatkan pemahaman terkait APD pada para DPJP. 3. Berkolaborasi dengan SDM terkait ketidak disiplin petugas dalam pemakaian APD. 4. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan. 5. Lakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

			6. Berikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. 7. Tanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.		
--	--	--	---	--	--

3.6.1.1.9 Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius

3.6.1.1.9.1 Grafik Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan



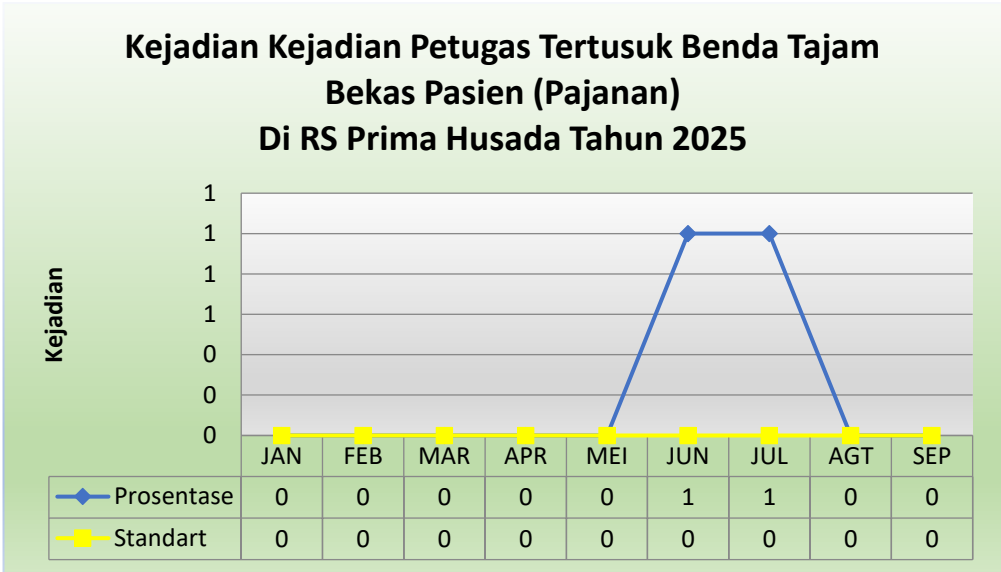
Analisa	Prosentase kepatuhan pemilahan sampah infeksius dan non infeksius keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 94,35%. Dari hasil monitoring dan supervise, memang masih ditemukan petugas yang tidak melakukan pemilahan dengan baik saat melakukan tindakan dengan permasalahan utama yang sulit dihindari yaitu terkait pembuangan sampah bungkus spuit dan alcohol swab yang sering sekali dimasukkan ke sampah infeksius.				
Masalah saat ini	Petugas tidak patuh melakukan pemisahan sampah saat melakukan tindakan sehingga sampah yang seharusnya non infeksius menjadi infeksius (terutama bungkus alkes).				
Permasalahan sebelumnya	Petugas tidak patuh melakukan pemisahan sampah saat melakukan tindakan sehingga sampah yang seharusnya non infeksius menjadi infeksius.				
Tindakan yang dilakukan	1. Memberikan materi diklat kolaborasi dengan pokja akrditasi tentang pemilahan sampah. 2. Menganjurkan menyiapkan kresek hitam dan kresek kuning pada saat akan melakukan tindakan yang sekiranya akan menghasilkan banyak sampah non infeksius dan infeksius atau 2 bengkok. 3. Memberikan proses pembelajaran langsung petugas unit dan Karu/PJ saat itu yang salah melakukan pembuangan sampah dan segera menganjurkan untuk membenarkan bila memungkinkan dan memberitahukan pemilahan sampah yang benar. 4. Melakukan monitoring pemilahan sampah saat melakukan tindakan. 5. Melakukan supervisi pada tempat sampah yang ada di unit-unit. 6. Menjelaskan terkait proses pembayaran saat membuang sampah infeksius pada pihak ke-3 tergantung dari berat timbangan sampah, untuk menyadarkan bahwa kesalahan pembuangan sampahnya dapat merugikan rumah sakit				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

Meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah unit.	Meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah unit.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Peletakkan tempat sampah baik infeksius dan non infeksius harus ditata dengan benar. 2. Lakukan edukasi ulang pada staf tentang pemilahan sampah. 3. Berikan proses pembelajaran pada petugas unit saat itu yang salah melakukan pembuangan sampah dan segera menganjurkan untuk membenarkan bila memungkinkan. 4. Sampaikan kesalahan pembuangan unit pada kepala unit dan IPCLN unit dalam forum rapat PPI maupun grup WA (untuk menciptakan efek jera).	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan
---	---	----------------------------------	--	----------------------------------	------------

3.6.1.1.10 Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam

3.6.1.1.10.1

Grafik Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam Bekas Pasien (Pajanan)



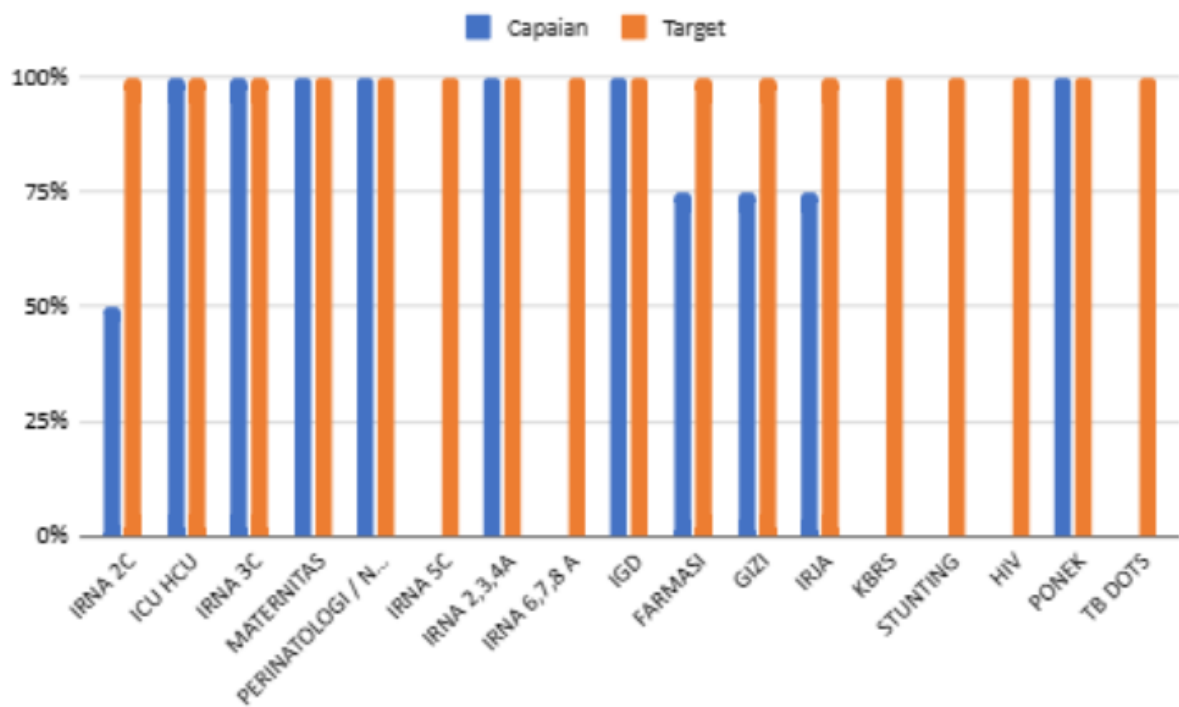
Pertahankan proses pemilahan sampah yang benar dan pengelolaan benda tajam yang baik.	Menurunkan kejadian pajanan sesuai dengan standar 0 kejadian.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Monitoring proses pemilahan sampah khususnya benda tajam saat melakukan tindakan. 2. Monitoring penggunaan safety box pada troli tindakan. 3. Biasakan petugas untuk membersihkan peralatan yang digunakan langsung tanpa mengoperkan pada shift berikutnya. 4. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan untuk mencegah paparan. 5. Monitoring teknik recapping tutup jarum.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan
---	---	----------------------------------	--	----------------------------------	------------

3.6.3 Tim PKRS

3.6.3.1 Edukasi Kelompok Unit

Unit	Target	Juli	Agt	September	%	MANDOK	Keterangan
IRNA 2C	4x/Bulan	75%	50%	50%	Tercapai	Lampiran B	IRNA 2C belum mencapai target
ICU\HCU	4x/Bulan	0%	100%	100%	Tidak Tercapai	Lampiran B	ICU/HCU mencapai target
IRNA 3C	4x/Bulan	0%	0%	100%	Tidak Tercapai	Lampiran B	IRNA 3C mengalami peningkatan dari Bulan Agustus dan mencapai Target
MATERNITAS	4x/Bulan	75%	100%	75%	Tercapai	Lampiran B	MATERNITAS mengalami Penurunan
PERINATOLOGI	4x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Lampiran B	PERINATOLOGI mencapai target
IRNA 5C	4x/Bulan	100%	50%	100%	Tidak Tercapai	Lampiran B	IRNA 5C mengalami peningkatan dari Bulan Agustus dan mencapai target
IRNA 2A,3A,4A	4x/Bulan	100%	50%	0%	Meningkat	Lampiran B	IRNA 2A,3A,4A mengalami Penurunan
IRNA 6A,7A,8A	4x/Bulan	0%	100%	100%	Meningkat	Lampiran B	IRNA 6A,7A,8A Sesuai Target
IGD	4x/Bulan	0%	0%	100%	Tidak Tercapai	Lampiran B	IGD mengalami peningkatan dari Bulan Agustus dan mencapai Target
FARMASI	4x/Bulan	50%	50%	75%	Meningkat	Lampiran B	FARMASI perlu ditingkatkan kembali
GIZI	4x/Bulan	100%	100%	75%	Menurun	Lampiran B	Gizi Mengalami penurunan
IRJA	4x/Bulan	100%	100%	75%	Menurun	Lampiran B	IRJA Mengalami penurunan

Grafik Edukasi Kelompok Unit



ANALISIS : Berdasarkan data edukasi kelompok unit pada bulan September Petugas PKRS tiap unit belum terlaksana dengan maksimal, dari data tersebut Unit IRNA 2C, 5C, IRNA 6,7,8A, FARMASI dan TIM PROGNAS KBRS, HIV, STUNTING, TB belum melaksanakan Edukasi Kelompok dengan maksima.

RTL : Menyampaikan kepada KARU unit yang belum tercapai kinerjanya untuk mengejar ketertinggalan edukasi, edukasi dilakukan di bulan April.

3.6.3.1 Pembinaan Komunitas Berbasis RS Prima Husada

UNIT	TARGET	KEGIATAN	JULI	AGT	SEPTEMBER	%	MANDOK	KET
Komunitas Geriatri	2X/Bulan	Senam	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Hypnoterapi						
		KIE						
Komunitas Ibu Hamil	2X/Bulan	Senam	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Hypnoterapi						
		KIE						
Komunitas Shirothul Jannah Perempuan	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Karya wisata						
Komunitas Shirothul Jannah Laki Laki	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
Bimbingan Doa	8X/Bulan	Mendoakan Pasien	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
General Meeting Karyawan	1x/2Bulan		0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	
Pembinaan Fatayat	1X/Tahun							

3.6.3.2 KIE Upaya Preventif Promotif PROGNAS

UNIT	TARGET	JULI	AGT	SEPTEMBER	%	BUKTI DI FORM EDUKASI TERINTEGRASI ATAU KOLABORASI	KET
PONEK	4X/Bulan	75%	25%	100%	Tidak Tercapai	√	terlaksana
HIV	4X/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	Belum terlaksana
STUNTING dan WASTING	4X/Bulan	0%	25%	0%	Tidak Tercapai	-	Belum terlaksana
KELURAGA BERENCANA RUMAH SAKIT (KABERUSA)	4X/Bulan	50%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	Belum terlaksana
TB DOTS	4X/Bulan	0%	25%	0%	Tidak Tercapai	-	Belum terlaksana

ANALISIS : Bulan September PROGNAS belum tercapai.
RTL : Koordinasi dengan Kepala Bidang Umum dan Pelayanan untuk dapat Meningkatkan produktivitas Tim Prognas.

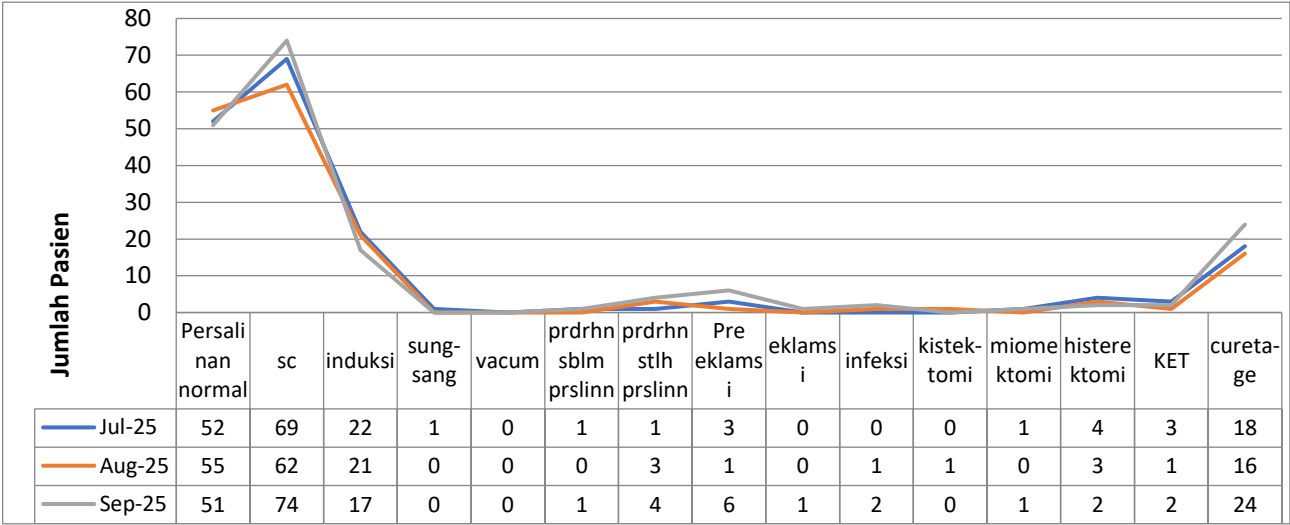
3.6.4 Tim Prognas

3.6.4.1 PONEK

3.6.4.1.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Ponek September 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JULI 2025	BULAN AGUSTUS 2025	BULAN SEPTEMBER 2025
1	Persalinan			
	a. Persalinan Normal	52	55	51
	b. <i>SectioCaesaria</i>	69	62	74
2				
	a. Induksi / Drip	22	21	17
	b. Sungsang	1	0	0
	c. Vacum	0	0	0
3				
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	1	0	1
	b. Perdarahan setelah Persalinan	1	3	4
	c. Pre Eklamsi	3	1	6
	d. Eklamsi	0	0	1
	e. Infeksi	0	1	2
4				
	a. Curretage	18	16	24
	b. Kistektomi	0	1	0
	c. Miomektomi	1	0	1
	d. Histerectomy	4	3	2
	e. KET	3	1	2

3.6.4.1.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Bulan September 2025



- Analisis :**
1. Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada bulan September 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 74 pasien. Dan untuk persalinan normal pada bulan September 2025 sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 51 persalinan. Untuk persalinan normal, jika memang tidak ada penyulit maka persalinan bisa ditolong bidan terlebih dahulu. Jumlah persalinan secara SC dan Persalinan normal pada bulan September sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan jumlah pasien di maternitas juga meningkat pada bulan September 2025.
 2. Kebanyakan pasien yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas sc, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya, atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal distress. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi sc cito.
 3. Tidak ada persalinan sungsang pada bulan September 2025, sedangkan pada bulan Juli 2025 ada 1 persalinan sungsang. Dan tidak ada persalinan dengan vacuum pada bulan September 2025 dan 2 bulan sebelumnya.
 4. Induksi Persalinan pada bulan September mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 17 pasien
 5. Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan September 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 6 pasien. Dan ada 1 kejadian eklamsi pada bulan September 2025.
 6. Jenis pelayanan curetase di bulan September 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 24 pasien. Curetase dilakukan untuk Indikasi abortus, mola, blighted ovum, sisa plasenta dan pada kasus-kasus gynecology biasanya dengan indikasi menometroragi, hiperplasia endometrium, dan lainnya.

- Rencana dan Tindak Lanjut :**
1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.
 2. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makanan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
 3. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.

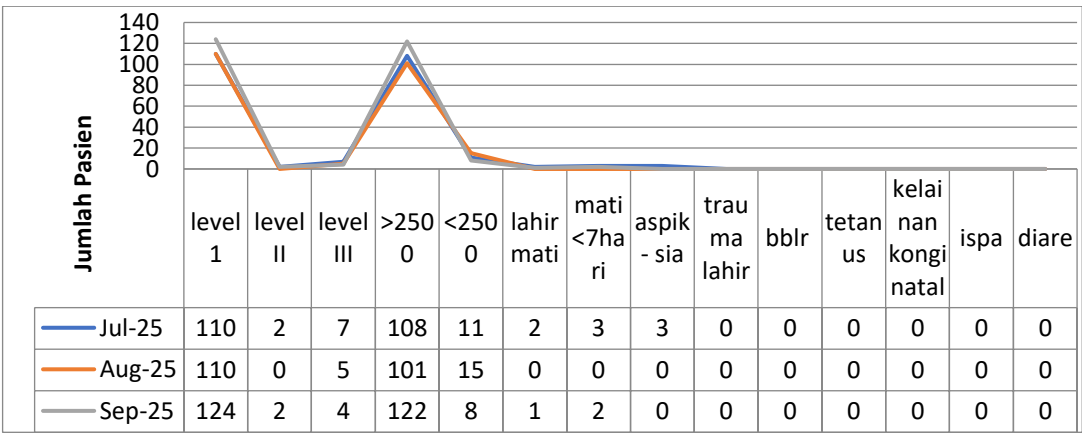
- Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.

3.6.4.1.3 Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

3.6.4.1.3.1 Tabel Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Ponек September 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JULI 2025	BULAN AGUSTUS 2025	BULAN SEPTEMBER 2025
1				
	a. Level 1	110	110	124
	b. Level II	2	0	2
	c. Level III	7	5	4
2				
	a. ≥ 2500 gram	108	101	122
	b. ≤ 2500 gram	11	15	8
3				
	a. Kelahiran Mati	2	0	1
	b. Mati Neonatal < 7 Hari	3	0	1
4				
	a. Asphyxia	3	0	0
	b. Trauma Kelahiran	0	0	0
	c. BBLR	11	15	8
	d. Tetanus Neonatorum	0	0	0
	e. Kelainan Congenital	0	0	0
	f. ISPA	0	0	0
	g. DIARE	0	0	0
5	Lain-lain	0	0	0

3.6.4.1.3.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Di RS Prima Husada September 2025



Analisis :

- Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1 di bulan September 2025 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 124 bayi. Dan untuk pelayanan level 2 pada bulan September sebanyak 2 bayi, sedangkan pada level 3 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 4 bayi. Jumlah bayi bulan September 2025 meningkat seiring dengan jumlah persalinan pada bulan September 2025
- Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah >2500 gram di bulan September 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 122 bayi.
- Dan jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan September 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 8 bayi. Masih

adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.

4. Kasus BBLR pada bulan September 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 8 bayi.
5. Ada 1 kasus kelahiran mati pada bulan September 2025, sedangkan pada bulan Agustus tidak ada kasus, dan Juli sebanyak 2 kasus.
6. Ada 2 kasus kematian neonatus <7 hari pada bulan September, sedangkan pada bulan Agustus tidak ada kasus, dan Juli sebanyak 3 kasus.

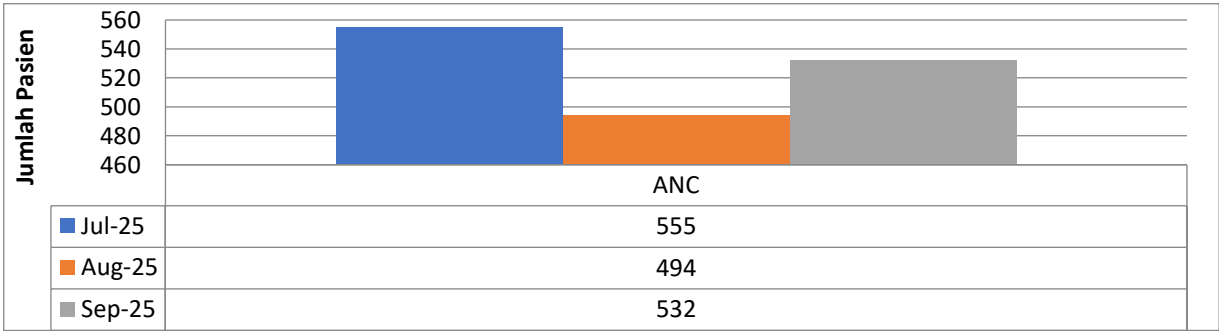
Rencana dan Tindak Lanjut

1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.
3. Melakukan edukasi pada ibu hamil agar melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau kehamilan

3.7.53 Pelayanan Ante Natal Care (ANC)
Tabel Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Ponpek September 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
1	ANC	555	494	532

Grafik Jumlah Pelayanan Ante Natal Care Di RS Prima Husada September 2025



Analisis :

Pelayanan ANC pada bulan September 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 532 kunjungan.

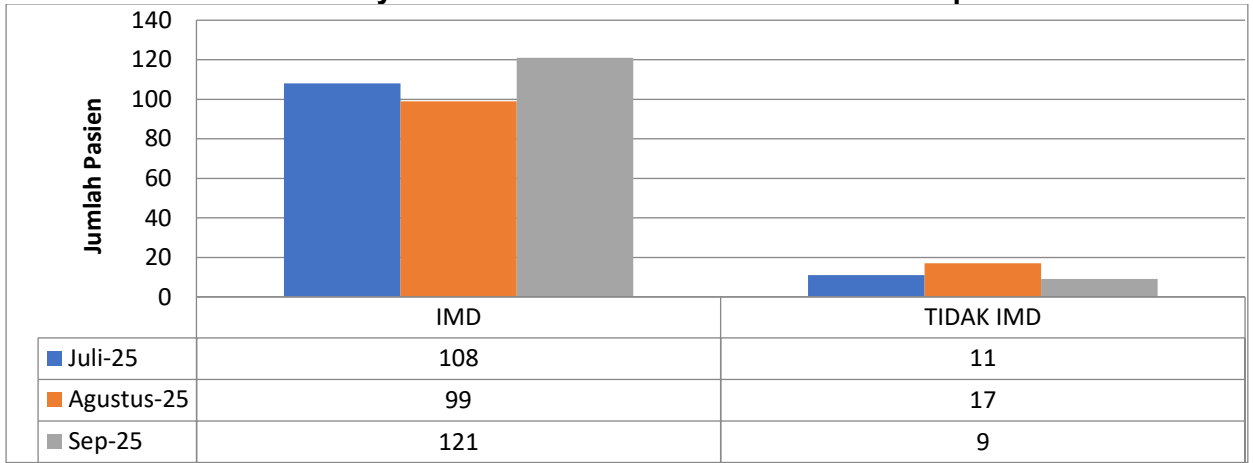
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pemeriksaan ANC seperti USG 4 dimensi serta kegiatan senam hamil yang diharapkan menarik minat para ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di RS.

3.7.54 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Tabel Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) September 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
1	IMD	108	99	121
2	Tidak IMD	11	17	9

Grafik Jumlah Pelayanan IMD di RS Prima Husada Bulan September 2025



Analisis :

1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan September 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 122 bayi. Dan tidak semua bayi baru lahir dilakukan IMD, dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD.
2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan September menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 9 bayi, Sedangkan pada bulan Agustus sebanyak 17 bayi, dan Juli sebanyak 11 bayi.
3. Berikut ini bayi yang tidak dilakukan IMD pada bulan September 2025

NO	NAMA BAYI	DIAGNOSA	PERAWATAN BBL
1	By Ny Anggun Ratna Sari	Imatur + BBLSR + RDS	Inkubator + CPEP
2	By Ny Dewita Oktari	NCB, BBLR	Cuvis
3	By Ny Lia Rosalina	NP-Spt+ BBLASR+ obs.dyspneu ok neonatal pneumonia dd HMD + asfiksia	Inkubator + CPEP
4	By Ny Meila kartika	NCB, BBLR, HIPOGLIKEMI REFRAKTER	Cuvis
5	By Ny Milyuni	NKB, BBLR	Cuvis
6	By Ny Mugiasih	NKB, BBLR	Cuvis
7	By Ny Putri wulandari	RDS OK HMD, Neonatal Pneumonia	Inkubator + CPEP
8	By Ny Reza Vanny	RDS +BBLR, Prematur	Inkubator + CPEP
9	By Ny Ria Stifani	RDS OK HMD, Neonatal Pneumonia	Inkubator + CPEP

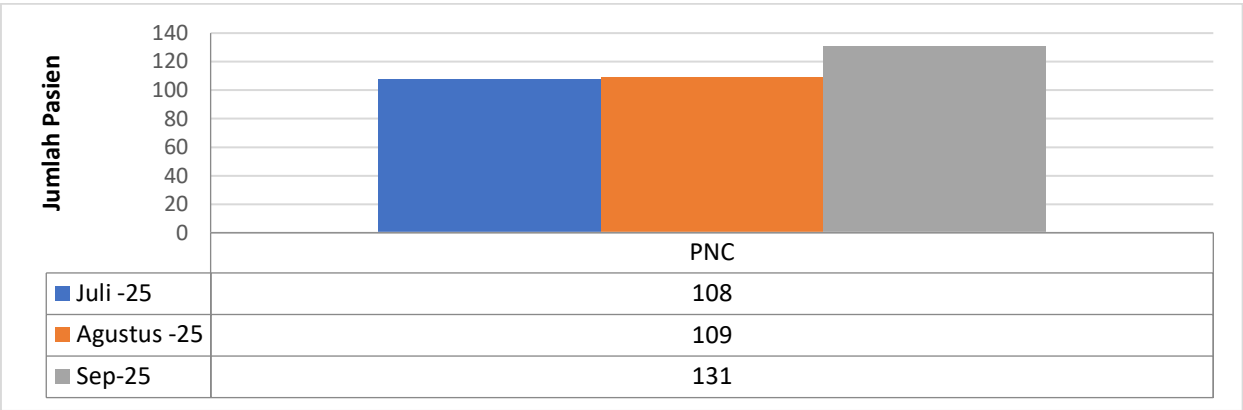
Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat ataukah tidak.

3.7.55 Pelayanan Post Natal Care (PNC)
Tabel Pelayanan Post Natal (PNC) Ponek September 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
1	PNC	108	109	131

Grafik Jumlah Pelayanan Post Natal Care di RS Prima Husada Bulan September 2025



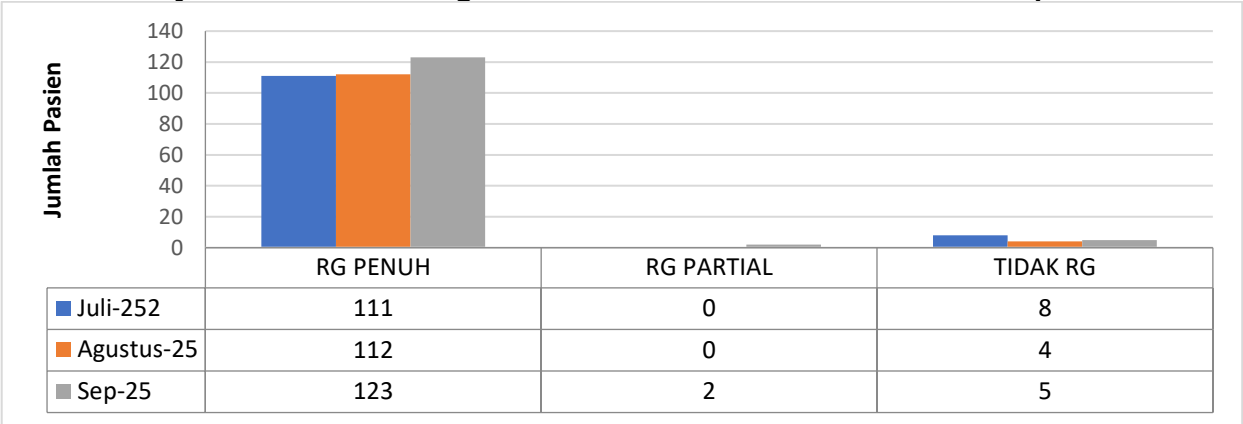
Analisis :
Pelayanan PNC pada bulan September 2025 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 131 kunjungan..

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan Edukasi ke pasien pasca bersalin untuk melakukan pemeriksaan PNC di RS Prima Husada

3.1.2.2.1.5 Pelayanan Rawat Gabung
Tabel Pelayanan Rawat Gabung Ponek September 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JULI 2025	BULAN AGUSTUS 2025	BULAN SEPTEMBER 2025
1	Rawat gabung penuh	111	112	123
2	Rawat gabung partial	0	0	2
3	Tidak Rawat gabung	8	4	5

Grafik Pelayanan Rawat Gabung Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan September 2025



Analisis :

- 1. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan September 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 123 bayi. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat
- 2. Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan September 2025 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 5 bayi.
- 3. Berikut bayi yang tidak dilakukan rawat gabung

NO	NAMA	DIAGNOSA	PERAWATAN BBL
1	By Ny Anggun Ratna Sari	Imatur + BBLSR + RDS	Inkubator + CPEP
2	By Ny Lia Rosalina	NP-Spt+BBLASR+ obs.dyspneu ok neonatal pneumonia dd HMD + asfiksia	Inkubator + CPEP
3	By Ny Reza Vanny	RDS +BBLR, Prematur	Inkubator + CPEP
4	By Ny Putri wulandari	RDS OK HMD, Neonatal Pneumonia	Inkubator + CPEP
5	By Ny Ria Stifani	RDS OK HMD, Neonatal Pneumonia	Inkubator + CPEP

Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di cuvis atau incubator karena berat bayi < 2500 gram atau masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan alat bantu pernafasan dan observasi.

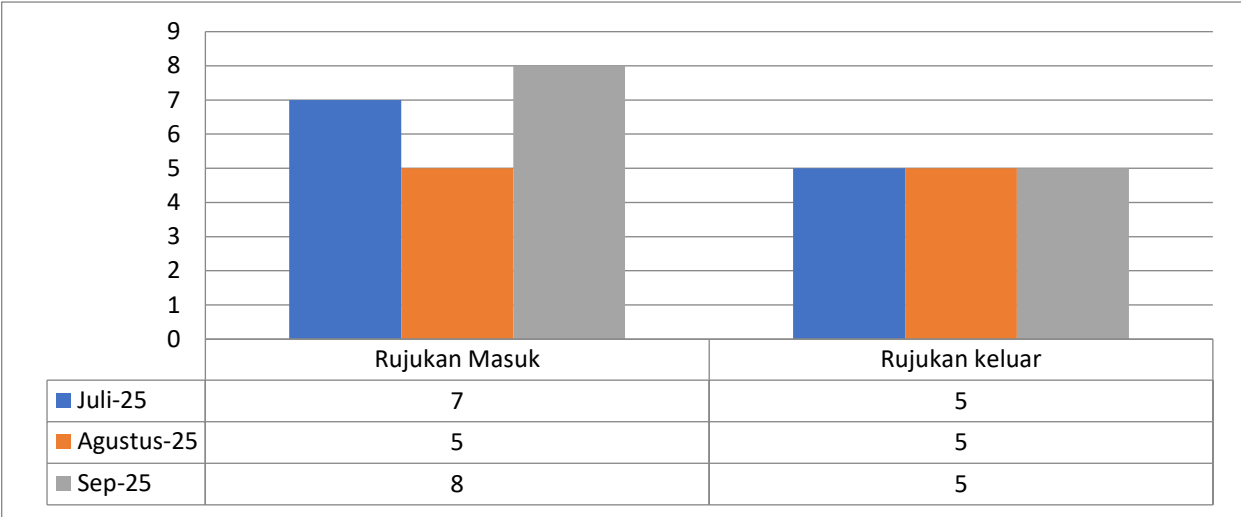
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan skrining awal untuk pasien yang layak dilakukan rawat gabung ibu dan bayi.

3.1.2.2.1.6 Pelayanan Jejaring Rujukan
Tabel Pelayanan Jejaring Rujukan Ponек September 2025

NO	RUJUKAN	BULAN JULI 2025	BULAN AGUSTUS 2025	BULAN SEPTEMBER 2025
1	Rujukan Masuk	7	5	8
2	Rujukan keluar	5	5	5

Grafik Pelayanan Rujukan RS Prima Husada Bulan September 2025

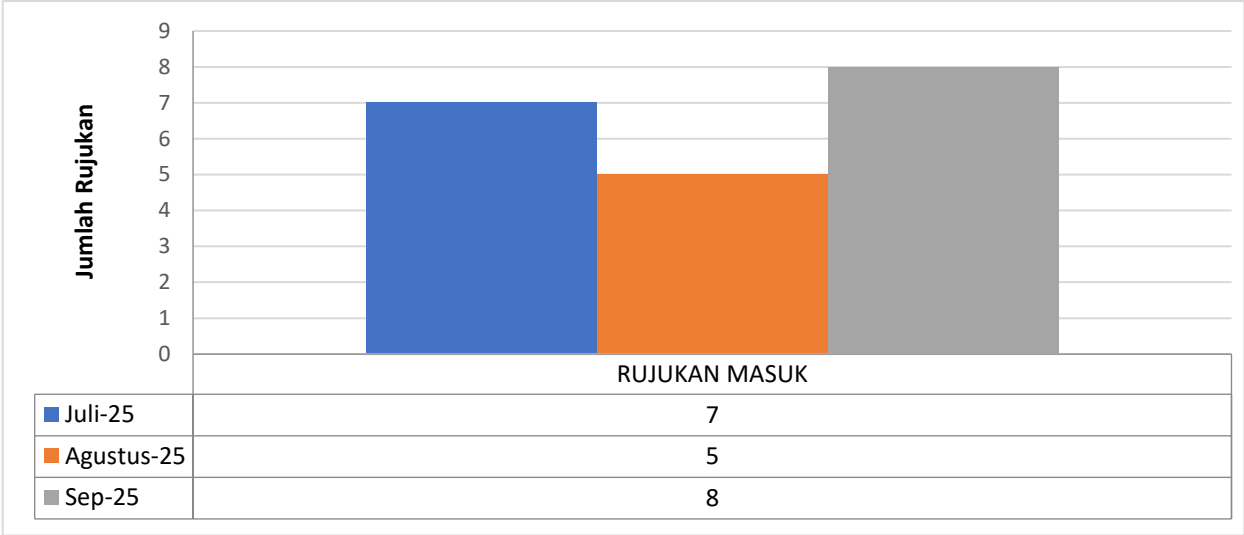


3.1.2.2.1.6.1 Rujukan Masuk
Tabel Rujukan Masuk Ponsek September 2025

Bulan Juli 2025			
1	By Ny Marita	Asfiksia	PMB Tri
2	Ny Anis Puspita Sari	G1 P0000 Ab000 UK 37-38 mgg dg PEB	PKM Singosari
3	Ny Evi Yuniarti	G3 P2002 Ab000 UK 40-41 mgg dg KPD + KIFL	PKM Ardimulyo
4	Ny Nurul Sa'adah	G2 P1001 Ab000 Uk 8-10 mgg dg Abotus Inkomplit	PMB Tri W
5	Ny Dita Puri A	G1 P0000 Ab000 Uk 38-39 mgg dg KIFA	Klinik Mutiara Sehat
6	Ny Shifatul Husni	G1 P0000 Ab000 Uk 41-42 mgg dg KIFL	PMB Titik Sunaryati
7	Ny Vira	G1 P0000 Ab000 Uk 34-36 mgg dg PEB	Klinik Muslimat
Bulan Agustus 2025			
1	By Ny Nur Fitri	RDS	PMB Tri W
2	Ny. Illa Rodhiyah	G4 P1103 AB100 UK 10-12 Mgg dg Abortus Inkomplit	Klinik Mutiara Sehat
3	Ny Siska A	G1 P0000 AB 0 UK 32-34 MGG dg kala 2	PKM Singosari
4	Ny Siti Nur H	G1P000 AB00 UK 39-40 Mgg dg kala 2	PKM Lawang
5	Ny Widya A	G1 P0000 AB000 UK 32-34 Mgg dg PPR0M	Klinik Mutiara Sehat
Bulan September 2025			
1	By Ny Sri bawon 1	RDS ok HMD, Neonatal pneumonia	RS Sumber Santosa
2	By Ny Sri bawon 2	RDS ok HMD, Neonatal pneumonia	RS Sumber Santosa
3	By By Erwin	RDS ok HMD, Neonatal pneumonia	PKM Singosari
4	By Rayyan Maulana	PNEUMONIA, NEC, BBLSR	RS Sahabat
5	Ny Erwin	P2103 Ab000 dengan post partum + HPP ec sisa plasenta	PKM Singosari
6	Ny Meila	G3 P0010 Ab100 UK 36-37 mgg dg HT+ DM+BOH	PMB Titik Sunaryati
7	Ny Nur	G1 P0000 Ab000 UK 39-40 mgg dg KPD	PMB Titik

	Halimatus		Sunaryati
8	Ny Cholis Ambiyah	G2 P1001 Ab000 UK 40-41 mgg dengan PEB +KPD	PKM Singosari

Grafik Pelayanan Rujukan Masuk RS Prima Husada Bulan September 2025



Analisis :
 Jumlah rujukan masuk pada bulan September meningkat yaitu 8 rujukan, sedangkan pada bulan Agustus sebanyak 5, dan Juli 2025 7 rujukan.

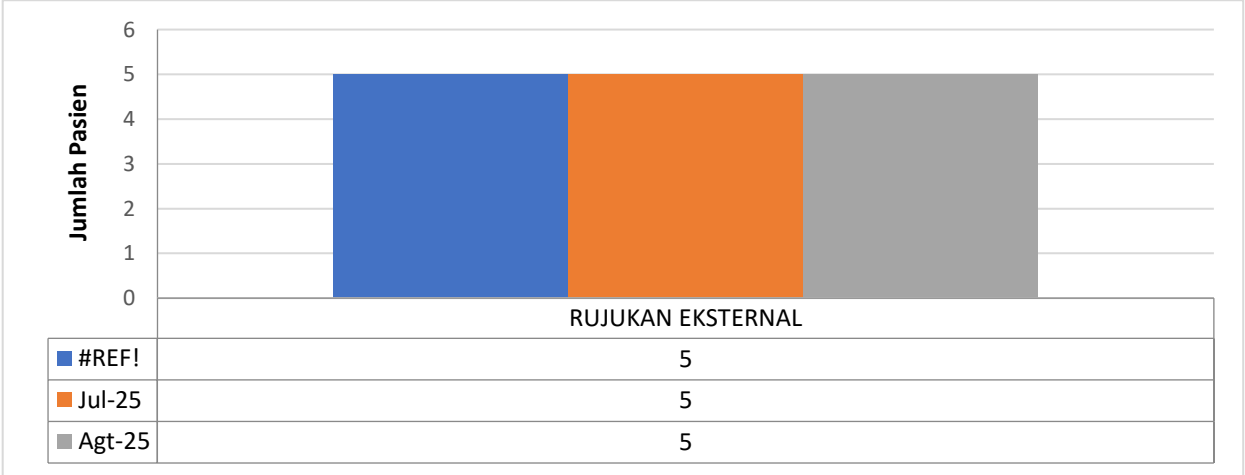
Rencana dan Tindak Lanjut
 Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM atau RS setempat untuk bekerja sama.

3.1.2.2.7.2 Rujukan Keluar
 Tabel Rujukan Keluar Ponек September 2025

Bulan Juli 2025						
1	Stefia Shallom	16 th	IGD	Abdominal pain susp Neoplasma Ovarial	Pro laparatomi back up bedah digestive	RS Saiful Anwar
2	By Ny Manda Kumalasari	3 hari	NICU	RDS + BBLR	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Saiful Anwar
3	By Ny Nadia	4 hari	NICU	RDS + BBLSR + NKB	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
4	By Ny Marita	1 hari	NICU	RDS + Susp DS	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
5	By Ny Retnosari	1 hari	NICU	RDS + Bronchopneumonia + NEC	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
Bulan Agustus 2025						
1	Riyanti	41 Th	Maternitas	P2103 Ab000 dg Post SC+MOW hari ke 2 a/l Inpending eklamsi + anuria	Pro Hemodialisa	RS Saiful Anwar
2	Nn Nafisa	17 Th	Irna 5C	Susp Internal bleeding ec KET + trombositopenia + anemia	Pro Laparatomy cito dg backup transfusi TC	RS Saiful Anwar
3	By Ny	1 hr	NICU	NKB + BBLR	Pro Sub	RS

	Wikke				Spesialis Neonatologi	Lavalette
4	By Ny Nur Aini	2 hr	NICU	NCB + Pneumonia	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
5	By Ny Nur Fitri	3 hr	NICU	RDS	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Saiful Anwar
Bulan September 2025						
1	By Ny Apsah	3 hr	NICU	Bronchopneumonia + Hipoglikemia refrakter	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
2	By Ny Lia	3 hari	NICU	NP-Spt + BBLASR + obs. dyspneu ok neonatal pneumonia dd HMD + asfiksia	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
3	By Ny Erwin	1 hari	NICU	RDS ok HMD, Neonatal pneumonia	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Soepraoen
4	By Ny Sri bawon 2	1 hari	NICU	RDS ok HMD, Neonatal pneumonia	Pro Sub Spesialis Neonatologi	RS Lavalette
5	Ny Lilis	38 th	PONEK	G2 P0000 AB100 UK 30-32 mgg dengan Eklamsi + HT emergency + nprimi tua sprimer + riwayat infertile +HSVB	Penanganan lebih lanjut	RS Saiful Anwar

Grafik Pelayanan Rujukan Eksternal di RS Prima Husada Bulan September 2025



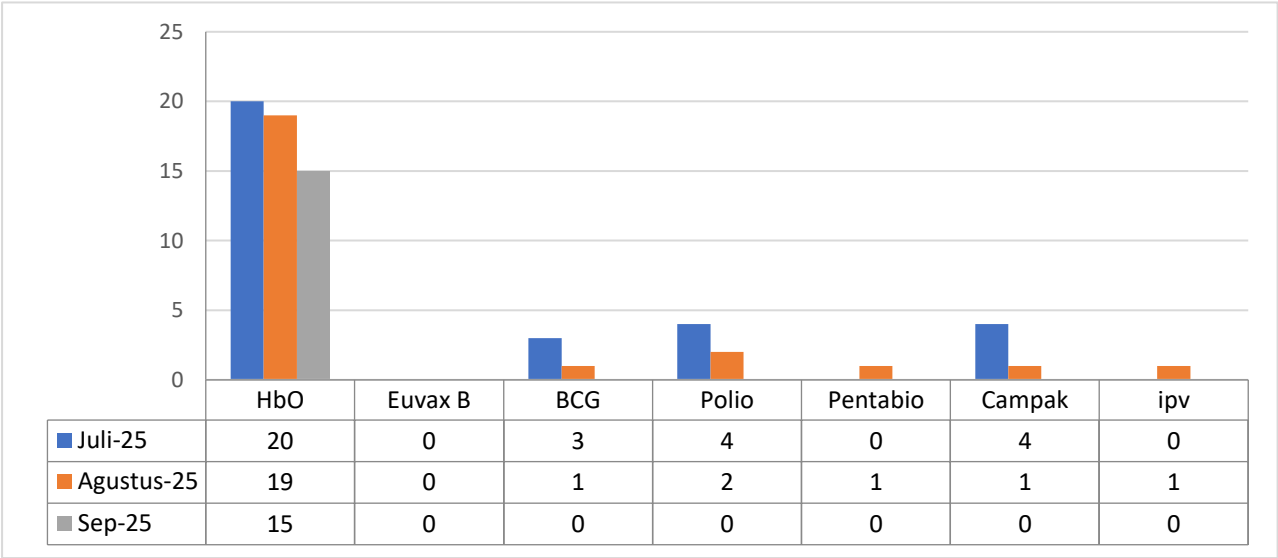
Analisis :
 Pada bulan September dan 2 bulan sebelumnya jumlah rujukan eksternal sama yaitu 5 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :
 Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

3.1.2.2.12.8 Pelayanan Imunisasi
Tabel Pelayanan Imunisasi Ponak September 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN JULI 2025	BULAN AGUSTUS 2025	BULAN SEPTEMBER 2025
1	HbO	20	19	15
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	3	1	0
3	Polio	4	2	0
4	Pentabio	0	1	0
5	Campak	4	1	0
6	IPV	0	1	0

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan September 2025



Analisis :

1. Tidak ada penggunaan vaksin euvax B pada periode September 2025 maupun 2 bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyak nya pasien bayi baru lahir dengan status BPJS, sehingga tidak menggunakan vaksin euvax B
2. Bayi yang melakukan Imunisasi Hbo pada bulan September sebanyak 15 bayi, sedangkan pada bulan Agustus sebanyak 19 bayi, dan bulan Juli sebanyak 20 bayi. Hal ini dikarenakan minimnya ketidakterseidanya vaksin HB0 di RS prima Husada malang, dikarenakan stok vaksin dari dinas Kesehatan kabupaten malang terbatas sehingga Puskesmas hanya bisa memberikan sedikit ke RS swasta, sehingga bayi yang baru lahir yang belum mendapat imunisasi HB0 diarahkan untuk imunisasi Hbo di Puskesmas wilayah masing-masing sebelum usia 7 hari
3. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan September dan Juli, sedangkan bulan Agustus sebanyak 1 bayi.
4. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan September, sedangkan pada bulan Agustus sebanyak 1 bayi, dan Juli sebanyak 3 bayi.
5. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi Campak pda bulan September, sedangkan bulan Agustus sebanyak 1 bayi, dan pada bulan Juli sebanyak 4 bayi,
6. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan September, sedangkan bulan Juli sebanyak 4 bayi.
7. Tidak ada bayi yang melakukan imunisasi Pentabio pada bulan September dan Juli, sedangkan pada bulan Agustus sebanyak 1 bayi. Imunisasi pentabio diberikan bersamaan dg rota dan PCV, sedangkan vaksin tersebut ada pembatasan dari puskesmas.

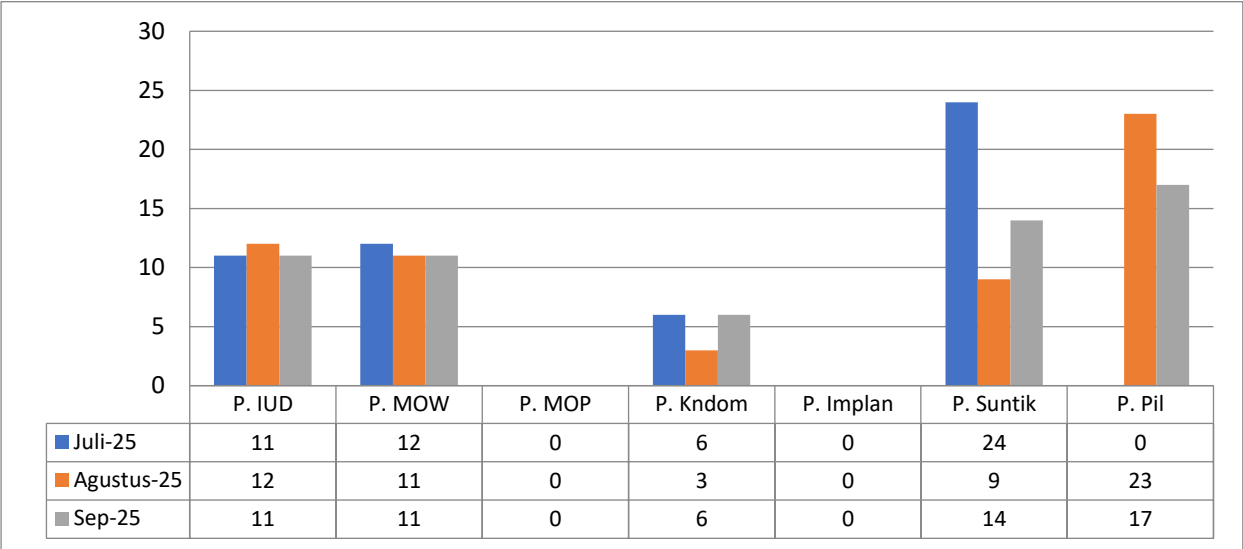
Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
- 2. Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.2.2.1.2.9 Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
Tabel Pelayan Keluarga berencana (KB) Ponek Agustus 2025

NO	JENIS	JUMLAH PASANG		
		BULAN JULI 2025	BULAN AGUSTUS 2025	BULAN SEPTEMBER 2025
1	IUD	11	12	11
2	MOW	12	11	11
3	MOP	0	0	0
4	Kondom	6	3	6
5	Implant	0	0	0
6	Suntikan	24	9	14
7	Pil	0	23	17

Grafik Pelayanan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan September 2025



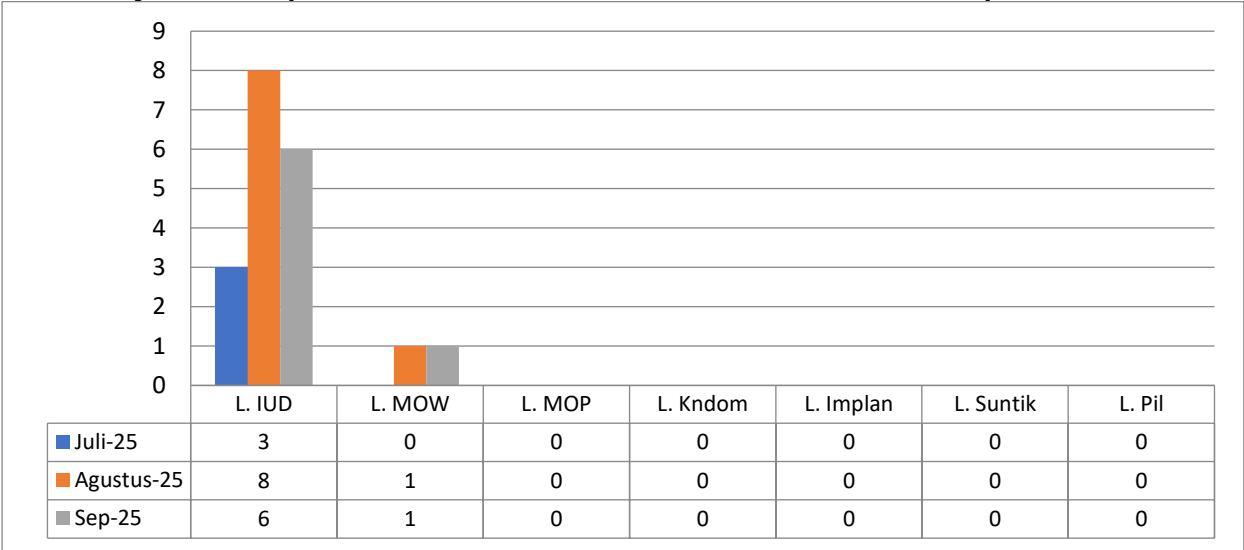
Aanalisis :

- 1. Pemasangan KB IUD pada bulan bulan September 2025 sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 11 akseptor yang terdiri dari 6 akseptor IUD Nova T dan 5 akseptor IUD copper T, pemakaian KB belum maksimal dikarenakan KB IUD coper T pasca salin ada biaya jasa dokter Rp. 400.000, biaya gratis jika dipasang oleh bidan tetapi pasien tidak berkenan, memilih KB di faskes tingkat 1
- 2. Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan September 2025sama dengan bulan sebelumnya, yaitu 11 pasien, sedangkan pada bulan Juli sebanyak 12 pasien. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder. Tindakan MOW dilakukan jika ada indikasi dari DPJP.
- 3. Pasien yang menggunakan metode kondom pada bulan September sama dengan bulan Juli yaitu 6 pengguna, sedangkan pada bulan Juli sebanyak 6 pengguna
- 4. Pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan September sebanyak 17 pengguna, sedangkan pada bulan Agustus sebanyak 23 pengguna, dan Juli tidak ada.
- 5. Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan September meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 14 pengguna, sedangkan bulan Agustus sebanyak 9 pengguna dan sedangkan bulan Juli sebanyak 24 pengguna

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

NO	JENIS	JUMLAH LEPAS		
		JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
1	IUD	3	8	6
2	MOW	0	1	1
3	MOP	0	0	0
4	Kondom	0	0	0
5	Implant	0	0	0
6	Suntikan	0	0	0
7	Pil	0	0	0

Pelayanan Pelepasan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan September 2025



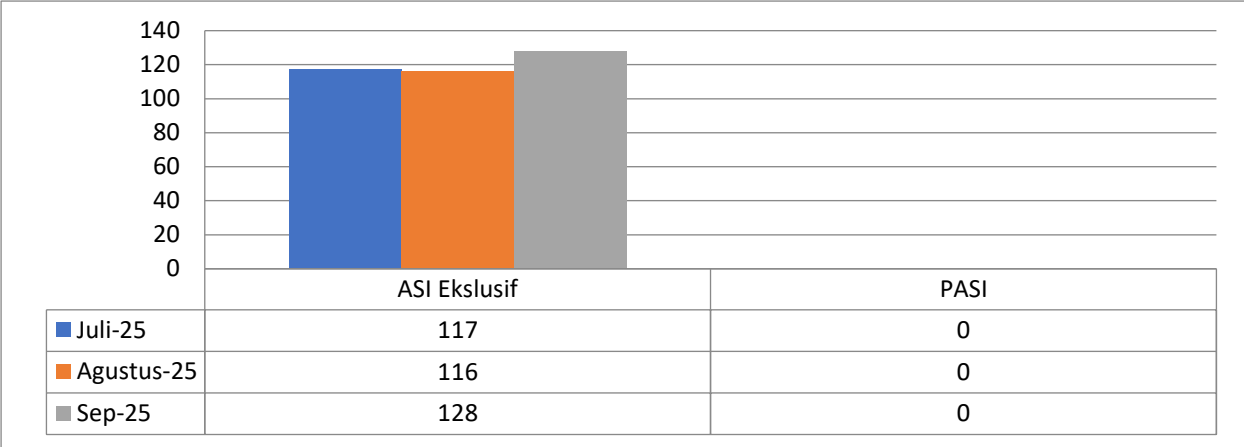
- Analisis :**
- 1. Pelepasan KB IUD pada bulan September menurun yaitu 6 Akseptor, sedangkan pada bulan Agustus sebanyak 8 akseptor, dan Juli yaitu 3 Akseptor
 - 2. Ada 1 pelepasan KB Implan pada bulan Agustus dan september, sedangkan Juli tidak ada

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

3.3 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif
Tabel 5.10 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif September 2025

NO	PEMBERIAN ASI	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JULI 2025	BULAN AGUSTUS 2025	BULAN SEPTEMBER 2025
1	Asi eksklusif	117	116	128
2	Asi /PASI	0	0	0

Grafik Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif Di RS Prima Husada Bulan September 2025



Analisis :

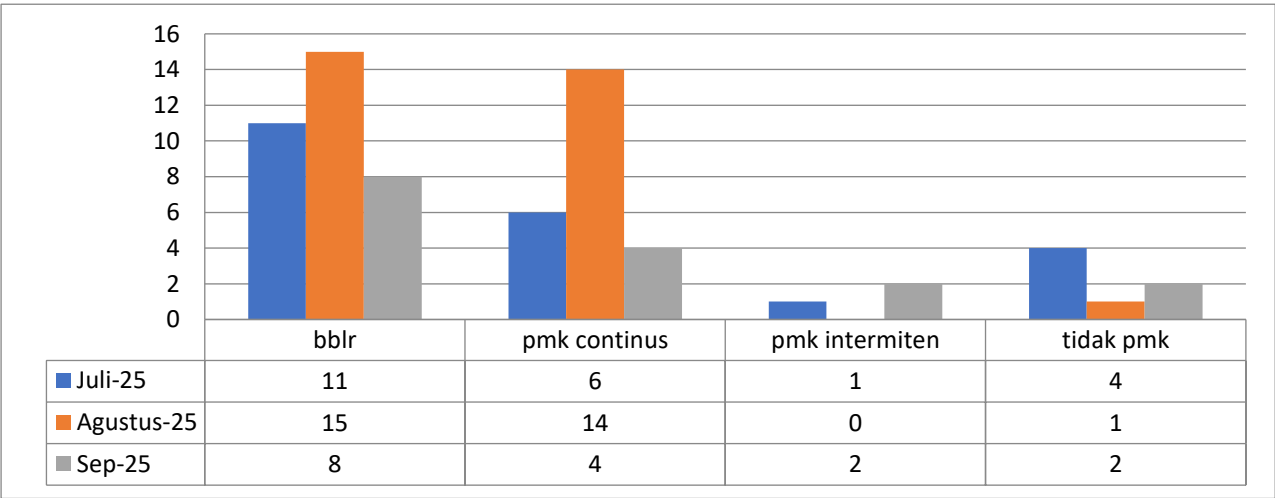
- 1. Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan September meningkat yaitu 128 bayi, sedangkan pada bulan Juli sebanyak 117 bayi, dan Juli sebanyak 117 bayi. Hal ini dikarenakan meskipun ada bayi dengan BBLR juga tetap diberikan ASI eksklusif
- 2. Tidak ada bayi yang mendapat PASI pada bulan September dan 2 bulan sebelumnya. Diperbolehkan menggunakan sufor pada bayi dengan kondisi tertentu, dan pastinya atas rekomendasi dari dokter spesialis anak.

Rencana dan Tindak Lanjut :

Dilakukannya Edukasi dengan adanya kelas ibu menyusui saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Sehingga ada kegiatan tanya jawab, demonstrasi dan bertukar ilmu terkait pemberian ASI eksklusif

3.2.2.1.2.10 Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR
Tabel Pelayanan Perawatan metode kangguru (PMK) Pada BBLR di Ponek September 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JULI 2025	BULAN AGUSTUS 2025	BULAN SEPTEMBER 2025
1	Bayi BBLR	11	15	8
2	PMK continuos	6	14	4
3	PMK Intermiten	1	0	2
4	Tidak PMK	4	1	2



Grafik Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR di RS Prima Husada September 2025

Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan PMK continus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500gram.
- 2. Ada 2 pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan September, sedangkan pada bulan Juli sebanyak 1 bayi. Hal ini dikarenakan bayi sesak memakai c-pap dan perawatan inkubator.
- 3. Sedangkan metode PMK continus pada bulan September menurun yaitu 4 bayi dengan BBLR kondisi bayi stabil, sedangkan pada bulan Agustur 2025 sebanyak 14 bayi, dan bulan Juli 2025 sebanyak 6 bayi. hal ini seiring dg jumlah BBLR yang ada
- 4. Ada 2 bayi yang tidak dilakukan PMK pada bulan September, sedangkan pada bulan Agustus ada 1 bayi, dan Juli ada 4 bayi.

Berikut daftar bayi yang tidak dilakukan PMK

No	Nama	Diagnosa	Perawatan BBL	Alasan
1.	By Ny Anggun Ratna Sari	Imatur + BBLSR + RDS	Inkubator + CPEP	meninggal
2.	By Ny Lia Rosalina	NP-Spt+ BBLASR+ obs.dyspneu ok neonatal pneumonia dd HMD + asfiksia	Inkubator + CPEP	Rujuk

Rencana dan Tindak Lanjut

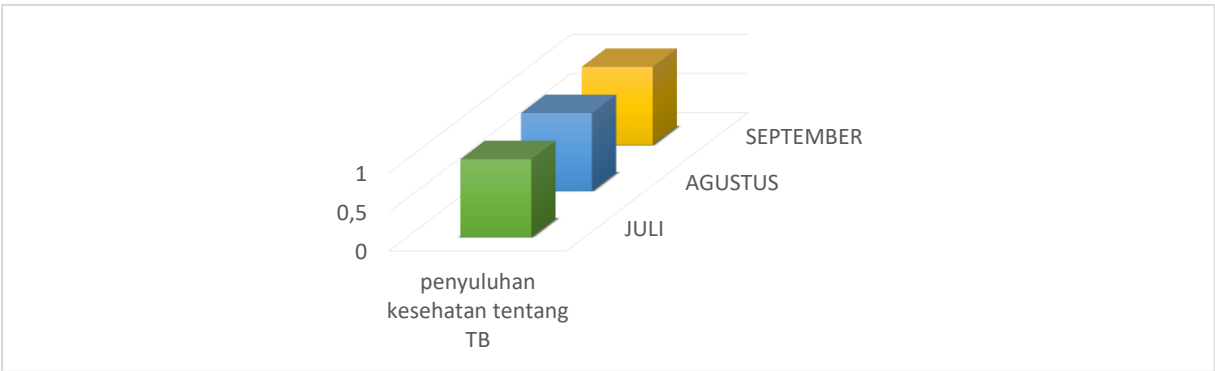
Perawatan Metode Kangguru sesuai dengan SPO yang berlaku

1.1.2.2. TB DOT’S

3.7.56 Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Tentang Tuberculosis

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH KEGIATAN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1	Penyuluhan kesehatan tentang tuberculosis	1	1	1

Grafik Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan di RS Prima Husada



Analisis:

Peserta audiens ditujukan kepada pasien dan keluarga pasien, dengan harapan peserta memahami hasil penyuluhan.

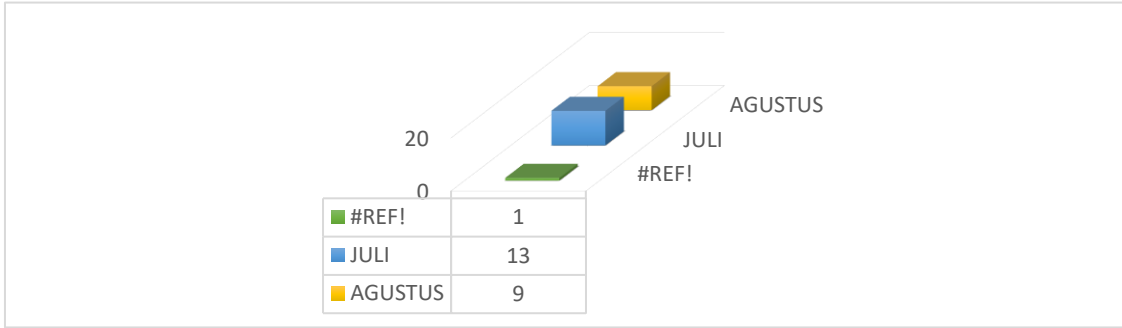
Rencana dan Tindak Lanjut:

Harus diadakan promosi kesehatan secara berkala terkait TBC seperti; pentingnya patuh dalam pengobatan TBC, kapan waktu yang tepat minum obat TBC, apa tanda gejala TBC, dll.

3.1.2.2.2 Skringing Pasien

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Pemberian Masker	13	9	6

Grafik Jumlah Pasien Dengan Skringing Awal Pemberian Masker di RS Prima Husada



Analisis :

- 1. Pada bulan September 2025 terdapat 6 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
- 2. Pada bulan Oktober 2025 terdapat 0 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart
- 3. Pada bulan November 2025 terdapat 0 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart

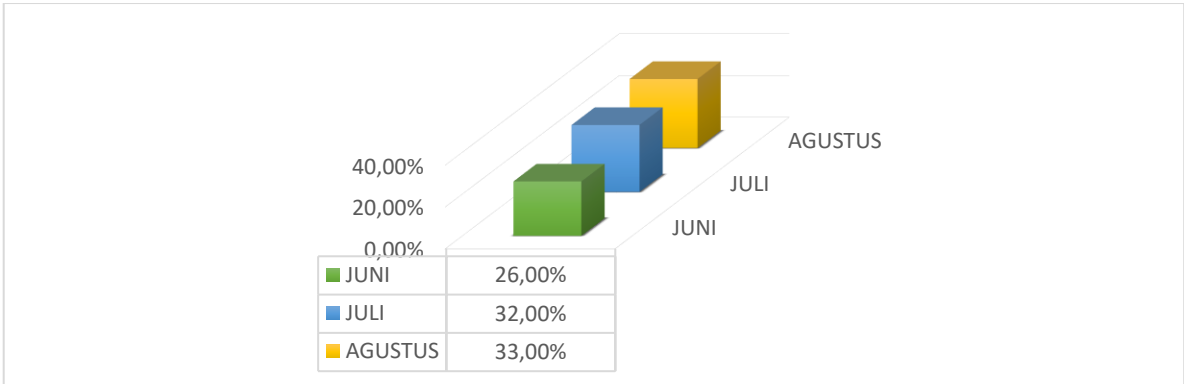
Rencana dan Tindak Lanjut:

- 1. Memfasilitasi ketersediaan masker
- 2. Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan)

3.1.2.2.3 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Proporsi pasien (terduga dan baru) tekonfirmasi bakteriologis	32	33	37

Grafik Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis di RS Prima Husada



Analisis :

- 1) Pada bulan Juli 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 32 orang
- 2) Pada bulan Agustus 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 33 orang
- 3) Pada bulan September 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 37 orang

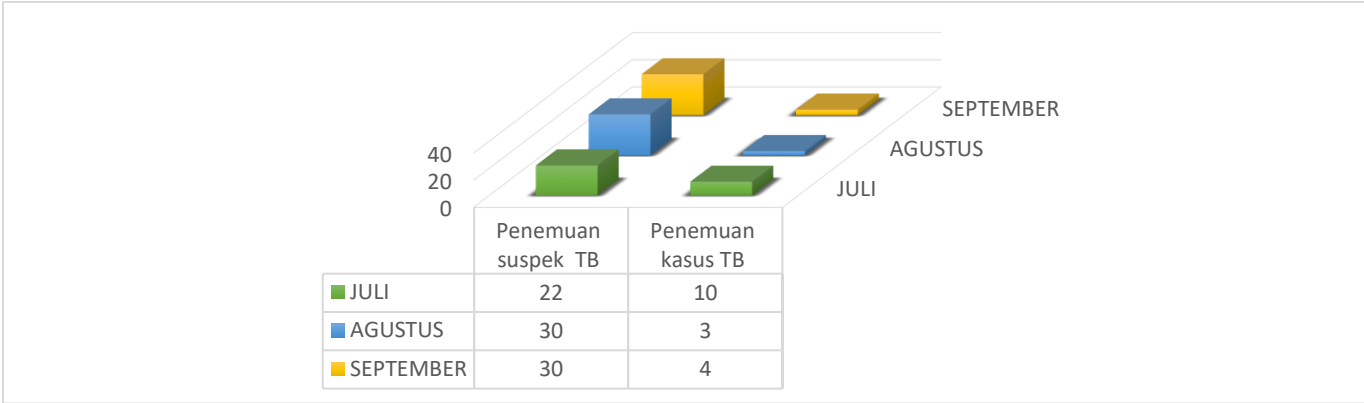
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

3.1.2.2.4 Penemuan Kasus TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Penemuan suspek TB	22	30	30
2	Penemuan kasus TB	10	3	4

Grafik Penemuan Kasus TB Baru di Rumah Sakit Prima Husada



Analisis :

- 1. Pada bulan Juli 2025 terdapat 22 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 10 pasien
- 2. Pada bulan Agustus 2025 terdapat 33 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 3 pasien
- 3. Pada bulan September 2025 terdapat 30 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 4 pasien

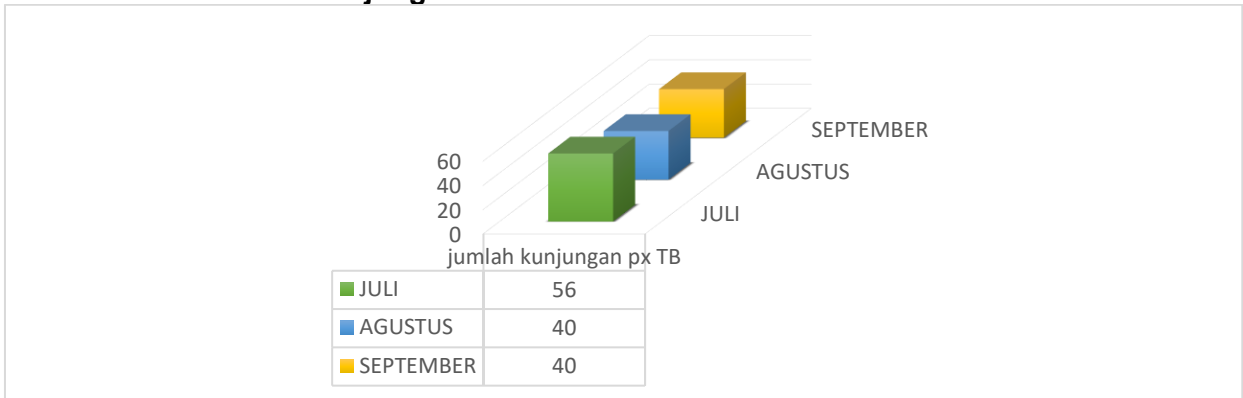
Rencana dan Tindak Lanjut:

Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasien untuk melakukan skrinning TB

3.1.2.2.5 Jumlah Kunjungan pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Pasien TB Kunjungan Keseluruhan	56	40	40

Grafik Jumlah Kunjungan Pasien TB Baru di Rumah Sakit Prima Husada



Analisis:

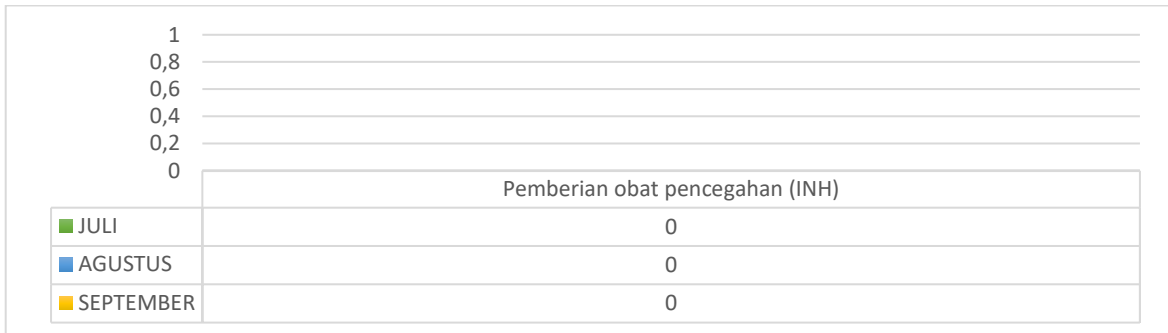
1. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan Juli 2025 di poli pasien TBC mencapai 56 pasien.
2. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan Agustus 2025 di poli pasien TBC mencapai 40 pasien
3. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan September 2025 di poli pasien TBC mencapai 40 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :
Meningkatkan kunjungan pasien

3.1.2.2.6 Pemberian Obat Pencegahan

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Pemberian obat pencegahan (INH)	0	0	0

Grafik Pemberian Obat Pencegahan di Rumah Sakit Prima



Analisis :

Tidak ada yang mendapat obat pencegahan (INH), hal ini dikarenakan kurang pengetahuannya pasien dan keluarga pasien mengenai pengobatan pencegahan (INH)

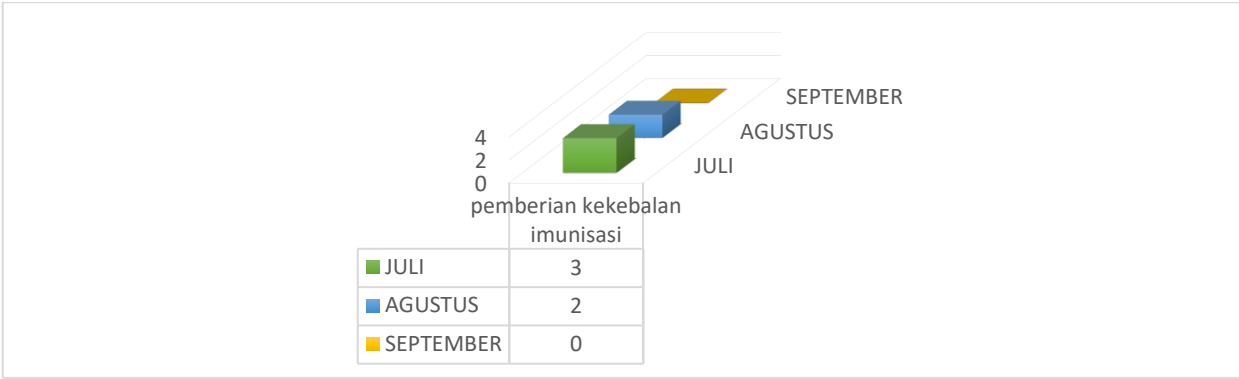
Rencana dan Tindak Lanjut

1. Memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa jika ada salah satu keluarga yang terdiagnosa TB kemudian memiliki saudara dengan usia dibawah 17 tahun, agar segera memeriksakan dan bersedia di berikan obat pencegahan (INH)
2. Pemberian obat INH ditujukan pada anak usia dibawah 5 tahun yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosa TB

3.1.2.2.7 Pemberian Imunisasi BCG

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Pemberian imunisasi BCG	3	2	0

Grafik Pemberian Kekebalan Imunisasi di RS Prima Husada



Analisis :

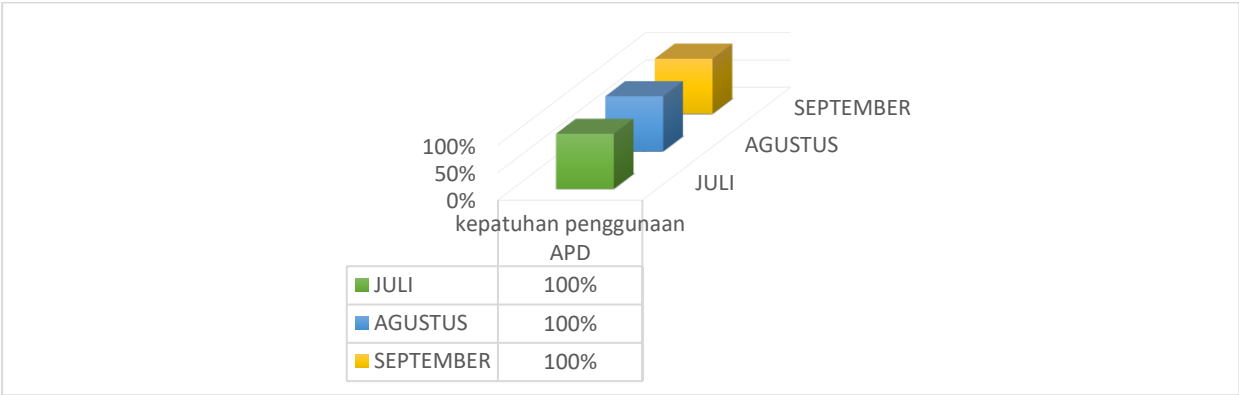
- 1. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 3 pasien yang diimunisasi pada bulan Juli
- 2. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 2 pasien yang diimunisasi pada bulan Agustus
- 3. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 0 pasien yang diimunisasi pada bulan Agustus

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG
- 2. Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulanya

3.1.2.2.8 Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD	100%	100%	100%



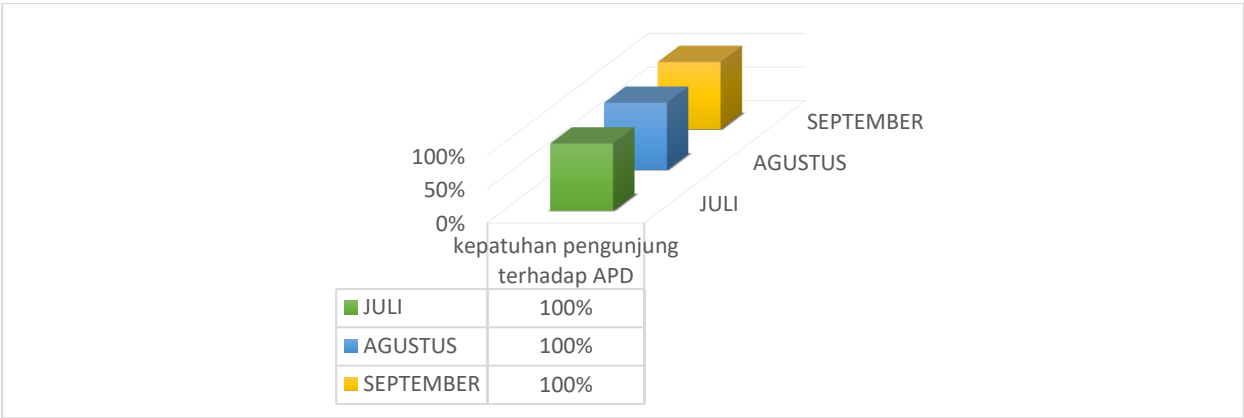
Analisis :

Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.1.2.2.9 Kepatuhan Pengunjung Pasien Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Kepatuhan pengunjung pasien terhadap APD	100%	100%	100%



Analisis:
Hasil diatas menunjukan (100%) kepatuhan terhadap APD. Hal ini terjadi karna peningkatan kesadaran pengunjung akan cara penulara.n karena disebabkan covid yang terus menularkan virus

Rencana dan Tindak Lanjut :
Memperkuat kepatuhan pengunjung dengan cara wajib memberikan masker kepada pengunjung saat di nerstation dengan menanyakan keluarga dari pasien isolasi

3.1.2.2.10 Penempatan Pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Penempatan pasien TB	100%	100%	100%

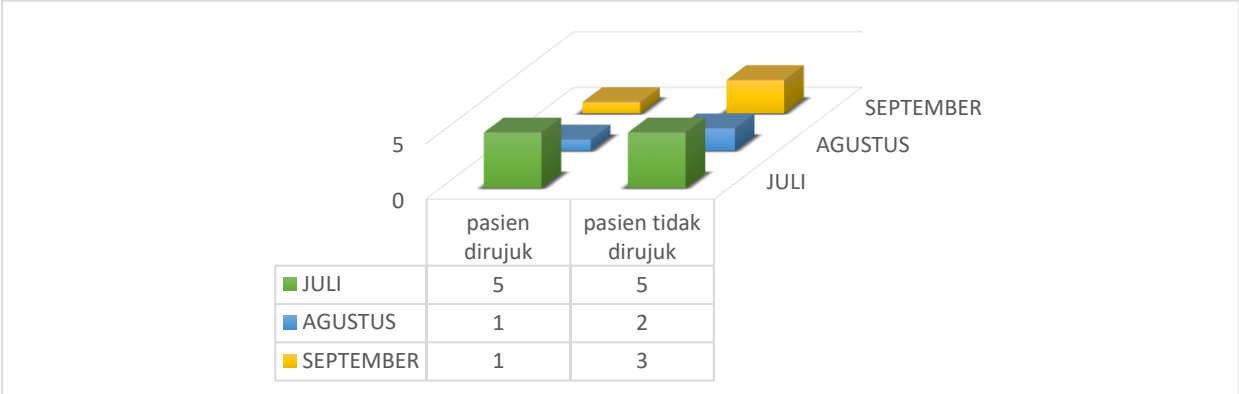
Analisis:
Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang isolasi, hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan penempatan dengan benar

3.1.2.2.11 Pasien TB yang dirujuk

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Pasien TB yang dirujuk	5	1	1
2.	Pasien TB yang tidak dirujuk	5	2	3

Grafik Pasien TB yang dirujuk Di Rumah Sakit Prima Husada



- Analisis :**
- 1. Pada bulan Juli 2025 terdapat 5 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
 - 2. Pada bulan Agustus 2025 terdapat 1 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
 - 3. Pada bulan September 2025 terdapat 1 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

3.1.2.2.12 Stok OAT

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	OAT Anak	3	1	3
2.	OAT Harian Dewasa	11	10	8
3.	Ethambutol	896	672	672
4.	Pirazinamid	890	890	308
5.	Isoniazid	1380	1380	756
6.	Rimfapicin 450 mg	1570	1470	1290
7.	Rimfapicin 300 mg	0	0	1470

Grafik Stok Obat TBC Di Rumah Sakit Prima Husada



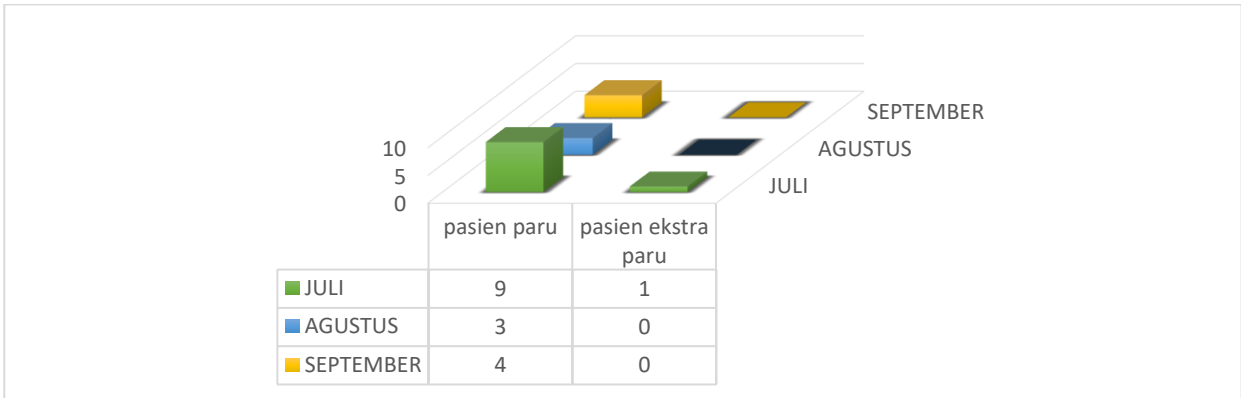
Analisis :
Setiap 1 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinkes

Rencana dan Tindak Lanjut :
Menetapkan pengambilan obat dengan sesuai jadwal.

3.1.2.2.13 Pasien Paru dan Ekstra Paru

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Pasien paru	9	3	4
2.	Pasien Ekstra paru	1	0	0

Grafik Pasien Paru dan Ekstra Paru di Rumah Sakit Prima Husada



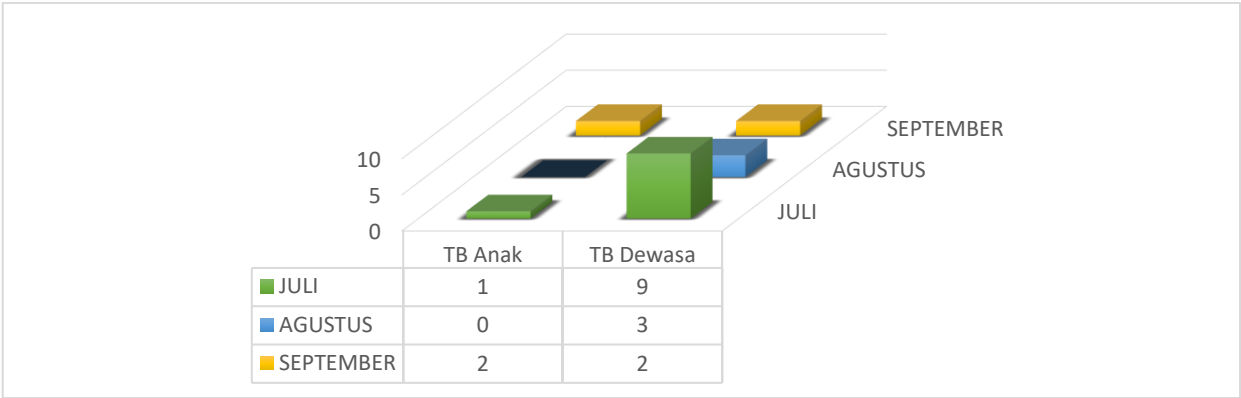
- Evaluasi :
- 1. Pada bulan Juli 2025 terdapat 8 pasien paru dan 1 pasien ekstra paru
 - 2. Pada bulan Agustus 2025 terdapat 3 pasien paru dan 0 pasien ekstra paru
 - 3. Pada bulan September 2025 terdapat 4 pasien paru dan 0 pasien ekstra paru

Rencana dan Tindak Lanjut :
Memberikan pengobatan yang sama pada ekstra paru meski pengobatannya akan lebih lama

3.1.2.2.14 Pasien Anak Dan Pasien Dewasa TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Pasien Anak	1	0	2
22.	Pasien Dewasa	9	3	2

Grafik Pasien Anak dan Pasien Dewasa di Rumah Sakit Prima



- Analisis :
- 1. Pada bulan Juli terdapat 1 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 9 pasien

2. Pada bulan Agustus terdapat 0 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 3 pasien
3. Pada bulan September terdapat 2 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 2 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pencatatan TB sesuai kategori pasien.

3.1.2.2.15 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK TB

No	Kegiatan	Nama Pasien	Patuh	Tidak Patuh	Alasan
1.	dr. Andy, Sp. P(K)	Ny. S	V		
		Ny. I	V		
		Ny. S	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK	Tn. P	V		
3.	dr. Yunita, Sp. P				

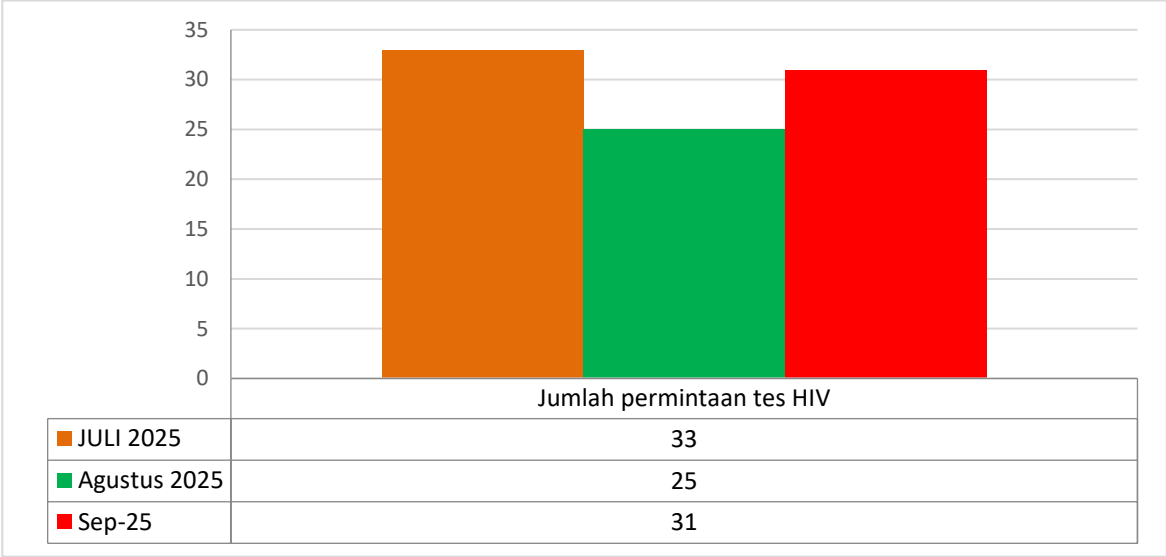
Analisis :
Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan

Rencana dan Tindak Lanjut :
Tetap mempertahankan kepatuhan dokter sesuai dengan PPK TB yang berlaku di RS Prima Husada Kabupaten Malang

3.1.2.3 HIV

Jumlah Permintaan Tes HIV				
NO	URAIAN	BULAN		
		JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
1	Permintaan Test HIV	33	25	31

**Grafik Jumlah Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan September 2025**



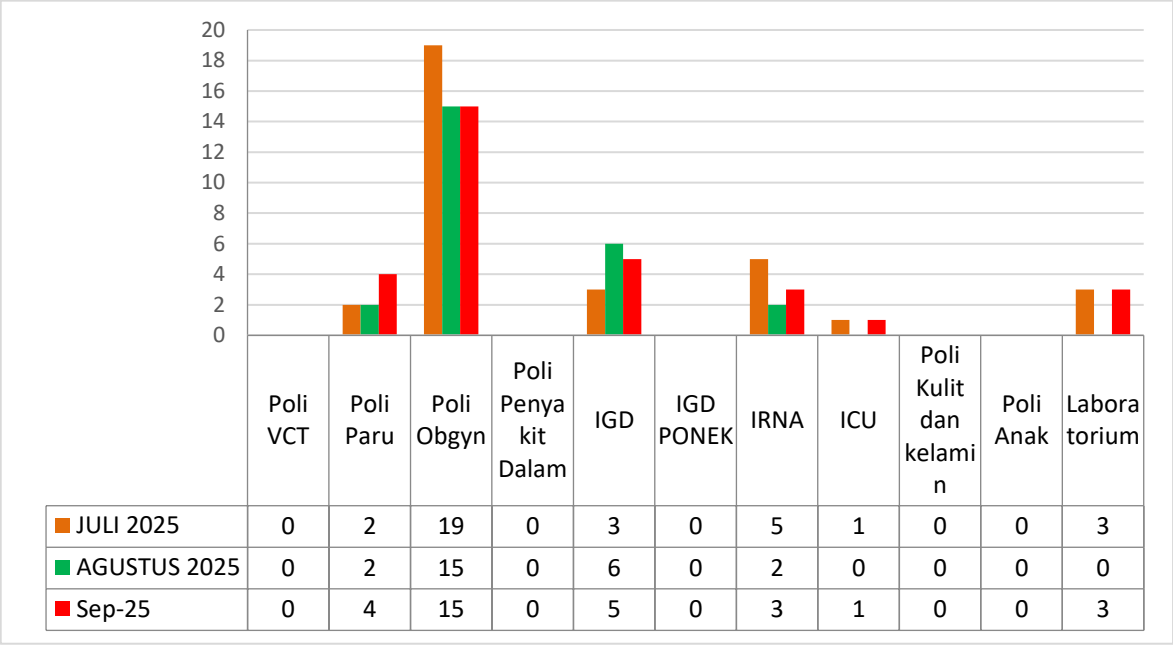
Analisis :
 Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah permintaan test HIV pada bulan Juli 2025 sebanyak 33 pemeriksaan. pada bulan Agustus 2025 sebanyak 25 pemeriksaan Sedangkan pada bulan September 2025 sebanyak 31 pasien.
 Hal ini dikarenakan terdapat pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya.

Rencana Tindak Lanjut :
 Dilakukan skrining ulang pada pasien-pasien yang terduga HIV, pasien hamil trimester 3 dan juga pasien-pasien mandiri yang ingin dilakukan pemertiksaan HIV sesuai sukarela baik pasien IGD, rawat jalan maupun rawat inap.

3.7.57 Asal Permintaan Tes HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
1	Poli VCT	0	0	0
2	Poli Paru	2	2	4
3	Poli Obgyn	19	15	15
4	Poli Penyakit Dalam	0	0	0
5	IGD	3	6	5
6	IGD PONEK	0	0	0
7	IRNA	5	2	3
8	ICU	1	0	1
9	Poli Kulit dan kelamin	0	0	0
10	Poli Anak	0	0	0
11	Laboratorium	3	0	3

Grafik Jumlah Asal Permintaan Tes HIV di RS Prima Husada Bulan September 2025



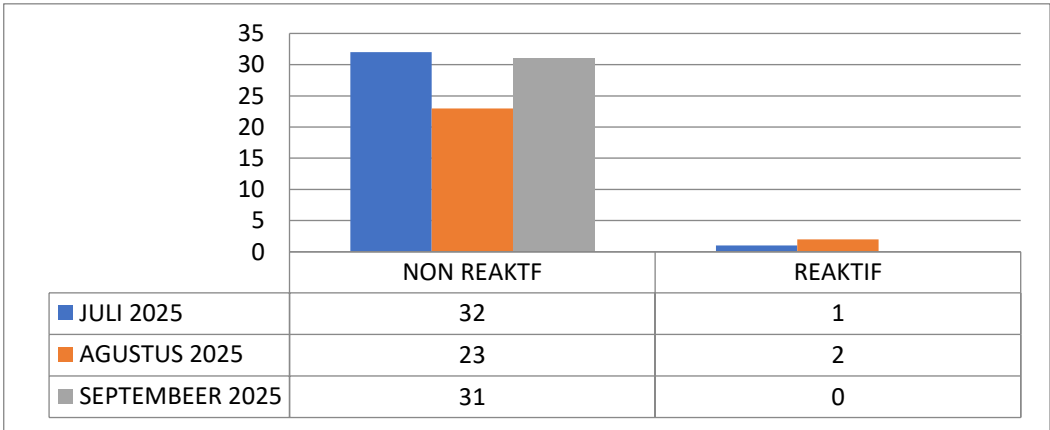
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah asal permintaan test HIV di Poli kandungan tetap tinggi dibandingkan dari unit lain pada bulan Juli 2025 sebanyak 19 pasien. pada bulan Agustus 2025 sebanyak 15 pasien Sedangkan pada bulan September 2025 sebanyak 15 pasien.
Hal ini dikarenakan sudah tersdianya Reagen HIV dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk program ibu hamil sehingga pasien dengan kriteria hamil trimester II sudah bisa dilakukan screening HIV.

Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan sosialisasi terkait Permintaan testing HIV dilakukan baik di IGD, rawat jalan, maupun rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga capaian permintaan testing HIV bisa berjalan.

3.1.2.3.2 Status HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
1	Non Reaktif	32	23	31
2	Reaktif	1	2	0

Grafik Status HIV September 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan pasien dengan status HIV reaktif yang dilakukan pemeriksaan di RS prima Husada Malang pada pada bulan juli 2025 sebanyak 1 pasien dari poli rawat jalan, pada bulan Agustus 2025 sebanyak 2 pasien dari IGD. Sedangkan pada bulan September 2025 tidak terdapat pasien dengan HIV reaktif

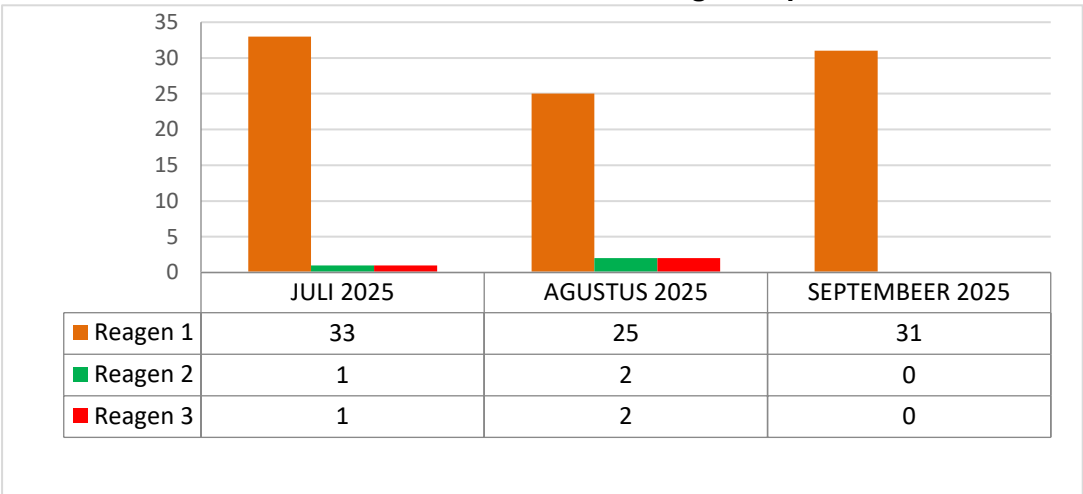
Rencana Tindak Lanjut :

Rumah sakt prima husada malang masih belum bisa melakukan pelayanan pasien dengan HIV/AIDS, apabila ditemukan pasien dengan HIV reaktif maka akan kami lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah MOU dengan RS Prima Husada Malang.

3.7.58 Jumlah Pemakaian Reagen

No	URAIAN	BULAN		
		JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
1	Reagen 1	33	25	31
2	Reagen 2	1	2	0
3	Reagen 3	1	2	0

Grafik Jumlah Pemakaian Reagen September 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pemakaian reagen pada bulan Juli 2025 memakai reagen 3 dikarenakan ada pasien reaktif sebanyak 1 pasien pada bulan Agustus 2025 memakai reagen 3 dikarenakan ada pasien reaktif sebanyak 2 pasien Sedangkan pada bulan September 2025 hanya memakai reagen 1 dengan jumlah 31 pasien

Rencana Tindak Lanjut :

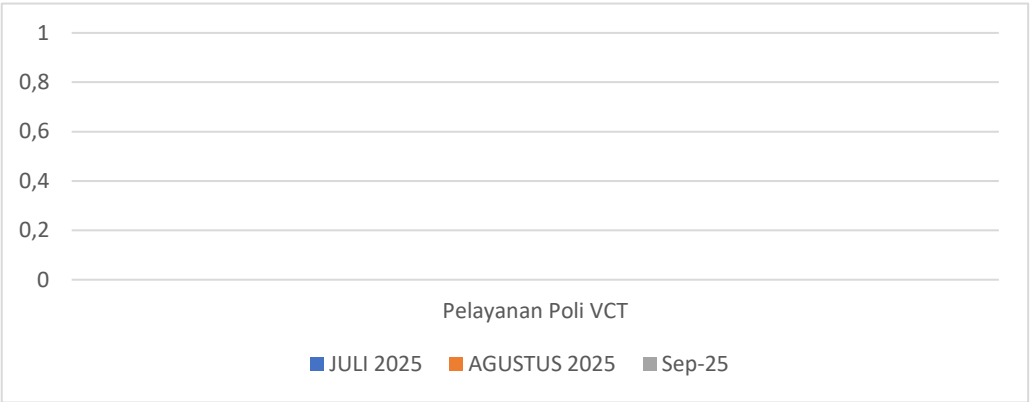
Pemakaian reagen HIV tergantung dari hasil pemeriksaan dengan Reagen 1. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan Reagen 1 hasil Non Reatif maka tidak dilanjutkan pemakaian Reagen 2 dan 3.

Tetapi apaila saat pemeriksaan dengan Reagen 1 ditemukan hasil Reaktif maka pemeriksaan dilanjutkan dengan penggunaan Reagen 2 dan Reagen 3

3.7.59 Pelayanan Poli Vct (Voluntary Conseling And Testing)

No	URAIAN	BULAN		
		JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
1	Pelayanan Poli VCT	0	0	0

Grafik Pelayanan Poli VCT September 2025



Analisis pelayanan Poli VCT

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa tidak ada kunjungan di poli VCT di RS Prima Husada. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS

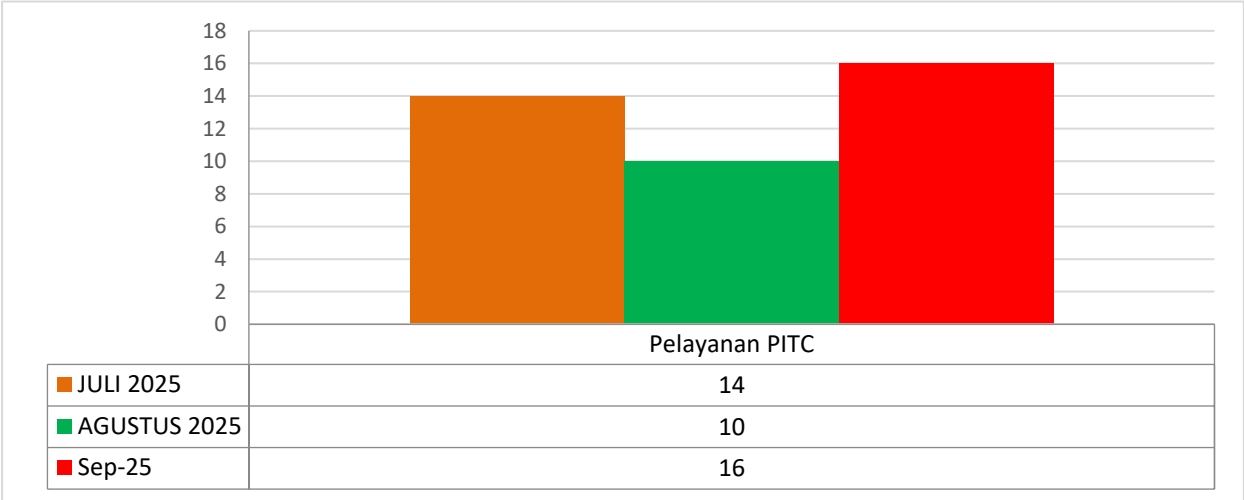
Rencana Tindak Lanjut

Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husadabelum berdiri sendiri, melainkan masih bergabung dengan oli penyakit Dalam di Rawat jalan. Hal ini dikarenaka asih belum adanya kunjungan pasien ke poli VCT

3.7.60 Pelayanan PITC (Provider Initiated Testing and Counseling)

No	URAIAN	BULAN		
		JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
1	Pelayanan PITC	14	10	16

Grafik Pelayanan PITC September 2025



Analisis :

Dari data diatas terdapat keimpulan bahwa telah dilakukan edukasi pemeriksaan HIV oleh petugas kesehatan untuk dilakukan testing HIV pada bulan pada bulan Juli 2025 sebanyak 14 pasien. pada bulan Agustus 2025 sebanyak 10 pasien. Sedangkan pada bulan September 2025 sebanyak 16 pasien

Hal ini dikarenakan testing dan konseling dilakukan saat pasien menunjukan gejala HIV dan dilakukanya sreening baik di ruangan maupun IGD

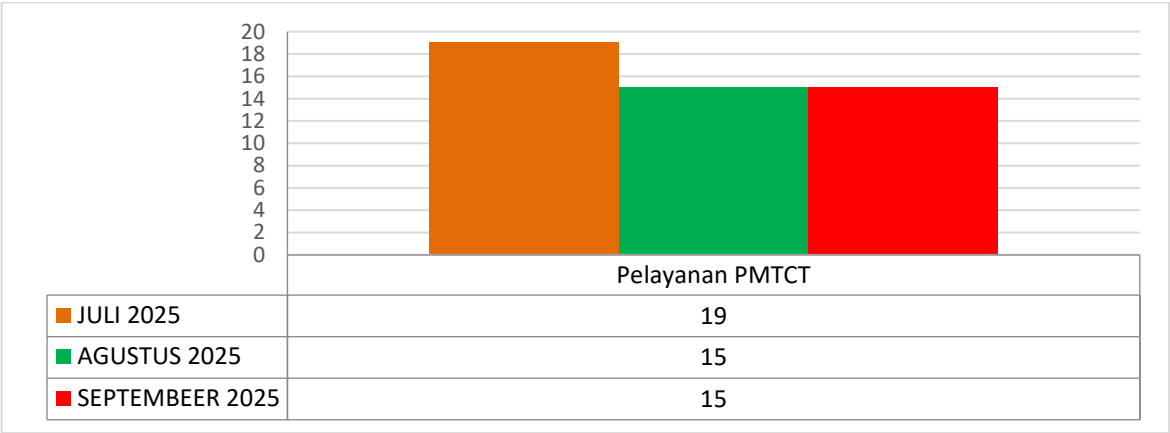
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan peningkatan terkait penjangkaran pasien dengan dialkukanya edukasi pasien tentang testing HIV kepada pengunjung atau masyarakat sehingga pasien paham tentang pentingnya dilakukan pemeriksaan HIV.

3.7.61 Pelayanan Pmtct (Prevention to Mother Of Child Transmision)

No	URAIAN	BULAN		
		JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
1	Pelayanan PMTCT	19	15	15

Grafik Pelayanan PMTCT September 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV sebagai screening dan deteksi pencegahan penularan dari ibu ke Bayi. Pada bulan pada bulan juli 2025 sebanyak 19 pasien. pada bulan agustus 2025 sebanyak 15 pasien Sedangkan pada bulan September 2025 sebanyak 15 pasien.
Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

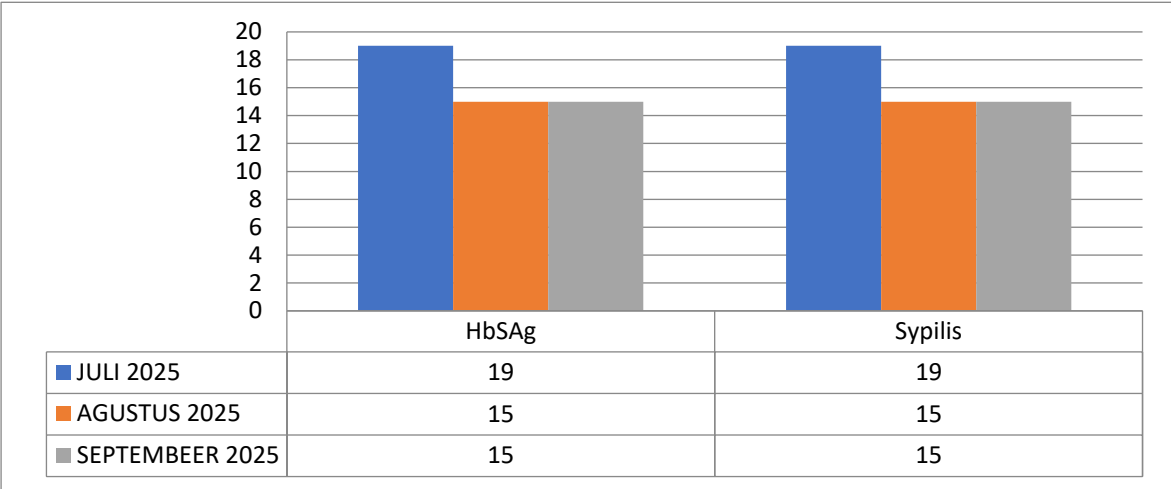
Rencana Tindak Lanjut :

Reagen pemeriksaan HIV yang diperoleh dari dinas kesehatan sudah tersedia di RS Prima Husada Malang sehingga Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

3.7.62 Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
1	HbSAg	19	15	15
2	Sypilis	19	15	15

Grafik Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
September 2025



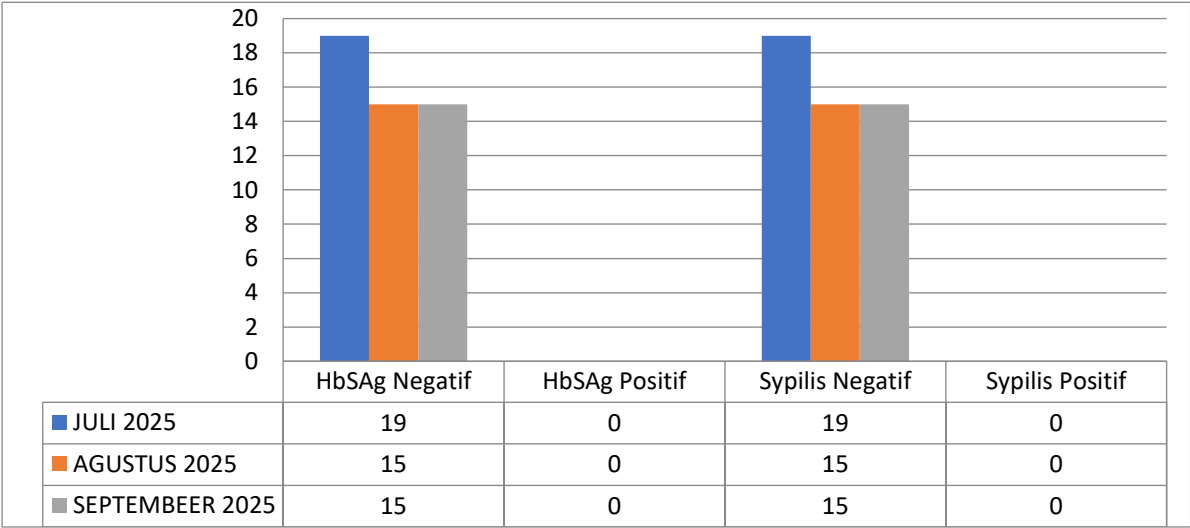
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HbSAg dan Sypilis pada bulan pada bulan pada bulan Juli sebanyak 19 pasien. pada bulan agustus sebanyak 15 pasien Sedangkan pada bulan September 2025 sebanyak 15 pasien Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan triple eliminasi dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan Triple eliminasi di RS Prima Husada Malang untuk pemeriksaan HbSAg dan Sypilis bisa dilakukan.

Rencana Tindak lanjut :
Pemeriksaan Triple eliminasi untuk ibu hamil bersifat wajib dan dilakukan 1 kali saat awal kehamilan. Di RS Prima Husada skrining pemeriksaan triple eliminasi sudah berjalan dan dilakukan saat kunjungan pada Trimester 2.

3.7.63 Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
1	HbSAg			
	Negatif	19	15	15
	Positif	0	0	0
2	Sypilis			
	Negatif	19	15	15
	Positif	0	0	0

**Grafik Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
September 2025**



Analisis :
 Dari hasil grafik diatas ditemukan data bahwa pada bulan Juli, Agustus dan September 2025 tidak ditemukan pasien dengan HbSAg maupun Shypilis dengan hasil positif.

Rencana Tindak Lanjut :

- Pada pasien HbSAg

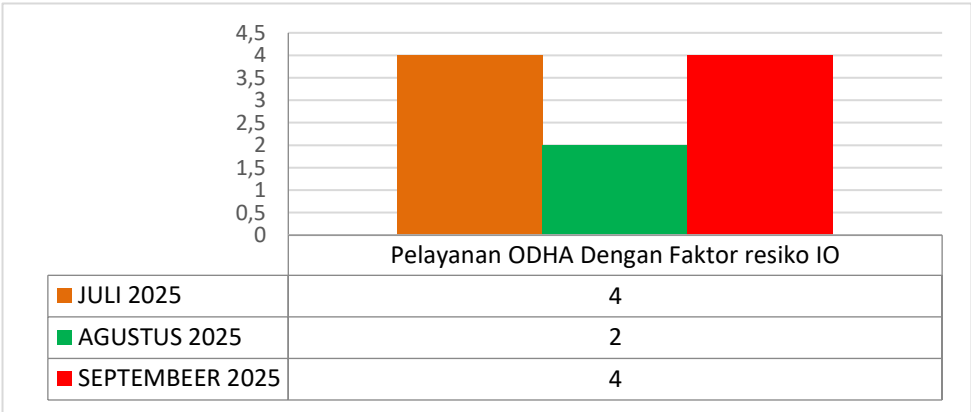
Saat kelahiran aka nada pemberian vaksin Hepatitis kepada bayi yaitu Hiper Heb dan juga Hb.O unijec yang diberikan saat bayi baru lahir sampai dengan maksimal 24 jam pemberian. Untuk ibu dengan HbSAg akan dilakukan pemberian vaksin hepatitis oleh Puskesmas sesuai domisili pasien.Penanganan pasien dengan HbSAg Rumah Sakit Prima Husada Malang Kolaborasi dengan puskesmas sesuai dengan domisili pasien.
- Pada pasien Sypilis

Di rumah sakit Prima Husada Malang sudah bisa melakukan pengobatan pasien dengan syphilis positif. Sehingga tidak lagi melakukan rujuk keluar.

3.7.64 Pelayanan Odha Dengan Factor Resiko Infeksi Oportunistik

No	URAIAN	BULAN		
		JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
1	Pelayanan ODHA Dengan Faktor resiko IO	4	2	4

Grafik Pelayanan Odha dengan Faktor Resiko IO September 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa terdapat pasien dengan diagnose TB positif yang dilakukan pemeriksaan HIV di RS Prima Husada. pada bulan Juli sebanyak 4 pasien. pada bulan agustus sebanyak 2 pasien. Sedangkan pada bulan September 2025 sebanyak 4 pasien. Hal ini dikarenakan dilakukanya screening pasien TB di RS Prima Husada Malang.

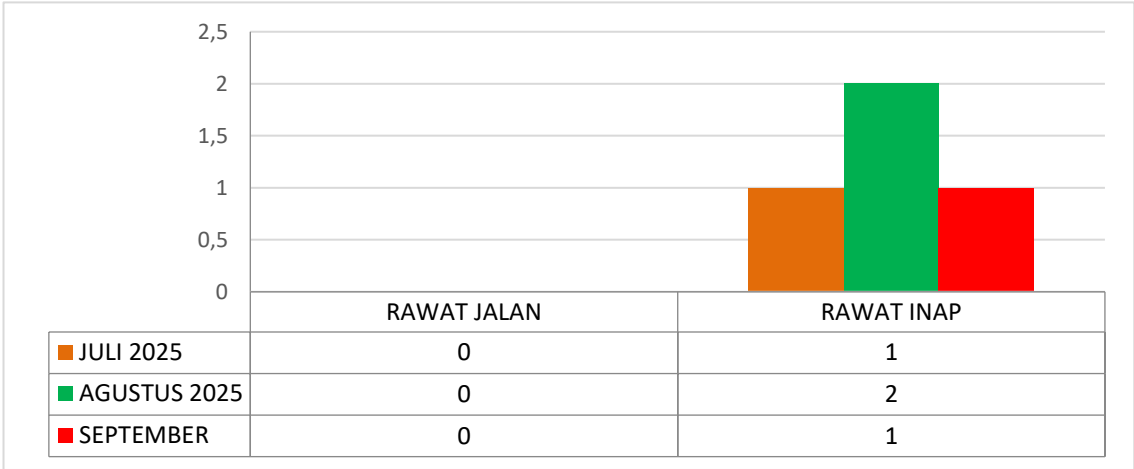
Rencana Tindak Lanjut :

Pasien-pasien dengan diagnose TB positif di Rumah Sakit Prima Husada Malang sudah patuh dilakukan screening pemeriksaan HIV/AIDS sesuai dengan SPO.
Diharapkan bisa saling kerjasama antar tim yaitu TIM TB dan Tim HIV.

3.7.65 Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
1	Rawat Jalan	0	0	0
2	Rawat Inap	1	2	1

Grafik Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS September 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa Pada bulan Juli 2025 terdapat 1 pasien yang dirujuk. pada bulan Agustus 2025 terdapat 2 pasien yang dirujuk dari rawat inap. Sedangkan pada bulan September 2025 sebanyak 1 pasien yang dirujuk dari rawat inap Pasien Dilakukan rujuk dikarenakan RS Prima husada malang belum bisa menangani pasien yang ditemukan positif HIV .

Rencana Tindak Lanjut :

Pelaksanaan Rujukan dilakukan apabila hasil pemeriksaan HIV Reaktif. Rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Malang.

3.1.2.4 Stunting & Wasting

1.1.2.4.1 Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting

Tabel Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting September 2025

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf , pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting	Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan edukasi pasien dan sosialisasi kepada seluruh staff mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan stunting dan wasting.

2	Program 1000 HPK	Pemberian Penyuluhan tentang pentingnya pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien
3	Suplementasi Folat Pada Ibu hamil	Suplementasi Folat Pada ibu hamil dilaksanakan di poli kandungan di RS Prima Husada Malang
4	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil	Pemberian PMT pada ibu hamil dilaksanakan pada saat kegiatan senam hamil di RS Prima Husada Malang
5	Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	1. Kegiatan konseling IMD dilaksanakan sesaat setelah ibu melahirkan 2. Konseling IMD dan ASI eksklusif dilaksanakan pada saat ibu telah memasuki rawat inap maternitas 3. Penyuluhan tentang pentingnya IMD dan pemberian ASI eksklusif juga dilaksanakan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan
6	Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita dilaksanakan di ruang rawat inap dan melakukan pendampingan di poli anak RS prima husada
8	Pemberian imunisasi	Pemberian imunisasi dilaksanakan di poli anak RS prima husada malang sesuai dengan jadwal praktek dokter spesialis anak dan di rawat inap sesaat setelah bayi baru dilahirkan.
9	Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Pemberian makanan tambahan balita gizi kurang dilaksanakan apabila ditemui balita dengan gizi kurang di rawat inap
10	Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi	1. Menyelenggarakan pelayanan konseling kesehatan maternal dan neonatal. 2. Konseling pemberian ASI eksklusif. 3. Penyediaan Pojok Laktasi untuk mendukung pemberian ASI eksklusif
11	Rumah Sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting	1. Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Stunting, Gizi Kurang, Gizi Buruk pada Balita 2. Memastikan kasus, penyebab dan tatalaksana lanjut oleh dokter spesialis anak. 3. Melakukan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian, pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting.
12	Rumah Sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan	Tidak terdapat kunjungan/ Pendampingan klinis kepada balita gizi kurang yang telah KRS dari RSPHM.
13	Program Pemantauan dan Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait edukasi yang sudah diberikan, serta membuat laporan dan evaluasi kegiatan.

Analisis

1. Melakukan tindakan pelayanan penurunan dan penanggulangan stunting dan wasting di Rumah Sakit.
2. Melakukan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting dan wasting kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien di rumah skait.

3.1.2.4.2 Kinerja Produktivitas

Tabel Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	LOKASI	JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
Program 1000 HPK	Penyuluhan	Pengunjung RS Prima	IRJA anak	1	1	1

	mengenai kehidupan 1000 hari pertama	Husada Malang	dan Kandungan			
Suplementasi Asam folat pada ibu hamil	1. Penyuluhan tentang pentingnya konsumsi asam folat pada ibu hamil 2. Pembagian tablet tambah darah dan asam folat	Ibu Hamil	Senam Hamil , Poli Kandungan, Hall gedung baru lantai 5	1	1	1
Pemberian PMT Ibu Hamil	Pemberian PMT dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil terindikasi KEK	Ibu Hamil	Hall gedung baru lantai 5	1	1	1
Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Ibu hamil	IRJA anak dan kandungan, irna maternitas	1	1	1
Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	1. Penyuluhan tentang stunting, makanan sehat pada bayi dan balita 2. Pembagian PMBA	IRNA Anak	IRJA	1	1	1
Pemantauan pertumbuhan (Pelay	Melakukan Pencatatan dan	Pasien Anak	IRJA anak	1	1	1

anan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	plotting pada buku KIA setelah pengukura n berat badan dan tinggi badan anak					
Pemberia n Imunisasi	Memastik an ketersedia an imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	Pasien anak dan Bayi baru lahir	IRJA anak	1	1	1
Pemberia n vitamin A	Bekerja sama dengan puskesma s terdekat untuk mendukun g program pemerinta h mengenai pemberian vitamin A	Pasien anak	IRJA anak	0	0	0
Pemberia n Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Memberik an PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun menu yang sesuai dengan ketersdiaa n bahan pangan di lingkunga n	Pasien anak	Rawat Inap	1	1	1
Pemberia n Taburia pada Baduta	Bekerja sama dengan puskesma s terdekat untuk mendukun g program pemerinta h mengenai pemberian bubuk	Pasien anak	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0

	taburia					
Pemberian Obat cacing pada ibu hamil	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian obat cacing pada ibu hamil	Ibu Hamil	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0

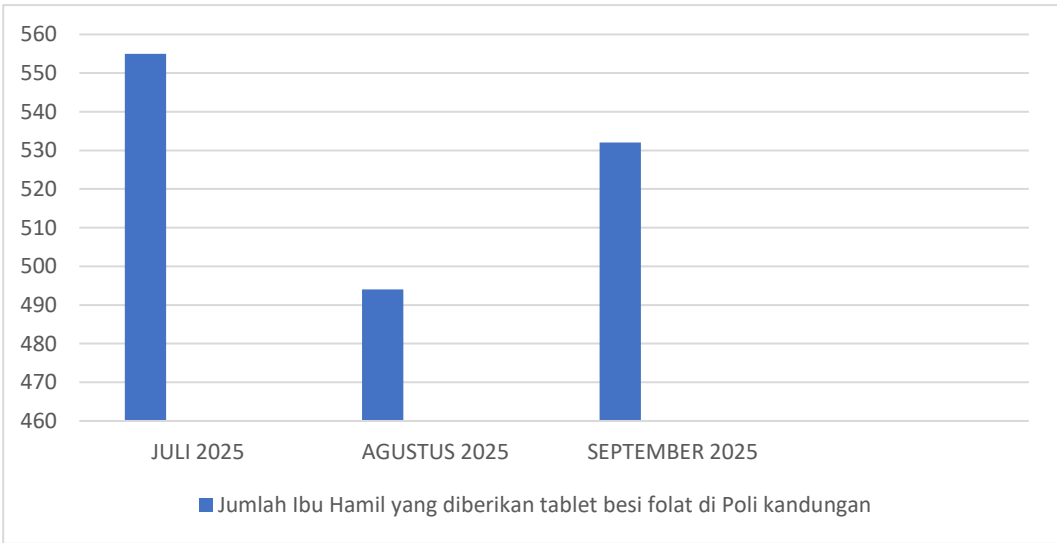
Analisis :
 Sebagian besar intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Pemberian bubuk Taburia dan Mineral mix dilakukan pemberian kepada pasien apabila terdapat pasien rujukan dari puskesmas. Karena bubuk taburia dan mineral mix hanya terdapat di puskesmas. Sehingga jika ada pasien teridentifikasi wasting pihak RS baru mendapat distribusi dari puskesmas wilayah balita tersebut tinggal.

Rencana Tindak Lanjut :
 Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit dan melakukan pemantauan kepada balita stunting.

3.1.2.4.3 Pemberian Tablet Besi Folat Bagi Ibu Hamil
Tabel Distribusi Tablet Besi Folat pada Ibu Hamil di RS Prima Husada Malang

BULAN	JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli kandungan	555	494	532

Grafik Jumlah Pemberian Tablet Besi Folat Pada Ibu Hamil September 2025



Analisis :
 Pemberian asam folat diberikan kepada ibu hamil pada usia kandungan trimester pertama.

Sedangkan pemberian tablet zat besi diberikan pada usia kandungan trimester 2 dan 3. Jumlah pemberian tablet besi folat turun dari sebelumnya 555 di bulan Juli menjadi 494 pada bulan Agustus yang mendapat tablet besi folat untuk ibu hamil.

Rencana Tindak Lanjut:

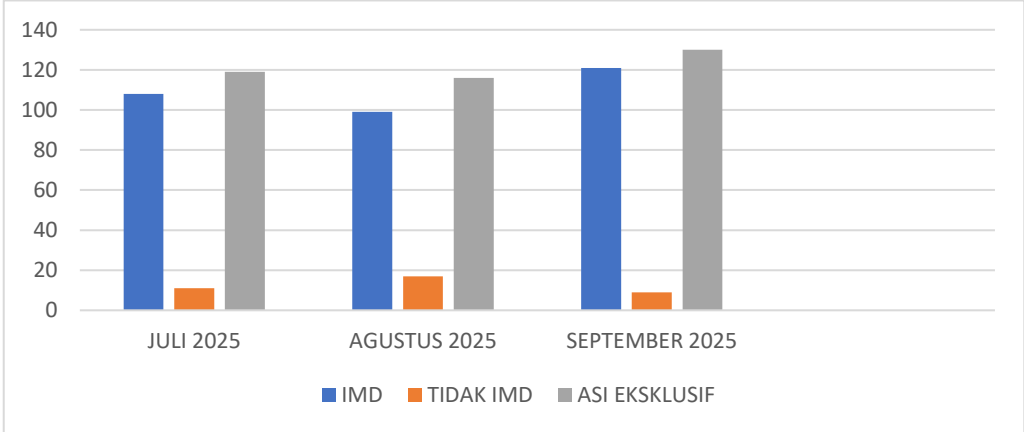
- 1. Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
- 2. Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

3.1.2.4.4 Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

Tabel Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN JULI 2025	BULAN AGUSTUS 2025	BULAN SEPTEMBER 2025
1	IMD	108	99	121
2	Tidak IMD	11	17	9
3	Mendapat Konseling ASI Eksklusif	119	116	130

Grafik Pelayanan IMD dan Konseling ASI Eksklusif September 2025



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan September sebanyak 121 bayi.
- 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan September 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 9 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
- 3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
- 4. 100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Jumlah Ibu mendapat konseling ASI Eksklusif meningkat pada bulan September 2025 yaitu sebanyak 130 pasien.

Rencana Tindak Lanjut:

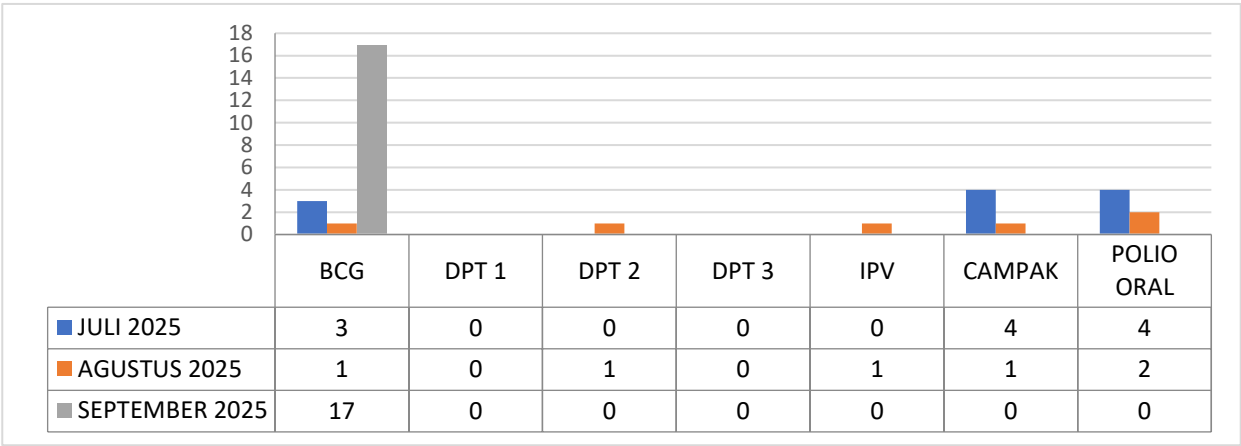
Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi.

3.1.2.4.5 Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

Tabel Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN JULI 2025	BULAN AGUSTUS 2025	BULAN SEPTEMBER 2025
1	BCG	3	1	17
2	DPT 1	0	0	0
3	DPT 2	0	1	0
4	DPT 3	0	0	0
5	DPT 4	0	0	0
5	IPV	0	1	0
6	Campak	4	1	0
7	Polio Oral	4	2	0

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada September 2025



Analisis:

- 1. Terdapat 17 balita yang melakukan imunisasi BCG di bulan September 2025.
- 2. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi DPT 1, DPT 2, DPT 3, DPT 4, IPV, CAMPAK, POLIO ORAL pada bulan September 2025.

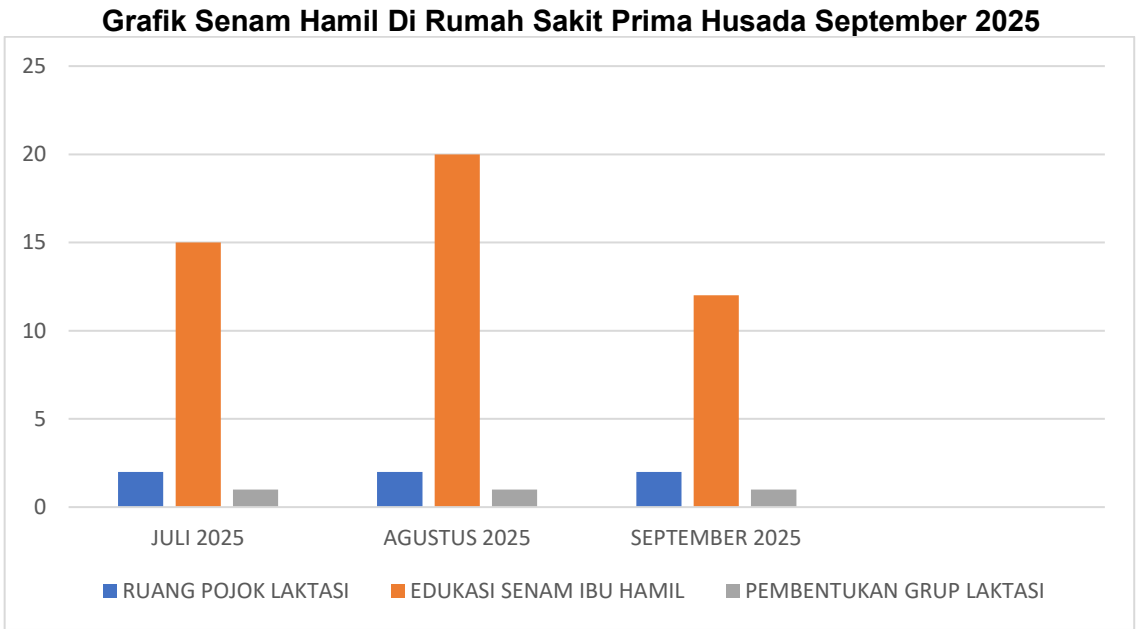
Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit. Bekerjasama dengan pihak puskesmas untuk keersediaan vaksin di RS.

3.1.2.4.6 Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

KEGIATAN PENERAPAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI	JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
Ruang Pojok Laktasi	2	2	2
Senam Hamil	15	20	12
Pembentukan Grup Laktasi	1	1	1



Analisis :

- 1. Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah Rumah Sakit Prima Husada Malang sebanyak 2 ruangan, di lantai 1 dan di lantai 2.
- 2. Grup Laktasi dibentuk untuk memberikan tips menyusui.
- 3. Pada bulan September edukasi pada ibu hamil dilakukan dengan memberikan penyuluhan Gizi Seimbang sebanyak 12 peserta penyuluhan dilakukan di poli obgyn

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti pampers dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.
- 2. Melakukan edukasi mengenai pentingnya mengikuti senam ibu hamil pada ibu hamil yang tidak memiliki kondisi penyulit saat hamil.

**3.1.2.4.7 Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting Dan Wasting
Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi**

RUJUKAN MASUK				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Asal Rujukan
Juli	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-
September	-	-	-	-
RUJUKAN KELUAR				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Tujuan Rujukan
Juli	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-
September	-	-	-	-

Grafik Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting dan Wasting Bulan September 2025



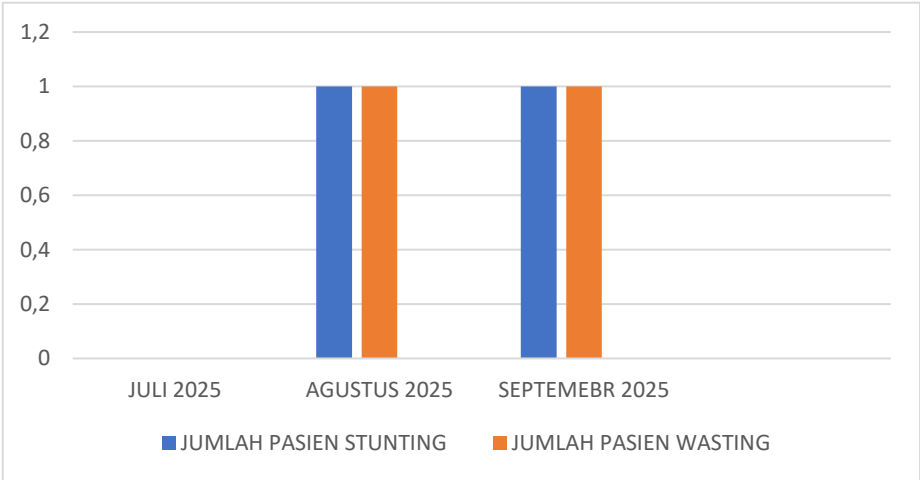
Analisis :
Tidak Terdapat pasien stunting atau wasting yang dirujuk keluar RS maupun rujuk masuk RS

Rencana Tindak Lanjut:
Perlu diadakan kerjasama lagi dengan puskesmas dan klinik faskes pertama untuk bekerjasama dalam menjaring pasien stunting dan wasting.

3.1.2.4.8 Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan
Tabel Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

BULAN	JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
Jumlah Pasien Stunting	0	1	1
Jumlah Pasien Wasting	0	1	1

Grafik Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan



Analisis :
Pada bulan September 2025 ditemukan 1 pasien stunting dan wasting. Hal tersebut berkaitan dengan kebiasaan makan yang kurang adekuat pada pasien. Makanan harus lebih beragam dan tinggi kalori dan protein. Anak mendapatkan PMT tambahan dari pemerintah 10 hari sekali menerima 10 biskuit dan susu 3 kotak. Berdasarkan berat badan menurut umur dikategorikan berat badan kurang dan tinggi badan menurut umur pasien termasuk kategori *stunting*. BB pasien saat masuk rumah sakit di BB 9,9 kg, TB: 85 cm.

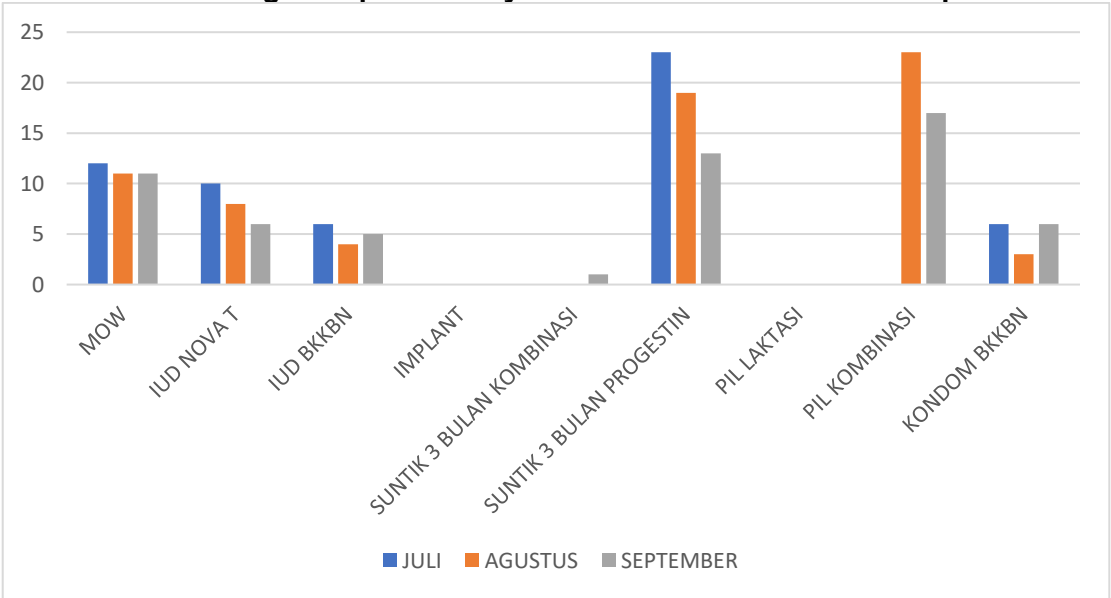
Rencana Tindak Lanjut :
Tim Stunting dan Wasting RS Prima Husada lebih gencar dalam melakukan pengukuran dan pelaporan pasien anak baik di rawat inap maupun rawat jalan

3.1.2.5 KBRS

3.7.66 Angka Capaian Pelayanan KB per Metode Kontrasepsi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
1	MOW	12	11	11
2	IUD Nova T	3	8	6
3	IUD BKKBN	6	4	5
4	IMPLANT	0	0	0
5	SUNTIK 3 BULAN KOMBINASI	0	0	1
6	SUNTIK 3 BULAN PROGESTIN	23	19	13
7	SUNTIK 1 BULAN	0	0	0
8	PIL KOMBINASI	0	23	17
9	PIL LAKTASI	0	0	0
10	KONDOM BKKBN	6	3	6

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Per Metode Kontrasepsi



Evaluasi :

- 1. Peserta MOW pada bulan Juli naik (12) Agustus (11) September tetap (11)
- 2. Peserta IUD Nova T pada bulan Juli turun (3) Agustus naik (8) September turun (6)
- 3. Peserta IUD BKKBN pada bulan Juli naik (6) Agustus (4) September naik (5)
- 4. Peserta KB suntik 3 bulan kombinasi, pada bulan Juli (1) Agustus dioperkan ke faskes lain sebanyak 80 vial,September (1)
- 5. Peserta KB suntik progestin pada bulan Juli naik (23) Agustus dipakai sebanyak (19) dioperkan ke faskes lain sebanyak (10) vial September turun (13)
- 6. Peserta KB pil kombinasi pada bulan Juli (0) Agustus (23) September turun (17)
- 7. Peserta KB Kondom pada bulan Juli (6) turun Agustus (3) September naik (6)

Analisis :

- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
- 2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

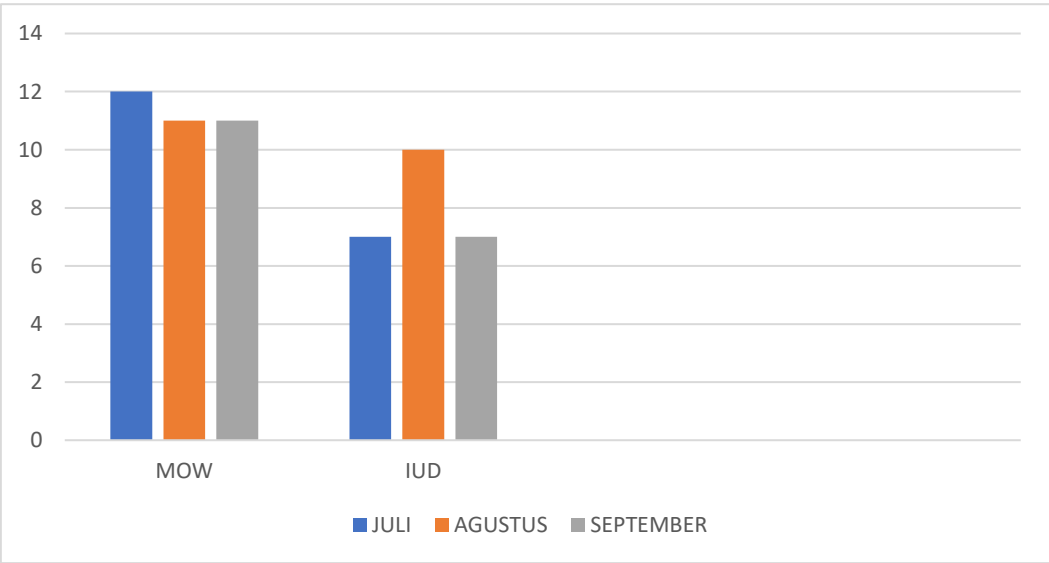
Rencana Tindak Lanjut :

Demi meningkatkan capaian KB maka rumah sakit akan melakukan pelatihan internal bagi para bidan dalam pemasangan IUD pasca plasenta,dan akan diadakan safari KB setiap 2 bulan sekali

Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Keguguran

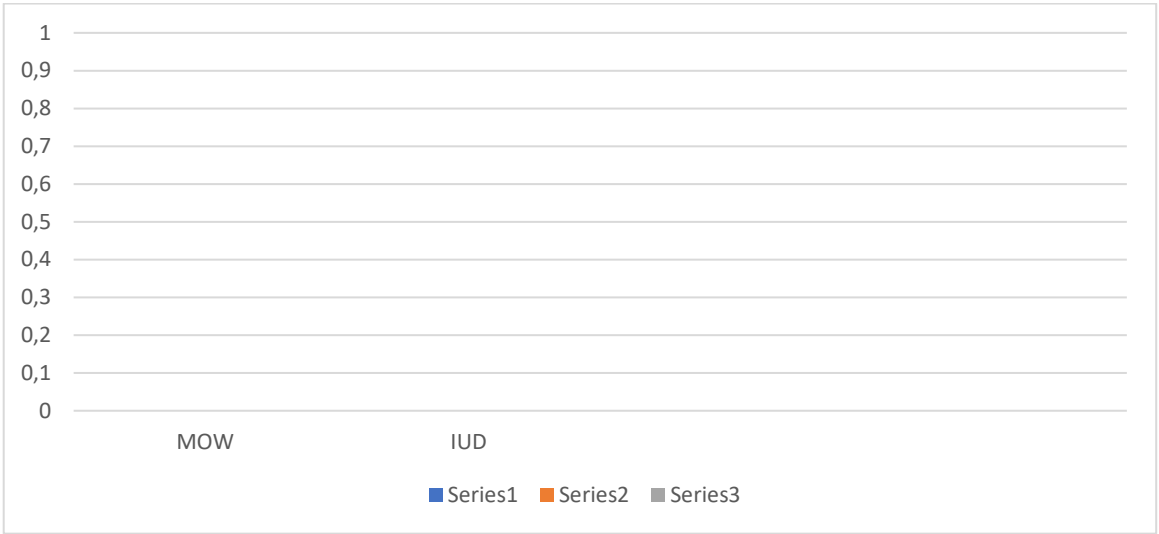
NO	JENIS PELAYANAN PASCA PERSALINAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
1	MOW	12	11	11
2	IUD	7	10	7

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan



NO	JENIS PELAYANAN PASCA KEGUGURAN	JUMLAH PASIEN		
		JULI 2025	AGUSTUS 2025	SEPTEMBER 2025
1	MOW	0	0	0
2	IUD	0	0	0

Grafik Angka Capaian Pelayan KB Pasca Keguguran



Evaluasi :

- 1. Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan pada bulan Juli-Agustus-September meningkat
- 2. Angka capaian pelayanan KB pasca keguguran pada bulan Juli-Agustus-September menetap.

Analisis :

- 1. Peningkatan jumlah sasaran pada triwulan pertama kemungkinan didapatkan karena sasaran KB sudah mengetahui pentingnya KB dari pengetahuan yang didapatkan saat sosialisasi yang dilakukan tim setiap bulannya.
- 2. Capaian pelayanan KB pasca keguguran menetap dikarenakan peserta mempunyai alasan ingin segera hamil lagi.

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
- 2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

3.2.3 Tim PPRA

3.2.3.1 Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif Triwulan III Tahun 2025

3.2.3.1.1 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Juli 2025

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1	Ardiansyah	L/30	dr. Arianto, Sp.OT	233336	Open wound of other of hand	30/06/2025	02/07/2025	3	Cefoperazone	2	1x1	1	4	0,25
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
2	Reva Aldo	L/29	dr. Anton, Sp.B	233308	Gangren Anogenital	30/06/2025	02/07/2025	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
3	Ni Luh Elinda	P/23	dr. Humaira, Sp.OG	162043	SC	04/07/2025	06/07/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
4	Mukiyat	L/55	dr. Ardhi, Sp.Pd	016856	TF + ISK	08/07/2025	12/07/2025	5	Ceftriaxone	2	2x1	7	2	3,5
									Asam Pipemidat		2x0.4	1,6	0,8	2,5
5	Umul Habibah	L/51	dr. Andy, Sp.P	233948	Asthma	11/07/2025	14/07/2025	4	Azithromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
6	Nadila Munip	P/23	dr. Humaira, Sp.OG	232809	Oligohydramnios	14/07/2025	16/07/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
7	Alipah	P/62	dr. Ardhanay, Sp. Pd	105460	DM	15/07/2025	19/07/2025	5	Levofloxacin inf	1	1x0,5	1,5	0,5	3
8	Ngateni	P/63	dr. Ardhi, Sp.Pd	110454	Hiperglikemi + ISK	15/07/2025	19/07/2025	5	Ceftriaxone	2	2x1	7	2	3,5
									Asam Pipemidat		2x0.4	2,4	0,8	3
9	Dullah	L/49	dr. Aji, Sp.Pd	234155	DF	16/07/2025	18/07/2025	2	Levofloxacin inf	2	1x0,75	2,25	0,5	4,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
10	Kalsum	P/72	dr. Anton, Sp.B	198907	Necrotizing facitis	21/07/2025	23/07/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		3x1	4	2	2

									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
11	Musilan	L/54	dr. Fahima, SP.N	234508	CVA ICH	23/07/2025	25/07/2025	3	Cefoperazone	1	2x1	3	4	0,75
12	Marsan	L/75	dr. Ira, Sp.JP	140599	NSTEMI	23/07/2025	26/07/2025	4	Azitromycin	2	1x0,5	1,5	0,3	5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2.5
13	Artinilis	L/48	dr. Ira, Sp.JP	203877	ALO	23/07/2025	26/07/2025	4	Azitromycin	2	1x0,5	1,5	0,3	5
									Ceftriaxone		2x1	6	2	3
14	Parman	L/74	dr. Catur, Sp.P	234586	Acute Respiratory Acute	24/07/2025	27/07/2025	4	Meropenem	2	3x1	9	3	3
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
15	Samsul Arifin	L/55	dr. Anton, Sp.B	221994	Gangren necrotic diabeticum	25/07/2025	27/07/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		3x1	4	2	2
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
16	Sunardi	L/71	dr. Edi, Sp. U	198133	BPH	26/07/2025	28/07/2025	3	Cetfizoxime	1	1x2	2	4	0,5
17	You wan	L/20	dr. Sigit, Sp.BP	234721	Multiple vulnus	27/07/2025	29/07/2025	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
18	M Misbahul M	L/17	dr. Zaki, Sp.B	175470	Lymphadhenopati	27/07/2025	29/07/2025	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
19	Nengah Ratna T	P/25	dr. Humaira, Sp.OG	229454	KPD	27/07/2025	29/07/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
20	Rizky Eka	L/19	dr. Oka, Sp.OT	233174	Union Phalenx	27/07/2025	29/07/2025	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2

3.2.3.1.2 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Agustus 2025

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Yanti Ningsih	P/26	dr. Aida, Sp.OG	162043	Pre Eklamsia	30/07/2025	01/08/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
2	Eny Zuhriah	P/63	dr. Anton, Sp.B	160878	Necrotizing facitis	01/08/2025	03/08/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1/5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
3	Kusairi	L/58	dr. Ardhanay, Sp.Pd	235268	DM Hiperglikemi	06/08/2025	08/08/2025	3	Levofloxacin	1	1x0.5	1.5	0.3	5
4	Ra'im	L/73	dr. Catur, Sp. P	125436	COPD	06/08/2025	09/08/2025	4	Meropenem	1	3x1	6	3	2
5	Dasuki	L/65	dr. Andy, Sp.P	186331	COPD	07/08/2025	11/08/2025	5	Azitromycin	1	1x0.5	1.5	0.3	5
6	Hilda Dwi Vanka	P/23	dr. Humaira, Sp.OG	171684	Oligohydramnios	08/08/2025	10/08/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
7	Faradilla S	P/25	dr. Andy, Sp.P	235471	Pneumoni	10/08/2025	13/08/2025	4	Azitromycin	2	1x0.5	0.5	0.3	1.67
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
8	Patrum	L/71	dr. Pradana, Sp. U	234831	BPH	12/08/2025	14/08/2025	3	Ceftizxime	1	1x2	2	4	0.5
9	Lailatur R	P/51	dr. Andi, Sp.B	235567	Hemorrhoids with complication	12/08/2025	15/08/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
10	Chofifa	P/53	dr. Fachriy, Sp.BS	235247	Necrotizing facitis	13/08/2025	15/08/2025	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
11	Anang Fakhmi	L/35	Dr. Ardhi, Sp. Pd	235486	TF	13/08/2025	16/08/2025	4	Levofloxacin	1	1x1	2.25	0.3	7.5
12	Aan Trinova	L/35	dr. Zaki, Sp.B	166558	Peritonitis akut	21/08/2025	24/08/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
13	Soewarsih	P/76	dr. Heri, Sp.Pd	074832	TF + ISK	22/08/2025	25/07/2025	4	Ceftriaxone	2	2x1	7	2	3,5
									Asam Pipemidat		2x0.4	2,4	0,8	3
14	lin Budi	P/58	dr. Ardhi, Sp.Pd	001240	DM Hiperglikemi + ISK	22/08/2025	26/07/2025	5	Ceftriaxone	2	2x1	8	2	4

									Asam Pipemidat		2x0.4	2,8	0,8	3.5
15	Sulistiani	P/57	dr. Arianto, Sp.OT	172936	CF Distal	23/08/2025	25/08/2025	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1.5
16	Ririn Wijayanti	P/48	dr. Yoga, Sp.JP	066465	Dyspnea	23/08/2025	26/08/2025	2	Levofloxacin inf	2	1x0,5	1,5	0,5	3
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
17	Ester Ningmawati	P/59	dr. Anton, Sp.B	194608	Necrotizing facitis	25/08/2025	26/08/2025	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1.5
18	Ony Devita	P/23	dr. Humaira, Sp.OG	118438	SC	26/08/2025	28/08/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
19	Tohit	L/55	dr. Aji, Sp.Pd	236147	TF + Shock Condition	26/08/2025	29/08/2025	4	Ceftriaxone	3	2x1	4	2	2
									Cefotaxime		3x1	6	4	2
									Asam Pipemidat		2x0.4	2,4	0.8	3
20	Rahit German	L/19	dr. Catur E, Sp. P	236262	Cronic fever, Efusi pleura	28/08/2025	31/08/2025	4	Ceftriaxnoe	1	2x1	6	2	3

3.2.3.1.3 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan September 2025

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIO TIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Choirul Anam	L/84	dr. Edi, Sp. U	236329	BPH	01/09/2025	03/09/2025	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
2	Samsul Arifin	L/55	dr. Ardhany, Sp. Pd	221994	DM + CKD	01/09/2025	04/09/2025	4	Levofloxacin inf	1	1x0,5	2	0,3	6,67
3	Alifah	P/41	dr. Heri, Sp.Pd	200272	DM 2 + ISK	04/09/2025	09/09/2025	6	Asam Pipemidat	2	2x0,4	2,4	0,8	3
									Ceftriaxone		2x1	7	2	3,5
4	Ani Andarwati	P/31	dr. Ardhi, Sp. Pd	144918	TF	08/09/2025	10/09/2025	3	Ciprofloxacin po	1	2x0,5	2	1	2
5		P/25		182763	Abortus	09/09/2025	10/09/2025	2	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5

	Nimas Noviantika		dr. Humaira, Sp. OG						Amoxicilin		3x0,5	1,5	1,5	1
6	Siti Meilina Dwi	P/24	dr. Humaira, Sp. OG	232752	Oligohidramnion	12/09/2025	14/09/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
7	Hermanto	L/37	dr. Zaki, Sp.B	237018	Peritonitis akut	14/09/2025	16/09/2025	3	Cefoperazon e	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
8	Didi Supriadi	L/82	dr. Andy, Sp. P	237027	Pneumoni PSI	14/09/2025	17/09/2025	4	Azitromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
9	Irina Kusuma P	P/24	dr. Humaira, Sp. OG	010721	KPD	16/09/2025	18/09/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
10	Hafidah	P/68	dr. Aji, Sp. Pd	237124	Cholelithiasis	16/09/2025	21/09/2025	6	Ceftriaxone	2	2x1	2	2	1
									Cefotaxime		3x1	10	4	2,5
11	Heru Suryo	L/56	dr. Pradana, Sp. U	123508	Hydrouretronefrosis is osis	17/09/2025	19/09/2025	3	Ceftizoxime	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1.5
12	Amalia Iffah	P/38	dr. Anton, Sp. B	204588	Appendisitis akut	17/09/2025	20/09/2025	4	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
13	Bheny Murtopo	L/54	dr. Yoga, Sp. JP	237325	ADHF + Sepsis	20/09/2025	25/08/2025	6	Ceftriaxone	2	2x1	8	2	4
									Levofloxacin inf		1x0,5	1,5	0,3	5
14	Tatik Suprihatin	P/56	dr. Andy, Sp. P	090921	Pneumoni	21/09/2025	23/09/2025	3	Azitromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
15	Rasit	L/61	dr. Heri, Sp. Pd	237275	Abses Hepar	22/09/2025	25/09/2025	4	Ceftraixone	2	2x1	5	2	2,5
									Metronidazole inf		2x0,5	2,5	1,5	1,67
16	Melati Mandasari	P/39	dr. Ardhi, Sp. Pd	237445	ISK	23/09/2025	27/09/2025	4	Asam Pipemidat	2	2x0,4	1,6	0,8	2
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
17	Puput Pratiwi	P/18	dr. Aji, Sp. Pd	061672	Colic abdomen	23/09/2025	27/09/2025	5	Goforan (Cefotaxime)	1	2x1	8	4	2
18	Wahyundari	P/47	dr. Zaki, Sp. B	099504	Hernia Umbilical	23/09/2025	25/09/2025	3	Cefoperazon e	2	1x2	2	4	0,5

									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
19	Zainul Bahri	L/53	dr. Anton, Sp.B	156453	Gangrene Necrotic Diabeticum	26/09/2025	28/09/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1/5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
20	Pudji Rahaju	P/72	dr. Oka, Sp.OT	236404	CF Distal	26/09/2025	28/09/2025	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT

3.6.6.1 Tabel Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Agustus Tahun 2025

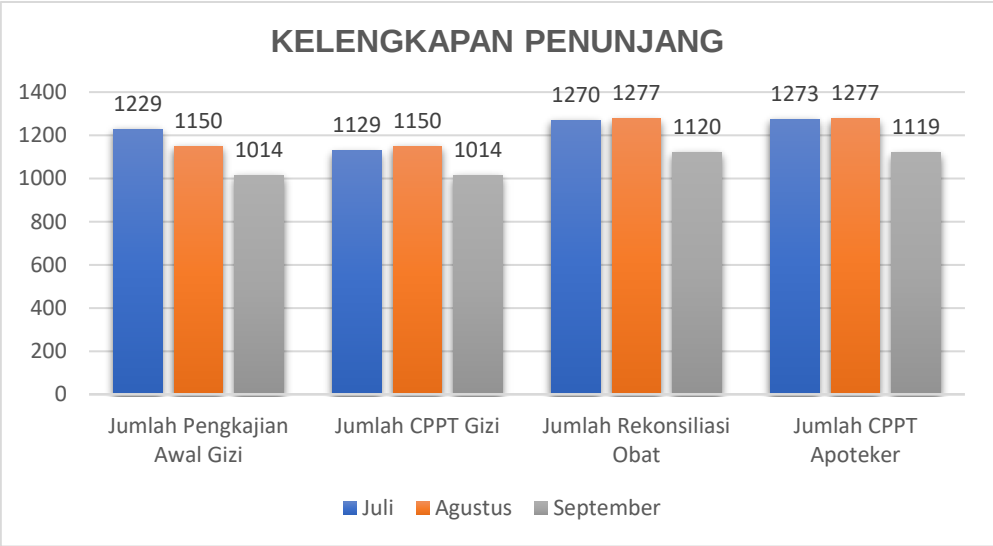
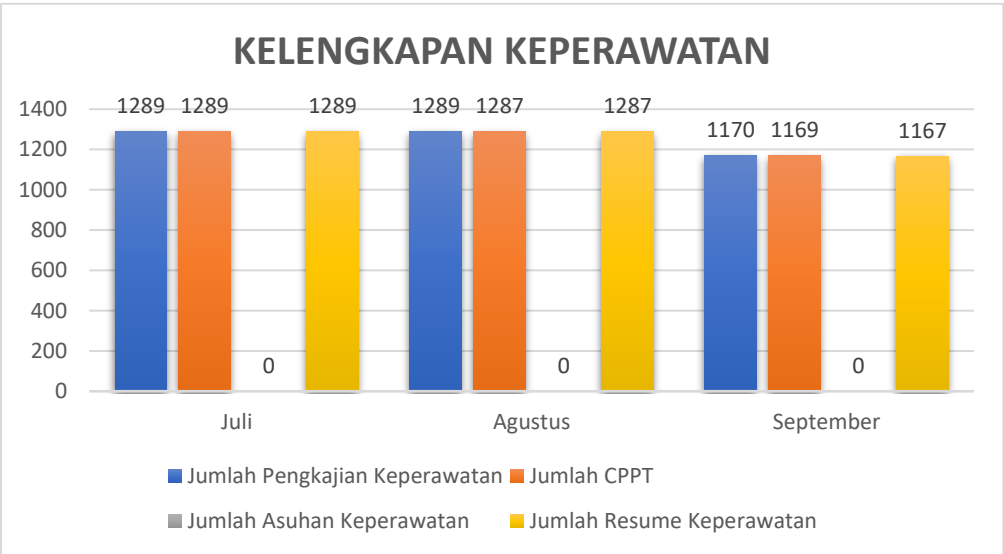
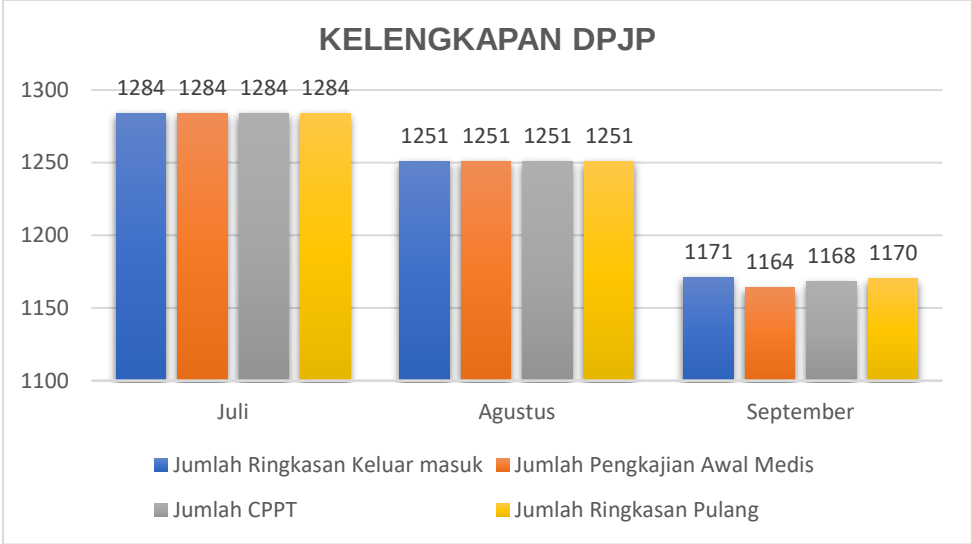
KELENGKAPAN																
DPJP																
BULAN	Ringkasan Keluar Masuk				Pengkajian Awal Medis				CPPT				Ringkasan Pulang			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	1055	98.1	20	1.9	1019	94.8	56	5.2	1026	95.4	49	4.6	1061	98.7	14	1.3
Maret	1201	99.17	10	0.83	1128	93.15	83	6.85	1196	98.76	15	1.24	1187	98.02	24	1.98
April	1204	99	12	1	1148	94	69	6	1200	99	16	1	1185	97	31	3
Mei	1265	98	12	2	1175	92	99	8	1229	94	50	6	1246	97	28	3
Juni	1164	99.87	4	0.13	1127	96.87	41	3.13	1150	98.31	19	1.69	1162	99.72	6	0.28
Juli	1281	99,89	3	0,10	1281	99,89	3	0,11	1281	99,89	3	0,11	1281	99,89	3	0,11
Agustus	1247	97	4	3	1241	99	10	1	1250	100	1	0	1250	100	1	0
September	1171	100	0	0	1164	98,14	7	1,86	1168	99,73	4	0,33	1170	99,84	1	0,16

KELENGKAPAN																
PERAWAT																
BULAN	Pengkajian Keperawatan				CPPT				Asuhan Keperawatan				Resume Keperawatan			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	1070	99.5	5	1048	1048	1048	1048	1.8	1056	98.2	1	0.1	1074	99.9	1	0.1
Maret	1200	98.68	16	1.32	1189	97.78	27	2.22	1214	99.84	2	0.16	1193	98.11	23	1.89
April	1240	99	10	1	1233	99	17	1	1242	99	8	1	1229	98	21	2
Mei	1270	99	7	1	1240	98	37	2	-	-	-	-	1267	99	10	1
Juni	1184	100	0	0	1177	99.49	7	0.51	-	-	-	-	1182	99.80	2	0.20
Juli	1289	100	0	0	1289	100	0	0	-	-	-	-	1289	100	0	0

Agustus	1289	100	0	0	1287	100	0	0	-	-	-	-	1287	100	0	0
September	1170	99,52	1	0,48	1169	99,33	2	0,67	-	-	-	-	1170	99,52	1	0,48

KELENGKAPAN																
BULAN	AHLI GIZI								APOTEKER							
	Pengkajian Awal Gizi				CPPT				Rekonsialisasi Obat				CPPT			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	944	92	82	8	944	92	82	8	1010	98	16	2	912	89	114	11
Maret	1049	97.6	26	2.4	1074	99.9	1	0.1	1066	99.2	9	0.8	1067	99.3	8	0.7
April	1249	99.9	1	0.1	1250	100	0	0	1247	99.8	3	0.2	1250	100	0	0
Mei	753	72	266	25	1019	100	0	0	1298	100	0	0	1298	100	0	0
Juni	661	66	372	34	1032	99.91	1	0.09	1173	99.95	1	0.05	1172	98.8	2	1.2
Juli	666	58	563	48	1124	99,65	5	0,35	1269	96,67	1	3,33	1272	96,67	1	3,33
Agustus	1150	100	0	0	1150	100	0	0	1277	100	0	0	1274	100	0	0
September	1014	100	0	0	1014	100	0	0	1120	100	0	0	1119	99,96	1	0,4

3.1.1.7 3.1.1.6 Grafik Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Agustus 2025



Analisis :

- 1. Ketidaklengkapan DRM Ahli Gizi terisi lengkap 100% , sebanyak 1014 dokumen
- 2. Pengkajian keperawatan 100% lengkap pada Bulan September 2025.
- 3. Masih ditemukan ketidaklengkapan pengkajian awal medis oleh DPJP pada Bulan September 2025.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Menginformasikan kepada KARU hasil audit ketidaklengkapan DRM untuk melengkapi kekurangannya.
- 2. Melakukan supervise secara berkala.
- 3. Trial ERM Rawat Inap, diperlukan warning jika form belum terisi lengkap sehingga tidak bisa melanjutkan ke menu berikutnya.
- 4. Sosialisasi saat Rapat Unit, cara pengisian DRM.
- 5. Membuat rapot ketidaklengkapan .
- 6. Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan

3.7 Permasalahan Rumah Sakit

3.7.67 Permasalahan Instalasi Kamar Operasi (IKO)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Unit			
1	Laporan operasi pasien jasa raharja selalu tidak muncul nama tim operasinya, sehingga ada kendala di tim asuransi untuk pengklaiman	P	1. Tim operasi sudah diinput oleh perawat IKO 2. Penjamin di awal untuk pasien JR adalah UMUM. Sehingga pada saat penginputan diawal sudah ada tim dan kategorinya, saat berubah penjamin, ada perbedaan penginputan oleh kasir, sehingga tidak sinkron dengan ERM
		D	Koordinasi dengan programmer untuk menindaklanjuti kasus tersebut
		S	Laporan operasi sudah bisa muncul nama tim nya
		A	Lakukan evaluasi dan koordinasi ulang dengan programmer apabila ada trouble dan kendala baik pengisian maupun preview cetak nya.
2	Alat orthopedi martin (vasgrip) belum datang	P	1. Sudah pengajuan bulan februari 2025 2. Dari PT menunggu penawaran dari vendor 3. Membandingkan harga beberapa vendor 4. Ada vendor martin dan disuruh uji coba kan di IKO 5. Pengajuan evaluasi alat martin ke PT 6. Follow up alat datang karena dokter ortopedi komplain
		D	Follow up ke pengadaan PT, sudah proses P.O estimasi 3-4 bulan
		S	Koordinasi dengan unit dan PT untuk selalu monitor dan follow up
		A	Lakukan follow up berkala sampai barang datang

3.7.68 Permasalahan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Kabid/ Komite Terhadap Unit			
1	Tren kunjungan rawat inap bpjs turun dari bulan sebelumnya karena indikasi masuk rawat inap harus benar-benar sesuai prosedur bpjs	P	Indikasi medis rawat inap pasien bpjs harus masuk kriteria kegawatdaruratan
		D	Sharing dan sosialisasi kembali untuk refreshing ilmu kegawatan sesuai ACLS
		S	Menekankan kembali untuk di IGD, bahwa tidak ada penolakan pasien, melainkan penjelasan terkait penjamin yang digunakan oleh pasien jika tidak sesuai indikasi dirawat.
		A	Monitoring dan Kerjasama dengan dokter IGD dan tim IGD agar menjaga kualitas pelayanan meskipun penjamin pasien adalah bpjs kesehatan
2	PR ERM SPRI IGD	P	Mengidentifikasi PR ERM dari verifikator terkait kesesuaian SPRI maupun isinya
		D	Ingatkan dan sosialisasikan kembali bagian yangs sering di PR kan oleh verifikator diantaranya GCS, Operasi/tidak operasi, nama keluarga yang diberikan edukasi
		S	Pembetulan PR ERM wajib diselesaikan dalam waktu 1x24 jam
		A	Monitoring dan evaluasi kerjasama dengan kains RM untuk mengecek PR ERM saat itu juga, agar bisa dilengkapi dengan segera.
3	Penerimaan rujukan dari luar termasuk Klinik Mutiara Sehat	P	Respon cepat semua rujukan yang masuk dari IGD by WA
		D	Pengisian link dan mempermudah akses masuk ke IGD
		S	Berikan prioritas penuh untuk diterima (fast track) di IGD terutama Klinik FKTP/perusahaan, PSC, Resita
		A	Monitoring penertiban dalam penulisan rujukan yang masuk, jika rujukan ditolak, alasannya harus jelas dikarenakan fasilitas berupa DPJP, sarana dan prasana RSPHM tidak ada.
4	Pengukuran TB dan BB realtime untuk pasien IGD di triase	P	Pengukuran BB dan TB harus realtime dilakukan saat pasien datang, kecuali pada kondisi pasien tidak sadar, kesakitan hebat atau kondisi kegawatan lainnya
		D	Menempatkan BB dan TB di triase yang sebelumnya di depan PONEK, tujuannya agar memudahkan pasien datang langsung bisa di ukur TB dan BB
		S	Pengukuran BB dan TB harus sesuai untuk menentukan dosis obat dan terapi lanjutan
		A	Koordinasi dengan gizi dengan menjalankan skrining gizi yang sesuai sehingga jika ditemukan ada resiko malnutrisi , dapat di TL oleh ahli gizi nya.
5	Waktu tunggu IGD lebih dari 6 jam sehingga menyebabkan	P	Identifikasi penyebab waktu tunggu IGD yang lama

	penumpukan pasien dan pasien baru tidak masuk	D	- PJ atau Karu harus mengatur sirkulasi perpindahan pasien di IGD - Plotting perawat belum dibentuk sehingga masing-masing perawat masih belum jelas harus memegang pasien apa saja - Koordinasi dengan dokter IGD dan PIPP, untuk memindah pasien yang stabil ke ruangan
		S	Operan antar shift harus jelas dan terdokumentasi
		A	Pendampingan operan pasien dan penunjukan plotting yang sesuai harus dipatuhi setiap shift
6	Penunggu pasien di dalam IGD banyak sehingga pelayanan tidak optimal karena terlalu ramai	P	Penunggu pasien di IGD dibatasi 1 orang, selama ini penunggu pasien keluar masuk dan bergerombol terutama jika ada kondisi KLL atau kegawatan
		D	Dari hasil rapat koordinasi, saran diadakan stiker penunggu pasien hanya 1 orang di tiap bed dan ditaruh poster di luar IGD
		S	Dengan adanya stiker di masing-masing bed IGD, maka penunggu dapat terkontrol dan tidak bergerombol
		A	Kerjasama dengan security untuk penertiban penunggu pasien di IGD

3.7.69 Permasalahan Rawat Inap

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Orientasi ruangan belum berjalan secara konsisten di unit beserta dokumentasi di ERM	P	Setiap pasien MRS di rawat inap harus dilakukan orientasi ruangan
		D	Setelah orientasi ruangan, di ERM harus didokumentasikan dilengkapi dengan TTD pasien atau keluarga pasien
		S	Impementasi di lapangan kurang konsisten, karena ada 2 kondisi yaitu sudah dilakukan, tetapi tidak terdokumentasi, tidak dilakukan dan tidak terdokumentasi
		A	Kerjasama dengan karu rawat inap untuk mendisiplinkan staf nya dalam pendokumentasian orientasi ruangan rawat inap di ERM
2.	Pendokumentasian pengkajian edukasi di ERM belum seragam	P	Pendokumentasian pasien di rawat inap meliputi pemberian informasi dan pengkajian edukasi mulai dari PDF sampai rawat inap
		D	Penulisan belum konsisten dilakukan
		S	Data secara random, ada yang sudah didokumentasikan dengan lengkap termasuk hand hygiene, etika batuk, hasil asuhan, rencana kepulangan, dan asuhan lanjutan di rumah
		A	Kerjasama dengan karu rawat inap untuk mendisiplinkan staf nya dalam pendokumentasian orientasi ruangan rawat inap di ERM
3.	Pasien rawat inap terganggu karena banyak pengunjung	P	Koordinasi dengan security untuk mendisiplinkan pengunjung

	datang melebihi jam besuk terutama malam hari	D	Koordinasi untuk meminimalisir banyak pintu masuk yang ke rawat inap dengan memasang pintu di samping IKO
		S	Kunci pintu di samping IKO saat jam kunjung ditutup
		A	Security tetap monitoring dan supervisi keliling, dan koordinasi dengan PJ/ karu rawat inap apabila masih ada pengunjung yang belum keluar saat jam besuk sudah berakhir.

3.7.70 Permasalahan Rawat Jalan

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Pasien rawat jalan tidak gawat darurat, semua masuk ke IGD sehingga masuk false emergency	P	Identifikasi pasien indikasi rawat inap tetapi tidak gawat darurat sehingga tidak perlu di MRS kan di IGD
		D	Buat SPO alur masuk pasien rawat inap dari POLI
		S	Impementasi SPO ditemui kendala untuk pasien beda penjamin, SPRI tidak muncul
		A	Koordinasi dengan programmer agar SPRI tetap muncul, tanpa pasien harus masuk ke IGD untuk didaftar ulang
2	Pengisian lembar transfer kosong untuk pasien lodingan yang diambil oleh rawat inap	P	Untuk pengisian lembar transfer karena sudah ERM, pengisian dilakuakn oleh perawat rawat inap
		D	Di ERM ditulis staf yang mengambil pasien ke di PDF, dan yang menerima boleh dari PJ atau karu
		S	Meminimalisir kekosongan TTV dan tanda tangan di ERM
		A	Evaluasi kembali kendala yang muncul pada pasien lodingan elektif
3	Ketidaksesuaian isi resume medis rawat jalan dengan anamnesa dan pemeriksaan penunjang	P	Jika ada pemeriksaan penunjang yang dilakukan setelah poli, contoh USG abdomen yang tidak dilakukan saat hari H, akan ada kendala potensi tidak sesuai dengan anamnesa dan hasil penunjang
		D	Di anamnesa dan indikasi dilakukan penunjang tersebut harus muncul dan rinci, misal Dx : Colic abdomen dd Cholelitisias sehingga di resume yang ditarik oleh verifikator bisa sesuai
		S	Jika ditemukan resume medis yang tidak sesuai, konfirmasi dengan DPJP untuk di benahi sebelum naik klaim
		A	Monitor dan evaluasi target penyelesaian sudah tepat waktu atau belum, koordinasi antara asce dan karu rawat jalan
4	Poli gigi 2 ada beberapa bagian part yang rusak	P	Tombol dental bermasalah dan tidak bisa digunakan
		D	Pembuatan form kerusakan oleh IPSRS
		S	Pengajuan perbaikan ke vendor dan bersurat ke PT
		A	Alat dental gigi sudah diperbaiki oleh vendor akhir september 2025 dan sudah berfungsi

3.7.71 Permasalahan Instalasi Farmasi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Hasil stok opname farmasi yang sudah stabil pada akhir tahun 2024 dan belum mencapai target selisih 0.	P	Pertanggungjawaban Selisih Hasil Stok Opname
		D	Berdasarkan Surat Edaran dari RS Nomor 218/I-SE/DIR/III/2025 tentang Pertanggungjawaban Selisih Hasil Stok Opname Farmasi disampaikan beberapa kebijakan
		S	Evaluasi hasil stok opname belum mencapai target 0
		A	- Penyesuaian / Adjustment stock (akibat dari adanya selisih hasil stock opname) dengan acuan selisih wajar sebesar 1% dari total persediaan TIDAK LAGI DIBERLAKUKAN per 1 Januari 2025. - Acuan selisih hasil SO sesuai dengan BA (Berita Acara) hasil SO. - Selisih Kurang (jumlah fisik barang yang ditemukan saat SO < jumlah yang tercatat dalam sistem) dilakukan analisis selisih terlebih dahulu dan menentukan unit yang terlibat kemudian hitung beban 60% kepada Manajemen Rumah Sakit (Direktur Rumah Sakit, Kabid Penunjang, Kabid Pelayanan Medis, Kabid Keperawatan, Kabid Umum & keuangan, Kains. Farmasi). Penanggung jawab rak dan unit terlibat sebesar 40% dari jumlah selisih SO. Pembebanan langsung pada periode berjalan. - Selisih Lebih (jumlah fisik barang yang ditemukan saat SO > jumlah yang tercatat dalam sistem) dilakukan analisis selisih terlebih dahulu, jika selisih lebih masih dalam selisih wajar tidak dibebankan, jika terdapat selisih lebih yang mengalami peningkatan ekstrim, maka diberlakukan pembebanan selisih lebih hasil SO berupa teguran tertulis dari direktur rumah sakit kepada unit penyebab selisih SO dan penanggung jawab rak. - Hasil dari perhitungan selisih akan disesuaikan dalam penggalan setiap bulan
2.	Terdapat selisih stok opname yang fluktuatif. Juli 2025 = +1.370.844 Agustus 2025 = +1.412.881 September 2025 = -128.673	P	Perencanaan scan barcode.
		D	1. Sudah dilakukan pengajuan proposal scan barcode dan pengadaan alat yang menunjang pelayanan. 2. Sudah dilakukan presentasi perencanaan scan barcode beserta tujuan dan manfaatnya.
		S	Selisih stok opname di gudang farmasi dan depo farmasi
		A	1. Scan barcode dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan akurasi data, pengendalian stok yang lebih baik, kepatuhan terhadap regulasi, pengurangan biaya operasional, tindak lanjut yang lebih efisien, integrasi sistem yang lebih baik, peningkatan pelayanan pasien. 2. Scan barcode menunggu antrian di progamer PT.
3.	Penulisan Kartu Pengambilan Obat (KPO) yang masih manual dan membuat waktu obat jadi lama. Prosentase waktu tunggu obat non racikan 43.08% dan waktu tunggu obat racikan 15.70%	P	Perencanaan elektronik KPO dalam pelayanan resep.
		D	Koordinasi dengan Programmer untuk membuat fitur elektronik KPO di SIMRS yang bisa diakses oleh DPJP dan Apoteker.
		S	1. Penulisan KPO masih manual sehingga memakan waktu dan penulisan yang tidak baku dan tidak terbaca. 2. Komplain pasien akibat pasien tidak membawa KPO.
		A	1. Elektronik KPO menunggu antrian di progamer PT. 2. Mendata KPO tertinggal sebagai bukti kuat bahwa KPO manual resiko hilang. KPO tertinggal ada 111 KPO.

4.	Obat tertinggal 2x24 jam	P	Perbaiki kebijakan obat tertinggal.
		D	Menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal.
		S	1. Obat tertinggal bulan September mengalami penurunan namun masih ditemukan pasien mengambil obat lebih 2x24 jam. 2. Farmasi sudah menghubungi pasien agar obat tertinggal dikirim oleh primantara namun banyak pasien menolak karna obat diambil sendiri ke farmasi.
		A	1. Farmasi tiap hari menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal. 2. Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan. 3. Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru.
5.	Penambahan daftar obat near ED	P	Mempercepat pengeluaran barang near ED.
		D	Membuat surat edaran untuk DPJP supaya membantu mengeluarkan barang near ED dari Depo Farmasi maupun Gudang Farmasi.
		S	Obat near ED yang tidak segera dikeluarkan akan mejadi death moving dan menyebabkan kerugian terhadap rumah sakit.
		A	1. Kolaborasi dengan Komite Medik untuk membantu pengeluaran barang near ED. 2. Melakukan negoisasi dengan DPJP untuk menggunakan barang near ED sesuai dengan kebutuhan. 3. Kolaborasi dengan Pengadaan PT untuk melakukan retur obat near ED kepada distributor.
6.	Tempat penyimpanan vaksin tidak sesuai dengan standar, ditemukan VVM (Vaksin Vial Monitor) untuk vaksin pemerintah warna segiempat lebih gelap dari warna lingkaran sehingga tidak layak digunakan.	P	Pengadaan VR (Vaccine Refrigerator) di Depo Farmasi sesuai dengan standar penyimpanan vaksin.
		D	1. Memperbaiki VR yang ada supaya bisa digunakan kembali. 2. Mengedukasi perawat dan petugas farmasi terkait penyimpanan yang benar.
		S	Vaksin yang tidak layak diberikan kepada pasien bisa dikembalikan ke Puskesmas Wilayah, tetapi RS harus memikirkan bagaimana vaksin tidak sampai diretur.
		A	1. Vaksin pemerintah disimpan di VR Gudang Farmasi. 2. Perubahan alur pengambilan vaksin oleh perawat poli. 3. Koordinasi dengan PJ Vaksin Pemerintah untuk permintaan vaksin baru ke Puskesmas.
7.	Ditemukan resep IU (Ketidaksesuaian surat kontrol poli dengan jadwal ambil obat apotek online BPJS Kesehatan 30 hari). Juli 2025 = 40 resep Agustus 2025 = 19 resep September 2025 = 36 resep	P	Koordinasi dengan Karu poli
		D	1. Sosialisasi fitur edit no apol. 2. Koordinasi dengan Karu poli untuk edukasi ke perawat perhitungan obat 30 hari agar surat kontrol sesuai.
		S	1. Perawat salah perhitungan obat 30 hari sehingga surat kontrol tidak sesuai 30 hari. 2. Farmasi banyak pendingan resep di SIMRS karena belum bisa input no apol. 3. Farmasi utang input obat di apol. 4. Jika sudah waktunya input apol farmasi telpon verifikator bahwa resep sudah dikerjakan.
		A	1. Alur fitur "Edit No APOL" :

			a. Input resep IU di apol b. Copy no apol c. Klik kanan sesuai resep yang telah dikerjakan di apol d. Klik "Edit No APOL" e. Paste no apol f. Klik OK 2. Alur perubahan surat kontrol ; a. Farmasi menemukan IU di apol b. Farmasi konfirmasi ke perawat poli untuk hapus surkon di SIMRS. c. Farmasi konfirmasi ke CSO untuk hapus di V-Claim pada grup whatsapp Pelayanan BPJS Kes jika merubah surat kontrol pakai HP IFRS dengan format: Ganti Surat Kontrol Nama pasien : No. RM : DPJP : Tanggal perubahan : Alasan perubahan : IU/TK tanggal berapa d. Perawat input ulang surkon terbaru di SIMRS dan mengirimkan di grup WA. e. Pendaftaran mengubah di V-Claim f. Apoteker KIE pasien menuju CSO untuk mengambil surat kontrol, jika obat di primantara maka farmasi mencetak surat kontrol dan di steples ke obatnya. g. Pasien mengambil obat ke farmasi jika sudah ke CSO.
8.	Obat Rawat Inap di tandon di Nurse Station	P	Pengecekan obat tandonan di nurse station setelah dilakukan serah terima obat ODD
		D	Sosialisasi ke Apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi terkait pengecekan obat tandonan di nurse station
		S	Memaksimalkan jobdesc distribusi obat rawat inap oleh Tenaga Vokasi Farmasi dan Apoteker untuk mengecek obat yang ada di nurse station
		A	Pada saat distribusi obat rawat inap Tenaga Vokasi Farmasi wajib mengecek obat-obat yang ada di nurse station. Jika ada tandonan obat, Tenaga Vokasi Farmasi wajib menanyakan ke perawat jam pemberian obatnya. Jika sudah terlewat jam pemberiannya maka Tenaga Vokasi Farmasi wajib cek DPO obat yang ada di nurse station jika sudah lewat waktu pemberian harus di retur saat itu juga, serah terima obat dengan perawat dan perawat juga langsung input retur di simrs. Apoteker rawat inap saat visite pasien juga wajib double check obat yang ada di nurse station. Jika obat signa PRN / kp berkoordinasi dengan apoteker, apakah pasien masih membutuhkan terapi tersebut.
9.	Pertanyaan sewaktu visite terlalu monoton dan template	P	Koordinasi dengan apoteker terkait pelayanan visite apoteker
		D	Sosialisasi ke apoteker
		S	PT. DPM menemukan cara visite apoteker terlalu monoton dan template sehingga pengecekan apakah pasien sudah minum obat atau belum belum di jalankan. Pertanyaan keluhan bisa diganti dengan pertanyaan "Bagaimana kabar bapak/ ibu hari ini? Apakah sudah membaik?". Pertanyaan riwayat penyakit, riwayat obat, dan riwayat alergi apoteker bisa mengkaji di Asessment awal IGD sehingga tidak perlu ditanyakan kembali ke pasien dan melanjutkan pengkajian terkait obat yang dibawa dari rumah
		A	Saat visite pertanyaan tidak template dan monoton, lebih ceria, lebih humble.

			Langkah-langkahnya : Sebelum visite apoteker mengkaji riwayat penyakit, riwayat obat, dan riwayat alergi di asesment awal IGD. “Selamat pagi bapak / ibu, perkenalkan diri” Identifikasi pasien “Bagaimana kabar bapak/ ibu hari ini? Apakah sudah membaik?” “Apakah obatnya sudah diminum hari ini pak/ bu?” Jika belum maka apoteker meminumkan obat ke pasien. “Setelah minum obat apakah ada efek samping?” “Obat yang dikonsumsi di rumah apa saja?” Kemudian menjelaskan obat yang diterima saat rawat inap dan efek samping yang bisa terjadi/ jika ada interaksi obat.
10.	Pelunasan resep non pasien	P	Koordinasi dengan keuangan PT. DPM, kasir dan farmasi
		D	Perbaikan alur pelayanan resep non pasien di SIMRS
		S	PT. DPM menemukan obat karyawan dan pembelian urinal/ pispot yang diinputkan non pasien belum dilunaskan di sistem sehingga banyak tagihan yang belum terbayarkan muncul di keuangan PT.
		A	Pembayaran obat non pasien wajib minta nota yang sudah terstempel LUNAS oleh kasir, setelah itu baru diberikan barangnya. Jika sudah terstempel lunas tetapi di billing belum dilunasi telfon kasir. Jika belum terselesaikan hingga akhir shift wajib ditulis dioperan unit farmasi. Jika pegawai RSPH yang membeli obat : tulis nama/unit
11.	Kesalahan input nama obat di apotek online BPJS Kesehatan sehingga terjadi pendingan obat kronis.	P	Pengajuan bridging simrs dan apotek online BPJS Kesehatan
		D	1. Sosialisasi dan pemahaman kembali kepada apoteker dan tenaga vokasi farmasi terkait pendingan yang sering terjadi untuk memperbaiki ketelitian inputan obat di apotek online BPJS Kesehatan. 2. Pengecekan inputan obat kronis di apotek online BPJS Kesehatan setiap akhir shift khususnya obat-obat yang sering muncul pendingan.
		S	Kesalahan input nama obat di apotek online BPJS Kesehatan dan muncul di pendingan obat kronis yaitu velpraz tab 250 mg/ valproat 250 SK tab salut 250 mg (salah input valproat 250 SK tab lepas lambat 250 mg), berotec / fenoterol hbr 100 sk inh 100 mcg/puff (salah input fenoterol hbr 0,1 SK btl 50 ml), alat oros 10 mg / aripriprazol 10 SK tab dispersible 10 mg (salah input aripriprazol 15 SK tab discmelt 15 mg)
		A	Sosialisasi pengecekan inputan obat kronis di apotek online BPJS Kesehatan setiap akhir shift khususnya obat-obat yang sering muncul pendingan.
12.	Rekonstitusi sediaan steril bentuk serbuk injeksi wajib dilakukan di LAF	P	Pelaksanaan rekonstitusi serbuk injeksi semuanya dilakukan di LAF
		D	Pengajuan proposal pelatihan penyiapan obat intravena dan teknik aseptik
		S	Perlu adanya pelaksanaan pengoplosan obat injeksi bentuk serbuk untuk setiap obat yang akan digunakan, sehingga perlunya farmasi untuk mengoplos obat setiap shiftnya di LAF namun terkendala dengan jumlah tenaga yang melakukan pengoplosan injeksi selama ini adalah apoteker.
		A	1. Tenaga vokasi farmasi sesuai regulasi PMK terbaru bisa diberikan kewenangan melakukan rekonstitusi sediaan steril dengan syarat sudah terlatih. 2. Dilakukan pelatihan dispensing sediaan steril. 3. Dilakukan trial dispensing sediaan steril setiap shift.

			4. Dilakukan penjadwalan per shift untuk TVF dan Apoteker yang akan mengoplos.
--	--	--	--

3.7.72 Permasalahan Rekam Medis

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Terkait keterlambatan, tukar jadwal, dan human error	P	Mengajukan konseling yang bersangkutan ke SDM atau KABID
		D	Karu koordinasi dengan KABID dan SDM
		S	Memperhatikan dan mengatur jadwal staff untuk mengurangi tingkat kelelahan sehingga bisa menekan angka keterlambatan
		A	Melakukan konseling ke staff yg bersangkutan dan berkolaborasi dengan KABID dan SDM salah satunya memberikan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis
2	Ketidaklengkapan pengisian form rekam medis oleh PPA	P	Mengajukan sosialisasi ke PPA terkait pengisian DRM yang baik dan benar
		D	Karu koordinasi dengan KABID
		S	Mengecek ulang setiap DRM yang akan di setor ke RM dan melengkapi yang kurang sehingga DRM sudah lengkap waktu di setor ke RM
		A	Sosialisasi ke semua PPA tentang ketepatan dan kelengkapan pengisian dokumen rekam medis sehingga tidak ada lagi DRM yang tidak lengkap
3	Surat Rujukan penuh masih manual belum SIMRS	P	Pengajuan fitur Rujuk Penuh di SIMRS ke programmer
		D	Karu koordinasi dengan programmer
		S	Surat rujukan penuh tidak lagi manual tetapi bisa langsung terhubung ke VCLAIM sehingga bisa mengurangi waktu tunggu di pendaftaran
		A	1. Follow up ke progammer
			2. Monitoring dan evaluasi SIMRS

3.7.73 Permasalahan Laundry

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Mesin Pengering Dinamo Rusak	P	1) Membuat pengajuan perbaikan 2) Distribusi linen bersih ke PHS untuk di keringkan 3) Pengajuan pengering cadangan
		D	1) Membuat pengajuan perbaikan dinamo mesin dan pembelian sparepart 2) Pembelian sparepart Cadangan 3) Pembelian mesin RT baru sebagai Cadangan 4) Membawa linen bersih untuk di keringkan ke PHS
		S	1) Setiap barang (mesin pengering) yang load pemakaian banyak harus punya barang Cadangan

			2) Komunikasi terkait kendala mesin dengan tim IPSRS
		A	1) Jika terjadi kerusakan mesin pengering utama maka linen akan di olah di RSPHS 2) Selalu sedia spare part 3) Pembelian mesin pengering Cadangan 8 kg

3.7.74 Permasalahan Instalasi Gizi dan Dapur

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Tikus di dapur sudah berkurang, akan tetapi masih ada tikus yang berkeliaran dan hanya melewati jebakan yang sudah dipasang oleh vendor	P	Memperbaiki struktur gedung dapur agar tidak ada celah tempat tikus masuk ke dapur
		D	Kolaborasi dengan tim IPSRS dan tukang RSPHM
		S	Kontaminasi makanan akibat adanya vector yang ada di lingkungan dapur
		A	Kolaborasi dengan tim IPSRS dan vendor untuk memperbaiki jebakan tikus yang diletakkan di dapur
2	Selisih antara jumlah barang pada kartu stok dan jumlah fisik bahan makanan	P	Pendisiplinan pengisian kartu stok
		D	Kolaborasi dengan tim pengolahan dan penyaji dalam pengisian kartu stok bahan makanan
		S	Risiko kehabisan stok bahan makanan apabila tidak teratur mengisi kartu stok bahan makanan
		A	Sosialisasi ulang kepada tim pengolahan dan tim penyaji dalam pengisian kartu stok bahan makanan
3	Beberapa pasien ada yg membawa makanan dari luar RS	P	Pasien dan keluarga pasien mematuhi edukasi yang diberikan ahli gizi untuk tidak membawa makanan dari luar rumah sakit
		D	Kolaborasi antara ahli gizi dan perawat untuk mengontrol makanan yang dibawa keluarga pasien saat berkunjung
		S	Risiko kontaminasi makanan yang dapat memberikan dampak negative pada pasien (keracunan makanan, diare)
		A	Tim gizi, penyaji makanan , dan perawat selalu mengontrol makanan yang dibawa pasien dan selalu mengingatkan untuk hanya mengkonsumsi makanan yang ada di rumah sakit untuk menghindari risiko kontaminasi makanan.
4	Buah untuk pasien sebagian besar masih mentah sehingga pemberian buah melon pada diet DM rasanya tidak manis dan masih keras	P	Pembelanjaan bahan makanan (Buah) berkualitas bagus dan siap konsumsi
		D	Kolaborasi antara ahli gizi, pengadaan, dan tim pembelian dalam menentukan kualifikasi bahan makanan yang sesuai
		S	Risiko tidak tepatnya diet yang diberikan kepada pasien terkait

			ketersediaan buah yang sesuai dengan diet pasien
		A	Tim pengadaan, pembelian, dan tim gizi berkolaborasi dalam pembelian bahan makanan
5	Pembelian buah untuk pasien dilakukan seminggu sekali. Sehingga pada setiap minggunya ada beberapa buah yang busuk dan tidak dapat dipakai	P	Pembelian bahan makanan (Buah) berkualitas bagus dan siap konsumsi
		D	Kolaborasi antara ahli gizi, pengadaan, dan tim pembelian dalam menentukan kualifikasi bahan makanan yang sesuai
		S	Risiko tidak tepatnya diet yang diberikan kepada pasien terkait ketersediaan buah yang sesuai dengan diet pasien
		A	Tim pengadaan, pembelian, dan tim gizi berkolaborasi dalam pembelian bahan makanan
6	Alur penyerahan alat makan bersih dari pencucian central sebaiknya dibuatkan jalur khusus agar langsung menuju ruang pemorsian	P	Alur penyerahan alat makan harus bebas dari kontaminasi untuk menjamin hygiene sanitasi alat makan
		D	Kolaborasi antara ahli gizi dan IPSRS dalam pembuatan alur yang sesuai
		S	Risiko alat makan terkontaminasi makanan mentah sehingga tidak terjaga kebersihannya
		A	Tim gizi dan IPSRS berkolaborasi dalam pembuatan alur yang sesuai untuk penyerahan alat makan bersih ke tempat pemorsian

3.8

Profil SDM

3.8.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	0	0
2	Kabid Pelayanan Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
3	Kabid Penunjang Medis	D3 Kebidanan	0	0	0	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	0	0	0	0	0
5	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Satuan Pengawas Internal	SMK	1	1	1	0	0
7	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
8	Dokter Casemix	Dokter Umum	1	1	0	1	0
9	Farmasi	Profesi Apoteker	40	12	6	6	0
		S1 Farmasi		3	2	1	0
		D3 Analis Farmasi dan Makanan		1	1	0	0
		D3 Farmasi		22	14	8	0
		SMK		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
10	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	10	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	7	1	0

		SMK		0	0	0	0
		SMA		1	1	0	0
11	CSSD	D3 Keperawatan	5	3	2	1	0
		SMA		1	1	0	0
		SMK		1	0	1	0
12	Fisioterapi	S1 Fisioterapi	5	1	0	1	0
		D3 Fisioterapi		3	2	1	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	0
13	Gizi	S1 Ilmu Gizi	17	2	2	0	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	2	0	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		7	0	7	0
		SMA		1	0	1	0
		SMP		3	2	1	0
14	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	1	0	1	0
		S1 Teknik Informatika		1	0	1	0
15	ICU dan HCU	Profesi Ners	12	5	5	0	0
		D3 Keperawatan		7	6	1	0
16	IGD	Profesi Ners	24	11	8	3	0
		D3 Keperawatan		8	6	2	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
17	IKO	Profesi Ners	12	8	8	0	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		0	0	0	0
18	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
19	IPSRs	S1 Tenik Elektro	6	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	3	0	0
20	IRJA	Profesi Ners	27	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		15	13	2	0
		D4 Keperawatan Gigi		1	1	0	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
21	IRNA 2C	Profesi Ners	6	5	4	1	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
22	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	18	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		11	7	4	0
23	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	13	4	2	2	0
		D3 Keperawatan		8	7	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
24	IRNA 5C	Profesi Ners	8	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		5	4	1	0
25	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	21	8	4	4	0
		D3 Keperawatan		13	10	3	0
26	Maternitas	Profesi Kebidanan	10	1	0	1	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		7	7	0	0
27	Neonatologi	Profesi Ners	8	3	2	1	0

		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
28	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	9	3	3	0	0
		S1 Akuntansi		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
29	Laboratorium	D4 Analis Kesehatan	9	1	0	1	0
		D3 Analis Kesehatan		8	7	1	0
30	Laundry	SMK	4	1	0	1	0
		SMA		2	1	1	0
		SMP		1	0	1	0
31	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	7	7	7	0	0
32	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	15	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Asuransi Kesehatan		1	0	1	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		7	5	2	0
		D1 Administrasi Perkantoran		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
33	PIPP & MPP	Profesi Ners	4	0	0	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
		D3 Kebidanan		2	2	0	0
34	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	0	0
35	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	5	2	0
36	SDM	S1 Psikologi	1	1	1	0	0
37	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	0	0
38	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	0	0
39	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
40	Cleaning Service	SMK	40	14	8	6	0
		SMA		21	17	4	0
		SMP		5	5	0	0
41	Security	SMK	12	5	2	3	0
		SMA		7	6	1	0
42	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	5	1	1	0	0
		SMA		3	2	1	0
		SMP		1	1	0	0
43	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
44	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	5	5	1	4	0
45	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
46	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
47	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
48	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
49	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
50	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter	3	3	0	3	0

		Spesialis					
51	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
54	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
56	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
59	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
61	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total			429	429	282	147	0

Keterangan :
Pada bulan September tidak ada staf resign.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

RS Prima Husada Malang yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sumber Daya Manusia ataupun dari sisi sarana dan prasarannya. Dimana masih terdapat beberapa Sumber Daya manusia yang masih belum tertib baik dari kelompok tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang masih belum tertib secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dengan penataan SDM yang disesuaikan dengan alur dan tata letak Gedung yang baru, maka dilakukan juga penambahan tenaga khususnya perawat untuk memenuhi kebutuhan setelah dilakukan evaluasi dan Analisa beban kerja. Proporsi antara karyawan kontrak/tidak tetap dengan karyawan tetap, dimana masih banyak karyawan kontrak/tidak tetap di RS Prima Husada Malang diperkirakan bisa mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah sakit

Kepatuhan DPJP dalam memvisite pasien dan melengkapi dokumen Rekam medis yang masih jauh dari standar juga mempengaruhi kualitas pelayanan di RS Prima Husada Malang dan menghambat proses klaim. Kinerja RS dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal Rumah Sakit. Jumlah kunjungan di RS Prima Husada Malang masih didominasi oleh kunjungan pasien lama dari BPJS Kesehatan. Pelayanan di beberapa unit yang belum optimal dikerenakan salah satu dampak kekurangan tenaga kerja membawa akibat pada pelayanan.

B. SARAN

1. Meningkatkan ketertiban administrasi di Unit SDM terutama ketertiban absensi dengan memanfaatkan SIM SDM yang baru
2. Membentuk dan mengoptimalkan kinerja dari komite – komite yang ada di RS Prima Husada Malang
3. Meningkatkan kepatuhan visite DPJP dengan mencatat dan melaporkan waktu visite DPJP serta mentertribkan DPJP dalm pengisian Dokumen Rekam Medis
4. Memperbaiki proses rekrutmen staf sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
5. Meningkatkan skill dan pengetahuan SDM dengan giat mengaktifkan diklat dan pelatihan internal serta mengikuti pelatihan secara eksternal
6. Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke RS Prima Husada Malang
7. Menjalin lebih banyak kerjasama dengan stakeholder dari luar RS Prima Husada Malang

BAB V
PENUTUP

Demikian laporan bulan September 2025 ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Malang pada Juli 2025, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Malang, 07 Oktober 2025
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M. Kes

LAMPIRAN

NO	NAMA PKS	JENIS INSTANSI	MULAI BERLAKU	TANGGAL EXPIRED	KETERANGAN	NOMOR PKS RUMAH SAKIT	NOMOR PKS INSTANSI
1	ASURANSI DAYIN MITRA	ASURANSI	05 Februari 2015	05 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/269/XII/2014	003/MKT/HLT/PKS/I/2015
2	Batas Media 99	PERUSAHAAN	05 Juni 2024	05 Juni 2027	Pelayanan Kesehatan	158/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	-
3	BPJS KESEHATAN	ASURANSI	01 Januari 2025	31 Desember 2025	Pelayanan Kesehatan	2035/E-PKS/DIR/XII/2024	651/KTR/VII-05/1224
4	CV AUMERTA ANGGUN	PERUSAHAAN	28 Agustus 2023	28 Agustus 2026	PELAYANAN KESEHATAN	164.1/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2023	-
5	ESWEJE Aesthetic Center	INSTANSI KESEHATAN	01 Maret 2024	01 Maret 2027	Sterilisasi alat kesehatan	079/DPM/E-PKS/DIR/III/2024	9,1202E+12
6	Pelayanan Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu	AKRE	05 Desember 2022	04 Desember 2025	Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu	1754/E-PKS/DIR/XII/2022	-
7	Indonesia Smelting Technology	PERUSAHAAN	01 Juni 2024	01 Juni 2026	Rujukan Pelayanan	194/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	005/HRGA-IST/V/2024
8	Instruktur Zumba	AKRE	23 Februari 2024	23 Februari 2025	Instruktur Zumba	067/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	-
9	Klinik Mutiara Sehat (Karanglo, Lawang, Karangploso)	INSTANSI KESEHATAN	02 Agustus 2021	02 Agustus 2026	Pelayanan Laboratorium	429.77/I-PKS/DIR/VIII/2021	069/PKS/PDP/VIII/2021
10	Klinik Endisa Husada	INSTANSI KESEHATAN	01 Agustus 2023	01 Agustus 2026	Rujukan Pelayanan	148.3/DPM/E-PKS/DIR/VII/2023	PK/01/VII/2023-KEH
11	Klinik Losari Medika	INSTANSI KESEHATAN	06 Februari 2024	06 Februari 2027	Rujukan Pelayanan	-	021/DPM/E-PKS/DIR/II/2024
12	Klinik Pratama Beauty Medika Singosari	INSTANSI KESEHATAN	25 Mei 2024	25 Mei 2027	Rujukan Pelayanan	145/DPM.E-PKS/DIR/V/2024	001/PKS/12/2024
13	Klinik Rawat Jalan Mitra Prima Care	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2027	Pelayanan Kesehatan	346/DPM/E-PKS/DIR/XII/2024	025/MPC/E-PKS/KA/XII/2024
14	Klinik Utama Medika	INSTANSI	24	24 September	Rujukan Pasien	299/DPM/E-	-

		KESEHATAN	September 2024	2027		PKS/DIR/IX/2024	
14	Klinik Utama Rawat Jalan Akasia	INSTANSI KESEHATAN	25 April 2024	25 April 2027	Pelayanan Kesehatan	116/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	011/KUA/E-PKS/HMS/III/2024
15	Penerjemah Bahasa Isyarat untuk Difabel	AKRE	14 September 2022	13 September 2025	Penerjemah Bahasa Isyarat Untuk Difabel	1378/E- PKS/DIR/X/2022	-
16	Penerjemah Bahasa Madura	AKRE	01 Agustus 2022	02 Agustus 2025	Penerjemah Bahasa Madura	1305/E- PKS/DIR/IX/2022	-
17	Penerjemah Bahasa Asing	AKRE	01 Agustus 2022	01 Agustus 2025	Penerjemah Bahasa Inggris	1288/E- PKS/DIR/IX/2022	-
18	Persada Hospital	INSTANSI KESEHATAN	10 Oktober 2022	10 Oktober 2027	Pelayanan Kesehatan	152.45//DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	1083.b.HS/MOU/X/PH-2022
19	PMI Kabupaten Malang	INSTANSI KESEHATAN	19 Agustus 2024	19 Agustus 2026	Penyediaan Darah	246/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	0904/02.06.28/UTD/VIII/2024
20	PMI Kabupaten Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Juni 2023	30 Juni 2023	Rujukan Pelayanan	-	768/E-PKS/DIR/V/2023
21	PMI Kota Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Desember 2023	01 Desember 2025	Penyediaan Darah	1790/E- PKS/DIR/XI/2023	2214/02.06.27/UTD/XI/2023
22	PRAKTEK BIDAN MANDIRI NIA IRAWATI, S.TR.KEB	INSTANSI KESEHATAN	07 Februari 2024	26 Februari 2027	Rujukan dan Pelayanan Penunjang	081/DPM/E- PKS/DIR/III/2024	-
23	PT AA International Indonesia	ASURANSI	02 September 2019	02 September 2020	Pelayanan Kesehatan Grab	-	-
24	PT Administrasi Medika	ASURANSI	01 Juli 2024	01 Juli 2027	Asuransi		071/PKS/AdM/ManagedCare/VII2024
25	PT AIA Financial	ASURANSI	04 November 2020	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	No.069/DPM/E- PKS/DIR/X/2020	No. 639/AIA/-DPM/XI/2020
26	PT AJ Central Asia Raya	ASURANSI	02 Juni 2017	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	277/RSPH/E- IKS/DIR/VI/2017	DIR/PKS-RS/1455/VI/2017
27	PT AJINOMOTO SALES INDONESIA	PERUSAHAAN	01 Mei 2012	30 APRIL 2013 (selanjutnya)	PELAYANAN KESEHATAN		

				perpanjang otomatis)			
28	PT Alfiza Medika Utama	INSTANSI KESEHATAN	07 Maret 2024	07 Maret 2028	Pelayanan Kesehatan	090/DPM/E-PKS/DIR/III/2024	018/MOU/KAMU/07/III/2024
29	PT Aloita Prima (Harris Hotel Malang)	PERUSAHAAN	29 Juli 2024	29 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	221/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	-
30	PT ANTARMITRA SEMBADA CAB. MALANG	PERUSAHAAN	01 Desember 2024	01 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	304.1.DPM/E-PKS/DIR/X/2024	344/MLG/AMS/XII/2024
31	PT APLIKANUSA LINTASARTA	ASURANSI	25 Februari 2015	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/100/II/2015	095/LA/MOU/00300/2015
32	PT ASABRI	ASURANSI	13 Desember 2023	12 Desember 2026	PELAYANAN KESEHATAN	1902/E-PKS/DIR/XII/2023	PEFJ-182/HK.02.01/HBL.H/XII/2023
33	PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA	ASURANSI	12 Oktober 2023	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	PH/E-PKS/171/X/2013	499B/AAD-LEG-AGR/X/2013
34	PT Asuransi Allianz Life Indonesia	ASURANSI	12 Desember 2017	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	729/AZLI-LGL/AG/XII/2017
35	PT ASURANSI ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA	ASURANSI	18 November 2024	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	698.21/DPM/I-PKS/DIR/IX/2024	391/ALLISYA-LGL/AG/XI/2024
36	PT ASURANSI ASTRA BUANA	ASURANSI	01 September 2020	31 Agustus 2023	PELAYANAN KESEHATAN	1033/RSPHS/E-PKS/DIR/VIII/2020	26/HID-PM/ASURANSIASTRA/IX/2020
37	PT ASURANSI DAYIN MITRA	ASURANSI	05 Februari 2015	05 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/269/XII/2014	003/MKT/HLT/PKS/II/2015
38	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia	ASURANSI	01 Oktober 2023	01 Oktober 2028	Asuransi	183.3/DPM/E-PKS/DIR/X/2023	157/GI/OPS/Prov-PKS/X/2023
39	PT Asuransi Jiwa In Health Indonesia (Mandiri Inhealth)	ASURANSI	01 Februari 2023	31 Januari 2025	Asuransi	028.2/DPM/E-PKS/DIRR/11/2023	0.32/AJII.KOP-SBY/PKS/0123
40	PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA	ASURANSI	01 Desember 2024	01 Desember 2025	PELAYANAN KESEHATAN	361/DPM/E-PKS/DIR/XII/2024	331-11/EB-CONT/2024

41	PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK (ASURANSI MAG)	ASURANSI	28 Januari 2020	27 Januari 2024	RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN	015/DPM/E- PKS/DIR/XI/2019	PKS-0097/XI/2019/MAG-R2
42	PT Asuransi Reliance Indonesia	ASURANSI	06 November 2024	06 November 2027	Asuransi	338/DPM/E- PKS/DIR/XI/2024	024/LGL-ARI/PKS-RS-IB/XI/2024
43	PT ASURANSI RELIANCE INDONESIA	ASURANSI	07 September 2020	07 September 2025	PELAYANAN KESEHATAN	368/DPM/I- PKS/DIR/VIII/2020	163/LGL-ARI/PKS/RS-COB/IX/2020
44	PT ASURANSI SINARMAS	ASURANSI	01 September 2019	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	010/DPM/E- PKS/DIR/IX/2019	364/PKS-RS/PH.RI.ASM/IX/2019
45	PT ASURANSI SINARMAS MSIG	ASURANSI	10 September 2012	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		063/PKS-AJSMSIG-RS/IX/2012
46	PT ASURANSI TAFAKUL KELUARGA	ASURANSI	02 Januari 2017	01 Januari 2020	PELAYANAN KESEHATAN	508/RSPH/E- IKS/DIR/XI/2016	0642/PKS-RS-01/I/2017
47	PT ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA	ASURANSI	30 Oktober 2021	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	612/RSPHS/E- PKS/DIR/X/2019	300/PKS/DIR/TKP/X/2019
48	PT AXA SERVICES INDONESIA (ADMEDIKA)	ASURANSI	15 Agustus 2013	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		067/AGR-LEG/ASI/VIII/2013
49	PT Bestari Murni Anugrah	PERUSAHAAN	04 Juni 2024	04 Juni 2027	rujukan pelayanan	159/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
50	PT BNI LIFE INSURANCE	ASURANSI	25 Juli 2016	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	082/RSPH/E- IKS/DIR/II/2016	274.PKS.BL.DIR.0716
51	PT CAKRA SURYA HUSADA	PERUSAHAAN	02 Agustus 2022	02 Agustus 2025	ASUHAN PASIEN & PELAYANAN PENUNJANG	112.1/DPM/E- PKS/DIR/VII/2022	138/MOU/VIII/CSH/2022
52	PT Citra Karsa Dinamika	PERUSAHAAN	01 Juli 2024	01 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	196/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
53	PT Docdoc Healthcare Indonesia	ASURANSI	12 Desember 2024	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	-
54	PT Equity Life Indonesia	ASURANSI	14 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	-	091/ELI/LGL/X/19

55	PT EQUITY LIFE INDONESIA	ASURANSI	14 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		090/ELI/LGL/X/19
56	PT Fullerton Health Indonesia	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis		-	640/IP-OP/PKS/FHI/VIII/2019
57	PT Global Assistance & Healthcare	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	-	640/IP-OP/PKS/GAH/VIII/2019
58	PT Green Mountains Natural Food	PERUSAHAAN	07 Agustus 2024	07 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	225/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	01/GMN/KS/VI/2024
59	PT HANWA LIFE INSURANCE INDONESIA	ASURANSI	16 Maret 2015	15 Maret 2016	PELAYANAN KESEHATAN		0088/HLI-GH/PKS-RS/03-2015
60	PT Indo Aneka Atsiri	PERUSAHAAN	07 Agustus 2024	06 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	222/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	066/IAA/HRGA/VI/2024
61	PT INDOLAKTO PANDAAN	PERUSAHAAN	10 Januari 2014	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		
62	PT Indonesia Marine	PERUSAHAAN	10 September 2024	10 September 2027	Pelayanan Kesehatan	-	-
63	PT INTERNATIONAL SERVICES PASIFIC CROSS	VENDOR	03 Oktober 2022	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	150/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	953/ISPC/PKS/X/2022
64	PT JASA RAHARJA	ASURANSI	04 Juli 2022	04 Juli 2027	PENAGANAN DAN PENYELESAIAN SATUNAN KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DAN LALU LINTAS JALAN	912.1/E-PKS/DIR/VII/2022	P/13/SP/2022
65	PT Java Smartindo	PERUSAHAAN	01 Agustus 2020	Perpanjangan Otomatis	Jasa Pengelolaan Administrasi Kesehatan	364/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	PKS.TPA-JSMART.290/VIII/20/RS.SW.C
66	PT JAYA OBAYASI	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	360/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	
67	PT Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	ASURANSI	17 Juli 2020	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	034/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020	092/KBM-DPM/PKS/VII/2020
68	PT LABBIOGEN ARTHA MEGA	INSTANSI KESEHATAN	02 September 2024	01 September 2027		262/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2024	B-MKT 01/001/623/VII/2024

69	PT MALANG INTERMEDIA PERS	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	025/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	103.1/PKS/DIR/JPRM/VIII/2020
70	PT Medilink Digital Media	ASURANSI	22 Maret 2024	22 Maret 2027	Pelayanan Kesehatan	09/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	229/L/PKS/MDM-DPM/III/2024
71	PT MEDLINX ASIA TEKNOLOGI	ASURANSI	28 November 2016	Perpanjangan Otomatis	APLIKASI LAYANAN KESEHATAN	150/PKS- RSPRIMAHUSADA- MAT/DIR/XI/2016	
72	PT MOOR SUKSES INTERNASIONAL	ASURANSI	08 Juli 2024	08 Juli 2027	PELAYANAN KESEHATAN	200/DPM/E- PKS/DIR/2024	001/MSI/VI/2024
73	PT PAN PACIFIC INSURANCE	ASURANSI	31 Agustus 2020	31 Agustus 2023	PELAYANAN PERAWATAN DAN PENGOBATAN	017/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	0593-01/PKS/PRV-PANFIC/RS- PHMS/VIII/2020
74	PT PANCAMAS ELITE	PERUSAHAAN	12 Juni 2024	12 Juni 2027	Pelayanan Kesehatan	172/DPM/E- PKS/DIV/VI/2024	-
75	PT PANCAMAS ELITE	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	032/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	
76	PT PLN (Persero)	ASURANSI	02 Juli 2024	31 Desember 2025		261/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	0017.Add/HKM.02.01/F010800300/2022
77	PT Prima Sarana Jasa - Asuransi SOS	ASURANSI	17 September 2018	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	735/E- PKS/DIR/IX/2018	296/GAN/PT-6/HOSP/SEP/2018
78	PT Prudential Life Assurance	ASURANSI	28 Januari 2021	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	047/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2020	1578/PMN-PLA/XI/2020
79	PT Suprima Mitra Adihusada	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	640/IP-OP/PKS/TIRTA/VIII/2019
80	PT TASPEN (PERSERO)	ASURANSI	11 Juni 2024	10 Juni 2026	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	110/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	JAN-09/C.5.1/2024
81	PT TASPEN (PERSERO)	ASURANSI	01 Januari 2023	31 Desember 2025	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	008/E- PKS/DIR/I/2023	JAN-01/DIR/2023
82	PT TIRTA INVESTAMA	PERUSAHAAN	31 Agustus 2020	31 Agustus 2025	PELAYANAN KESEHATAN		
83	PT Tonggak Ampuh	PERUSAHAAN	31 Agustus 2024	31 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	263/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	-
84	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA	PERUSAHAAN	01 Agustus	31 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	150.2/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	050/AK/2/VII/TBINA-Kenaf/2023

			2023				
85	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA PASURUAN PLANT	PERUSAHAAN	27 Oktober 2020	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	1076/RSPHS/E-PKS/DIR/IX/2020	002/AK/10/V/TBINA-Kenaf/2020
86	PT Unggul Anugrah Sejahtera	PERUSAHAAN	04 Juni 2024	04 Juni 2027	Rujukan Pelayanan	160/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	-
87	PT Uniplastindo Interbuana	PERUSAHAAN	29 Juli 2024	29 Juli 2027	Pelayanan Kesehatan	224/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	-
88	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA	PERUSAHAAN	04 Januari 2021	04 Januari 2024	PELAYANAN KESEHATAN	303/DPM/I-PKS/DIR/VI/2021	002/PKS-COB/I/2021
89	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA	PERUSAHAAN	22 Maret 2024	22 Maret 2027	PELAYANAN KESEHATAN	183/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	014/PKS-COB/III/2024
90	PT YAMAHA MUSICAL PRODUCTS INDONESIA (YMPI)	PERUSAHAAN	01 Juni 2022	01 Juni 2025	PELAYANAN KESEHATAN	004/DPM/E-PKS/VI/2022	/YMPI/HI/PKS/VI/2022
91	PT Yanmar Diesel Indonesia	PERUSAHAAN	15 April 2024	15 April 2027	Pelayanan Kesehatan	108/DPM/E-PKS/DIR/IV/2024	107/YADIN/Pdn/Pga/IV/2024
92	PT Zurich Asuransi Indonesia TBK	ASURANSI	25 Juni 2024	24 Juni 2029	Asuransi	151/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	268/ZAI-LEG-AGR/VI/2024
93	RS Islam UNISMA Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Januari 2024	31 Desember 2026	Rujukan Pelayanan	222.11/DPM/E-PKS/DIR/XI/2023	08/PKS/RSI-4/I/2024
94	RS Lavalette	INSTANSI KESEHATAN	07 Agustus 2024	07 Agustus 2027		236/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2024	DA01-ADDNM-BB/P-B/24-07-16/138
95	RS Prima Husada Sukorejo	INSTANSI KESEHATAN	01 Oktober 2022	01 Oktober 2025	Pelayanan Kesehatan	1376/E-PKS/DIR/X/2022	1608/RSPJS/E-PKS/DIR/X/2022
96	RS Siti Miriam Lawang	INSTANSI KESEHATAN	31 Agustus 2024	31 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	264/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	566/HMS/RSSM/VIII/2024
97	RSIA Puri Bunda	INSTANSI KESEHATAN	06 Februari 2024	06 Februari 2026	Rujukan Pelayanan	020/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	001/PKS/PB/I/2024
98	RSUD Bangil	INSTANSI	22 Juli	22 Juli 2027	Rujukan Pelayanan	222/DPM/E-	400.7.5.2/1531.1/424.072.01/2024

		KESEHATAN	2024			PKS/DIR/VII/2024	
99	Yayasan Bhakti Luhur	AKRE	05 Desember 2022	04 Desember 2025	Pelayanan Rohaniawan Agama Kristen	1753/E- PKS/DIR/XII/2022	-
100	RS PANTI NIRMALA	INSTANSI KESEHATAN	07 Oktober 2022	06 Oktober 2025	PELAYANAN RUJUKAN	152.44/DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	3740/069/RSPN/X/2022
101	PKM SINGOSARI	INSTANSI KESEHATAN	12 April 2022	12 April 2027	TUBERKULOSIS DENGAN STRATEGI DOTS	593/I- PKS/DIR/IV/2022	440/894/35.07.103.135.2022
102	KLINIK IDAMAMUK	INSTANSI KESEHATAN	16 Juni 2021	PERPANJANG OTOMATIS	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG	347/DPM/I- PKS/DIR/VII/2021	/005/VI/2021
103	KLINIK RAWAT INAP MUSLIMAT SINGOSARI	INSTANSI KESEHATAN	15 April 2023	15 April 2026	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG	107.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	031.A/A.1/M/RSMS/02/IV/2023
104	KLINIK TIRTO HUSADA	INSTANSI KESEHATAN	18 September 2023	18 September 2026	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	176.3/DPM/E- PKS/DIR/IX/2023	015.004/KTH/IX/2023
105	KLINIK UTAMA JANTUNG HUSNA MEDIKA MALANG	INSTANSI KESEHATAN	01 Desember 2023	32/11/26	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	241.2/DPM/E- PKS/DIR/XII/2023	023/PKS/DIR-HMMMALANG/XII/2023
106	DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR NIA ANITA	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2029	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	347/DPM/E- PKS/DIR/2024	
107	DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR INDRAWAN DWANTORO	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2029	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	348/DPM/E- PKS/DIR/XII/2024	
108	RSJ DR RADJIMAN WEDIODONONGRAT LAWANG	INSTANSI KESEHATAN	30 Oktober 2023	30 Oktober 2026	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	220.1/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	HK.03.01/D.XXXVII/12226A/2023
109	RSUD DR SAIFUL ANWAR	INSTANSI KESEHATAN	01 November 2024	01 November 2026	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	234/DPM/E- PKS/VIII/2024	400.14.5/7499.1/102.7/2024
110	KLINIK PRATAMA RAWAT JALAN MAWAR WASKITHA HUSADA	INSTANSI KESEHATAN	23 Januari 2024	22 Januari 2027	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	001.34/DPM/E- PKS/DIR/I/2024	
111	PRAKTEK BIDAN MANDIRI RIZA KHUTMI, S.S.T	INSTANSI KESEHATAN	05 Agustus 2024	05 Februari 2027	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	221/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	
112	RSU UNIVERSITAS	INSTANSI	05	22 Agustus	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	248/DPM/E-	081/SK_PKS/RSU-UMM/VIII/2024

	MUHAMMADIYAH MALANG	KESEHATAN	Agustus 2024	2027		PKS/DIR/VIII/2024	
113	IBAZZ AESTHETIC MEDICAL CENTER BY DR UMMAH	INSTANSI KESEHATAN	14 Juni 2024	14 Juni 2027	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	180/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	
114	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MALANG	INSTANSI KESEHATAN	02 Januari 2025	02 Januari 2026	PELAYANAN KELUARGA BERENCANA IUD & IMPLANT	2053/E- PKS/DIR/XII/2024	100-3-7/103/35-07-313/2025